

DRAFT

ICS

INDONESIAN CODING STANDARD

PEDOMAN

PENGODEAN IDRG

VERSI 1 2026



DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	18
DAFTAR TABEL	20
DAFTAR SINGKATAN.....	26
GLOSARIUM	32
A. INDONESIAN DIAGNOSIS RELATED GROUP (iDRG)	33
1. Struktur Kode iDRG	33
a. <i>Major Diagnostic Category (MDC)</i>	33
b. <i>Disease Cluster (DC)</i>	35
c. <i>Patient Type Designation (PTD)</i>	35
d. <i>Complexity Level (CL)</i>	35
B. KETENTUAN UMUM KODING iDRG	37
1. Ketentuan Umum Pengkodean (<i>Coding</i>) iDRG	37
a. Diagnosis Utama	38
1) Elemen-elemen penting diagnosis utama	38
b. Diagnosis Sekunder	41
1) Diagnosis Komorbid (<i>Pre-Admission Comorbidity</i>)	41
2) Komplikasi (<i>Post-Admission Comorbidity</i>)	42
c. Sumber Daya	43
d. Penyebab Luar (<i>External Cause</i>)	44
2. Aturan Koding Morbiditas ICD-10 Versi Tahun 2010:	46
a. <i>Rule MB1</i>	46
b. <i>Rule MB2</i>	47
c. <i>Rule MB3</i>	48
d. <i>Rule MB4</i>	49
e. <i>Rule MB5</i>	50
f. Aturan Koding Spesifik	50
1) Pengodean kondisi dugaan/suspek, gejala, penemuan abnormal, dan situasi tanpa penyakit	50
2) Pengodean kondisi multipel	52
3) Pengodean kategori kombinasi	54
4) Pengodean sekuele kondisi tertentu	56
5) Pengodean kondisi-kondisi akut dan kronis	57

6)	Pengodean kondisi pasca-prosedur dan komplikasinya	58
7)	Pengodean untuk penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV)	
(B20-B24)	59	
8)	Pengodean Neoplasma	60
9)	Pengodean diabetes mellitus (E10-E14).	61
10)	Pengodean Persalinan (O80-O84).	62
3.	Pengodean Prosedur / Tindakan	64
a.	Aturan dalam pengodean Tindakan / Prosedur	64
1)	Kata “ <i>See, See also</i> ” (lihat, lihat juga);	64
2)	Kata “ <i>omit code</i> ” (tidak dikoding);	64
3)	Kata “ <i>code also</i> ” (dikoding juga);	66
4)	Kata “ <i>exclude</i> ” (tidak termasuk).....	66
5)	Kata “ <i>includes</i> ” (termasuk).	66
b.	Kode Tindakan / Prosedur Operasi	66
4.	Pendokumentasian Klinis.....	67
a.	Gunakan Istilah Diagnosis Paling Spesifik.....	68
b.	Hindari Penggunaan Singkatan.....	68
5.	Hal - Hal yang harus dilakukan Pengode dalam memberikan kode diagnosis atau tindakan/prosedur	69
a.	Prinsip Pengodean Diagnosis	69
b.	Penentuan Kode Berdasarkan Dokumentasi	70
c.	Bukti Pendukung yang sah saat menentukan kode diagnosis:.....	71
d.	Bukti pendukung yang Tidak Sah untuk menentukan kode diagnosis: 71	
6.	Penentuan aturan etiologi & manifestasi.....	71
7.	Indonesian Modification (IM) Pada ICD-10 dan ICD 9 CM.....	73
C.	KETENTUAN & PERHATIAN KHUSUS KODING iDRG.....	75
1.	Penggunaan Kode Lateralisasi Posisi Anatomi Tubuh	75
a.	Prinsip Dasar Penggunaan.....	75
2.	Aturan Pencatatan Tindakan Berulang dan Sesi Operasi (Setting dan Multiplicity).....	77
a.	Definisi Setting dan Multiplicity	78
b.	Pencatatan Sesi Tindakan (<i>Setting</i>) dan Jumlah Lokasi (<i>Multiplicity</i>).78	
1)	<i>Setting</i> (Perbedaan Waktu/Sesi tindakan).....	78

	2)	<i>Multiplicity</i> (Jumlah Lokasi pada Sesi yang Sama)	78
3.		Tata cara pengkodean multi speciality consultation dan persiapan operasi	79
4.		MDC 10 Pre-MDC	81
5.		MDC 11 Sistem Syaraf	82
	a.	PENJELASAN KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 11.....	82
	1)	<i>Meningitis</i> (G00-G03)	82
	2)	<i>Encephalitis And Myelitis</i> (G04-G05)	82
	3)	<i>Intracranial And Intraspinal Abscess And Granuloma</i> (G06-G07) ..	82
	4)	<i>Sequela of inflammatory diseases of central nervous system</i> (G09)...	83
	5)	<i>Parkinsonism</i> (G20-G22)	84
	6)	<i>Dystonia</i> (G24)	85
	7)	<i>Alzheimer's Disease</i> (G30)	85
	8)	<i>Epilepsy and Status Epilepticus</i> (G40-G41)	85
	9)	<i>Migraine and Headache</i> (G43-G44)	87
	10)	<i>Transient Ischaemic Attack (TIA)</i> (G45)	87
	11)	<i>Sleep Apnoea</i> (G47.3)	87
	12)	<i>Cranial Nerve Disorders</i> (G50-G53).....	88
	13)	<i>Polyneuropathy</i> (G61-G63)	89
	14)	<i>Myopathy</i> (G70-G73).....	89
	15)	<i>Sindrom Paralitik</i> (G81–G83).....	90
	16)	<i>Hydrocephalus</i> (G91, G94, Q03)	91
	17)	<i>Cerebrovascular Accident (CVA)</i> (I60-I64)	92
	18)	<i>Other Cerebrovascular Disease</i> (I65-I68).....	92
	19)	<i>Sequela of Cerebrovascular Diseases</i> (I69.-)	93
	b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 11 ...	93
6.		MDC 12 MATA & ADNEXA	94
12	a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC	94
	1)	<i>Conjunctivitis</i> (H10.-)	94
	2)	<i>Pinguecula and Pterygium</i> (H11.0–H11.1)	94
	3)	<i>Corneal Scar</i> (H17).....	95
	4)	<i>Contact Lens Intolerance</i>	95
	5)	<i>Uveitis</i> (H20-H22, H30, H32).....	96

	6)	<i>Retinal Procedures</i>	98
	7)	<i>Cataract (H25-H26)</i>	98
	8)	<i>Aphakia (H27.0)</i>	99
	9)	<i>Refractive Error (H52)</i>	99
	10)	<i>Visual Impairment (H54.-)</i>	100
	b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 12	101
7.		MDC 13 TELINGA, MULUT, TENGGOROKAN	102
13	a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC	102
	1)	<i>Otitis Externa (H60.-)</i>	104
	2)	<i>Cholesteatoma (H71)</i>	104
	3)	<i>Perforation Of Tympanic Membrane (H72.-)</i>	105
	4)	<i>Vertigo (H81, R42)</i>	106
	5)	<i>Hearing Loss (H90-H91)</i>	107
	6)	<i>Embedded and Impacted Teeth (K01.-)</i>	108
	7)	<i>Dental Caries (K02.-)</i>	108
	8)	<i>Diseases Of Pulp And Periapical Tissues (K04.-)</i>	109
	9)	<i>Cellulitis and Abscess of Mouth (K12.2)</i>	109
	10)	<i>Rhinitis (J00, J30, J31.0)</i>	110
	11)	<i>Sinusitis (J01, J32)</i>	111
	12)	<i>Tonsillectomy</i>	111
	13)	<i>Hoarseness</i>	112
	b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 13	113
8.		MDC 14 SISTEM PERNAFASAN	116
14	a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC	116
	1)	<i>Influenza (J09-J11)</i>	116
	2)	<i>Pneumonia (J12-J18, J69)</i>	116
	3)	<i>Bronchitis (J20, J40-J42)</i>	119
	4)	<i>Stenosis Laryngotracheal (J38.6, J39.8, J95.5)</i>	119
	5)	<i>Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (J44.-)</i>	120
	6)	<i>Asthma (J45-J46)</i>	120
	7)	<i>Bronchiectasis (J47)</i>	121
	8)	<i>Lung Diseases Due To External Agents (J60-J66)</i>	121

9)	<i>Hypersensitivity Pneumonitis Due To Organic Dust (J67.-)</i>	121
10)	<i>Respiratory Conditions Due To External Agents (J68.-, J70.-)</i>	121
11)	<i>Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) (J80)</i>	121
12)	<i>Pulmonary oedema (J81)</i>	121
13)	<i>Abscess Of Lung (J85)</i> Jika dokter mendiagnosis abses paru disertai pneumonia, dan pneumonia tersebut tidak disebabkan oleh organisme spesifik yang termasuk dalam kode J09–J16, gunakan kode J85.1 (<i>Abscess of lung with pneumonia</i>). Namun, jika pneumonia disebabkan oleh organisme tertentu yang sudah diklasifikasikan dalam kode J09 sampai J16 (misalnya pneumonia akibat virus influenza, bakteri spesifik, atau organisme lain yang telah ditentukan), maka cukup gunakan kode pneumonia spesifik dari J09–J16.	122
14)	<i>Pleural Effusion (J90-J91)</i>	122
15)	<i>Pneumothorax (J93.-)</i>	122
16)	<i>Other Pleural Conditions (J94.-)</i>	122
17)	<i>Postprocedural respiratory disorders (J95)</i>	123
18)	<i>Respiratory Failure (J96.-)</i>	123
19)	<i>Interstitial emphysema (J98.2) & Subcutaneous emphysema (T79.-)</i>	124
b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 14	124
9.	MDC 15 JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	126
a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC	
15	126	
1)	<i>Heart Valve Disease (I05-I09, I34-I39)</i>	126
2)	<i>Primary and Secondary Hypertension (I10 dan I15)</i>	126
3)	<i>Primary Hypertension</i>	126
4)	<i>Secondary hypertension (I15.-)</i>	126
5)	<i>Hypertensive Heart and Renal Disease (I11-I13)</i>	127
6)	<i>Acute Myocardial Infarction (I21-I22)</i>	129
7)	<i>Complications Following Acute Myocardial Infarction (I23.-)</i>	129
8)	<i>Chronic Ischaemic Heart Disease (I25.-)</i>	130
9)	<i>Pulmonary Heart Disease (I27.-)</i>	130
10)	<i>Pericarditis (I30-I32)</i>	131
11)	<i>Endocarditis (I33, I38, I39)</i>	131
12)	<i>Myocarditis (I40-I41)</i>	132
13)	<i>Cardiomyopathy (I42-I43)</i>	132

14)	Heart Block (I44-I45).....	133
15)	Cardiac Arrest (I46)	133
16)	Ventricular Fibrillation and Flutter (I49.0)	133
17)	Heart Failure (I50.-)	134
18)	Peripheral Vascular Disease (I70, I73).....	134
19)	Arterial Embolism and Thrombosis (I74.-).....	134
20)	Phlebitis and Thrombophlebitis (I80.-)	134
21)	Oesophageal Varices (I85.-, I98.2 - I98.3).....	134
22)	Gastric Varices (I86.4)	135
23)	Circulatory Disease Procedures	135
b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 15.	137
10.	MDC 16 SALURAN PENCERNAAN.....	143
a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC	
16	143	
1)	Oesophagitis And Oesophageal Ulcer (K20, K22.1)	143
2)	Oesophageal Obstruction (K22.2)	143
3)	Perforation Of Oesophagus (K22.3).....	143
4)	Dyskinesia Of Oesophagus (K22.4)	144
5)	Diverticulum Of Oesophagus (K22.5)	144
6)	Gastro-Oesophageal Laceration-Haemorrhage Syndrome (K22.6)	144
7)	Disorders of oesophagus (K23.-).....	144
8)	Gastritis And Duodenitis (K29.-).....	144
9)	Dyspepsia (K30)	145
10)	Other Diseases Of Stomach And Duodenum (K31.-)	145
11)	Appendicitis (K35-K37).....	146
12)	Hernia (K40-K46)	146
13)	Noninfective Enteritis And Colitis (K50-K52)	146
14)	Allergic And Dietetic Gastroenteritis And Colitis Due To Cow's Milk Protein (K52.20)	146
15)	Vascular Disorders Of Intestine (K55.-)	147
16)	Paralytic Ileus And Intestinal Obstruction Without Hernia (K56.-).147	
17)	Diverticular Disease Of Intestine (K57.-)	147
18)	Other Functional Intestinal Disorders (K59.-).....	147

19)	<i>Diseases Of Anus And Rectum (K60-K62)</i>	147
20)	<i>Other Diseases Of Intestine (K63.-)</i>	148
21)	<i>Peritonitis (K65, K67)</i>	148
22)	<i>Hemoperitoneum (K66.1)</i>	148
23)	<i>Intestinal Malabsorption (K90.-)</i>	149
24)	<i>Postprocedural Disorders Of Digestive System (K91.-)</i>	149
25)	<i>Gastrointestinal Haemorrhage (K92.0-K92.2)</i>	149
26)	<i>Gastrointestinal Procedures</i>	149
b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 16	149
11.	MDC 17 HEPATOBILIER DAN PANKREAS	152
a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC	
17	152	
1)	<i>Toxic Liver Disease (K71.-)</i>	152
2)	<i>Hepatic Failure, not elsewhere classified (K72.-)</i>	152
3)	<i>Fibrosis and cirrhosis of liver (K74)</i>	152
4)	<i>Abscess Of Liver (K75.0)</i>	152
5)	<i>Other diseases of liver (K76.-)</i>	153
6)	<i>Liver Disorders In Diseases Classified Elsewhere (K77.-*)</i>	153
7)	<i>Cholelithiasis And Diseases Of Biliary Tract (K80-K83)</i>	153
8)	<i>Pancreatitis (K85, K86.0, K86.1, K87)</i>	153
b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 17	154
12.	MDC 18 MUSKULOSKELETAL DAN JARINGAN IKAT	156
a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC	
18	156	
1)	<i>Pyogenic Arthritis (M00.-)</i>	156
2)	<i>Direct infections of joint in infectious and parasitic diseases classified elsewhere (M01.-)</i>	156
3)	<i>Reactive Arthropathies (M02)</i>	156
4)	<i>Postinfective and reactive arthropathies in diseases classified elsewhere (M03)</i>	156
5)	<i>Rheumatoid Arthritis (M05-M06)</i>	157
6)	<i>Psoriatic And Enteropathic Arthropathies (M07)</i>	157
7)	<i>Juvenile Arthritis (M08)</i>	157
8)	<i>Gout And Crystal Arthropathies (M10-M11)</i>	157

9)	Other Arthritis (M13.-) Polyarthritis And Monoarthritis (M13.0 - M13.1)	158
10)	<i>Coxarthrosis [Arthrosis Of Hip]</i> (M16)	158
11)	<i>Gonarthrosis [Arthritis Of Knee]</i> (M17)	160
12)	<i>Acquired Clawhand, Clubhand, Clawfoot, And Clubfoot</i> (M21, Q66.0)	161
13)	<i>Disorders Of Patella</i> (M22)	161
14)	Chronic Instability Of Knee (M23.5)	162
15)	Haemarthrosis (M25.0)	163
16)	Polyarteritis Nodosa And Vasculopathies (M30-M31)	163
17)	Systemic Lupus Erythematosus (M32)	163
18)	Systemic Sclerosis (M34)	163
19)	Scoliosis (M41)	164
20)	Spondylolisthesis (M43.1, Q76.2)	165
21)	Spondylosis (M47)	165
22)	Intervertebral Disc Disorders (M50-M51)	166
23)	Spine Fusion And Instrumentation	167
24)	Spontaneous Fracture (M48.4, M48.5, M80, M84.3, M84.4)	167
25)	Fracture In Neoplastic Disease (M49.5, M90.7)	168
26)	Rhabdomyolysis (M62.8)	168
27)	Radial Styloid Tenosynovitis [De Quervain] (M65.4)	168
28)	Necrotizing Fasciitis (M72.6)	168
29)	Fibromyalgia (M79.7)	168
30)	Myofascial Pain Syndrome (M79.8)	169
31)	Osteoporosis (M80-M82)	169
32)	Nonunion Of Fracture [Pseudarthrosis] (M84.1, M96.0)	169
33)	Periprosthetic Fracture (M96.6)	169
b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 18	169
13.	MDC 19 KULIT DAN SUBKUTAN	171
a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC	171
19		
1)	Impetigo (L01.-)	171
2)	Cutaneous Abscess, Furuncle, and Carbuncle (L02.-)	171
3)	Cellulitis (L03.-)	172

4)	Pemphigus dan Pemphigoid (L10.- dan L12.-)	172
5)	Atopic Dermatitis (L20.-)	172
6)	Irritant Contact Dermatitis (L24.-)	173
7)	Dermatitis due to Substances Taken Internally (L27.-)	173
8)	Psoriasis (L40.-)	173
9)	Lichen Planus (L43.-)	174
10)	Erythema Multiforme (L51.-)	174
11)	Erythema Nodosum (L52)	175
12)	Other Erythematous Conditions (L53-L54)	175
13)	Alopecia (L63-L66)	175
14)	Hypertrichosis (L68.-)	175
15)	Vitiligo and Other Disorders of Pigmentation (L81-L81)	176
16)	<i>Epidermal Thickening</i> (L82-L86)	176
17)	<i>Transepidermal Elimination Disorders dan Pyoderma Gangrenosum</i> (L87 - L88)	176
18)	<i>Decubitus Ulcer and Pressure Area</i> (L89)	177
19)	<i>Atrophic Disorders of Skin</i> (L90)	177
20)	<i>Hypertrophic Scar</i> (L91.0)	177
21)	<i>Granulomatous Disorders</i> (L92)	177
22)	Lupus Erythematosus (L93)	178
23)	Localized Connective Tissue Disorders (L94)	178
24)	Vasculitis Limited to Skin (L95)	178
25)	Ulcer of Lower Limb (L97)	178
26)	Disorders of Skin and Subcutaneous Tissue (L98)	178
b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 19	178
14.	MDC 20 ENDOKRIN, NUTRISI DAN METABOLIK	181
a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC	
20	181	
1)	Hypothyroidism (E03.-)	181
2)	Thyrotoxicosis [Hyperthyroidism] (E05.-)	181
3)	Thyroiditis (E06.-)	181
4)	Procedural Codes for Thyroid Disorders	181
5)	Diabetes Mellitus (E10-E14)	182
6)	Pemberian Kode untuk Komplikasi Diabetes:	182

7)	Penyakit Lain pada Pasien Diabetes	184
8)	Disorder of Pancreatic Internal Secretion (E16.3-E16.9).....	184
9)	Hyperparathyroidism (E21.0-E21.3, E83.5)	184
10)	Hyperfunction of Pituitary Gland (E22, E24.0)	185
11)	Cushing' Syndrome (E24.-).....	185
12)	Hyperaldosteronism (E26.-)	185
13)	Primary Adrenocortical Insufficiency (E27.1)	185
14)	Adrenomedullary Hyperfunction (E27.5).....	186
15)	Androgen Excess (E28.1).....	186
16)	Testicular Hypofunction (E29.1)	186
17)	<i>Disorders of Puberty</i> (E30.-).....	186
18)	Disorders of Lipoprotein Metabolism (E78.-)	186
19)	Hyperuricemia (E79.0)	187
20)	Disorders of Calcium Metabolism (E83.5).....	187
21)	Amyloidosis (E85.-)	187
22)	Volume Depletion and Fluid Overload (E86, E87.7)	187
23)	Hypernatremia and Hyponatremia (E87.0-E87.1)	188
24)	Acidosis (E87.2)	188
25)	Alkalosis (E87.3).....	188
26)	Hyperkalemia and Hypokalemia (E87.5-E87.6)	188
27)	Lipodystrophy (E88.1).....	189

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 20.189

15. MDC 21 DISEASE AND DISORDERS OF THE KIDNEY AND URINARY TRACT.....190

21	a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 190	
	1)	Glomerular diseases (N00-N08)
	2)	Obstructive And Reflux Uropathy (N13.-)
	3)	Renal Tubulo-Interstitial Disorders (N14-N16)
	4)	Acute Kidney Injury (N17.3-) ^(IM)
	5)	Chronic Kidney Disease (N18.-).....
	6)	Urolithiasis N20-N23.....
	7)	Contracted And Small Kidney (N26-N27).....
	8)	Cyst Of Kidney (N28.1)

	9)	<i>Bladder-Neck Obstruction</i> (N32.0).....	193
	b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 21.	193
	16.	MDC 22 SISTEM REPRODUKSI PRIA	195
22	a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 195	
	1)	<i>Hyperplasia of Prostate</i> (N40).....	195
	b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 22.	195
	17.	MDC 23 SISTEM REPRODUKSI WANITA	197
23	a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 197	
	1)	<i>Inflammatory Disease Of Female Pelvic Organs</i> (N70-N74)	197
	2)	<i>Female Pelvic Peritoneal Adhesions</i> (N73.6)	198
	3)	<i>Disease of Bartholin's Gland</i> (N75)	199
	4)	<i>Other Inflammation of Vagina and Vulva</i> (N76-N77).....	200
	5)	<i>Endometriosis</i> (N80.-)	201
	6)	<i>Prolapsus Genital</i> (N81)	201
	7)	<i>Cyst Of Ovary</i> (N83.0-N83.2).....	201
	8)	<i>Hyperplasia Endometrial</i> (N85.0-N85.1)	202
	9)	<i>Leukorrhea</i> (N89.8).....	202
	10)	<i>Postcoital And Contact Bleeding</i> (N93.0).....	202
	11)	<i>Vaginal Bleeding</i> (N93.8-N93.9).....	204
	12)	<i>Menopause</i> (N95)	204
	13)	<i>Habitual Aborter</i> (N96)	205
	b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 23.	205
	18.	MDC 24 KEHAMILAN, PERSALINAN DAN NIFAS.....	207
24	a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 207	
	1)	<i>Ectopic Pregnancy</i> (O00).....	207
	2)	<i>Abortion</i> (O03-O07).....	208
	3)	<i>Hypertensive in Pregnancy</i> (O10-O16)	212
	4)	<i>Excessive Vomiting in Pregnancy</i> (O21,-).....	213
	5)	<i>Infections in Pregnancy</i> (O23, O41.1, O85, O86, O98).....	213
	6)	<i>Diabetes Mellitus in Pregnancy</i> (O24).....	216

7)	Maternal Care for Known or Suspected Malpresentation of Fetus (O32,-)	216
8)	Maternal Care for Known or Suspected Disproportion (O33.-, O64-O66)	217
9)	Maternal Care for Tumour of Corpus Uteri (O34.1)	220
10)	Maternal Care for Other Abnormalities of Cervix (O34.4)	221
11)	Premature Rupture of Membranes (O42.-)	222
12)	False Labour (O47,-)	222
13)	Preterm Labour and Delivery (O60.-)	222
14)	Intrapartum Haemorrhage , Postpartum Haemorrhage (O67.- , O72.-)	224
15)	<i>Labour and delivery complicated by fetal stress [distress] (O68.-)</i>	225
16)	<i>Perineal and Vaginal Laceration during Delivery, Obstetric high vaginal laceration alone (O70.-, O71.4)</i>	226
17)	Delivery (O80-O84)	226
18)	Caesarean section (O82.-)	228
19)	<i>Maternal Diseases Classifiable Elsewhere but Complicating Pregnancy, Childbirth and The Puerperium (O98.-,O99.-)</i>	229
b.	Perhatian khusus pada kode eksklusif O99.- (<i>Other maternal diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>):	230
c.	Perhatian khusus pada kode eksklusif dalam kategori O99.-. Sebagai contoh, kode O99.1 (<i>Other diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>) memiliki kondisi eksklusif untuk hemoragik dengan koagulasi defek (O46.0, O67.0, O72.3).	230
1)	Solusi Unacceptable obs. diag. comb. 0-12 pada MDC 24	232
d.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 24	244
19.	MDC 25 PERINATOLOGI	247
a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC	247
1)	Neonatus (Bayi baru lahir)	247
2)	<i>Fetus and Newborn Affected by Maternal Factors and by Complications of Pregnancy, Labour and Delivery (P00-P04)</i>	247
3)	<i>Slow Fetal Growth and Fetal Malnutrition (P05)</i>	248

4)	<i>Disorders Related to Short Gestation and Low Birth Weight, Not Elsewhere Classified (P07.-)</i>	248
5)	<i>Birth Injury to Skeleton (P13)</i>	250
6)	<i>Birth Asphyxia (P21.-)</i>	250
7)	<i>Congenital Pneumonia (P23.-)</i>	250
8)	<i>Neonatal Aspiration Syndromes (P24.-)</i>	251
9)	<i>Haemolytic Diseases of Fetus and Newborn; Neonatal Jaundice (P55; P58-P59)</i>	251
10)	<i>Transitory disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus and newborn (P70.-)</i>	251
b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 25	252
20.	MDC 26 PENYAKIT PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH	252
a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC	252
26		
1)	<i>Stem Cell / Bone Marrow Harvesting and Transplantation</i>	252
2)	<i>Anemia (D50-D64)</i>	255
3)	<i>Other Aplastic Anaemias (D61.-)</i>	256
4)	<i>Coagulation Disorders (D65-D69)</i>	256
5)	<i>Non-Thrombocytopenic Purpura (D69.0-D69.2)</i>	256
6)	<i>Agranulocytosis</i>	257
b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 26	257
21.	MDC 27 MYELOPROLIFERATIVE DISEASES AND DISORDERS, POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS	258
a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC	258
27		
1)	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C81-C96)</i>	258
22.	MDC 28 PENYAKIT INFEKSI DAN PARASIT	259
a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC	259
28		
1)	<i>Other Salmonella Infections (A01-A02)</i>	259
2)	<i>Enteroinvasive Escherichia Coli Infection (A04.0-A04.4)</i>	259
3)	<i>Botulism (A05.1)</i>	260
4)	<i>Amoebiasis (A06.-)</i>	260

5)	<i>Tuberculosis (A15-A19)</i>	260
6)	<i>Infection Due To Other Mycobacteria (A31.-)</i>	262
7)	<i>Listeriosis (A32.-)</i>	262
8)	<i>Diphtheria (A36.-)</i>	262
9)	<i>Meningococcal Infection (A39.-)</i>	263
10)	<i>Sepsis (A40-A41)</i>	263
11)	<i>Congenital Syphilis (A50.-)</i>	265
12)	<i>Anogenital Herpesviral [Herpes Simplex] Infection (A60.-)</i>	266
13)	<i>Viral Meningitis (A87.-)</i>	266
14)	<i>Dengue Fever [Classical Dengue] (A90-A91)</i>	266
15)	<i>Measles (B05.-)</i>	266
16)	<i>Human Immunodeficiency Virus [HIV] Disease (B20-B24)</i>	267
17)	<i>Aspergillosis (B44.-)</i>	269
18)	<i>Malaria (B50-B54)</i>	269
19)	<i>Toxoplasmosis (B58.-)</i>	269
b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 28	269
23.	MDC 29 PENYAKIT DAN GANGGUAN MENTAL	272
a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC	
29	272	
1)	<i>Dementia (F00-F03)</i>	272
2)	<i>Delirium, Not Induced by Alcohol and Other Psychoactive Substances (F05)</i>	272
3)	<i>Other Mental Disorders due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disease (F06.-)</i>	273
4)	<i>Skizofrenia (F20.-)</i>	273
5)	<i>Acute and transient psychotic disorders (F23.-)</i>	273
6)	<i>Schizoaffective disorders (F25.-)</i>	274
7)	<i>Bipolar affective disorder (F31-)</i>	274
8)	<i>Somatoform Disorders (F45-)</i>	275
9)	<i>Eating Disorders (F50.-)</i>	275
10)	<i>Sleep Disorders (G47.-, F51.-)</i>	276
11)	<i>Mental and Behavioural Disorders Associated with The Puerpeium, Not Elsewhere Classified (F53.-)</i>	276
12)	<i>Specific Personality Disorders (F60.-)</i>	276

	13)	<i>Enduring Personality Changes, Not Attributable to Brain Damage and Disease (F62.-)</i>	277
	14)	Retardasi Mental (F70-F79)	277
	15)	<i>Other behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence (F98.-)</i>	277
	b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 29	278
	24.	MDC 30 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN	279
30	a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 279	
	1)	<i>Encounter For General Medical Examination (Z00-Z01)</i>	279
	2)	<i>Examination And Encounter For Administrative Purposes (Z02)</i>	280
	3)	<i>Medical Observation And Evaluation For Suspected Diseases And Conditions (Z03)</i>	281
	4)	<i>Follow-Up Examination After Treatment (Z08-Z09)</i>	281
	5)	<i>Contact With And Exposure To Communicable Diseases (Z20.-)</i>	282
	6)	<i>Asymptomatic Human Immunodeficiency Virus [HIV] Infection Status (Z21)</i>	282
	7)	<i>Contraceptive Management (Z30.-)</i>	282
	8)	<i>Supervision Of Normal Pregnancy (Z34-Z35)</i>	283
	9)	<i>Outcome Of Delivery (Z37.-)</i>	283
	10)	<i>Liveborn Infants According To Place Of Birth (Z38.-)</i>	284
	11)	<i>Postpartum Care And Examination (Z39.-)</i>	284
	12)	<i>Other Surgical Follow-Up Care (Z42-Z48)</i>	284
	13)	<i>Care Involving Use Of Rehabilitation Procedures (Z50.-)</i>	285
	14)	<i>Other medical care (Z51.-)</i>	285
	15)	<i>Donors Of Organs And Tissues (Z52.-)</i>	285
	16)	<i>Persons Encountering Health Services For Specific Procedures, Not Carried Out (Z53.-)</i>	285
	17)	<i>Problems related to physical environment (Z58)</i>	286
	b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 30	286
	25.	MDC 31 MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA	289
31	a.	PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 289	
	b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 31	295

26.	MDC 32 LUKA BAKAR.....	296
32	a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 296	
	1) <i>Burns And Corrosions Of External Body Surface, Specified By Site (T20-T25)</i>	296
	b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 32	296
27.	MDC 33 <i>INJURIES, POISONING & CERTAIN OTHER CONSEQUENCES OF EXTERNAL CAUSES</i>	298
33	a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 298	
	1) <i>Poisoning By Drugs, Medicaments And Biological Substances (T36-T50)</i>	298
	2) <i>Post-Traumatic Wound Infection, Not Elsewhere Classified (T79.3)</i>	298
	3) <i>Compartment Syndrome (T79.6, M62.2)</i>	298
	4) <i>Infection following a procedure not elsewhere classified (T79.6) & Infection and inflammatory reaction due to other internal prosthetic devices, implants and grafts, not elsewhere classified (T85.7)</i>	299
	5) <i>Mechanical Complication of Internal Fixation Device of Bones (T84.1 & T84.2)</i>	299
	6) <i>Infection and Inflammatory Reaction due to Internal Fixation Device [Any Site] (T84.6)</i>	299
	7) <i>Complications of other internal prosthetic devices, implants and grafts (T85,-)</i>	300
	b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 33	300
28.	MDC 34 NEOPLASMA	301
34	a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 301	
	1) <i>Prosedur Terapi Kanker (Kemoterapi, Radioterapi)</i>	301
	2) <i>Komplikasi Terkait dengan Keganasan</i>	303
	3) <i>Kode Morfologi Neoplasma</i>	303
	4) <i>Periampullary Carcinoma (C17.0, C24.0, C24.1, C25.0)</i>	304
	5) <i>Liver Carcinoma (C22.-)</i>	304
	6) <i>Ewing's Sarcoma (C40-C41)</i>	304
	7) <i>Carcinoma Mammae (C50.-)</i>	305
	8) <i>Carcinoma of cervix (C53.-)</i>	305
	9) <i>Malignant neoplasm of corpus uteri (C54-C55)</i>	305

10)	<i>Neoplasm of ovary (C56, D27, D39.1)</i>	305
11)	<i>Primary and Secondary Neoplasm Coding</i>	306
12)	<i>Benign neoplasm of bone and articular cartilage (D16)</i>	306
13)	<i>Leiomyoma of Uterus (D25.-)</i>	306
14)	<i>Craniopharyngioma (D35.3, D44.4)</i>	306
b.	PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 34	306
29.	MDC 35 REHABILITASI MEDIK	308
30.	MDC 36 UNGROUPABLE ATAU UNRELATED	309
a.	Error Codes	309
b.	<i>3611199 Primary Diagnosis code is not valid for Female or Male</i>	309
c.	<i>3611299 Diagnosis code is not valid for patient's age</i>	310
d.	<i>3600019 Unrelated OR Procedure</i>	310
e.	<i>3614129 Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Drug Type</i>	311
f.	<i>3614229 Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Episode Type</i>	312
g.	<i>3615029 Error: Missing Code Also: Angiocardiography Proc.</i>	312
h.	<i>3615129 Error: Missing Code Also: Catheterization Proc.</i>	313
i.	<i>3615229 Error: Stent Insertion wo/ Number of Stent or Number of Vessels</i>	313
j.	<i>3615329 Error: Number of Stent wo/ Insertion Proc.</i>	315
k.	<i>3615429 Error: Angioplasty wo/ Number of Vessels</i>	315
l.	<i>3615529 Error: Missing code also (00.56 or 00.57)</i>	315
m.	<i>3634819 Error blood transfusion for neoplasm without anemia</i>	315
n.	<i>36001x9 Ungroupable: Radiotherapy Session w/o Radiotherapy Proc.</i>	316
o.	<i>36002x9 Ungroupable: Radiotherapy w/o Z51.0</i>	317
p.	<i>36003x9 Ungroupable: Chemotherapy Proc. without Z51.1</i>	317
q.	<i>3635129 Ungroupable: Rehabilitation without Procedures</i>	318
31.	MDC 90 PROSEDUR DIAGNOSIS	322

DAFTAR GAMBAR

Gambar A.1. Penulisan kode iDRG	33
Gambar B.1. Contoh kode (IM) dan Prosedur <i>Include</i>	74
Gambar C.1. <i>Setting</i> dan <i>Multiplicity</i>	79
Gambar C.2. Pedoman koding dalam iDRG terkait jantung dan pembuluh darah	137
Gambar C.3. Pedoman koding dalam iDRG terkait jantung dan pembuluh darah	138
Gambar C.4. Alur Koding Stent Coronary & Non Coronary	138
Gambar C.5. Peritoneal Adhesiolysis Proc	150
Gambar C.6. Alur Rehabilitasi Medik	308
Gambar C.7. Contoh error codes pada <i>Primary Diagnosis code is not valid for Male</i>	309
Gambar C.8. Contoh error codes pada <i>Primary Diagnosis code is not valid for Female</i>	309
Gambar C.9. Contoh error codes pada <i>Diagnosis code is not valid for patient's age</i>	310
Gambar C.10. Contoh error codes pada <i>Unrelated OR Procedure</i>	310
Gambar C.11. Contoh <i>Unrelated OR Procedure</i> yang benar	310
Gambar C.12. Contoh error codes pada <i>Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Drug Type</i>	311
Gambar C.13. Contoh <i>Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Drug Type</i> yang benar.....	311
Gambar C.14. Contoh error codes pada <i>Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Episode Type</i>	312
Gambar C.15. Contoh <i>Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Episode Type</i> yang benar	312
Gambar C.16. Contoh error codes pada <i>Error: Stent Insertion wo/ Number of Stent or Number of Vessels</i>	314
Gambar C.17. Contoh <i>Error: Stent Insertion wo/ Number of Stent or Number of Vessels</i> yang benar	314
Gambar C.18. Contoh <i>Error: Stent Insertion wo/ Number of Stent or Number of Vessels</i> yang benar	315
Gambar C.19. Contoh error codes pada <i>Error blood transfusion for neoplasm without anemia</i>	316

Gambar C.20. Contoh <i>Error blood transfusion for neoplasm without anemia</i> yang benar.....	316
Gambar C.21. Contoh error codes pada <i>Ungroupable: Radiotherapy Session w/o Radiotherapy Proc</i>	317
Gambar C.22. Contoh <i>Ungroupable: Radiotherapy Session w/o Radiotherapy Proc</i> yang benar.....	317
Gambar C.23. Contoh error codes pada <i>Ungroupable: Radiotherapy w/o Z51.0</i>	317
Gambar C.24. Contoh error codes pada <i>Ungroupable: Chemotherapy Proc. without Z51.1</i>	318
Gambar C.25. Contoh <i>Ungroupable: Chemotherapy Proc. without Z51.1</i> yang benar	318
Gambar C.26. Contoh error codes pada <i>Ungroupable: Rehabilitation without Procedures</i>	321
Gambar C.27. Contoh <i>Ungroupable: Rehabilitation without Procedures</i> yang benar	321

DAFTAR TABEL

Tabel A.1. Daftar <i>Major Diagnostic Categories</i> (MDC)	34
Tabel A.2. Deskripsi Jenis <i>Treatment Partition</i>	35
Tabel A.3. Deskripsi Jenis Layanan yang diterima (PTD)	35
Tabel A.4. Deskripsi Pengelompokkan <i>Complexity Level</i> (CL)	36
Tabel B.1. Contoh Kasus Penetapan Diagnosis Utama	37
Tabel B.2. Contoh Kasus Penetapan Diagnosis Utama	39
Tabel B.3. Contoh Kasus Penentuan Kode Diagnosis Utama	40
Tabel B.4. Contoh Kasus Penentuan Kode Diagnosis Utama	40
Tabel B.5. Contoh Kasus Penentuan Diagnosis Komplikasi	42
Tabel B.6. Contoh Kasus Penentuan Diagnosis Komplikasi	43
Tabel B.7. Contoh Kasus Diagnosis Penyebab Eksternal untuk Cedera Kronis	45
Tabel B.8. Contoh prinsip pengodean diagnosis	69
Tabel C.1. Contoh Penerapan Kode Lateralisasi untuk Diagnosis	76
Tabel C.2. Contoh kasus <i>multi speciality consultation</i> dan <i>pre op</i>	79
Tabel C.3. Contoh kasus <i>multi speciality consultation</i> dan <i>pre op</i>	80
Tabel C.4. Contoh kasus untuk epilepsi umum	85
Tabel C.5. Contoh kasus untuk epilepsi fokal	86
Tabel C.6. Contoh kasus untuk <i>epidural haemorrhage</i>	86
Tabel C.7. Contoh kasus <i>sleep apnoea and snoring</i>	88
Tabel C.8. Contoh kasus <i>cranial nerve disorders</i>	88
Tabel C.9. Contoh kasus <i>cranial nerve disorders</i>	88
Tabel C.10. Contoh kasus <i>myopathy</i>	89
Tabel C.11. Contoh kasus sindrom paralitik	91
Tabel C.12. Contoh kasus sindrom paralitik	91
Tabel C.13. Contoh kasus <i>pinguecula</i> dan <i>pterygium</i>	95
Tabel C.14. Contoh kasus <i>pinguecula</i> dan <i>pterygium</i>	95
Tabel C.15. Contoh kasus <i>retinal procedures</i>	98
Tabel C.16. Catatan operasi dokter pada <i>resume medis</i> pada kasus <i>retinal procedures</i> beserta kode bedah	98
Tabel C.17. Catatan operasi dokter pada <i>resume medis</i> pada kasus <i>cataract</i> beserta kode bedah	98
Tabel C.18. Contoh kasus <i>aphakia</i>	99

Tabel C.19. Contoh kasus <i>visual impairment</i>	100
Tabel C.20. Contoh kasus <i>visual impairment</i>	100
Tabel C.21. Contoh kasus <i>visual impairment</i>	101
Tabel C.22. Contoh kasus kontrol <i>post vitrectomy</i>	102
Tabel C.23. Contoh kasus <i>Pulpitis</i>	104
Tabel C.24. Contoh kasus <i>otitis externa</i>	104
Tabel C.25. Contoh kasus <i>cholesteatoma</i>	105
Tabel C.26. Contoh kasus <i>perforation of tympanic membrane</i>	106
Tabel C.27. Contoh kasus <i>vertigo</i>	106
Tabel C.28. Contoh kasus <i>hearing loss</i>	107
Tabel C.29. Contoh kasus <i>hearing loss</i>	108
Tabel C.30. Subkategori sesuai diagnosa dokter yang spesifik pada kasus <i>dental caries</i> beserta kode ICD-10.....	108
Tabel C.31. Subkategori sesuai diagnosa dokter yang spesifik pada kasus <i>dental caries</i> beserta kode ICD-10.....	109
Tabel C.32. Klasifikasi lokasi infeksi beserta kode spesifik.....	110
Tabel C.33. Contoh kasus <i>tonsillectomy</i>	112
Tabel C.34. Kode ICD dan DC khusus yang berhubungan pada MDC 15	138
Tabel C.35. Contoh kasus <i>disorder of arteries and arterioles</i>	140
Tabel C.36. Contoh kasus <i>erythema multiforme</i>	174
Tabel C.37. Contoh kasus <i>erythema multiforme</i>	174
Tabel C.38. Contoh kasus <i>radical excision of skin lesion</i>	179
Tabel C.39. Contoh kasus <i>unilateral radical mastectomy</i>	180
Tabel C.40. Contoh kasus <i>renal tubulo-interstitial disorders</i>	191
Tabel C.41. Contoh kasus <i>chronic kidney disease</i>	192
Tabel C.42. Contoh kasus lupus nefritis.....	192
Tabel C.43. Kode diagnosis untuk peradangan dan infeksi pada organ daerah panggul wanita.....	197
Tabel C.44. Contoh kasus <i>tuberculous infection of cervix uteri</i>	197
Tabel C.45. Contoh kasus <i>acute pelvic inflammatory disease</i>	198
Tabel C.46. Contoh kasus <i>disease of bartholin's gland</i>	199
Tabel C.47. Contoh kasus <i>disease of bartholin's gland</i>	199
Tabel C.48. Contoh kasus <i>disease of bartholin's gland</i>	199

Tabel C.49. Contoh kasus <i>leukorrhea</i>	202
Tabel C.50. Contoh kasus <i>postcoital bleeding</i>	203
Tabel C.51. Contoh kasus <i>postcoital and contact bleeding</i>	204
Tabel C.52. Contoh kasus <i>tubal pregnancy</i>	208
Tabel C.53. Contoh kasus <i>abortion</i>	209
Tabel C.54. Contoh kasus <i>abortion</i>	209
Tabel C.55. Contoh kasus <i>abortion</i>	209
Tabel C.56. Contoh kasus <i>abortion</i>	210
Tabel C.57. Contoh kasus <i>abortion</i>	210
Tabel C.58. Contoh kasus <i>abortion</i>	211
Tabel C.59. Contoh kasus <i>abortion</i>	211
Tabel C.60. Contoh kasus <i>abortion</i>	212
Tabel C.61. Contoh kasus <i>infection in pregnancy</i>	214
Tabel C.62. Contoh kasus <i>infection in pregnancy</i>	214
Tabel C.63. Contoh kasus <i>infection in pregnancy</i>	215
Tabel C.64. Contoh kasus <i>infection in pregnancy</i>	215
Tabel C.65. Contoh kasus <i>infection in pregnancy</i>	215
Tabel C.66. Contoh kasus <i>maternal care for known or susp malpresentation of fetus</i>	216
Tabel C.67. Contoh kasus <i>maternal care for known or susp malpresentation of fetus</i>	217
Tabel C.68. Contoh kasus <i>maternal care for known or suspected disproportion</i>	218
Tabel C.69. Contoh kasus <i>maternal care for known or suspected disproportion</i>	218
Tabel C.70. Contoh kasus <i>maternal care for known or suspected disproportion</i>	219
Tabel C.71. Contoh kasus <i>maternal care for known or suspected disproportion</i>	219
Tabel C.72. Contoh kasus <i>maternal care for tumour of corpus uteri</i>	220
Tabel C.73. Contoh kasus <i>maternal care for tumour of corpus uteri</i>	220
Tabel C.74. Contoh kasus <i>maternal care for other abnormalities of cervix</i>	221
Tabel C.75. Contoh kasus <i>Preterm Labour and Delivery</i>	223
Tabel C.76. Contoh kasus <i>Preterm Labour and Delivery</i>	223

Tabel C.77. Contoh kasus <i>Preterm Labour and Delivery</i>	223
Tabel C.78. Contoh kasus <i>Preterm Labour and Delivery</i>	224
Tabel C.79. Contoh kasus <i>Labour and delivery complicated by fetal stress [distress]</i>	225
Tabel C.80. Contoh kasus <i>Delivery</i>	226
Tabel C.81. Contoh kasus <i>Delivery</i>	227
Tabel C.82. Contoh kasus <i>Delivery</i>	227
Tabel C.83. Contoh kasus <i>Caesarean section</i>	228
Tabel C.84. Contoh kasus <i>Caesarean section</i>	229
Tabel C.85. Contoh kasus <i>Maternal Diseases Classifiable Elsewhere but Complicating Pregnancy, Childbirth and The Puerperium</i>	230
Tabel C.86. Contoh kasus <i>Maternal Diseases Classifiable Elsewhere but Complicating Pregnancy, Childbirth and The Puerperium</i>	231
Tabel C.87. Contoh kasus <i>Maternal Diseases Classifiable Elsewhere but Complicating Pregnancy, Childbirth and The Puerperium</i>	231
Tabel C.88. Contoh kasus <i>Maternal Diseases Classifiable Elsewhere but Complicating Pregnancy, Childbirth and The Puerperium</i>	232
Tabel C.89. Contoh kasus <i>Neonatus</i>	247
Tabel C.90. Contoh kasus <i>Neonatus</i>	247
Tabel C.91. Contoh kasus <i>Fetus and Newborn Affected by Maternal Factors and by Complications of Pregnancy, Labour and Delivery</i>	248
Tabel C.92. Contoh kasus <i>Disorders Related to Short Gestation and Low Birth Weight, Not Elsewhere Classified</i>	249
Tabel C.93. Contoh kasus <i>Disorders Related to Short Gestation and Low Birth Weight, Not Elsewhere Classified</i>	249
Tabel C.94. Contoh kasus <i>Birth Asphyxia</i>	250
Tabel C.95. Contoh kasus <i>Transitory disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus and newborn</i>	251
Tabel C.96. Contoh kasus Penjelasan Khusus Kode ICD dalam Kategori MDC 26	252
Tabel C.97. Contoh kasus <i>Stem Cell / Bone Marrow Harvesting and Transplantation</i>	253
Tabel C.98. Contoh kasus <i>Stem Cell / Bone Marrow Harvesting and Transplantation</i>	253

Tabel C.99. Contoh kasus <i>Stem Cell / Bone Marrow Harvesting and Transplantation</i>	253
Tabel C.100. Contoh kasus <i>Stem Cell / Bone Marrow Harvesting and Transplantation</i>	254
Tabel C.101. Contoh kasus <i>Coagulation Disorders</i>	256
Tabel C.102. Contoh kasus <i>Sepsis</i>	263
Tabel C.103. Contoh kasus <i>Sepsis</i>	264
Tabel C.104. Contoh kasus <i>Sepsis</i>	265
Tabel C.105. Contoh kasus <i>Human Immunodeficiency Virus [HIV] Disease</i>	267
Tabel C.106. Contoh kasus <i>Human Immunodeficiency Virus [HIV] Disease</i>	267
Tabel C.107. Contoh kasus <i>Human Immunodeficiency Virus [HIV] Disease</i>	268
Tabel C.108. Contoh kasus <i>Human Immunodeficiency Virus [HIV] Disease</i>	268
Tabel C.109. Contoh kasus <i>Dementia in Alzheimer's Disease</i>	272
Tabel C.110. Contoh kasus <i>Delirium, Not Induced by Alcohol and Other Psychoactive Substances</i>	272
Tabel C.111. Contoh kasus <i>Other Mental Disorders due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disease</i>	273
Tabel C.112. Contoh kasus <i>Skizofrenia</i>	273
Tabel C.113. Contoh kasus <i>Acute and transient psychotic disorders</i>	274
Tabel C.114. Contoh kasus <i>Schizoaffective disorders</i>	274
Tabel C.115. Contoh kasus <i>Bipolar affective disorder</i>	274
Tabel C.116. Contoh kasus <i>Somatoform Disorders</i>	275
Tabel C.117. Contoh kasus <i>Specific Personality Disorders</i>	276
Tabel C.118. Contoh kasus <i>Other behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence</i>	278
Tabel C.119. Contoh kasus <i>Follow-Up Examination After Treatment</i>	281
Tabel C.120. Contoh kasus <i>Follow-Up Examination After Treatment</i>	281
Tabel C.121. Contoh kasus <i>Persons Encountering Health Services For Specific Procedures, Not Carried Out</i>	285
Tabel C.122. Contoh kasus <i>Persons Encountering Health Services For Specific Procedures, Not Carried Out</i>	286
Tabel C.123. Contoh kasus Penjelasan Khusus Kode ICD dalam Kategori MDC 31.....	292

Tabel C.124. Contoh kasus Penjelasan Khusus Kode ICD dalam Kategori MDC 31.....	293
Tabel C.125. Contoh kasus Penjelasan Khusus Kode ICD dalam Kategori MDC 31.....	293
Tabel C.126. Contoh kasus Penjelasan Khusus Kode ICD dalam Kategori MDC 31.....	294
Tabel C.127. Contoh kasus <i>Burns And Corrosions Of External Body Surface, Specified By Site</i>	296
Tabel C.128. Contoh kasus <i>Poisoning By Drugs, Medicaments And Biological Substances</i>	298
Tabel C.129. Contoh kasus <i>Mechanical Complication of Internal Fixation Device of Bones</i>	299
Tabel C.130. Contoh kasus Prosedur Terapi Kanker.....	301
Tabel C.131. Contoh kasus Prosedur Terapi Kanker.....	302
Tabel C.132. Contoh kasus Prosedur Terapi Kanker.....	302
Tabel C.133. Contoh kasus Komplikasi Terkait dengan Keganasan.....	303
Tabel C.134. Kode Morfologi Neoplasma	303
Tabel C.135. Contoh kasus Terapi Rehabilitasi	308

DAFTAR SINGKATAN

ACL	: <i>Anterior Cruciate Ligament</i>
AFS	: <i>Allergic Fungal Sinusitis</i>
AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
AKI	: <i>Acute Kidney Injury</i>
AML	: <i>Acute Myeloid Leukemia</i>
APMPPE	: <i>Acute Posterior Multifocal Placoid Pigment Epitheliopathy</i>
AR-DRG	: <i>Australian Refined Diagnosis Related Group</i>
ARPE	: <i>Acute Retinal Pigment Epitheliitis</i>
AUB	: <i>Abnormal Uterine Bleeding</i>
AZOOR	: <i>Acute Zonal Occult Outer Retinopathy</i>
BMHP	: <i>Bahan Medis Habis Pakai</i>
BMP	: <i>Bone Morphogenetic Protein</i>
BMV	: <i>Balloon Mitral Valvuloplasty</i>
BPH	: <i>Benign Prostatic Hypertrophy/hyperplasia</i>
BPJS	: <i>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</i>
CABG	: <i>Coronary Artery Bypass Grafting</i>
CAPD	: <i>Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis</i>
CART	: <i>Classification and Regression Trees</i>
CC	: <i>Complexity and Comorbidity</i>
CDE	: <i>Common bile duct Exploration</i>
CIDP	: <i>Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy</i>
CKD	: <i>Chronic Kidney Disease</i>

CL	: <i>Complexity Level</i>
COPD	: <i>Chronic Obstructive Pulmonary Disease</i>
CPR	: <i>Cardiopulmonary Resuscitation</i>
CT Scan	: <i>Computed Tomography Scan</i>
CVI	: <i>Chronic Venous Insufficiency</i>
CVP	: <i>Central Venous Pressure</i>
CWL	: <i>Caldwell-Luc</i>
DIBH	: <i>Deep Inspiration Breath Hold</i>
DIC	: <i>Disseminated Intravascular Coagulation</i>
DC	: <i>Disease Cluster</i>
DM	: <i>Diabetes Mellitus</i>
DPJP	: <i>Dokter Penanggung Jawab Pasien</i>
DUB	: <i>Dysfunctional Uterine Bleeding</i>
DVT	: <i>Deep Vein Thrombosis</i>
EBRT	: <i>External Beam Radiotherapy</i>
ECT	: <i>Electroconvulsive Therapy</i>
ECCE	: <i>Extracapsular Cataract Extraction</i>
EGD	: <i>Esophagogastroduodenoscopy</i>
EPS	: <i>Invasive Electrophysiologic Testing</i>
ERC	: <i>Endoscopic retrograde cholangiography</i>
ERCP	: <i>Endoscopic retrograde cholangiopancreatography</i>
ESBL	: <i>Extended Spectrum Beta-Lactamase</i>
ESS	: <i>Endoscopic Sinus Surgery</i>

ESWL	: <i>Extracorporeal Shockwave Lithotripsy</i>
FFR	: <i>Fractional Flow Reserve</i>
FKRTL	: Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FPKTL	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut
GHRH	: <i>Growth Hormone-Releasing Hormone</i>
HAP	: <i>Hospital-Acquired Pneumonia</i>
HDL	: <i>High-Density Lipoprotein</i>
HIE	: <i>Hypoxic Ischaemic Encephalopathy</i>
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HNP	: <i>Hernia Nukleus Pulposus</i>
ICCE	: <i>Intracapsular Cataract Extraction</i>
ICD-10	: <i>International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems, Tenth Revision</i>
ICD-9-CM	: <i>International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem, Ninth Revision, Clinical Modification</i>
iDRG	: <i>Indonesian Diagnosis Related Group</i>
IM	: <i>Indonesian Modification</i>
IMRT	: <i>Intensity-Modulated Radiotherapy</i>
IPPB	: <i>Intermittent Positive Pressure Breathing</i>
IUD	: <i>Intrauterine Device</i>
IUGR	: <i>Intrauterine Fetal Growth Restriction/Retardation</i>
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KB	: Keluarga Berencana

LBP	: <i>Low Back Pain</i>
LOA	: <i>Left Occipito-Anterior</i>
LOP	: <i>Left Occipito-Posterior</i>
MCP	: <i>Multifocal Choroiditis With Panuveitis</i>
MDC	: <i>Major Diagnostic Category</i>
MEWDS	: <i>Multiple Evanescent White Dots Syndrome</i>
MRI	: <i>Magnetic Resonance Imaging</i>
MSS	: <i>Microscopic Sinus Surgery</i>
NARES	: <i>Non-Allergic Rhinitis with Eosinophilia Syndrome</i>
NSTEMI	: <i>Non-ST-Elevated Myocardial Infarction</i>
OMSK	: <i>Otitis Media Supuratif Kronis</i>
ORIF	: <i>Open Reduction Internal Fixation</i>
OS	: <i>Oculus Sinister</i>
PA	: <i>Patologi Anatomi</i>
PCCL	: <i>Patient Clinical Complexity Level</i>
PCI	: <i>Percutaneous Coronary Intervention</i>
PCL	: <i>Posterior Cruciate Ligament</i>
PCOS	: <i>Polycystic Ovary Syndrome</i>
PCR	: <i>Polymerase Chain Reaction</i>
PE	: <i>Phacoemulsification</i>
PET CT	: <i>Positron Emission Tomography-Computed Tomography</i>
PIC	: <i>Punctate Inner Choroidopathy</i>
PID	: <i>Pelvic Inflammatory Disease</i>
PPL	: <i>Pars Plana Lensectomy</i>

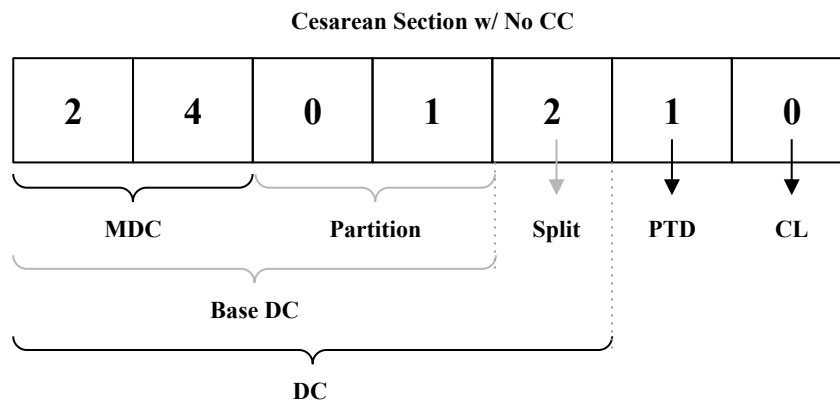
PPOK	: Penyakit Paru Obstruktif Kronis
PPV	: <i>Pars plana vitrectomy</i>
PRC	: <i>Packed Red Cells</i>
PTCA	: <i>Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty</i>
PTD	: <i>Patient Type Designation</i>
ROA	: <i>Right Occipito-Anterior</i>
ROP	: <i>Right Occipito-Posterior</i>
ROSC	: <i>Return of Spontaneous Circulation</i>
SC	: <i>Sectio Caesarean</i>
SIRS	: <i>Systemic Inflammatory Response Syndrome</i>
SLE	: <i>Systemic Lupus Erythematosus</i>
SPECT CT	: <i>Single Photon Emission Computed Tomography-Computed Tomography</i>
STEMI	: <i>ST-Elevated Myocardial Infarction</i>
TACE	: <i>Transarterial Chemoembolization</i>
TB	: <i>Tuberculosis</i>
TDC	: <i>Tunneled Dialysis Catheter</i>
TEE	: <i>Transesophageal Echocardiography</i>
THT	: Telinga Hidung dan Tenggorokan
TIA	: <i>Transient Ischemic Attack</i>
TKR	: <i>Total Knee Replacement</i>
TL	: <i>Tubal Ligation</i>
TMS	: <i>Transcranial Magnetic Stimulation</i>
TR	: <i>Tubal Resection</i>
TURED	: <i>Transurethral Resection of Ejaculatory Duct</i>
UFR	: <i>Uroflowmetry</i>
UPP	: <i>Urethral pressure profile</i>

USG	: <i>Ultrasonography</i>
VA	: <i>Visual Acuity</i>
VAP	: <i>Ventilator-Associated pneumonia</i>
WDS	: <i>White Dots Syndrome</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

GLOSARIUM

A. INDONESIAN DIAGNOSIS RELATED GROUP (iDRG)

Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG) adalah suatu sistem pengelompokkan kasus berdasarkan kesamaan klinis (diagnosis, pengobatan dan/atau prosedur) atau kemiripan penggunaan sumber daya. Dalam sistem terbaru, kode iDRG terdiri dari 7 digit kode yang mencakup *Major Diagnostic Category (MDC)*, *Disease Cluster (DC)*, *Patient Type Designation (PTD)* dan *Complexity Level (CL)*.



Gambar A.1. Penulisan kode iDRG

Keterangan:

1. Digit ke-1 dan 2 menunjukkan kode MDC (*Major Diagnostic Category*)
2. Digit ke-3 dan 4 menunjukkan kode *Treatment Partition*
3. Digit ke-5 menunjukkan kode *Split*
4. Digit ke-6 menunjukkan PTD (*Patient Type Designation*)
5. Digit ke-7 menunjukkan CL (*Complexity Level*)
6. MDC + *Partition* menunjukkan kode Base DC (*Disease Cluster*)
7. MDC + *Partition* + *Split* menunjukkan kode DC (*Disease Cluster*)

1. Struktur Kode iDRG

a. *Major Diagnostic Category (MDC)*

MDC merupakan pengkategorian diagnosis yang dilakukan berdasarkan sistem organ atau etiologi penyakit yang umumnya dikaitkan dengan spesialisasi tertentu yang biasanya menjadi penyebab utama perawatan. MDC merupakan 2 digit pertama dalam susunan kode iDRG dan berjumlah sebanyak 28 MDC (27 *groupable* dan 1 MDC *ungroupable*) yang dideskripsikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel A.1. Daftar *Major Diagnostic Categories* (MDC)

Kode	Deskripsi
10	<i>Pre MDC*</i>
11	<i>Diseases and Disorders of the Nervous System</i>
12	<i>Diseases and Disorders of the Eye</i>
13	<i>Diseases and Disorders of the Ear, Mouth and Throat</i>
14	<i>Diseases and Disorders of the Respiratory System</i>
15	<i>Diseases and Disorders of the Circulatory System</i>
16	<i>Diseases and Disorders of the Digestive System</i>
17	<i>Diseases and Disorders of the Hepatobiliary System and Pancreas</i>
18	<i>Diseases and Disorders of the Musculoskeletal System and Connective Tissue</i>
19	<i>Diseases and Disorders of the Skin, Subcutaneous Tissue and Breast</i>
20	<i>Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases and Disorders</i>
21	<i>Diseases and Disorders of the the Kidney and Urinary Tract</i>
22	<i>Diseases and Disorders of the Male Reproductive System</i>
23	<i>Diseases and Disorders of the Female Reproductive System</i>
24	<i>Pregnancy, Childbirth and Puerperium</i>
25	<i>Newborns and Other Neonates with Conditions Originating in the Perinatal Period</i>
26	<i>Diseases and Disorders of the Blood and Blood Forming Organs and Immunological Disorders</i>
27	<i>Myeloproliferative Diseases and Disorders, Poorly Differentiated Neoplasms</i>
28	<i>Infectious and Parasitic Diseases</i>
29	<i>Mental Diseases and Disorders</i>
30	<i>Factors Influencing Health Status and Other Contacts with Health Services</i>
31	<i>Multiple Significant Trauma</i>
32	<i>Burns</i>
33	<i>Injuries, Poisonings and Toxic Effects of Drugs</i>
34	<i>Neoplasms</i>
35	<i>Rehabilitation</i>
36	<i>Ungroupable or Unrelated</i>
90	<i>Diagnostic Procedures</i>

**Pre-MDC* adalah kasus-kasus yang memiliki tingkat spesialisasi tinggi dan memerlukan biaya besar

b. *Disease Cluster (DC)*

DC merupakan 5 digit pertama dalam kode iDRG yang terdiri atas 2 digit pertama (MDC), digit ke-3 dan ke-4 (*treatment partition*), dan digit ke-5 (*split*). MDC dan *treatment partition* sendiri telah membentuk kode DC dasar/*Base DC*. DC merupakan pengelompokan kluster penyakit yang berdasarkan diagnosis atau pengobatan atau prosedur yang diterima, usia, jenis kelamin, cara pulang, lama hari perawatan, dan lain-lain. *Split* merupakan kode 1 – 9 yang menggambarkan perbedaan diagnosis/prosedur, usia, jenis kelamin, cara pulang, lama hari perawatan, dll. Sedangkan *treatment partition* merupakan suatu pembagian perawatan dengan mengkategorikannya menjadi sub kelompok berdasarkan jenis perawatan yang diterima seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel A.2. Deskripsi Jenis *Treatment Partition*

Kode	Deskripsi
01 – 40	<i>Surgical</i>
41 – 60	<i>Non Surgical</i>
61 – 99	<i>Medical</i>

c. *Patient Type Designation (PTD)*

PTD merupakan digit ke-6 dalam kode iDRG yang mengacu pada pengelompokan kasus berdasarkan jenis layanan yang diterima oleh pasien di Rumah Sakit, yaitu rawat inap atau rawat jalan.

Tabel A.3. Deskripsi Jenis Layanan yang diterima (PTD)

Kode	Deskripsi
1	Rawat Inap
2	Rawat Jalan

d. *Complexity Level (CL)*

CL merupakan digit terakhir pada kode iDRG yang merepresentasikan jenis kasus berdasarkan ada tidaknya *complexity* dan *comorbidity* (CC) yang dipengaruhi oleh diagnosis sekunder dan dihitung menggunakan indeks *Patient Clinical Complexity Level* (PCCL). CC dapat merujuk tingkatan komplikasi atau kompleksitas kasus atau komorbiditas penyakit lainnya yang muncul bersamaan dengan diagnosis utama sehingga meningkatkan sumber daya dalam melakukan penatalaksanaan (Tabel A.4). Oleh karena itu, CL menggambarkan kemiripan penggunaan sumber daya dalam melayani pasien.

Pengelompokan CL dilakukan dengan metode *Classification and Regression Trees* (CART) memiliki peran fundamental dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem *Diagnosis-Related Groups* (DRG), termasuk Thai DRG dan AR-DRG (*Australian Refined DRG*). Sistem DRG bertujuan mengelompokkan pasien

ke dalam kategori-kategori yang memiliki kemiripan klinis dan keseragaman biaya perawatan. CART merupakan metode statistik yang bekerja layaknya pohon keputusan, di mana data pasien dipilah secara bertahap berdasarkan variabel-variabel seperti diagnosis utama, tindakan prosedur, usia, dan kondisi penyakit penyerta. Proses pemilahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling signifikan dalam menjelaskan perbedaan biaya antar pasien. Dengan kemampuannya menyeimbangkan dua aspek penting, yaitu membentuk kelompok yang homogen dari sisi biaya sekaligus mempertahankan koherensi klinis, CART menjadi alat yang ideal dalam menyusun kelompok DRG yang akurat dan mencerminkan kompleksitas kasus yang ditangani.

Tabel A.4. Deskripsi Pengelompokkan *Complexity Level* (CL)

Kode	Deskripsi
0	<i>No CC</i>
1	<i>Mild CC</i>
2	<i>Moderate CC</i>
3	<i>Severe CC</i>
4	<i>Catastrophic CC</i>
9	<i>Merge CC (without CL)</i>

Dengan demikian, penentuan kode iDRG yang tepat sangat bergantung pada pengodean diagnosis atau pengobatan dan/atau prosedur yang dilakukan oleh pemberi kode, berdasarkan dokumentasi medis yang lengkap dan akurat yang telah disusun oleh dokter di dalam rekam medis pasien.

B. KETENTUAN UMUM KODING iDRG

1. Ketentuan Umum Pengkodean (*Coding*) iDRG

Koding adalah kegiatan pemberian kode untuk diagnosis utama dan sekunder sesuai dengan ICD-10 Versi Tahun 2010 yang diterbitkan oleh WHO dan pemberian kode tindakan atau prosedur berdasarkan ICD-9-CM Versi Tahun 2010 dengan *Indonesian Modification* (IM). Dalam pedoman ini, kedua ICD tersebut akan disingkat menjadi ICD-10-IM dan ICD-9-IM untuk penulisan selanjutnya. Koding merupakan elemen penting dalam sistem pembiayaan prospektif dimana koding menjadi salah satu penentu besaran biaya yang dibayarkan kepada FKRTL. Sistem pengkodean yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengklasifikasikan dan mencatat data terkait penyakit atau kematian adalah koding morbiditas atau koding mortalitas. Dalam aturan dan pedoman koding yang digunakan dalam iDRG ini mengacu pada aturan koding morbiditas.

Koding morbiditas pada iDRG adalah proses pemberian kode diagnosis penyakit berdasarkan diagnosis yang sudah ditetapkan dokter. Semua penyakit yang terdiagnosis wajib dikodekan oleh pemberi kode sesuai dengan bukti penegakkan dan tatalaksana tanpa melihat status keluar pasien hidup atau meninggal serta sesuai dengan kaidah pengodean yang diatur dalam ICD 10 2010 dengan *Indonesian Modification* (IM). Sedangkan koding mortalitas digunakan untuk menentukan penyebab kematian (*cause of death*) sehingga tidak digunakan dalam pengodean iDRG.

Sumber data untuk pengodean iDRG berasal dari data diagnosis dan tindakan/prosedur yang terdokumentasi dalam rekam medis dan terangkum dalam *resume* medis. Ketepatan koding diagnosis dan tindakan/prosedur sangat berpengaruh terhadap hasil pengelompokan (*grouper*) dalam aplikasi iDRG.

Beberapa diagnosis memerlukan dua kode sesuai sistem klasifikasi ganda (*dual classification* atau *dagger-asterisk system*), kaidah koding dalam iDRG selalu gunakan kode *dagger* sebagai diagnosis utama dan *asterisk* sebagai diagnosis sekunder. Meskipun kedua posisi tersebut sama-sama tergolong sekunder, posisi *dagger* tetap menjadi yang pertama dikodekan dan *asterisk* setelahnya. Dengan kata lain, prioritas pengodean diberikan kepada *dagger*, bukan pada *asterisk*.

Tabel B.1. Contoh Kasus Penetapan Diagnosis Utama

Contoh 1	Pasien perempuan berusia 34 tahun menjalani perawatan untuk terapi kanker lidah. Pasien memiliki diagnosis <i>malignant neoplasm of tongue</i> dan mendapatkan tindakan kemoterapi injeksi serta transfusi darah karena anemia akibat penyakit neoplastik.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode

Diagnosis Utama	Kemoterapi	Z51.1 <i>Chemotherapy session for neoplasm</i>
Diagnosis Sekunder	Ca lidah + anemia	C02.9 <i>Malignant neoplasm of tongue, unspecified</i> D63.0* <i>Anaemia in neoplastic disease</i>
Prosedur	Kemo + Transfusi	99.25 <i>Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance</i> 99.04 <i>Transfusion of packed cells</i>

a. Diagnosis Utama

Diagnosis utama adalah diagnosis yang ditegakkan oleh dokter pada akhir episode perawatan yang menyebabkan pasien mendapatkan perawatan atau pemeriksaan lebih lanjut. Jika terdapat lebih dari satu diagnosis, maka diagnosis yang menggunakan sumber daya paling banyak akan dipilih sebagai diagnosis utama. Jika tidak terdapat diagnosis yang ditegakkan pada akhir episode perawatan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku, maka gejala utama, hasil pemeriksaan penunjang yang tidak normal, atau masalah lainnya ditetapkan menjadi diagnosis utama.

1) Elemen-elemen penting diagnosis utama

Penentuan Diagnosis Utama

Dokter harus menetapkan satu diagnosis tunggal sebagai diagnosis utama, meskipun pasien memiliki beberapa diagnosis selama masa perawatan. Berikut ini adalah elemen penting dalam penentuan diagnosis utama:

Ditetapkan Setelah Perawatan Selesai

Diagnosis utama ditentukan setelah perawatan berakhir, berdasarkan diagnosis akhir yang dicatat dengan jelas, lengkap dan spesifik dalam rekam medis pasien.

Kondisi yang Menjadi Sebab Utama Pasien Dirawat

Diagnosis utama harus merujuk pada kondisi atau keluhan yang menyebabkan pasien mendapatkan perawatan atau pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit bukan penyakit yang muncul selama perawatan.

Contoh 1: Pasien datang dengan diare dehidrasi berat dan ditegakkan diagnosa oleh dokter diare Amoeba dengan dehidrasi berat, ditengah perawatan terjadi infeksi plebitis pada tangan, maka plebitis tidak boleh dijadikan diagnosa utama.

Prioritas Penyakit yang Dirawat

Jika pasien memiliki diagnosis lebih dari satu, maka dipilih diagnosis yang menjadi fokus utama perawatan. Jika perawatan ditujukan untuk beberapa diagnosis yang menjadi fokus utama perawatan, maka utamakan untuk memilih diagnosis paling parah atau mengancam jiwa yang membutuhkan sumber daya terbesar.

Jika diagnosis belum dapat ditegakkan sampai akhir episode perawatan

Jika diagnosis belum dapat ditegakkan sampai akhir episode perawatan misalnya pasien pulih/ meninggal/ dirujuk tanpa diagnosis yang dapat ditegakkan setelah dilakukan tatalaksana medis, maka yang dicatat adalah:

Gejala utama, contoh: “nyeri perut tanpa penyebab jelas”

Tanda klinis, contoh: “demam tinggi berkepanjangan”

Tabel B.2. Contoh Kasus Penetapan Diagnosis Utama

Contoh 2	Pasien menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan hiperkolesterolemia, telah menjalani perawatan rutin dan berkelanjutan. Kali ini, pasien datang dengan gejala nyeri kepala yang berat. Dokter menemukan tekanan darah 200/140 mmHg. Pasien dirawat di rumah sakit dan dokter mendiagnosis <i>Malignant Hypertension</i> .	
	Penulisan Diagnosis yang salah	Penulisan Diagnosis yang benar
Diagnosis Utama	HT + DM + hiperkolesterolemia	<i>Malignant Hypertension</i>
Diagnosis Sekunder	-	<i>Diabetes mellitus type 2</i> <i>Hypercholesterolemia</i>

Penentuan Kode Diagnosis Utama

Saat menentukan kode diagnosis utama, cari kode yang sesuai dengan diagnosis utama yang telah ditulis oleh dokter pada *Resume Medis* (ringkasan pulang) menggunakan ICD-10-IM. Jika diagnosis utama yang telah ditulis oleh dokter tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya mencantumkan lebih dari satu diagnosis utama atau mencantumkan diagnosis sekunder di kolom diagnosis utama, maka pemberi kode harus melakukan konfirmasi langsung dengan dokter.

Jika diagnosis utama tidak didokumentasikan secara spesifik atau tidak mencerminkan karakteristik pasien, pemberi kode mempertimbangkan data spesifik pasien seperti jenis kelamin, usia, status kehamilan, persalinan, atau pasca persalinan untuk memperjelas kode. Contoh: Jika diagnosis utama adalah “hipertensi” pada ibu hamil, gunakan kode O10.- *Pre-existing hypertension complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*.

Beberapa diagnosis memerlukan dua kode sesuai sistem klasifikasi ganda (*dual classification* atau *dagger-asterisk system*).

Contoh 2: Jika diagnosis utama adalah *cryptococcal meningitis*:

Kode dengan tanda † (*dagger*): B45.1† (*Cerebral cryptococcosis*) sebagai diagnosis utama.

Kode dengan tanda * (*asterisk*): G02.1* (*Meningitis in mycoses*) sebagai diagnosis tambahan.

Pemberi kode tidak memiliki kewenangan untuk mengubah diagnosis yang telah ditetapkan oleh dokter dalam kondisi apapun. Apabila diagnosis belum dapat

ditegakan secara spesifik oleh dokter, maka dapat menggunakan kode gejala utama, misalnya untuk “*Other and unspecified abdominal pain*” dapat menggunakan kode R10.4 atau kode yang tidak spesifik lainnya apabila jenis penyakit belum dapat dirinci lebih lanjut, misalnya kode E14.9 untuk “*Unspecified diabetes mellitus*”.

Untuk jenis pasien tertentu seperti ibu hamil/pasca persalinan, bayi baru lahir, pasien HIV/AIDS atau kanker, maka metode pengodean diagnosis utama mungkin dapat dilakukan secara berbeda. Dalam hal ini, pemberi kode harus mengikuti aturan khusus yang tercantum pada pedoman ini.

Tabel B.3. Contoh Kasus Penentuan Kode Diagnosis Utama

Contoh 3	Dokter mencatat diagnosis utama sebagai <i>laceration wound</i> (luka robek) tanpa menyebutkan lokasi yang spesifik. Jika pemberi kode tidak mencari informasi dari hasil pemeriksaan fisik yang mencatat bahwa pasien memiliki luka robek di punggung bagian bawah, hal ini dapat menghasilkan kode diagnosis yang kurang spesifik. Pemberi kode wajib meminta dokter untuk meninjau ulang diagnosis tersebut agar lebih detail dengan mencantumkan lokasi/regio luka tersebut	
Diagnosis	Luka laserasi	
Kode yang salah	T14.1	<i>Open wound of unspecified body region</i>
Kode yang benar	S31.0	<i>Open wound of lower back and pelvis</i>

Tabel B.4. Contoh Kasus Penentuan Kode Diagnosis Utama

Contoh 4	Pasien perempuan hamil 30 minggu datang untuk perawatan karena mengalami <i>thrombosed internal haemorrhoids</i> . Dokter mencatat penyakit tersebut sebagai diagnosis utama, tetapi tidak memperhatikan bahwa kondisi pasien sedang hamil, yang membuat hal tersebut tidak sesuai dengan struktur kode ICD-10. Jika pemberi kode tidak memeriksa informasi bahwa pasien sedang hamil, mungkin akan memberikan kode diagnosis utama yang kurang tepat. Dokter mencatat penyakit tersebut sebagai diagnosis utama, yang tidak sesuai dengan struktur kode ICD-10. Jika pemberi kode tidak memeriksa informasi bahwa pasien sedang hamil, mungkin akan memberikan kode diagnosis utama yang salah.	
Diagnosis	Wasir internal trombosis	
Kode yang salah	I84.0	<i>Internal thrombosed haemorrhoids</i>
Kode yang benar	O22.4	<i>Haemorrhoids in pregnancy</i>

b. Diagnosis Sekunder

Diagnosis Sekunder merupakan diagnosis yang menyertai diagnosis utama pada saat pasien masuk atau yang terjadi selama episode perawatan sesuai dengan bukti penegakkan dan tatalaksana. Diagnosis ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi pasien secara menyeluruh. Jika suatu kode diagnosis tidak menjelaskan secara lengkap kondisi atau penyebab (agen), lokasi, atau tingkat keparahan tertentu, maka dapat ditambahkan kode sekunder untuk melengkapi dan mengidentifikasi kondisi atau agen tersebut dengan lebih rinci. Diagnosis sekunder terdiri dari ko-morbiditas dan/atau komplikasi.

1) Diagnosis Komorbid (*Pre-Admission Comorbidity*)

Komorbiditas, atau *pre-admission comorbidity*, adalah kondisi atau penyakit yang telah ada sebelum pasien menjalani perawatan di rumah sakit, yang menyertai dan/atau yang muncul bersamaan dengan diagnosis utama.

Kriteria Penetapan Komorbiditas

Suatu diagnosis dapat diklasifikasikan sebagai komorbiditas apabila memenuhi seluruh kriteria berikut:

Kondisi telah ada sebelum pasien dirawat di rumah sakit

Diagnosis komorbiditas hanya berlaku untuk kondisi atau penyakit yang secara klinis sudah dialami oleh pasien sebelum tanggal masuk rawat inap (*pre-admission*). Penyakit atau gangguan yang timbul selama perawatan tidak dapat diklasifikasikan sebagai komorbiditas.

Memiliki tingkat keparahan yang bermakna secara klinis

Komorbiditas harus memberikan dampak terhadap perjalanan penyakit atau perawatan pasien. Dampak tersebut berupa:

Peningkatan risiko komplikasi, kematian, atau kecacatan;

Perlunya pemeriksaan penunjang tambahan, seperti pemeriksaan laboratorium atau radiologi; dan/atau

Kebutuhan intervensi atau penanganan khusus, seperti konsultasi spesialis, tindakan pembedahan, atau penggunaan obat-obatan tertentu.

Jumlah diagnosis komorbiditas yang diperbolehkan

Dokter boleh mencantumkan lebih dari satu komorbiditas tanpa batasan jumlah, selama setiap diagnosis yang dicantumkan harus memenuhi kriteria di atas serta berdasar pada evaluasi klinis yang akurat. Contoh komorbiditas :

Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gagal ginjal kronis, penyakit jantung iskemik.

Penyakit autoimun seperti *systemic lupus erythematosus* .

Catatan:

Copyright@ Pusat Pembiayaan Kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

Jika pasien memiliki luka atau kondisi di beberapa area tubuh dengan tingkat keparahan yang lebih rendah daripada kondisi utama, hal ini juga dianggap sebagai komorbiditas.

Komorbiditas yang dicatat dokter di *resume* medis (ringkasan pulang) harus ditulis dengan jelas dalam rekam medis. Pemberi kode tidak berwenang menambahkan diagnosis komorbiditas secara sepihak berdasarkan hasil laboratorium atau pemeriksaan penunjang khusus lainnya.

2) Komplikasi (*Post-Admission Comorbidity*)

Komplikasi (*Complication* atau *Post-Admission Comorbidity*) adalah penyakit yang timbul dalam masa perawatan dan memerlukan pelayanan tambahan serta mendapatkan tata laksana sewaktu episode pelayanan.

Kriteria penting dalam diagnosis komplikasi adalah sbb:

Muncul atau teridentifikasi saat pasien dirawat di rumah sakit.

Tidak terkait langsung dengan diagnosis utama dan memiliki tingkat keparahan yang cukup untuk:

Meningkatkan risiko komplikasi, kematian, atau kecacatan.

Memerlukan pelayanan/pemeriksaan tambahan, obat, atau tindakan medis khusus.

Mebutuhkan penanganan dari dokter spesialis lain.

Bisa terjadi di sistem tubuh yang berbeda dan tidak harus terkait dengan diagnosis utama.

Dokter boleh mencantumkan lebih dari satu komplikasi tanpa batasan jumlah.

Contoh Diagnosis Komplikasi :

Trombosis (penggumpalan darah) mendadak.

Serangan jantung mendadak.

Alergi obat.

Efek samping dari pengobatan atau operasi.

Tabel B.5. Contoh Kasus Penentuan Diagnosis Komplikasi

Contoh 5	Pasien dengan <i>deep vein thrombosis</i> (DVT) mengalami komplikasi berupa emboli paru (<i>pulmonary embolism</i>) akibat bekuan darah di kaki yang terlepas dan mengalir ke paru-paru.
Diagnosis Utama	Trombosis vena dalam
Komplikasi	Emboli paru

Tabel B.6. Contoh Kasus Penentuan Diagnosis Komplikasi

Contoh 6	Pasien dalam contoh 8 (dengan diagnosis utama <i>deep vein thrombosis</i>) mengalami diare akut pada hari ke 3 saat perawatan di rumah sakit. Dokter mendiagnosis <i>acute gastroenteritis</i> sebagai komplikasi, meskipun kondisi ini tidak terkait dengan diagnosis utama.
Diagnosis Utama	Trombosis vena dalam
Komplikasi	Gastroenteritis akut

Dalam contoh 5 dan 6, komplikasi yang muncul menyebabkan pasien mengalami kesulitan lebih besar karena pasien harus dirawat di rumah sakit lebih lama, menggunakan obat tambahan, dan menimbulkan biaya perawatan yang lebih tinggi. Kondisi ini memenuhi kriteria definisi komplikasi.

Kode diagnosis komplikasi harus berdasarkan diagnosis yang dicantumkan dokter sebagai komplikasi dalam *resume* medis (ringkasan pulang). Diagnosis tersebut harus dituliskan secara jelas dalam rekam medis oleh dokter yang merawat atau tim medis yang menangani sebagai bukti sah untuk pemberian kode diagnosis komplikasi.

Pemberi kode tidak berwenang menambahkan diagnosis komplikasi secara sepihak berdasarkan hasil laboratorium atau pemeriksaan penunjang khusus lainnya.

c. Sumber Daya

Penatalaksanaan yang diberikan untuk diagnosis utama atau diagnosis sekunder sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya pelayanan kesehatan yang digunakan selama proses perawatan. Sumber daya ini mencakup satu atau lebih bentuk dukungan klinis dan nonklinis, yang diperlukan untuk mencapai manfaat pelayanan yang optimal.

Sumber daya dalam konteks penatalaksanaan meliputi hal berikut ini, namun tidak terbatas pada:

- Konsultasi medis (termasuk konsultasi antar spesialis);

- Pemeriksaan fisik dan penunjang, seperti pemeriksaan laboratorium, radiologi, atau diagnostik lainnya;

- Tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya;

- Tindakan medis, baik invasif maupun non-invasif;

- Bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan dalam perawatan;

Obat-obatan;

Alat kesehatan, termasuk penggunaan alat bantu atau terapi penunjang lainnya;

Bentuk dukungan lainnya yang memiliki kontribusi signifikan terhadap hasil tata laksana pasien.

Pemanfaatan sumber daya tersebut wajib terdokumentasi secara lengkap dalam rekam medis pasien dan akan menjadi dasar dalam pengkodean diagnosis dan prosedur.

d. Penyebab Luar (*External Cause*)

Penyebab luar (*external cause*) dalam sistem ICD-10 merupakan komponen esensial yang digunakan untuk mengklasifikasikan penyebab luar dari cedera, keracunan, dan efek samping lainnya. Kode-kode ini, yang tercakup dalam Bab XX (V00-Y99), dirancang untuk memberikan informasi tentang bagaimana suatu cedera atau kondisi kesehatan terjadi (mekanisme cedera), intensinya (ketidaksengajaan, bunuh diri, atau serangan), tempat kejadian, aktivitas korban saat kejadian, serta status orang tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung penelitian cedera dan evaluasi strategi pencegahan cedera. Dalam praktik pengodean, penting untuk dipahami bahwa kode *external cause* tidak boleh digunakan sebagai diagnosis utama, kode ini harus selalu diurutkan setelah kode cedera dari Bab XIX (S00-T88) atau kondisi lain yang relevan.

Struktur kode *external cause* dalam ICD-10 mencakup beberapa blok besar, dimulai dari kecelakaan transportasi (V00-V99), kecelakaan akibat penyebab eksternal lain seperti jatuh, paparan kekuatan mekanik, tenggelam (W00-X58), cedera yang disengaja seperti bunuh diri (X60-X84) dan serangan (X85-Y09), kejadian dengan maksud belum ditentukan (Y10-Y34), serta komplikasi perawatan medik dan bedah (Y40-Y84). Dalam proses pengkodean, terdapat beberapa pedoman penting yang harus diperhatikan. Pertama, kode *external cause* tertentu (V00-Y34) harus disertai dengan kode tempat kejadian (Y92) dan kode aktivitas (Y93) untuk memberikan kelengkapan informasi. Kedua, pencarian kode dilakukan melalui Indeks Penyebab Eksternal Cedera di Volume 3 ICD-10, yang biasanya menggunakan kata kunci yang menggambarkan keadaan cedera, diikuti dengan agen penyebabnya. Ketiga, jika terdapat lebih dari satu penyebab eksternal, setiap kode harus dikodekan sesuai urutan kemunculannya dalam rekam medis.

1) Unsur penting dalam menentukan penyebab eksternal

2) Deskripsi mekanisme cedera/keracunan

Harus dijelaskan secara spesifik, seperti:

3) Pasien terjepit di boncengan belakang sepeda motor saat perjalanan ke tempat kerja, lalu motor tergelincir.

- 4) Digigit anjing liar saat bermain di taman.
- 5) Keracunan timbal selama bekerja di pabrik baterai.

6) Jenis kejadian

Dokter yang merawat wajib menyatakan klasifikasi kejadian sebagai salah satu dari kategori berikut:

- 7) Kecelakaan tidak disengaja, seperti jatuh, tergelincir, atau tertabrak;
- 8) Tindakan kekerasan, seperti pemukulan, penusukan, atau penganiayaan;
- 9) Upaya bunuh diri, seperti menelan racun atau melukai diri secara sengaja;
- 10) Tujuan tidak diketahui, apabila informasi yang tersedia tidak cukup untuk mengidentifikasi motif kejadian.

Jika dokter tidak mencantumkan penyebab eksternal, Pemberi kode harus mencari informasi tambahan dari rekam medis, seperti aktivitas pasien saat kejadian (misal: bekerja, olahraga), lokasi kejadian (misal: rumah, jalan raya), posisi pasien di kendaraan (misal: pengemudi, penumpang).

Contoh 1: Jika pasien jatuh dari tangga tetapi tidak dijelaskan penyebabnya, pemberi kode wajib meminta klarifikasi ke dokter.

11) Penyebab eksternal untuk cedera kronis

Jika cedera disebabkan oleh kejadian lama, misalnya patah tulang akibat kecelakaan 1 tahun lalu, maka perlu menggunakan kode Y85–Y89 (kejadian eksternal di masa lampau).

Tabel B.7. Contoh Kasus Diagnosis Penyebab Eksternal untuk Cedera Kronis

Contoh 7	Pasien mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor di pinggir jalan akibat terjatuh setelah melewati jalan berlubang. Insiden ini terjadi tanpa adanya tabrakan dengan pihak lain. Saat terjatuh, pasien menggunakan lengan untuk menahan tubuh dan motornya. Pemeriksaan fisik menunjukkan adanya pembengkakan dan nyeri tekan pada area trauma. Hasil pemeriksaan radiologi mengungkapkan fraktur (patah tulang) pada bagian tengah tulang humerus (lengan atas) kiri.	
Diagnosis yang salah	Diagnosis Utama	Kecelakaan sepeda motor
	Penyebab Eksternal	-
Diagnosis yang salah	Diagnosis Utama	Fraktur tertutup bagian tengah tulang humerus kiri

	Penyebab Eksternal	-
Diagnosis yang benar	Diagnosis Utama	Fraktur tertutup bagian tengah tulang humerus kiri
	Penyebab Eksternal	Penumpang sepeda motor terluka dalam kecelakaan lalu lintas non-tabrakan selama aktivitas rekreasi

2. Aturan Koding Morbiditas ICD-10 Versi Tahun 2010:

Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam menetapkan diagnosis utama sesuai dengan pedoman penulisan diagnosis utama yang terdapat pada B.1.a yang dilakukan oleh dokter, maka pemberi kode melakukan klarifikasi kepada dokter. Dalam hal pemberi kode tidak berhasil melakukan klarifikasi kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), maka pemberi kode menggunakan rule MB1 sampai MB5 untuk memilih kembali diagnosis utama (reseleksi), yaitu:

a. Rule MB1

Rule MB1 merupakan kondisi minor tercatat sebagai diagnosis utama, sedangkan kondisi yang lebih berarti dicatat sebagai diagnosis sekunder. Ketika kondisi minor atau yang telah berlangsung lama atau masalah insidental tercatat sebagai diagnosis utama, sedangkan kondisi yang lebih berarti, relevan dengan pengobatan dan/atau prosedur yang diberikan dan/atau spesialisasi perawatan tercatat sebagai diagnosis sekunder, maka reseleksi kondisi yang berarti tersebut sebagai diagnosis utama.

Contoh 1:

Diagnosis Utama : Sinusitis akut

Diagnosis Sekunder : Karsinoma endoserviks
Hipertensi

Prosedur : Histerektomi total

Spesialisasi : Ginekologi

Pasien di rumah sakit selama tiga minggu, diberikan kode C53.0 (*Malignant Neoplasm, Endocervix*) sebagai diagnosis utama, sinusitis akut dan hipertensi sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Arthritis rheumatoid

Diagnosis Sekunder : Diabetes mellitus
Hernia femoralis terpuntir
Arteriosklerosis generalisata

Prosedur : *Herniorrhaphy*

Spesialisasi : Bedah umum

Pasien di rumah sakit selama tiga minggu, diberikan kode K41.3 (*Unilateral Or Unspecified Femoral Hernia, With Obstruction, Without Gangrene*) sebagai diagnosis utama, arthritis rheumatoid, diabetes mellitus, dan arteriosklerosis generalisata sebagai diagnosis sekunder.

b. *Rule* MB2

Rule MB2 merupakan beberapa kondisi yang dicatat sebagai diagnosis utama. Jika beberapa kondisi yang tidak bisa dikode bersamaan tercatat sebagai diagnosis utama, dan menunjukkan bahwa satu di antaranya adalah diagnosis utama pada asuhan pasien berdasarkan alasan utama pasien mendapatkan pelayanan kesehatan selama perawatan, pilih kondisi tersebut. Jika tidak, pilih kondisi yang sesuai dengan spesialisasi yang menangani.

Contoh 1:

Diagnosis Utama : Katarak Meningitis stafilokokus
Penyakit jantung iskemik

Diagnosis Sekunder : -

Spesialisasi : Neurologi

Pasien di rumah sakit selama lima minggu, diberikan kode G00.3 (*Staphylococcal Meningitis*) sebagai diagnosis utama, katarak dan penyakit jantung iskemik sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Bronkitis obstruktif kronis
Hipertrofi prostat
Psoriasis vulgaris

Diagnosis Sekunder : -

Spesialisasi : Kulit dan Kelamin

Pasien diberikan kode L40.0 (*Psoriasis vulgaris*) sebagai diagnosis utama, bronkitis obstruktif kronis dan hipertrofi prostat sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 3:

Diagnosis Utama : Gastritis kronis
Keganasan sekunder di nodus limfa axilla
Karsinoma mammae

Diagnosis Sekunder : -

Prosedur : Mastektomi

Pasien diberikan kode C50.9 (*Malignant Neoplasm, Breast, Unspecified*) sebagai diagnosis utama, gastritis kronis dan keganasan sekunder di nodus limfa axilla sebagai diagnosis sekunder.

c. Rule MB3

Rule MB3 yaitu kondisi yang dicatat sebagai diagnosis utama, merupakan gejala dari kondisi yang telah didiagnosis dan diobati. Jika suatu gejala atau tanda (pada umumnya diklasifikasikan pada Bab XVIII), atau suatu masalah yang bisa diklasifikasikan pada Bab XXI, dicatat sebagai diagnosis utama, dan merupakan tanda, gejala atau masalah dari kondisi yang telah didiagnosis sebagai diagnosis sekunder dan telah dirawat, maka pilihlah kondisi yang didiagnosis tersebut sebagai diagnosis utama.

Contoh 1:

Diagnosis Utama : Hematuria

Diagnosis Sekunder : Varises vena tungkai
Papillomata dinding belakang kandung kemih

Prosedur : Eksisi diatermi papillomata

Spesialis : Urologi

Pasien diberikan kode D41.4 (*Neoplasm Of Uncertain Or Unknown Behaviour Of Bladder*) sebagai diagnosis utama, hematuria dan varises vena tungkai sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Koma

Diagnosis Sekunder : Penyakit jantung iskemik atherosclerosis
Diabetes mellitus, insulin dependent

Spesialis : Endokrinologi

Perawatan : Penentuan dosis insulin yang tepat

Pasien diberikan kode E10.0 (*Insulin-Dependent Diabetes Mellitus With Coma*) sebagai diagnosis utama karena status koma tersebut disebabkan oleh diabetes mellitus, sehingga digunakan kode kombinasi. Penyakit jantung iskemik dan atherosclerosis sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 3:

Diagnosis Utama : Kejang demam

Diagnosis Sekunder : Anemia

Pasien diberikan kode R56.0 (*Febrile Convulsions*) sebagai diagnosis utama. Anemia dikode sebagai diagnosis sekunder. *Rule MB3* tidak berlaku karena diagnosis utama bukan gejala yang mewakili diagnosis sekunder.

d. Rule MB4

Rule MB4 merupakan kespesifikan. Jika suatu diagnosis utama menggambarkan kondisi yang bersifat umum, sementara diagnosis lainnya menjelaskan kondisi yang lebih spesifik/rinci mengenai anatomi atau penyebab yang dicatat pada resume medis, maka dipilih diagnosis yang lebih spesifik/rinci sebagai diagnosis utama.

Contoh 1:

Diagnosis Utama : *Cerebrovascular accident*

Diagnosis Sekunder : *Diabetes mellitus*, Hipertensi, Perdarahan otak

Pasien diberikan kode I61.9 (*Intracerebral Haemorrhage, Unspecified*) sebagai diagnosis utama, diabetes mellitus dan hipertensi sebagai diagnosis sekunder, dan *cerebrovascular accident* tidak dikoding.

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Penyakit jantung kongenital

Diagnosis Sekunder : Defek septum ventrikel

Pasien diberikan kode Q21.0 (*Ventricular septal defect*) sebagai diagnosis utama dan penyakit jantung kongenital tidak dikoding.

e. Rule MB5

Rule MB5 merupakan diagnosis alternatif, yaitu:

- 1) Apabila terdapat gejala atau tanda yang ditulis sebagai diagnosis utama yang kemungkinan saling berkaitan, maka gejala tersebut sebagai diagnosis utama.

Contoh 1:

Diagnosis Utama : Sakit kepala mungkin karena stress atau
tegangan otot atau sinusitis akut

Diagnosis Sekunder : -

Pasien diberikan kode R51 (*Headache*) sebagai diagnosis utama.

- 2) Jika terdapat dua atau lebih diagnosis tertulis sebagai diagnosis utama, maka dipilih diagnosis yang paling pertama ditulis oleh DPJP sebagai diagnosis utama.

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Kolesistitis akut atau pankreatitis akut

Diagnosis Sekunder : -

Pasien diberikan kode K81.0 (*Acute Cholecystitis*) sebagai diagnosis utama.

f. Aturan Koding Spesifik

1) Pengodean kondisi dugaan/suspek, gejala, penemuan abnormal, dan situasi tanpa penyakit

Jika pasien sedang menjalani episode perawatan, pemberi kode harus hati-hati dalam mengklasifikasikan diagnosis utama pada Bab XVIII (Kode R) dan XXI (Kode Z). Jika hingga akhir episode perawatan belum ada diagnosis spesifik yang bisa ditegakkan, atau tidak ada penyakit / cedera yang bisa dikode, maka kode dalam Bab XVIII dan XXI dapat digunakan sebagai kode diagnosis utama (lihat juga *rules* MB3 dan MB5).

Kode gejala dan tanda dalam ICD-10-IM merujuk pada kode yang digunakan untuk mencatat keluhan atau tanda klinis pasien. Secara umum, pemberi kode tidak perlu memberikan kode gejala atau tanda jika penyebabnya sudah jelas dari

diagnosis utama dan/atau sekunder atau komorbiditas atau komplikasi yang telah ditetapkan.

Prinsip Pemberian Kode Gejala dan Tanda:

Prinsip Umum, jika gejala atau tanda berasal dari diagnosis yang sudah dikodekan, kode gejala/tanda tersebut tidak perlu dicantumkan. Contoh: Jika pasien demam karena *Pneumonia, unspecified* (J18.9), maka kode "*Fever, unspecified*" (R50.9) tidak perlu ditambahkan.

Gejala atau tanda tetap perlu dikodekan jika hanya muncul pada sebagian kasus penyakit tertentu (kriteria khusus) dan menunjukkan tingkat keparahan atau karakteristik klinis yang mempengaruhi penanganan pasien. Contoh: "Kejang" pada kasus meningitis dengan diagnosis *Meningitis, unspecified* (G03.9), maka tambahkan kode kejang sebagai kode tambahan.

Kapan Kode Gejala/Tanda Diberikan?

Jika dokter tidak mengetahui penyebab gejala/tanda. Contoh: Pasien datang dengan "nyeri kepala" tanpa diagnosis pasti, gunakan kode R51 (*Headache*). Pada kondisi kehamilan, tambahkan kode Z32.- (*Pregnancy examination and test*) atau Z33 (*Pregnant state, incidental*) untuk mengidentifikasi kehamilan.

Jika diagnosis pasti belum dapat ditegakkan sampai akhir perawatan. Contoh: Pasien dirawat karena "sesak napas" tetapi pulang sebelum diagnosis pasti ditegakkan, gunakan kode R06.0 (*Dyspnea*).

Jika pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain sebelum diagnosis pasti ditegakkan. Contoh: Pasien dengan "perdarahan saluran cerna" dirujuk tanpa hasil endoskopi, gunakan kode K92.2 (*Gastrointestinal haemorrhage, unspecified*).

Jika pemeriksaan khusus belum dilakukan untuk memastikan diagnosis. Contoh: Pasien "sakit perut" menunggu hasil USG, gunakan kode R10.4 (*Other and unspecified abdominal pain*).

Jika terdapat gejala dan tanda yang diberikan tatalaksana spesifik yang berbeda dengan diagnosis utama, maka tanda atau gejala tersebut dikode secara terpisah dari diagnosa utama. Contoh : pasien masuk dengan stroke dan terdapat tanda atau gejala disfagia dan mendapatkan tatalaksana spesifik.

Kapan Kode Suspek Diberikan?

Kategori Z03.– (*Medical observation and evaluation for suspected diseases and conditions*) digunakan untuk diagnosis suspek setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan standar pelayanan dan diagnosis tidak ditegakkan. Diagnosis suspek dapat diartikan sebagai:

Diagnosis awal yang dibuat sebelum ditegakkan diagnosis pasti ; dan/atau

Diagnosis yang ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan/atau pemeriksaan penunjang.

Contoh diagnosis suspek antara lain:

Contoh 1:

Ditemukan massa/benjolan di payudara kiri berdasarkan hasil pemeriksaan klinis yang dominan maka diagnosis utama adalah suspek neoplasma di payudara kiri sehingga diberikan kode Z03.1 (*Observation For Suspected Malignant Neoplasm*).

Untuk kasus neoplasma dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi (PA) dinyatakan sebagai neoplasm of *uncertain or unknown behaviour* maka menggunakan kode diagnosis D37-D48 tergantung lokasinya.

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Neoplasma faring

Diagnosis Sekunder : -

Tindakan : Pemeriksaan PA dengan hasil jenis tumor
tidak diketahui

Diberikan kode D37.0 (*Neoplasm of Uncertain or Unknown Behaviour of Lip, Oral Cavity and Pharynx*) sebagai diagnosis utama dan kode prosedur 90.34 (*Microscopic examination of specimen from ear, nose, throat, and larynx, parasitology*).

Contoh 3:

Diagnosis Utama : Epistaxis berat

Diagnosis Sekunder : -

Pasien menjalani rawat inap selama satu hari tanpa laporan prosedur atau pemeriksaan.

Diberikan kode R04.0 (*Epistaxis*). Hal ini dapat diterima karena pasien jelas dirawat hanya untuk kondisi darurat.

2) Pengodean kondisi multipel

Prinsip pemberian kode untuk penyakit dengan lokasi/bentuk *multiple* (lebih dari satu) adalah sebagai berikut.

Jika penyakit memiliki tingkat keparahan berbeda

Jika penyakit memiliki tingkat keparahan yang berbeda di beberapa lokasi atau manifestasi, maka tidak perlu memberikan kode untuk semua lokasi atau

manifestasi tersebut. Cukup gunakan kode untuk kondisi yang paling parah atau menjadi fokus utama penanganan.

Jika penyakit memiliki tingkat keparahan sama

Apabila suatu penyakit menunjukkan tingkat keparahan yang seragam pada beberapa lokasi atau variasi, maka gunakan kode gabungan untuk mewakili semua lokasi atau variasi tersebut sebagai diagnosis utama. Selanjutnya, tambahkan kode spesifik untuk masing-masing lokasi atau variasi sebagai diagnosis tambahan. Contohnya, pada pasien dengan luka lecet di beberapa area dengan tingkat keparahan yang sama, kode gabungan digunakan sebagai diagnosis utama, sementara detail lokasi luka dicantumkan sebagai diagnosis sekunder.

Jika tidak ada detail yang jelas

Jika informasi detail mengenai lokasi atau bentuk penyakit tidak tersedia, penggunaan kode umum (misalnya, "cedera *multiple*") mungkin diperlukan. Namun, pemberi kode tidak disarankan langsung memilih opsi ini apabila informasi tambahan masih dapat diperoleh dari rekam medis. Contohnya, jika dokter hanya mencatat diagnosis umum seperti "*multiple abrasion*" tanpa menyebutkan lokasi luka secara spesifik, tetapi catatan perawat di ruang gawat darurat mencantumkan lokasi luka dengan jelas, maka pemberi kode harus berkoordinasi dengan dokter untuk meninjau ulang diagnosis dan meminta detail lokasi luka sebelum mengkode setiap luka secara terpisah.

Selain itu, penggunaan kode ganda (*multiple coding*) diterapkan ketika terdapat diagnosis untuk kondisi multipel, seperti cedera multipel, *sequelae* (gejala sisa) multipel dari penyakit atau cedera sebelumnya, atau kondisi multipel yang muncul pada penyakit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Kondisi tersebut meliputi:

Jika salah satu kondisi lebih berat secara klinis dan lebih banyak menggunakan sumber daya dibandingkan dengan yang lain, maka kondisi tersebut dicatat sebagai diagnosis utama, sementara kondisi lain sebagai diagnosis sekunder.

Jika tidak ada satu kondisi yang lebih dominan, maka diagnosis seperti fraktur multipel, cedera kepala multiple, atau penyakit HIV yang menyebabkan infeksi multipel ditetapkan sebagai diagnosis utama, sedangkan kondisi spesifiknya dicatat sebagai diagnosis sekunder.

Contoh kondisi *multiple* antara lain:

Contoh 1:

Diagnosis Utama : HIV *disease resulting in multiple infections*

Diagnosis Sekunder : HIV *disease resulting in candidiasis*

HIV *disease resulting in other viral infections*

Diberikan kode B20.7 (*HIV disease resulting in multiple infections*) sebagai diagnosis utama, B20.4 (*HIV disease resulting in candidiasis*) dan B20.3 (*HIV disease resulting in other viral infections*) sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 2:

Diagnosis Utama : *Multiple open fracture of femur*

Diagnosis Sekunder : *Open fracture of shaft of femur*

Open fracture of lower end of femur

Diberikan kode S72.71 (*multiple open fracture of femur*) sebagai diagnosis utama, S72.31 (*open fracture of shaft of femur*) dan S72.41 (*open fracture of lower end of femur*) sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 3:

Diagnosis Utama : *Multiple closed fracture upper limbs*

Diagnosis Sekunder : *closed fracture shaft humerus*

closed fracture radius-ulna

Tindakan : *ORIF humerus ORIF radius-ulna*

Diberikan kode T02.40 (*Multiple closed fracture upper limbs*) sebagai diagnosis utama, S42.30 (*closed fracture shaft humerus*) dan S52.30 (*closed fracture radius-ulna*) sebagai diagnosis sekunder. Kode 79.31 (*Open reduction of fracture with internal fixation, humerus*) dan 79.02 (*Closed reduction of fracture without internal fixation, radius and ulna*) sebagai tindakan.

3) Pengodean kategori kombinasi

Kode kombinasi/gabungan adalah kode tunggal dalam ICD-10 yang mencakup lebih dari satu penyakit atau kondisi medis dalam satu deskripsi kode. Kode ini dirancang untuk menggambarkan beberapa kondisi yang terjadi bersamaan secara jelas dan spesifik. Jika pemberi kode dapat menggunakan satu kode gabungan untuk mencakup semua penyakit yang diderita pasien, maka kode tersebut harus diprioritaskan.

Prinsip pemberian kode gabungan

Kode tunggal untuk lebih dari satu kondisi (*multiple condition*)

Kode gabungan harus mencakup seluruh penyakit yang relevan dengan pasien dalam satu kode tanpa perlu kode tambahan.

Konsistensi dalam menggunakan kode gabungan

Penggunaan kode gabungan harus tetap menjaga kelengkapan kondisi klinis pasien.

Bukan untuk kode ambigu atau multi-lokasi

Kode gabungan tidak boleh digunakan untuk:

Kondisi yang tidak terkait secara klinis.

Penyakit yang muncul di lokasi tubuh berbeda (misal: fraktur di tangan dan kaki).

Diagnosis yang tidak spesifik (misal: "infeksi saluran pernapasan" tanpa detail).

Berikut adalah beberapa contoh pengodean kategori kombinasi

Contoh 1:

Diagnosis Utama : Gagal ginjal

Diagnosis Sekunder : Penyakit ginjal hipertensi

Diberikan kode I12.0 (*Hypertensive Renal Disease With Renal Failure*) sebagai diagnosis utama.

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Glaukoma karena peradangan mata

Diagnosis Sekunder : Penyakit ginjal hipertensi

Diberikan H40.4 (*Glaucoma Secondary to Eye Inflammation*) sebagai diagnosis utama.

Contoh 3:

Diagnosis Utama : Obstruksi usus

Diagnosis Sekunder : Hernia inguinalis kiri

Diberikan kode K40.3 (*Unilateral or Unspecified Inguinal Hernia, With Obstruction, Without Gangrene*) sebagai diagnosis utama.

Contoh 4:

Diagnosis Utama : Katarak diabetes tergantung insulin

Diagnosis Sekunder : Hipertensi

Spesialisasi : Oftalmologi

Diberikan kode E10.3† (*Insulin-Dependent Diabetes Mellitus with Ophthalmic Complications*) sebagai diagnosis utama dan H28.0* (*Diabetic Cataract* (E10-

E14) *with Common Fourth Character* 3) serta I10 (*Essential (Primary) Hypertension*) sebagai diagnosis sekunder.

4) Pengodean sekuele kondisi tertentu

Kode ICD-10-IM diberikan untuk sekuele (*“sequelae of...”*), yaitu B90-B94, E64.-, E68, G09, I69.-, O97, T90-T98, dan Y85-Y89. Kode sekuele digunakan untuk menunjukkan kondisi yang merupakan sisa atau dampak dari suatu penyakit yang telah terjadi sebelumnya.

Aturan koding untuk sekuele yaitu:

Jika terdapat kondisi yang lebih spesifik daripada sekuele, sebagai penyebab masalah yang saat ini sedang diperiksa atau diobati, maka kondisi tersebut ditetapkan sebagai diagnosis utama dan kode *“sequelae of ...”* ditambahkan sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 1:

Diagnosis Utama : Dysphasia akibat infark otak lama

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode R47.0 (*Dysphasia and Aphasia*) sebagai diagnosis utama dan I69.3 (*Sequelae of Cerebral Infarction*) sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Osteoarthritis sendi panggul akibat
fraktur lama panggul karena
kecelakaan kendaraan bermotor 10
tahun yang lalu

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode M16.5 (*Other post-traumatic coxarthrosis*) sebagai diagnosis utama dan T93.1 (*Sequelae of Fracture of Femur*) sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 3:

Diagnosis Utama : Epilepsi akibat abses lama otak

Diagnosis Sekunder : Neurologi

Diberikan kode G40.9 (*Epilepsy, Unspecified*) sebagai diagnosis utama dan G09 (*Sequelae of inflammatory diseases of central nervous system*) sebagai diagnosis sekunder.

Jika tidak ada kondisi yang lebih spesifik daripada sekuele, maka sekuele menjadi diagnosis utama.

Contoh 4:

Diagnosis Utama : Efek lanjut poliomyelitis

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode B91 (*Sequela of poliomyelitis*) sebagai diagnosis utama karena informasi lain tidak tersedia.

5) Pengodean kondisi-kondisi akut dan kronis

Pengodean kondisi-kondisi akut dan kronis diatur sebagai berikut:

Jika diagnosis utama dicatat sebagai kondisi akut (atau subakut) dan kronis, dan ICD-10 menyediakan kategori atau subkategori yang terpisah untuk masing-masing kondisi tetapi tidak menyediakan satu kode gabungan untuk keduanya, maka kondisi akut harus digunakan sebagai diagnosis utama.

Contoh 1:

Diagnosis Utama : PPOK dengan eksaserbasi akut

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode J44.1 (*Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation*) sebagai diagnosis utama karena disini terdapat kode gabungan akut dan kronis.

Jika ICD-10 tidak menyediakan kategori atau subkategori yang terpisah untuk masing-masing kondisi, maka kondisi akut ditetapkan sebagai diagnosis utama, dan kondisi kronis sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Gagal ginjal akut dan kronik

Diagnosis Sekunder : -

Tindakan : -

Diberikan kode N17.9 (*Acute Renal Failure, Unspecified*) sebagai diagnosis utama dan gagal ginjal kronik sebagai diagnosis sekunder.

Jika kondisi akut dan kronis terjadi pada organ/sistem tubuh yang berbeda, maka diagnosis utama ditetapkan pada kondisi yang menghabiskan sumber daya paling banyak.

Contoh 3:

Diagnosis Utama : Gastritis Akut

Diagnosis Sekunder : CKD Stage 5

Tindakan : Hemodialisa

Diberikan kode N18.5 (*Chronic Kidney Disease, Stage 5*) sebagai diagnosis utama dan K29.1 (*Other Acute Gastritis*) sebagai diagnosis sekunder dan Hemodialisa sebagai prosedur.

6) Pengodean kondisi pasca-prosedur dan komplikasinya

Terdapat tiga jenis kode komplikasi, yaitu:

Kelompok kategori komplikasi pada Bab XIX (T80-T88) yang berhubungan dengan operasi dan prosedur lain, contohnya infeksi luka operasi, komplikasi mekanis benda-benda implantasi, syok, dan lainnya.

Contoh 1:

Diagnosis Utama : Perdarahan berlebihan setelah pencabutan gigi

Diagnosis Sekunder : -

Spesialis : Gigi

Diberikan kode T81.0 (*Haemorrhage and Haematoma Complicating a Procedures NEC*) sebagai diagnosis utama.

Menggunakan kondisi yang dinyatakan *post-procedural* atau *post-operative*

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Hipotiroidisme sejak tiroidektomi 1 tahun yang lalu

Diagnosis Sekunder : -

Spesialis : Penyakit dalam

Diberikan kode E89.0 (*Postprocedural Hypothyroidism*) sebagai diagnosis utama.

Menggunakan kode sesuai kondisi yang ada, disertai tambahan kode Y83-Y84 untuk menjelaskan keadaan *post-procedural*

Contoh 3:

Diagnosis Utama : Psikosis pasca-bedah setelah operasi plastik

Diagnosis Sekunder : -

Spesialis : Psikiatri

Diberikan kode F09 (*Unspecified Organic or Symptomatic Mental Disorder*) sebagai diagnosis utama dan Y83.8 (*Other Surgical Procedures*) sebagai diagnosis sekunder yang merupakan penyebab dari reaksi abnormal pasien untuk mengindikasikan hubungan pasca bedah.

7) Pengodean untuk penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) (B20-B24)

Koding iDRG menggunakan kode 4 karakter untuk subkategori pada B20-B23 yang berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi yang lebih spesifik.

Contoh 1:

Diagnosis Utama : Penyakit HIV dan sarkoma Kaposi

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode B21.0 (*HIV Disease Resulting in Kaposi's Sarcoma*) sebagai diagnosis utama.

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Penyakit HIV dan kandidiasis

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode B20.4 (*HIV Disease Resulting in Candidiasis*) sebagai diagnosis utama.

Jika diagnosis utama yang dicatat adalah penyakit HIV memiliki lebih dari satu penyakit penyerta yang terkait, maka gunakan subkategori -.7 dari kode B20-B22. Pemberi kode dapat menggunakan kode B22.7 bila kondisi pasien mencakup dua atau lebih kategori yang termasuk dalam B20-B22 dan tidak dapat diklasifikasikan secara spesifik dalam salah satu kode saja. Kode tambahan dari dalam blok B20-B24 digunakan sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 3:

Diagnosis Utama : Toxoplasmosis dan cryptococcosis pada pasien HIV

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode B20.7 (*HIV Disease Resulting in Multiple Infections*) sebagai diagnosis utama, B20.8 (*HIV Disease Resulting in Other Infectious and Parasitic Disease*) dan B20.5 (*HIV Disease Resulting in Other Mycoses*) sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 4:

Diagnosis Utama : Penyakit HIV dengan pneumonia
Pneumocystis carinii, limfoma Burkitt
dan kandidiasis mulut.

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode B22.7 (*HIV Disease Resulting in Multiple Diseases Classified Elsewhere*) sebagai diagnosis utama. B20.6 (*HIV Disease Resulting in Pneumocystis Carinii Pneumonia*), B21.1 (*HIV Disease Resulting in Burkitt's Lymphoma*), dan B20.4 (*HIV Disease Resulting in Candidiasis*) sebagai diagnosis sekunder.

8) Pengodean Neoplasma

Kasus neoplasma baik primer atau sekunder (metastasis) yang merupakan fokus perawatan, harus dicatat dan dikode sebagai diagnosis utama.

Contoh 1:

Diagnosis Utama : Karsinoma prostat

Diagnosis Sekunder : Bronkitis kronis

Prosedur : Prostatektomi

Diberikan kode C61 (*Malignant Neoplasm of Prostate*) sebagai diagnosis utama dan J42 (*Unspecified Chronic Bronchitis*) sebagai diagnosis sekunder.

Pasien dengan riwayat neoplasma ganas yang tidak mendapatkan tatalaksana menggunakan kode Z85.0 – Z85.9 (*Personal history of malignant neoplasm*).

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Karsinoma mammae – diangkat dua tahun yang lalu

Diagnosis Sekunder : Karsinoma sekunder paru-paru

Prosedur : Bronkoskopi dengan biopsi

Diberikan kode C78.0 (*Secondary Malignant Neoplasm Of Lung*) sebagai diagnosis utama, Z85.3 (*Personal History Of Malignant Neoplasm Of Breast*) sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 3:

Diagnosis Utama : *Carcinoma bladder* telah diangkat, dirawat untuk pemeriksaan *follow-up* dengan *cystoscopy*

Diagnosis Sekunder : -

Prosedur : *Cystoscopy*

Diberikan kode Z08.0 (*Follow-Up Examination After Surgery For Malignant Neoplasm*) sebagai diagnosis utama, kode Z85.5 (*Personal History of Malignant Neoplasm of Urinary Tract*) sebagai diagnosis sekunder.

Pasien yang menjalani pemeriksaan neoplasma karena riwayat keluarga dengan neoplasma ganas, menggunakan kode Z80.0 – Z80.9 (*Family history of malignant neoplasm*).

9) Pengodean diabetes mellitus (E10-E14).

Karakter keempat dari kode diabetes mellitus (E10-E14) yaitu sebagai berikut :

Digit 0 sampai digit 5 (.0 sampai .5) dan digit 7 (.7) cukup jelas sesuai dengan aturan ICD-10 Versi Tahun 2010.

Contoh 1:

Diagnosis Utama : Gagal ginjal akibat glomerulonefrosis diabetes

Diagnosis Sekunder : -

Prosedur : *Cystoscopy*

Diberikan kode E14.2† dan N08.3* (*Unspecified Diabetes Mellitus With Renal Complications*).

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Diabetes Melitus tergantung insulin dengan nefropati, gangren, dan katarak

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode E10.7 (*Insulin-Dependent Diabetes Mellitus With Multiple Complication*) sebagai diagnosis utama, kode E10.2† dan N08.3* (*Insulin-Dependent Diabetes Mellitus With Renal Complications*), kode E10.5 (*Insulin-Dependent Diabetes Mellitus With Peripheral Circulatory Complications*) serta kode E10.3† dan H28.0* (*Insulin-Dependent Diabetes Mellitus With Ophthalmic Complications*) sebagai diagnosis sekunder.

Digit 6 (.6) digunakan jika diabetes mellitus dengan komplikasi spesifik lainnya selain yang terdapat pada digit 0 sampai digit 5 (.0 sampai .5).

Keterangan pada digit 6 (.6) dalam ICD-10 hanya merupakan sebagian contoh kasus karena tidak terdapat lambang dagger (†) setelah digit keempat.

Contoh 3:

Diagnosis Utama : Dermatitis diabetikum

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode E14.6+ (*Unspecified Diabetes Mellitus With Other Specified Complications*) sebagai diagnosis utama dan L99.8* (*Other Specified Disorders Of Skin And Subcutaneous Tissue in Disease Classified Elsewhere*) sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 4:

Diagnosis Utama : Lancereaux's diabetes

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode E14.6 (*Unspecified Diabetes Mellitus with Other Specified Complications*) sebagai diagnosis utama.

Digit 8 (-.8) digunakan jika diabetes mellitus dengan komplikasi yang tidak dijelaskan atau tidak spesifik dituliskan jenis komplikasinya.

Digit 9 (-.9) digunakan jika diabetes mellitus tanpa komplikasi.

Contoh 5:

Diagnosis Utama : Diabetes mellitus tipe II

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode dengan E11.9 (*Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus without Complications*) sebagai diagnosis utama.

10) Pengodean Persalinan (O80-O84).

Kode-kode O80-O84 (*Delivery*) digunakan sebagai diagnosis sekunder untuk menunjukkan metode persalinan.

Jika tidak terdapat komplikasi atau penyulit persalinan lainnya maka kode O80-O84 (*Delivery*) digunakan sebagai diagnosis utama.

Kode Z37.0 – Z37.9 (*Outcome of delivery*) digunakan sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 1:

Diagnosis Utama : Persalinan

Diagnosis Sekunder : -

Prosedur : Persalinan dengan forseps rendah

Diberikan kode O81.0 (*Low Forceps Delivery*) sebagai diagnosis utama karena tidak ada informasi lain tersedia dan kode Z37.- (*Outcome of delivery*) sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Persalinan

Diagnosis Sekunder : Kegagalan percobaan persalinan

Prosedur : *Sectio Caesarean*

Diberikan kode O66.4 (*Failed Trial of Labour, Unspecified*) sebagai diagnosis utama. O82.9 (*Delivery by Caesarean Section, Unspecified*) dan kode Z37.- (*Outcome of Delivery*) sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 3:

Diagnosis Utama : Persalinan anak kembar

Diagnosis Sekunder : -

Prosedur : Persalinan spontan

Diberikan kode O30.0 (*Twin Pregnancy*) sebagai diagnosis utama. O84.0 (*Multiple Delivery, All Spontaneous*) dan kode Z37.- (*Outcome of delivery*) dikode sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 4:

Diagnosis Utama : Hamil cukup bulan, melahirkan janin mati 2800gr

Diagnosis Sekunder : -

Prosedur : Kelahiran spontan

Diberikan kode O36.4 (*Maternal Care For Intrauterine Death*) karena penyebab spesifik kematian janin tidak bisa ditentukan, sebagai diagnosis utama. Kode O80.- (*Single spontaneous delivery*) dan Z37.1 (*Single Stillbirth*) sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 5:

Diagnosis Utama : Ketuban pecah dini

Diagnosis Sekunder : Persalinan SC
Anemia
Bayi lahir hidup tunggal

Spesialis : Obgyn

Diberikan kode O42.9 (*Premature Rupture of Membranes, Unspecified*) sebagai diagnosis utama, O99.0 (*Anaemia complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*), D64.9 (*Anaemia, Unspecified*), O82.- (*Single Delivery by Caesarean Section*) serta Z37.0 (*Single Live Birth*) sebagai diagnosis.

3. Pengodean Prosedur / Tindakan

Pengodean tindakan atau prosedur dilakukan untuk setiap tindakan medis yang telah dilakukan oleh tenaga medis, baik di ruang operasi maupun di luar ruang operasi, yang memiliki keterkaitan langsung dengan diagnosis pasien. Proses pengodean ini menggunakan ketentuan pengodean prosedur yang berlaku berdasarkan ICD 9 CM 2010 dengan *Indonesian Modification* (IM). Kepatuhan terhadap standar ini sangat penting untuk memastikan akurasi data klinis, validitas klaim, serta kesesuaian pengelompokan kasus dalam sistem pembiayaan kesehatan.

a. Aturan dalam pengodean Tindakan / Prosedur

1) Kata “*See, See also*” (lihat, lihat juga);

Jika ada pernyataan “*see, see also*” di belakang pernyataan tindakan/prosedur, maka harus melihat juga pernyataan tindakan yang dimaksud.

Contoh 1:

Atherectomy

coronary Atherectomy

Cerebrovascular –see Angioplasty

Coronary –see Angioplasty coronary 36.09

Diberikan kode 36.09 (*Angioplasty coronary*)

Contoh 2:

Catheterization –see also Insertion,

Catheter arteriovenous 39.93

Artery 38.91

Maka harus dilihat juga *Insertion*.

2) Kata “*omit code*” (tidak dikoding);

Apabila terdapat keterangan “*omit code*” pada indeks alfabet ICD 9 CM dengan *Indonesian Modification* (IM), artinya prosedur tersebut termasuk dalam kode prosedur lain yang terkait dan tidak perlu dikodekan secara terpisah. Pemberian kode (*omit code*) untuk prosedur pendekatan operasi tidak diperlukan.

Prosedur pendekatan operasi (*Operative-approach procedure*) adalah tahap awal dalam operasi, terutama untuk operasi organ dalam, yang dimulai dengan membuka akses ke dalam tubuh. Prosedur ini harus dilakukan sebelum tindakan operasi utama untuk pengobatan. Contoh istilah yang menunjukkan pendekatan operasi adalah:

- *Craniotomy* : Membuka tengkorak dengan cara melubangi tulang kepala
- *Craniectomy* : Membuka tengkorak dengan mengangkat sebagian tulang kepala
- *Sternotomy* : Membuka rongga dada melalui tulang sternum (tengah)
- *Thoracotomy* : Membuka rongga dada dari sisi lateral
- *Laparotomy* : Membuka rongga perut
- *Laminectomy* : Membuka rongga tulang belakang dengan mengangkat lamina
- *Arthrotomy* : Membuka sendi

Prosedur pendekatan operasi (*Operative-approach procedure*) dapat diberikan pada salah satu kondisi khusus dibawah ini:

Jika pendekatan operasi dilakukan sebagai satu-satunya tindakan (tanpa dilanjutkan dengan operasi pengobatan atau diagnosis lebih lanjut).

Dalam kasus ini, kode pendekatan operasi dianggap sebagai kode utama/prosedur tunggal.

Contoh aturan *omit code*:

Jika seorang pasien hanya menjalani *craniotomy* untuk mengakses tumor otak, tetapi tidak dilanjutkan dengan reseksi tumor, maka *craniotomy* dikodekan sebagai prosedur utama.

Jika *craniotomy* diikuti dengan reseksi tumor, maka hanya reseksi tumor yang dikodekan, dan *craniotomy* tidak perlu di kode.

Contoh 1:

Craniotomy 01.24

as operative approach – omit code

fetal 73.8

for decompression of fracture 02.02

reopening of site 01.23

Contoh 2:

Laparotomy NEC 54.19

as operative approach --omit code

exploratory (pelvic) 54.11

Contoh 3:

Laminectomy (decompression) (for exploration) 03.09

as operative approach --omit code

3) Kata “code also” (dikoding juga);

Jika ada pernyataan “code also” dibawah pernyataan tindakan atau prosedur yang telah dilakukan maka harus dikoding jika tindakan tersebut dilakukan.

Contoh 1:

42.69 Antesternal anastomosis of esophagus dengan gastrostomy

Code also any synchronous :

esophagectomy (42.40 – 42.42)

gastrostomy (43.1)

Diberikan kode prosedur 42.69 (*antesternal anastomosis of esophagus*) dan 43.19 (*other gastrostomy*).

4) Kata “exclude” (tidak termasuk)

Jika ada pernyataan “exclude” di bawah pernyataan tindakan/prosedur maka harus dikoding yang lain sesuai dengan petunjuk “exclude”.

Contoh 1:

Simple excision of lymphatic structure (40.2)

Exclude : biopsy of lymphatic structure (40.11)

5) Kata “includes” (termasuk).

Jika ada pernyataan “includes” di bawah pernyataan tindakan/prosedur maka pernyataan tindakan tersebut termasuk bagian atau contoh tindakan tersebut.

Contoh 1:

35.2 Replacement of heart valve

Includes: Excision of heart valve with replacement

b. Kode Tindakan / Prosedur Operasi

Pada Pencatatan dalam sistem iDRG, tindakan atau prosedur utama dicantumkan terlebih dahulu, selanjutnya diikuti dengan tindakan atau prosedur pendukung lainnya.

Tahapan Memilih Kode Tindakan Utama:

- 1) Prioritaskan tindakan yang mengobati penyakit utama sebagai kode utama. Jika ada beberapa tindakan untuk penyakit utama, pilih prosedur yang paling signifikan (misalnya, tindakan yang mengatasi lesi/organ utama penyebab penyakit).
- 2) Jika tidak ada tindakan untuk penyakit utama, pilih tindakan yang mengobati komplikasi sebagai kode utama.
- 3) Jika ada beberapa tindakan untuk komplikasi, pilih prosedur yang paling signifikan (misalnya, tindakan yang mengatasi lesi/organ utama penyebab komplikasi).
- 4) Jika tidak ada tindakan untuk komplikasi, pilih tindakan yang mengobati penyakit penyerta sebagai kode utama.
- 5) Jika ada beberapa tindakan untuk penyakit penyerta, pilih prosedur yang paling signifikan (misalnya, tindakan yang mengatasi lesi/organ utama penyebab penyakit penyerta).

Catatan:

- 6) Kode tindakan utama harus ditentukan setelah semua kode operasi lainnya terdaftar.
- 7) Kode tindakan utama mencerminkan prioritas klinis, bukan urutan waktu pelaksanaan operasi.

Contoh 1:

- 8) Pasien dengan kanker usus (penyakit utama) menjalani reseksi usus (operasi utama) dan pemasangan stoma (operasi tambahan). Kode prosedur utama adalah reseksi usus.
- 9) Pasien dengan abses hati (penyakit utama) disertai dengan diabetes (komorbid) dan menjalani drainase abses. Kode prosedur utama adalah drainase abses.

4. Pendokumentasian Klinis

Pencatatan diagnosis utama dan diagnosis sekunder secara spesifik dan detail sangat penting pada pelayanan kesehatan. Tenaga medis bertanggung jawab untuk mencatat kondisi utama pasien beserta kondisi lain yang relevan pada setiap episode perawatan. Pencatatan harus dilakukan secara sistematis dan sesuai standar agar rekam medis menjadi sumber informasi akurat, sehingga tidak hanya untuk pengelolaan pasien tetapi juga sebagai data statistik kesehatan masyarakat.

Proses klaim pembiayaan rumah sakit yang menggunakan sistem iDRG tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Sistem ini mengelompokkan kasus berdasarkan diagnosis utama, diagnosis sekunder, prosedur medis, tingkat keparahan penyakit, usia pasien, dan faktor lainnya. Kelengkapan serta ketepatan pencatatan diagnosis sangat memengaruhi kelompok DRG yang menentukan besaran tarif klaim

yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut (FPKTL).

Pencatatan diagnosis yang lengkap dan detail menyebabkan pengelompokan kasus kedalam kelompok DRG yang tepat sehingga biaya pelayanan kesehatan dapat dibayarkan sesuai kompleksitas penanganannya. Jika diagnosis dicatat secara umum atau kurang spesifik, rumah sakit berisiko mendapatkan tarif klaim lebih rendah karena kasus akan masuk ke kelompok DRG dengan tingkat kompleksitas lebih rendah.

Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendokumentasian klinis pasien:

a. Gunakan Istilah Diagnosis Paling Spesifik

Istilah yang biasa dicatat dokter sebagai diagnosis pasien memiliki 4 karakteristik spesifikitas, diurutkan dari yang paling spesifik ke kurang spesifik sebagai berikut:

- 1) Diagnosis Akhir (*Final Diagnosis*) merupakan diagnosis yang ditetapkan pada akhir pengobatan, setelah dilakukan evaluasi lengkap dan konfirmasi, misalnya: hasil laboratorium, pencitraan, atau pemeriksaan patologi.
- 2) Diagnosis Sementara (*Provisional Diagnosis*) merupakan diagnosis awal yang ditetapkan saat mulai pengobatan, sebelum dilakukan konfirmasi lengkap, misalnya: diagnosis kerja, *suspect* atau dugaan sementara.
- 3) Kondisi atau Sindrom merupakan kelompok gejala atau kondisi yang menggambarkan gangguan kesehatan secara umum, misalnya: sindrom nefrotik, sindrom metabolik.
- 4) Gejala dan Tanda merupakan manifestasi klinis yang tidak spesifik, misalnya: demam, nyeri perut, batuk.
- 5) Jika sampai akhir perawatan masih belum bisa ditegakkan diagnosisnya maka tidak diperkenankan untuk menulis diagnosis suspek atau dugaan sementara pada diagnosa akhir / final tetapi tulislah gejala atau tanda atau temuan abnormal dari hasil pemeriksaan fisik atau penunjang.

b. Hindari Penggunaan Singkatan

Dokter tidak diperbolehkan menggunakan singkatan (*abbreviation*) dalam penulisan *resume medis* (ringkasan pulang) dalam kondisi apa pun. Hal ini berisiko menyebabkan kesalahan kode yang tidak sesuai dengan kondisi pasien.

Singkatan dalam dokumen medis hanya boleh digunakan untuk keperluan internal rumah sakit dan harus dihindari dalam pendokumentasian catatan medis yang akan digunakan untuk pengodean iDRG dalam hal dokter menggunakan singkatan dalam penulisan pencatatan medis di dokumen klaim maka dokumen klaim akan dilakukan pengembalian untuk dilakukan perbaikan penulisan.

5. Hal - Hal yang harus dilakukan Pengode dalam memberikan kode diagnosis atau tindakan/prosedur

a. Prinsip Pengodean Diagnosis

Prinsip pengodean yang penting adalah selalu menggunakan diagnosis akhir sebagai dasar pemberian kode karena diagnosis ini merupakan hasil penilaian medis paling pasti dan definitif setelah evaluasi lengkap pasien. Jika diagnosis akhir sudah ditetapkan, maka gejala, kondisi atau sindrom sementara, serta diagnosis sementara yang terkait tidak perlu dikodekan untuk menghindari duplikasi dan memastikan data rekam medis hanya mencerminkan kondisi yang jelas dan telah dikonfirmasi. Fokus pengodean harus pada diagnosis yang paling spesifik dan definitif agar informasi kesehatan pasien tercatat dengan tepat, mendukung manajemen klinis yang baik, serta mempermudah proses pembiayaan layanan kesehatan seperti JKN berbasis DRG sesuai tingkat keparahan penyakit sebenarnya.

Contoh 1:

Pasien datang dengan diagnosis awal abdomen akut dan menjalani operasi. Catatan operasi menunjukkan adanya ulkus kronis di dinding anterior bagian pertama duodenum dengan perforasi berukuran 3 mm. Dalam ringkasan pulang (*resume medis*), dokter menyimpulkan bahwa kondisi pasien adalah perforasi ulkus duodenum kronis pada bagian pertama duodenum. Diagnosis akhir ini mencerminkan temuan spesifik dari pemeriksaan operasi, menggantikan diagnosis awal yang lebih umum (abdomen akut). Perforasi ulkus kronis ini menjadi fokus utama pengobatan dan kode diagnosis sesuai ICD-10 (K26.9) digunakan untuk dokumentasi medis.

Diagnosis Utama : Peritonitis dari perforasi tukak lambung

Diagnosis Sekunder : Tukak lambung

Contoh di atas, ringkasan untuk kasus diatas dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel B.8. Contoh prinsip pengodean diagnosis

Diagnosis Akhir (a)	Ulkus kronis di dinding anterior 1 bagian dari duodenum dengan perforasi
Diagnosis Sementara (b)	Perforasi tukak lambung
Keadaan (c)	Peritonitis
Tanda & Gejala (d)	Nyeri perut akut

Pada kasus tersebut, pemberi kode hanya menggunakan kode diagnosis akhir, yaitu K26.5 (*Chronic duodenal ulcer with perforation*) tanpa perlu memberikan kode tambahan untuk kondisi seperti *peptic ulcer perforation*, peritonitis, atau nyeri perut akut.

Maka Prinsip Pengodean adalah sebagai berikut :

- 1) Selalu gunakan Diagnosis Akhir (a) sebagai dasar pemberian kode penyakit.

- 2) Jika Diagnosis Akhir **(a)** telah ditetapkan, jangan mengkodekan gejala **(d)**, kondisi/sindrom **(c)**, atau Diagnosis Sementara **(b)** yang terkait.
- 3) Kode hanya berfokus pada diagnosis yang paling spesifik dan definitif.

b. Penentuan Kode Berdasarkan Dokumentasi

Setiap kode yang diberikan harus didukung oleh bukti tertulis, misalnya catatan medis, hasil laboratorium, laporan operasi, atau gambar radiologi, yang membuktikan penegakan diagnosis atau prosedur.

Contoh 1:

Catatan dokter pada *resume* medis (ringkasan pulang) adalah diagnosis utama Radang paru-paru sedangkan diagnosis sekunder adalah Diabetes mellitus, dalam laporan pemeriksaan *X-Ray*, ahli radiologi melaporkan bahwa pneumonia lobar ditemukan di lobus atas kiri dalam kultur dahak ditemukan *Klebsiella Pneumoniae*. Pasien terinfeksi HIV dan tidak memiliki gejala HIV. Mengenai tata cara pengodean HIV dapat dilihat pada aturan pengodean dasar dan MDC 28.

Dalam kasus ini pemberi kode memberikan kode sebagai berikut namun kurang tepat:

Diagnosis Utama : J15.0 *Pneumonia due to Klebsiella pneumoniae*

Diagnosis Sekunder : E10.9 *Insulin-dependent diabetes mellitus, without complication*

Z21 *Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status*

Semua kode dalam contoh di atas dianggap tidak tepat karena dinilai berlebihan (*over-coding*) dengan alasan berikut:

- 1) Hasil kultur sputum tidak dapat dijadikan dasar pemberian kode, pemberi kode harus konfirmasi kepada dokter mengenai kepastian diagnosis pneumonia dan dokter perlu melengkapinya dalam rekam medis mengenai diagnosis *klebsiella pneumonia*.
- 2) Dalam kasus ini, kode J18.1 (*Lobar pneumonia*) seharusnya didasarkan pada laporan X-ray oleh dokter radiologi, bukan hasil kultur sputum.
- 3) Meskipun kultur sputum menemukan *Klebsiella pneumoniae*, hal ini hanya menunjukkan penyebab infeksi, bukan diagnosis klinis pneumonia itu sendiri.
- 4) Bila secara klinis dan pemeriksaan penunjang sudah ditegaskan oleh dokter dan terdokumentasi dalam rekam medis maka kode J15.0 dapat digunakan.
- 5) Pemberian insulin dalam catatan perawatan tidak dapat digunakan untuk mendiagnosis diabetes tipe 1.
- 6) Mengasumsikan diabetes tipe 1 hanya dari penggunaan insulin adalah spekulasi yang tidak valid.
- 7) Catatan perawatan (misalnya: pemberian obat) tidak memenuhi syarat sebagai bukti untuk diagnosis, kecuali jika disertai konfirmasi klinis, misalnya: hasil tes gula darah atau diagnosis dokter.

- 8) Pastikan pemberi kode melakukan konfirmasi kepada dokter untuk memastikan tipe diabetes yang diderita pasien dan lengkapi rekam medis dan resume medis.

c. Bukti Pendukung yang sah saat menentukan kode diagnosis:

Data dalam rekam medis yang dapat digunakan untuk mendukung kode adalah:

1) Diagnosis Dokter yang Tervalidasi

Diagnosis yang tercantum dalam dokumen rekam medis, seperti *resume medis (ringkasan pulang)*, catatan operasi, atau laporan klinis yang telah dianalisis untuk memastikan akurasi pengodean.

2) Laporan Pemeriksaan Radiologi atau Penunjang Khusus lainnya

Hasil pemeriksaan radiologi (X-ray, USG, CT scan) atau pemeriksaan khusus yang dianalisis oleh dokter spesialis. Contoh: Laporan X-ray yang menyebutkan lobar pneumonia oleh dokter radiologi.

3) Laporan Patologi Anatomi

Hasil pemeriksaan jaringan atau cairan tubuh (darah, urine, feses, sputum) yang dianalisis oleh dokter yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Hasil Laboratorium yang Diinterpretasi

Hasil laboratorium abnormal yang diinterpretasi oleh dokter yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai diagnosis penyakit.

Contoh 1:

d. Bukti pendukung yang Tidak Sah untuk menentukan kode diagnosis:

Pemberi kode tidak diperbolehkan melakukan kodefikasi diagnosa & tindakan berdasarkan bukti pendukung yang tidak sesuai sebagai contoh:

1) Spekulasi dari Resep atau Catatan Perawatan

Menebak diagnosis hanya dari resep obat (misalnya: insulin) atau permintaan pemeriksaan tanpa konfirmasi klinis.

2) Simbol atau Kode Internal Rumah Sakit

Kode khusus yang hanya berlaku di satu institusi dan tidak sesuai standar ICD-10. Misalnya : Tulisan khusus, warna, atau simbol.

6. Penentuan aturan etiologi & manifestasi

a. Kode sistem dagger (†) dan asterisk (*)

- b. Jika diagnosis utama yang ditegakkan dokter dalam ICD 10 menggunakan kode dagger (†) dan asterisk (*) maka yang dikode sebagai diagnosis utama adalah kode dagger (†), sedangkan kode asterisk (*) sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 1:

Diagnosis Utama : Perikarditis tuberkulosa

Diagnosis Sekunder : -

Dikode A18.8† (*Tuberculosis of other specified organs*) sebagai diagnosis utama dan I32.0* (*Pericarditis in bacterial disease classified elsewhere*) sebagai diagnosis sekunder. Simbol (†) dan (*) tidak diinput di dalam aplikasi INA-CBG.

- c. Jika diagnosis sekunder yang ditegakkan dokter dalam ICD-10 menggunakan kode dagger (†) dan asterisk (*), maka kedua kode tersebut menjadi diagnosis sekunder, simbol (†) dan (*) tidak diinput di dalam aplikasi INA-CBG.

Contoh 2:

Diagnosis Utama : Stroke infark

Diagnosis Sekunder : Peritonitis TB

Dikode I63.9 (*Cerebral infarction, unspecified*) sebagai diagnosis utama, A18.3† (*Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands*) dan K67.3* (*Tuberculous peritonitis*) sebagai diagnosis sekunder.

- d. Jika diagnosis utama dan sekunder yang ditegakkan dokter dalam ICD 10 menggunakan kode dagger (†) dan asterisk (*) maka yang dikode sebagai diagnosis utama adalah kode dagger (†), sedangkan kode asterisk (*) sebagai diagnosis sekunder, simbol (†) dan (*) tidak diinput di dalam aplikasi INA-CBG.

Contoh 3:

Diagnosis Utama : Anemia

Diagnosis Sekunder : Ca Mammae

Dikode C50.9† (*Malignant neoplasm, breast, unspecified*) sebagai diagnosis utama dan D63.0* (*Anaemia in neoplastic disease*) sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 4:

Diagnosis Utama : Anemia pada penyakit kronis

Diagnosis Sekunder : Chronic Kidney Disease, Stage 5

Dikode N18.5† (*Chronic kidney disease, stage 5*) sebagai diagnosis utama dan D63.8* (*Anaemia in other chronic diseases classified elsewhere*) sebagai diagnosis sekunder.

e. Selain kode dagger dan asterisk

Dalam proses pengkodean diagnosis menggunakan ICD-10, pemberi kode wajib memperhatikan adanya tanda khusus seperti dagger (†) atau asterisk (*). Apabila tanda tersebut tidak ditemukan, pengkodean dilanjutkan dengan menelusuri adanya instruksi tambahan, sebagai berikut :

f. Instruksi “Use Additional Code, if desired, to identify specified condition”

Ketika terdapat Instruksi “Use additional code, if desired, to identify specified condition” maka diagnosis tersebut dapat dikode sebagai diagnosis sekunder jika mendapatkan pemeriksaan dan/tatalaksana sesuai kondisi yang spesifik dan bukan merupakan kode gabung.

Contoh 5:

Diagnosis Utama : Toxoplasmosis.

Diagnosis Sekunder : Kehamilan

Spesialisasi : Klinik perawatan antenatal

Dikode O98.6 (*Protozoal diseases complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*) sebagai diagnosis utama dan B58.9 (*Toxoplasmosis, unspecified*) sebagai diagnosis sekunder.

Jika tidak ada aturan dagger asterisk dan aturan etiologi dan manifestasi selain kode dagger asterisk, maka penentuan pengkodean sebagai berikut :

g. Aturan Umum

Ketentuan etiologi sebagai penyebab dasar ditetapkan sebagai diagnosis utama dan manifestasi ditetapkan sebagai diagnosis sekunder.

h. Penyesuaian Berdasarkan Fokus Perawatan

Pengkodean tetap harus memperhatikan fokus pelayanan serta kondisi yang memerlukan penggunaan sumber daya terbesar. Apabila manifestasi merupakan kondisi yang menjadi fokus utama perawatan dan menghabiskan sumber daya terbesar ditetapkan sebagai diagnosis utama dan etiologi sebagai diagnosis sekunder.

7. Indonesian Modification (IM) Pada ICD-10 dan ICD 9 CM

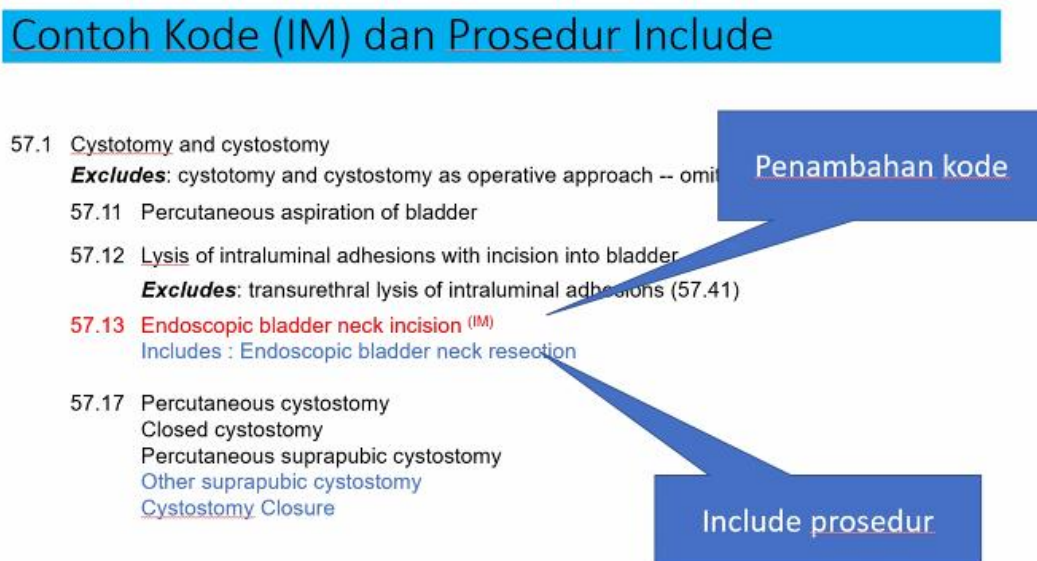
Indonesian Modification merupakan modifikasi terhadap klasifikasi dan aturan kodefikasi yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia serta disesuaikan dengan karakteristik pelayanan kesehatan, pola penyakit, serta kebutuhan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia.

Indonesian Modification merupakan penyesuaian kode yang dikembangkan dalam sistem ICD-10 dan ICD-9-CM, yang dibuat sebagai respons terhadap kebutuhan pengodean di lapangan. Dalam proses penyusunannya, Kementerian Kesehatan mengadopsi referensi aturan pengodean yang berlaku secara internasional dan penerapan di negara lain, usulan organisasi profesi kedokteran terkait diagnosis dan tindakan medis yang belum tercantum dalam sistem klasifikasi ICD. Usulan tersebut selanjutnya ditelaah untuk menentukan penanganan yang tepat, yaitu dengan menetapkan kode baru atau menambahkan keterangan *include* pada kode yang telah ada dalam ICD.

Indonesian Modification merupakan kode baru yang dibuat di dalam ICD-10 dan ICD 9 CM versi tahun 2010. Kode tersebut dibuat karena pemberi kode tidak dapat menemukan kode diagnosis dan/atau prosedur yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh dokter pada sistem aslinya. Para dokter melalui organisasi profesi mengirimkan usulan terkait tindakan-tindakan yang belum ada di dalam ICD untuk dilakukan telaah apakah perlu dibuatkan kode baru atau hanya ditambahkan *include* di dalam ICD.

Sebagai contoh di dalam ICD 9 CM, penggantian katup jantung tidak dibedakan antara satu katup jantung atau lebih dari satu yang diganti. Padahal, jika dilakukan penggantian katup lebih dari satu memiliki nominal dan penggunaan sumber daya yang lebih besar pula, maka dari itu dibuatlah kode baru berupa *Indonesia Modification*.

Contoh lainnya, prosedur bedah urologi yang bertujuan untuk memperluas leher kandung kemih (*bladder neck*) yang menyempit atau terhambat, umumnya disebabkan oleh striktur atau stenosis. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan alat bedah (sistoskopi) yang dimasukkan melalui uretra. Sayatan dibuat pada *bladder neck* menggunakan kauter atau serat laser. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran urin dan mempermudah buang air kecil. Prosedur tersebut belum terklasifikasi dalam ICD-9-CM 2010, sehingga dibuatlah penambahan kode 57.13.



Gambar B.1. Contoh kode (IM) dan Prosedur *Include*

Dari gambar di atas, tulisan yang berwarna merah merupakan kode baru sedangkan yang berwarna biru merupakan *include* yang ditambahkan dan yang berwarna hijau adalah *notes* atau catatan mengenai kode tersebut.

C. KETENTUAN & PERHATIAN KHUSUS KODING iDRG

Pemberi kode harus memperhatikan dokumentasi klinis yang tercantum dalam rekam medis dan menentukan kode diagnosis serta prosedur/tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam ICD-10 IM dan ICD 9 CM-IM. Selain itu, pemberi kode juga wajib mengikuti ketentuan khusus terkait tata cara pengodean yang disesuaikan dengan kekhususan kasus pada setiap MDC dalam sistem iDRG.

Berikut ini adalah perhatian khusus yang harus diperhatikan oleh pemberi kode:

1. Penggunaan Kode Lateralisasi Posisi Anatomi Tubuh

Akurasi pengodean diagnosis dan prosedur dalam sistem iDRG mensyaratkan spesifikasi yang tepat mengenai lateralitas dan lokasi anatomis. Penggunaan kode lateralisasi dan posisi anatomi yang konsisten diperlukan untuk:

- a. Memastikan presisi data klinis untuk pelayanan pasien
- b. Mendukung validitas data untuk kepentingan epidemiologi, penelitian, dan pengambilan kebijakan kesehatan

a. Prinsip Dasar Penggunaan

- 1) Kode lateralisasi dan posisi anatomi harus digunakan ketika rekam medis secara eksplisit mendokumentasikan sisi atau lokasi spesifik
- 2) Pengkodean mengacu pada sudut pandang anatomis pasien (kanan pasien = kanan, kiri pasien = kiri)
- 3) Kode lateralisasi merupakan *suffix* yang ditambahkan setelah kode diagnosis atau prosedur utama
- 4) Untuk kondisi bilateral, masing-masing sisi harus dikodekan secara terpisah kecuali ditentukan lain dalam panduan khusus

Tabel C.1. Contoh Penerapan Kode Lateralisasi untuk Diagnosis

Ilustrasi Kasus	Diagnosis (sesuai Rekam Medis)	Kode ICD- 10	Kode Lateralisasi	Catatan & Justifikasi
Mata				
Pasien datang dengan keluhan penglihatan kabur pada mata kanan. Pemeriksaan menegaskan katarak senilis.	Katarak senilis mata kanan (OD)	H25.9	HL00	Diagnosis eksplisit menyebut sisi kanan → wajib kode HL00.
Pasien dengan keluhan mata merah dan nyeri pada mata kiri. Diagnosa: konjungtivitis bakterial.	Konjungtivitis bakterial mata kiri (OS)	H10.9	HL01	Diagnosis menyebut mata kiri → wajib kode HL01.
Ginjal & Saluran Kemih				
Pasien nyeri pinggang kanan, CT scan menunjukkan batu di ginjal kanan.	Nefrolitiasis ginjal kanan	N20.0	NL11	Diagnosis spesifik ginjal kanan → wajib kode NL11.
Pasien dengan hidronefrosis akibat striktur ureter kiri.	Hidronefrosis ureter kiri	N13.3	NL14	Diagnosis spesifik ureter kiri → wajib kode NL14.
Pasien dengan sistitis akut tanpa komplikasi.	Sistitis akut	N30.0	-	Tidak perlu kode NL15, karena diagnosis umum kandung kemih (organ tunggal).
Gigi				
Pasien sakit gigi berdenyut pada gigi geraham belakang kanan bawah. Diagnosa: pulpitis irreversible.	Pulpitis irreversible pada gigi molar pertama rahang bawah kanan (gigi 46)	K04.0	KG46	Diagnosis spesifik pada satu gigi → wajib kode posisi gigi (KG46).

Pasien dengan karies pada gigi seri tengah atas kiri.	Karies dentin gigi seri tengah atas kiri (gigi 21)	K02.1	KG21	Diagnosis spesifik gigi → wajib kode KG21.
Kasus Khusus & Penanganan				
Pasien dengan riwayat jatuh, didiagnosa fraktur radius kanan.	Fraktur tertutup radius kanan	S52.5	-	Tidak ada kode lateralisasi khusus untuk tulang radius dalam iDRG. Lateralisasi sudah tercakup dalam kode ICD-10 (kanan/kiri).
Pasien dengan diagnosis "Glaukoma sudut terbuka bilateral".	Glaukoma sudut terbuka bilateral	H40.1	-	Diagnosis bilateral → tidak diberikan kode lateralisasi.
Pasien dengan "Nyeri pinggang" tanpa pemeriksaan lebih lanjut.	Nyeri pinggang tidak spesifik	R10.2	-	Tidak ada spesifikasi organ atau sisi → tidak perlu kode lateralisasi.
Pasien didiagnosa "Tumor ginjal" tanpa spesifikasi sisi dalam rekam medis.	Tumor ginjal maligna tidak spesifik sisi	C64.9	-	Dokumentasi tidak menyebutkan sisi → tidak boleh menebak. Kode tanpa lateralisasi.

2. Aturan Pencatatan Tindakan Berulang dan Sesi Operasi (Setting dan Multiplicity)

Sistem *Indonesian Diagnosis Related Groups* (iDRG) menerapkan pengodean tindakan medis (prosedur) menggunakan skema yang lebih rinci untuk memastikan perhitungan intensitas sumber daya dan biaya perawatan yang lebih proporsional. Untuk mengakomodasi kompleksitas tindakan operatif dengan kode tindakan yang sama dan yang dilakukan secara berulang dalam satu episode perawatan, iDRG menerapkan konsep Setting dan Multiplicity sebagai kode ekstensi yang melekat pada kode dasar ICD-9-CM.

Pemberi kode di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib membaca laporan operasi dan catatan medis pasien secara teliti untuk menentukan nilai *Setting* dan *Multiplicity* yang tepat.

a. Definisi Setting dan Multiplicity

1) Setting (Sesi/Waktu Tindakan)

Setting menunjukkan urutan sesi operasi, waktu, atau hari dilakukannya suatu prosedur selama satu episode rawat inap pasien.

Satu setting dihitung berdasarkan satu kali pasien dijadwalkan dan masuk ke ruang tindakan/operasi. Jika pasien memerlukan prosedur lanjutan dengan kode ICD-9-CM yang sama pada hari yang berbeda atau pada sesi masuk ruang operasi yang berbeda, maka nilai setting akan bertambah.

2) Multiplicity (Jumlah/Lokasi Tindakan)

Multiplicity menunjukkan jumlah pengulangan tindakan yang sama, atau tindakan yang dilakukan pada beberapa lokasi/organ tubuh yang berbeda, di dalam satu sesi/waktu operasi yang sama.

Konsep ini juga berlaku untuk prosedur bilateral (sisi kiri dan kanan) yang dikerjakan sekaligus.

b. Pencatatan Sesi Tindakan (*Setting*) dan Jumlah Lokasi (*Multiplicity*)

Sistem iDRG mengakomodasi pengulangan tindakan medis untuk memastikan perhitungan biaya yang akurat. Aturan penginputannya adalah sebagai berikut:

1) *Setting* (Perbedaan Waktu/Sesi tindakan)

Kondisi: Tindakan yang sama diulang pada waktu atau sesi yang berbeda (misal: pagi dan sore, atau pada hari berikutnya).

Cara Input: Masukkan kembali kode ICD-9-CM yang sama pada **baris/entri baru** di aplikasi.

2) *Multiplicity* (Jumlah Lokasi pada Sesi yang Sama)

Kondisi: Tindakan yang sama dilakukan pada beberapa lokasi organ tubuh yang berbeda dalam **satu waktu/jadwal tindakan yang sama**.

Cara Input: Tambahkan tanda tambah (+) dan jumlah lokasi tepat di belakang kode dasar ICD-9-CM. Format: **[Kode] + [Jumlah Lokasi]**.

Batas Maksimal: Angka maksimal yang dapat diinput adalah **9** (misal: +9). Jika lebih dari 9 lokasi, tetap ditulis +9. (*Catatan: Jika jumlah lokasi hanya 1, cukup tulis +1 atau sesuaikan dengan standar default aplikasi*).

Contoh Penginputan: Seorang pasien dirawat selama 4 hari dengan diagnosis T31.2 (*Burns involving 20-29% of body surface*) mendapatkan tindakan operasi eksisi debridemen pada 3 lokasi luka bakar yang berbeda, yaitu lengan kiri bagian depan, dada, dan perut bagian depan yang dilakukan setiap hari pada 3 lokasi yang berbeda pembersihan luka (*wound debridement*) maka kode yang digunakan adalah 86.22 (*Excisional debridement of wound, infection, or burn*) dan

tambahkan jumlah lokasi *multiplicity*. Oleh karena itu, tindakan tersebut dicatat seperti contoh berikut:

The top screenshot shows the iDRG interface with a diagnosis of 'Burns involving 20-29% of body surface' (T31.2) and a procedure of 'Excisional debridement of wound, infection, or burn' (86.22) set as Primary with a multiplicity of 3. The bottom screenshot shows the same interface but with four instances of the procedure (86.22), each set as Secondary with a multiplicity of 3, and a 'Set Primary' button is visible.

Gambar C.1. *Setting dan Multiplicity*

3. Tata cara pengkodean multi speciality consultation dan persiapan operasi

Jika dokter melakukan pemeriksaan dan melakukan konsultasi ke spesialis lain untuk persiapan operasi, gunakan kode prosedur 89.070 (*Other Specialist Pre-operative Consultation*)^(IM).

Tabel C.2. Contoh kasus *multi speciality consultation* dan *pre op*

Contoh 1	Pasien mendapatkan rujukan dari FKTP ke dokter spesialis bedah dengan diagnosis Hernia Inguinal Unilateral. Dokter spesialis bedah menetapkan rencana tindakan pembedahan Herniorrhaphy Unilateral. Dokter spesialis bedah melakukan konsultasi internal persiapan operasi (<i>Multispecialty Pre-OP</i>) kepada dokter spesialis penyakit dalam. Dokter spesialis penyakit dalam melakukan pemeriksaan klinis mendalam serta pemeriksaan penunjang Elektrokardiogram. Hasil pemeriksaan didokumentasikan secara lengkap dalam resume medis dan dokumen konsultasi internal dengan kesimpulan pasien dinyatakan layak operasi. Pasien kemudian kembali ke dokter spesialis bedah untuk dilakukan tindakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="453 1906 767 1962">Diagnosis Dokter</td><td data-bbox="767 1906 1319 1962">Pengode Menetapkan Kode</td></tr> </table>	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode		

Diagnosis Utama	Hernia Inguinalis Unilateral	K40.9 <i>Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Tindakan	Herniorrhaphy Elektrokardiogram Konsultasi Internal Persiapan Operasi	53.00 <i>Other and open repair of inguinal hernia</i> 89.52 <i>Electrocardiogram</i> 89.070 <i>(Other Specialist Pre-operative Consultation)^(IM)</i>

Jika dokter melakukan pemeriksaan dan melakukan konsultasi ke spesialis lain, gunakan kode prosedur 89.071 (*Other Specialist Consultation*)^(IM).

Tabel C.3. Contoh kasus *multi speciality consultation* dan *pre op*

Contoh 2	Pasien mendapatkan rujukan dari FKTP ke dokter spesialis neurologi dengan diagnosa HNP dan dilakukan pemeriksaan klinis, pemeriksaan Rontgen pada area lumbal, dan pemeriksaan lab terdapat keluhan terkait dengan penyakit jantung. Dokter spesialis neurologi membuat dokumen konsultasi internal kepada dokter spesialis jantung. Dokter spesialis jantung melakukan pemeriksaan klinis dan mendiagnosis Atrial Fibrilasi (I48) dan mengisi dokumen konsultasi internal. pasien kembali ke dokter spesialis neurologi. Dokter mendiagnosis HNP dan Atrial Fibrilasi	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	HNP Lumbal	M51.6 <i>Other specified intervertebral disc displacement</i>
Diagnosis Sekunder	Atrial Fibrilasi	I48 <i>(Atrial fibrillation and flutter)</i>
Prosedur	Rontgen pada area lumbal Konsultasi Internal	87.24 <i>(Other x-ray of lumbosacral spine)</i> 89.071 <i>(Other Specialist Consultation)^(IM)</i>

4. MDC 10 Pre-MDC

Perhitungan jumlah jam (durasi) pemakaian ventilasi mekanik invasif kontinu, dimulai dari intubasi (endotrakeal) dan berakhir pada saat ekstubasi (endotrakeal). Jika pasien telah terintubasi sebelum masuk rumah sakit, maka perhitungan dimulai dari waktu saat pasien masuk rumah sakit dan dibuktikan dengan pemasangan ventilator. Jika pasien dirujuk dan masih terintubasi, maka durasi perhitungan ventilator berakhir pada saat pelepasan ventilator.

Jika selama pemakaian ventilasi mekanik invasif diawali dengan intubasi dan kemudian dilanjutkan dengan trakeostomi, maka durasi perhitungan dimulai dari waktu intubasi (endotrakeal) dan berakhir pada saat ventilasi mekanik invasif dihentikan.

Jika pasien dilakukan trakeostomi, jumlah jam pemakaian ventilasi mekanik invasif kontinu dihitung sejak ventilasi mekanik dimulai yang dibuktikan dengan pemasangan ventilator dan berakhir pada saat ventilasi mekanik invasif dihentikan.

Jika pasien telah dilakukan trakeostomi sebelum masuk rumah sakit, maka perhitungan dimulai dari waktu saat pasien masuk rumah sakit dan dibuktikan dengan pemasangan ventilator. Jika pasien dirujuk dan masih terpasang trakeostomi, maka durasi perhitungan ventilator berakhir pada saat pelepasan ventilator.

Note : Perhitungan intubasi ekstubasi 24 jam → aman → intubasi kembali (non continu)

5. MDC 11 Sistem Syaraf

Beberapa kondisi yang termasuk dalam bab ini dapat disebabkan oleh efek obat atau faktor eksternal lainnya. Kode dari Bab XX dapat digunakan sebagai kode tambahan (diagnosis sekunder) sesuai kebutuhan.

a. PENJELASAN KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 11

1) Meningitis (G00-G03)

Meningitis non infeksi akibat obat atau metastasis kanker harus dikodekan sesuai dengan etiologi spesifik.

Jika dokter mendiagnosis *bacterial meningitis* tetapi tidak diketahui jenis bakterinya, gunakan kode G00.9 (*Bacterial meningitis, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis meningitis yang disebabkan oleh bakteri tertentu misalnya *pneumococcal*, gunakan kode G00.1 (*Pneumococcal meningitis*).

Jika dokter mendiagnosis *meningitis* yang tidak spesifik, gunakan kode G03.9 (*Meningitis, unspecified*).

2) Encephalitis And Myelitis (G04-G05)

Jika dokter mendiagnosis *myelitis viral* (misalnya cytomegalovirus), gunakan kode G05.1* (*Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis in viral diseases classified elsewhere*) dan tambahkan kode virus yang sesuai.

Jika dokter mendiagnosis *viral transverse myelitis* tanpa menyebutkan jenis virusnya, gunakan kode G04.3 (*Viral transverse myelitis, unspecified*)^(IM).

Jika dokter mendiagnosis *myelitis* dan virus penyebab diketahui, gunakan kode B00.4† (*Herpesviral encephalitis*) + G05.1* (*Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis in viral diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *acute transverse myelitis* tanpa menyebutkan penyebab infeksi virusnya, gunakan kode G37.3 (*Acute transverse myelitis in demyelinating disease of the central nervous system*).

Jika dokter mendiagnosis terkait penyakit *demyelination* misalnya, *multiple sclerosis*, gunakan kode G35 (*Multiple sclerosis*). Jika disebabkan oleh penyakit autoimun, gunakan G04.81 *Encephalitis Autoimun*^(IM), Jika penyebab tidak diketahui, gunakan kode yang sesuai dengan diagnosis klinis utama.

3) Intracranial And Intraspinal Abscess And Granuloma (G06-G07)

Jika dokter mendiagnosis *abscess* atau *granuloma* di otak, baik yang berlokasi di *epidural*, *extradural*, maupun *subdural*, gunakan kode G06.0 (*Intracranial abscess and granuloma*).

Jika dokter mendiagnosis *abscess* atau *granuloma* ditemukan di sumsum tulang belakang, baik yang berlokasi di *epidural*, *extradural*, maupun *subdural*, gunakan kode G06.1 (*Intraspinal abscess and granuloma*).

Jika penyebab infeksi diketahui, maka kode etiologi harus digunakan sebagai diagnosis utama dan menambahkan kode abses atau granuloma. Contoh, jika dokter mendiagnosis abses otak disebabkan oleh *amoeba*, gunakan kode A06.6† (*Amoebic brain abscess*) dan tambahkan kode G07* (*Intracranial and intraspinal abscess and granuloma in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

4) *Sequelae of inflammatory diseases of central nervous system (G09)*

Kode G09 digunakan untuk mencatat kondisi sisa yang disebabkan oleh penyakit pada sistem saraf pusat yang diklasifikasikan di G00-G08, selama kode asalnya tidak bertanda *asterisk* (*). Kode ini mencakup kondisi sisa yang secara eksplisit dinyatakan sebagai ‘sekuel’, ‘*late effect*’, atau kondisi yang masih ada satu tahun atau lebih setelah penyakit awal.

Kode G09 tidak digunakan sebagai kode utama jika kondisi sisa (*residual*) sudah dicatat secara spesifik. Dalam pengodean untuk kondisi sisa, kode G09 dapat digunakan sebagai kode tambahan yang bersifat opsional. Perlu diperhatikan bahwa kondisi sisa dari kategori G01*, G02*, G05*, dan G07* tidak boleh dikodekan ke G09, melainkan harus dikodekan ke kategori yang memang disediakan untuk sekuel dari kondisi dasar tersebut, misalnya B90–B94.

Contoh 1:

Kondisi utama : Tuli akibat *meningitis tuberculosis*

Spesialisasi : THT

Kode yang digunakan sebagai “kondisi utama” adalah gangguan pendengaran, tidak spesifik (H91.9). Kode B90.0 (Sekuel *tuberculosis* sistem saraf pusat) dapat digunakan sebagai kode tambahan.

Contoh 2:

Kondisi utama : *Epilepsy* akibat *abscess* otak lama

Spesialisasi : *Neurology*

Kode yang digunakan sebagai “kondisi utama” adalah epilepsi, tidak spesifik (G40.9). Kode G09 (Sekuel penyakit inflamasi sistem saraf pusat) dapat digunakan sebagai kode tambahan.

Contoh 3:

Kondisi utama : Retardasi mental ringan setelah ensefalitis pasca imunisasi

Spesialisasi : Psikiatri

Kode yang digunakan sebagai “kondisi utama” adalah retardasi mental ringan (F70.9). Kode G09 (Sekuel penyakit inflamasi sistem saraf pusat) dapat digunakan sebagai kode tambahan.

5) ***Parkinsonism (G20-G22)***

Jika dokter mendiagnosis *parkinsonism* disebabkan oleh penggunaan obat tertentu (misalnya, *neuroleptic* atau *metoclopramide*), gunakan kode G21.1 (*Other drug-induced secondary parkinsonism*) dan tambahkan kode eksternal sesuai jenis obat penyebabnya, misalnya T43.4 (*Butyrophenone and thioxanthene neuroleptics*) untuk obat *neuroleptic*.

Jika dokter mendiagnosis *malignant neuroleptic syndrome*, gunakan kode G21.0 (*Malignant neuroleptic syndrome*) dan tambahkan kode eksternal sesuai jenis obat penyebabnya.

Jika dokter mendiagnosis *progressive supranuclear palsy*, gunakan kode G23.1 (*Progressive supranuclear ophthalmoplegia [Steele-Richardson-Olszewski]*).

Jika dokter mendiagnosis *multiple system atrophy*, *shy-drager syndrome*, atau *neurogenic orthostatic hypotension*, gunakan kode G90.3 (*Multi-system degeneration*). Jika terdapat komplikasi tambahan, seperti *hypotension orthostatic*, maka dapat menambahkan kode spesifik untuk kondisi tersebut. Misalnya sebagai berikut.

Contoh 1:

Diagnosis : *Parkinsonism* akibat *haloperidol*

Kode : G21.1 (*Other drug-induced secondary parkinsonism*)
T43.4 (*Butyrophenone and thioxanthene neuroleptics*)

Contoh 2:

Diagnosis : Sindrom *neuroleptic malignant* akibat *Fluphenazine*

Kode : G21.0 (*Malignant neuroleptic syndrome*)
T43.4 (*Butyrophenone and thioxanthene neuroleptics*)

Contoh 3:

Diagnosis : *Neurogenic orthostatic hypotension* [*Shy-Drager*]

Kode : G90.3 (*Multi-system degeneration*)
I95.2 (*Hypotension due to drugs*)

6) **Dystonia (G24)**

Dystonia termasuk didalamnya *Dyskinesia* termasuk dalam blok G24 Dystonia, untuk diagnosa *athetoid cerebral palsy* menggunakan kode G80.3.

Jika dokter mendiagnosis *dystonia* yang disebabkan oleh penggunaan obat tertentu, gunakan kode G24.0 (*Drug-induced dystonia*) dan tambahkan kode penyebab eksternal sesuai jenis obat yang menjadi penyebabnya. Contohnya, penggunaan obat *Neuroleptic* golongan *Phenothiazine* gunakan kode X41.- (*Accidental*) atau X61.- (*Intentional Self-harm*) atau Y11.- (*Undetermined Intent*) atau Y49.3 (*Adverse effect in Therapeutic use*) yang disesuaikan dengan kondisi sebab eksternal pasien dalam tabel obat di volume 3 ICD 10 tahun 2010.

Jika dokter mendiagnosis *spasmodic torticollis* atau *cervical dystonia*, gunakan kode G24.3 (*Spasmodic torticollis*).

7) **Alzheimer's Disease (G30)**

Penetapan kode dalam klasifikasi penyakit *Alzheimers* didasarkan pada usia seseorang saat gejala pertama kali muncul, yang memungkinkan pengelompokan kasus secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristik *onsetnya*. Kode G30.0 (*Alzheimer disease with early onset*) digunakan jika gejala muncul sebelum usia 65 tahun, yang dikenal sebagai *early-onset Alzheimer*. Sementara itu, kode G30.1 (*Alzheimer disease with late onset*) digunakan untuk kasus-kasus di mana gejala mulai muncul setelah usia 65 tahun, yang menunjukkan *onset* yang sedikit lebih lambat namun tetap termasuk dalam kelompok risiko tinggi. Kode G30.9 (*Alzheimer disease, unspecified*) diterapkan jika informasi mengenai usia *onset* tidak diketahui secara pasti atau tidak dapat ditentukan karena keterbatasan data.

8) **Epilepsy and Status Epilepticus (G40-G41)**

Jika dokter mendiagnosis epilepsi disertai adanya kejang yang diprovokasi (*reactive seizures*), seperti kejang yang disebabkan oleh obat-obatan, perubahan hormon, gangguan tidur atau stress, maka gunakan kode G40.5 (*Special epileptic syndromes*). Jika kejang disebabkan oleh obat-obatan tertentu, maka tambahkan kode penyebab yang tercantum dalam Chapter XX (*External causes of morbidity and mortality*), seperti Y47.1 untuk *benzodiazepin*.

Jika diagnosis menunjukkan adanya status *epilepticus* maka kode yang digunakan adalah G41 (*Status epilepticus*).

Jika dokter mendiagnosis epilepsi yang tidak spesifik, maka gunakan kode G40.9 (*Epilepsy, unspecified*).

Tabel C.4. Contoh kasus untuk epilepsi umum

Contoh 1	Seorang pasien sedang duduk tiba tiba jatuh, kemudian tubuh kaku diikuti gerakan kelonjotan seluruh tubuh, mata melirik ke atas, mata tidak responsif terdapat busa di mulut. Setelah kejang, pasien tampak bingung. Dokter mendiagnosis epilepsi umum.
-----------------	---

	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Epilepsi umum	G40.3 <i>Generalized idiopathic Epilepsy and epileptic syndromes</i>
Diagnosis Sekunder	-	-

Tabel C.5. Contoh kasus untuk epilepsi fokal

Contoh 2	Seorang laki-laki sedang menaiki tangga di rumah, kemudian terjadi serangan epilepsy/kejang yang menyebabkan pasien terjatuh dari tangga. Terdapat luka terbuka di dahi dan sampai di rumah sakit pasien masih mengalami kejang. Dokter mendiagnosis epilepsi fokal dan luka terbuka di dahi. Selama perawatan pasien dilakukan observasi kejang dan diberikan obat anti epilepsi serta dilakukan tindakan jahit luka di dahi	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Epilepsi Fokal	G41.1 <i>(Localization-related (focal)(partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with simple partial seizures)</i>
Diagnosis Sekunder	Luka terbuka di dahi	S01.8 <i>Open wound of other parts of head</i>
Penyebab Eksternal	Jatuh dari tangga di rumah akibat serangan Epilepsy	W10.09 <i>Fall on and from stairs and steps, Home, During unspecified activity</i>
Prosedur	Jahit luka di dahi	86.59 <i>(Closure of skin and subcutaneous tissue of other sites)</i>

Tabel C.6. Contoh kasus untuk *epidural haemorrhage*

Contoh 3	Seorang laki-laki sedang menaiki tangga di rumah, kemudian terjadi serangan epilepsy/kejang yang menyebabkan pasien terjatuh dari tangga. Setelah dilakukan pemeriksaan klinis dan radiologis ditemukan <i>Epidural haemorrhage</i> . Dokter mendiagnosis <i>Epidural haemorrhage</i> dan epilepsi fokal. Pasien dilakukan tindakan kraniotomi evakuasi hematoma. Selama perawatan, juga dilakukan observasi kejang dan diberikan obat anti epilepsi.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Epidural haemorrhage</i>	S06.4 <i>(Epidural haemorrhage)</i>
Diagnosis Sekunder	Epilepsi Fokal	G41.1 <i>(Localization-related (focal) (partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with simple partial seizures)</i>
Penyebab Eksternal	Jatuh dari tangga di rumah akibat serangan Epilepsy	W10.09 <i>Fall on and from stairs and steps, Home, During unspecified activity</i>

Prosedur	Kraniotomi evakuasi hematom	01.31 (<i>Incision of cerebral meninges</i>)
-----------------	-----------------------------	--

9) ***Migraine and Headache (G43-G44)***

Jika dokter mendiagnosis *migraine* gunakan kode pada blok G43 sesuai dengan jenis *migraine* yang ditegakkan oleh dokter. Contoh : Jika dokter mendiagnosis *status migrainosus*, gunakan kode G43.2 (*Status migrainosus*). Jika *migraine* disebabkan oleh sebab luar tambahkan juga kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi sebab luarnya.

Jika dokter mendiagnosa *tension-type headache* gunakan kode G44.2 (*Tension-type headache*).

Penetapan kode untuk kondisi sakit kepala didasarkan pada penyebab yang diketahui atau detail spesifik diagnosis. Jika penyebab sakit kepala dapat diidentifikasi, gunakan kode penyebabnya. Contoh, jika disebabkan oleh infeksi sinus akut, gunakan kode J01.- (*Acute sinusitis*). Namun, jika diagnosis hanya mencantumkan sakit kepala tanpa diketahui penyebabnya setelah dilakukan pemeriksaan, gunakan kode R51.0 (*Headache, unspecified*)^(IM) untuk menggambarkan sakit kepala yang tidak spesifik.

10) ***Transient Ischaemic Attack (TIA) (G45)***

Pengodean untuk kasus (*Transient Ischemic Attack/TIA*) dapat diberikan kode G45.- sesuai jenis sindrom yang diidentifikasi oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki gangguan sementara pada aliran darah otak (*Transient Ischemic Attack/TIA*) atau sindrom terkait. Kode ini mencakup berbagai kondisi yang disebabkan oleh *ischaemic* sementara atau *insufficiency vascular* otak, dengan sub-kategori yang lebih spesifik tergantung pada manifestasi klinis pasien.

Jika dokter mendiagnosis *vertebro-basilar artery syndrome*, gunakan kode G45.0 (*Vertebro-basilar artery syndrome*).

11) ***Sleep Apnoea (G47.3)***

Jika dokter mendiagnosis *sleep apnoea* tanpa menyebutkan penyebabnya, gunakan kode G47.3 (*Sleep apnoea*). Jika dokter mendiagnosis *central sleep apnoea* tanpa menyebutkan penyebabnya, gunakan kode G47.31 (*Central sleep apnoea syndrome*)^(IM).

Jika dokter mendiagnosis *obstructive sleep apnoea* tanpa menyebutkan penyebabnya, gunakan kode G47.32 (*Obstructive sleep apnoea*)^(IM).

Jika dokter menyebutkan penyebab dari *sleep apnoea*, seperti hipertrofi tonsil dengan hipertrofi adenoid atau rhinitis kronis atau deviasi septum hidung atau hipertrofi konka hidung, maka gunakan kode penyebab dan tambahkan kode G47.3 (*Sleep apnoea*).

Tabel C.7. Contoh kasus *sleep apnoea and snoring*

Contoh 4	Seorang pasien anak yang mengalami keluhan mendengkur. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosis bahwa anak tersebut mengalami <i>sleep apnoea</i> , yang kemudian dipastikan melalui hasil <i>polysomnography</i> . Penyebab utama dari kondisi ini adalah pembesaran amandel disertai adenoid dan dilakukan <i>adenoidectomy</i> serta <i>tonsillectomy</i>	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Hypertrophy</i> amandel dan kelenjar gondok	J35.3 <i>Hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Sleep apnoea</i>	G47.3 <i>Sleep apnoea</i>
Operasi	<i>Tonsillectomy</i> dengan <i>adenoidectomy</i>	28.3 <i>Tonsillectomy with adenoidectomy</i>

12) Cranial Nerve Disorders (G50-G53)

Pengodean untuk kasus *cranial nerve disorders* gunakan kode G50-G53 sesuai dengan jenis kelainan dan lokasi saraf kranial yang terkena. Jika dokter mendiagnosis adanya kelainan pada *trigeminal nerve*, gunakan kode dalam kelompok G50.- (*Disorders of trigeminal nerve*). Jika dokter mendiagnosis adanya gangguan pada *facial nerve*, gunakan kode dalam kelompok G51.- (*Facial nerve disorders*). Jika dokter mendiagnosis kelainan yang melibatkan saraf kranial lainnya selain *trigeminal* dan *facial nerve*, gunakan kode dalam kelompok G52.- (*Disorders of other cranial nerves*).

Jika dokter mendiagnosis kelainan pada beberapa saraf kranial secara bersamaan, seperti kasus *Tolosa-Hunt syndrome* tanpa penyebab spesifik, gunakan kode G52.7 (*Disorders of multiple cranial nerves*). Jika dokter mendiagnosis penyebab dari *cranial nerve disorders*, gunakan kode penyebab dan tambahkan kode kelainan saraf kranial.

Tabel C.8. Contoh kasus *cranial nerve disorders*

Contoh 5	Pasien dengan kanker pada atap nasofaring dengan kelumpuhan pada beberapa saraf otak (<i>multiple cranial nerve palsies</i>).	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Carcinoma pada atap nasofaring	C11.0† <i>Superior wall of nasopharynx</i>
Diagnosis Sekunder	Beberapa kelumpuhan saraf kranial	G53.3* <i>Nerve root and plexus compressions in other dorsopathies</i>

Tabel C.9. Contoh kasus *cranial nerve disorders*

Contoh 6	Pasien yang mengalami trombosis sinus kavernosus dengan kelumpuhan pada beberapa saraf otak (<i>multiple cranial nerve palsies</i>).
-----------------	--

	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Thrombosis sinus cavernosus	I67.6 <i>Nonpyogenic thrombosis of intracranial venous system</i>
Diagnosis Sekunder	Beberapa kelumpuhan saraf kranial	G53.8* <i>Other cranial nerve disorders in other diseases classified elsewhere</i>

13) **Polyneuropathy (G61-G63)**

Jika dokter mendiagnosis penyebab *polyneuropathy*, gunakan kode penyebab dan tambahkan kode dalam kelompok G63.- (*Polyneuropathy in diseases classified elsewhere*).

Dalam kasus *polyneuropathy* karena keracunan obat atau zat beracun kode penyebab eksternal (V01-Y98) yang relevan harus ditambahkan untuk memberikan informasi lebih spesifik tentang penyebabnya. Selain itu, jika dokter mendiagnosis *Guillain-Barré syndrome*, gunakan kode G61.0 *Guillain-Barré syndrome*, sedangkan untuk *Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy* (CIDP), gunakan kode G61.8 *Other inflammatory polyneuropathies*.

Contoh 1: Jika dokter mendiagnosis pasien dengan kanker paru-paru yang disertai polineuropati, gunakan kode C34.9 (*Bronchus or lung, unspecified*) dan tambahkan kode G63.1* (*Polyneuropathy in neoplastic disease*).

Contoh 2: Jika dokter mendiagnosis pasien dengan penyakit DM *unspecified* yang disertai *polyneuropathy*, gunakan kode E14.4† (*DM unspecified with neurological complications*) dan tambahkan kode G63.2* (*Diabetic polyneuropathy*).

14) **Myopathy (G70-G73)**

Jika dokter mendiagnosis periodic paralysis dan ditemukan kondisi kelemahan otot (*Myopathy*) cukup dikode G72.3 (*Periodic Paralysis*) dan kondisi kelemahan otot (*Myopathy*) tidak dikode terpisah.

Dalam kasus di mana *myopathy* disebabkan oleh infeksi, gangguan kelenjar endokrin, atau penyakit autoimun, kode dari penyakit penyebab utama harus digunakan sebagai kode diagnosis utama, sedangkan kode dalam kelompok G73.4 – G73.7 digunakan sebagai kode diagnosis tambahan untuk menunjukkan adanya keterkaitan dengan *myopathy*.

Tabel C.10. Contoh kasus myopathy

Contoh 7	Dokter mendiagnosis pasien dengan miopati yang disebabkan oleh SLE. Dokter memberikan tatalaksana SLE dan miopati	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode

Diagnosis Utama	Lupus eritematosus sistemik	M32.1† <i>Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement</i>
Diagnosis Sekunder	Miopati	G73.7* <i>Myopathy in other diseases classified elsewhere</i>

15) Sindrom Paralitik (G81–G83)

Kode Sindrom Paralitik (G81–G83) tidak digunakan sebagai diagnosis utama jika terdapat penyebab yang mendasarinya telah dicatat sebagai diagnosis utama, kecuali jika episode perawatan memang difokuskan pada kelumpuhan itu sendiri. Kategori ini hanya digunakan sebagai diagnosis utama apabila kode dalam kategori ini dicatat tanpa spesifikasi lebih lanjut, atau disebut sebagai kondisi lama/telah berlangsung lama tanpa menyebutkan rincian penyebabnya. Kategori ini juga digunakan untuk kode ganda sebagai diagnosis sekunder untuk mengidentifikasi jenis hemiplegia berdasarkan penyebabnya.

Contoh 1: Jika dokter mendiagnosis stroke tidak spesifik, apakah perdarahan atau infark, dan disertai dengan hemiplegia tidak spesifik, maka gunakan kode I64 (*Stroke, not specified as haemorrhage or infarction*) dan tambahkan kode G81.9 (*Hemiplegia, unspecified*).

Contoh 2: Jika dokter mendiagnosis adanya riwayat *cerebral infarction* tiga tahun lalu dan disertai dengan kelumpuhan kaki kiri, maka gunakan kode G83.1 (*Monoplegia of lower limb*) dan tambahkan kode I69.3 (*Sequelae of cerebral infarction*).

Contoh 3: Jika dokter mendiagnosis stroke iskemik akibat emboli pada arteri serebral dan disertai dengan hemiplegia spastic, maka gunakan kode I63.4 (*Cerebral infarction due to embolism of cerebral arteries*) dan tambahkan G81.1 (*Spastic Hemiplegia*).

Kode dalam kelompok G81.- (*Hemiplegia*) digunakan sebagai kode diagnosis utama hanya jika dokter mendiagnosis pasien mengalami kelumpuhan separuh tubuh (*hemiplegia*), baik bersifat permanen maupun sementara tanpa detail tambahan seperti durasi atau penyebab spesifik. Kode ini juga dapat digunakan sebagai kode diagnosis tambahan untuk mengidentifikasi jenis kelumpuhan separuh tubuh, terlepas dari penyebabnya.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa kode I67.1 dan I67.4 – I67.9 tidak digunakan untuk kondisi sisa (*sequelae*), yang mengacu pada kondisi yang timbul akibat penyakit sebelumnya, baik efek jangka panjang maupun hasil yang muncul setelah satu tahun atau lebih. Oleh karena itu, jika dokter menentukan bahwa *Hemiplegia* adalah hasil dari *sequelae stroke*, maka kode I69.- (*Sequelae of cerebrovascular disease*) harus ditetapkan pada kondisi sekunder dari *Hemiplegia*, karena dengan demikian akan sesuai dengan kaidah pengodean morbiditas, yang menunjukkan bahwa *hemiplegia* adalah masalah saat ini dan merupakan satu-satunya kondisi yang mendasari kunjungan medis dan kausa adalah kondisi yang sudah tidak terdapat lagi namun memberikan efek sisa (*Late effect*).

Tabel C.11. Contoh kasus sindrom paralitik

Contoh 8	Pasien adalah seorang pria berusia 56 tahun. Dokter mendiagnosis bahwa anggota tubuh sebelah kanan pasien mengalami kelemahan dan kelumpuhan. Kondisi ini disebabkan oleh pecahnya <i>artery cerebral</i> yang terjadi empat bulan lalu. Saat ini, pasien sedang menjalani latihan terapi fisik dengan pendampingan untuk membantu pemulihan fungsi tubuhnya.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Kelumpuhan <i>hemiplegia</i> kanan	G81.0 <i>Flaccid hemiplegia</i>
Diagnosis Sekunder	Gejala sisa perdarahan intraserebral	I69.1 <i>Sequelae of intracerebral haemorrhage</i>
Prosedur	Latihan terapi fisik dengan pendampingan	93.11 <i>Assisting Exercise</i>

Tabel C.12. Contoh kasus sindrom paralitik

Contoh 9	Pasien adalah seorang pria berusia 67 tahun. Dokter mendiagnosis adanya kelemahan dan kekakuan pada tungkai kiri pasien, yang merupakan akibat dari <i>stroke</i> yang dialami satu tahun lalu. Saat ini, pasien telah diterima untuk menjalani latihan terapi fisik dengan pendampingan.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Hemiplegia kejang kiri	G81.1 <i>Spastic hemiplegia</i>
Diagnosis Sekunder	Gejala sisa infark serebral	I69.3 <i>Sequelae of cerebral infarction</i>
Prosedur	Latihan terapi fisik dengan pendampingan	93.11 <i>Assisting exercise</i>

16) ***Hydrocephalus* (G91, G94, Q03)**

Semua jenis *hydrocephalus* menggunakan kode dalam kelompok G91.- (*Hydrocephalus*) sesuai dengan diagnosis yang diberikan oleh dokter. Namun, jika dokter mendiagnosis *hydrocephalus congenital*, maka kode dalam kelompok Q03.- (*Congenital Hydrocephalus*) harus digunakan sesuai dengan spesifikasi diagnosis.

Dalam kasus di mana dokter menegaskan diagnosis bahwa *hydrocephalus* disebabkan oleh infeksi atau kanker, kode untuk penyakit utama (penyebab) harus digunakan sebagai diagnosis utama. Selain itu, kode berikut dapat ditambahkan sebagai diagnosis tambahan:

G94.0* untuk *hydrocephalus* yang terjadi pada penyakit infeksi dan parasit yang diklasifikasikan di tempat lain

G94.1* untuk *hydrocephalus in neoplastic disease*.

Dengan demikian, pengodean ini memastikan bahwa penyebab utama *hydrocephalus* telah diidentifikasi secara jelas, sementara kode tambahan memberikan informasi spesifik tentang kondisi *hydrocephalus* yang terkait.

17) Cerebrovascular Accident (CVA) (I60-I64)

Istilah seperti "*cerebrovascular accident*" atau "*stroke*" dianggap tidak spesifik, sehingga sebaiknya tidak menggunakan kode I64 (*Stroke, not specified as haemorrhage or infarction*), kecuali apabila telah dilakukan pemeriksaan masih tidak ditemukan kode yang lebih spesifik. Prioritaskan penggunaan kode yang lebih spesifik, dengan memilih dari kode-kode berikut:

I60.- (*Subarachnoid haemorrhage*).

I61.- (*Intracerebral haemorrhage*).

I62.- (*Other nontraumatic intracranial haemorrhage*)

I63.- (*Cerebral infarction*)

Ketika dokter mendiagnosis perdarahan *intracerebral*, kode harus diberikan secara rinci dalam kelompok I61.-. Untuk kondisi perdarahan otak yang disebabkan oleh trauma eksternal, gunakan kode S06.- (*traumatic intracranial haemorrhage*).

Ketika dokter mendiagnosis infark serebral, kode harus diberikan secara rinci dalam kelompok I63.- (*Cerebral infarction*) untuk menentukan apakah kondisi tersebut disebabkan oleh emboli atau trombosis, serta untuk menentukan lokasi pembuluh darah, apakah di *artery cerebral* atau *precerebral*.

Selain itu, kode tambahan dari kelompok G46.-* (*Vascular syndrome of brain in cerebrovascular disease*) harus diberikan sebagai diagnosis tambahan untuk menentukan pembuluh darah mana yang terkena kelainan tersebut.

18) Other Cerebrovascular Disease (I65-I68)

Jika dokter mendiagnosis *Occlusion* atau *stenosis* pada *artery precerebral* atau *cerebral* yang tidak menyebabkan *cerebral infarction*, gunakan kode sebagai berikut: I65.- (*Occlusion and stenosis of precerebral arteries, not resulting in cerebral infarction*) untuk kasus pada *artery precerebral*, dan I66.- (*Occlusion and stenosis of cerebral arteries, not resulting in cerebral infarction*) untuk kasus pada *artery cerebral*.

Jika dokter mendiagnosis *cavernous sinus thrombosis*, gunakan kode I67.6 (*Nonpyogenic thrombosis of intracranial venous system*).

Jika dokter mendiagnosis *cerebral arteritis* pada pasien dengan *systemic lupus erythematosus* (SLE), gunakan kode M32.1† (*Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement*), dan tambahkan kode I68.2* (*Cerebral arteritis in other diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

19) *Sequelae of Cerebrovascular Diseases (I69.-)*

Kode ini tidak digunakan sebagai kondisi utama jika sifat dari kondisi sisa (*residual*) sudah dicatat secara spesifik. Saat mengkode kondisi sisa tersebut, kode I69.- (*Sequelae of Cerebrovascular Diseases*) dapat digunakan sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis *old cerebrovascular accident* disertai dengan kelainan neurologis residu yang masih tersisa, gunakan kode untuk kelainan neurologis residu tersebut sebagai kode utama, kemudian tambahkan kode dari kelompok I69.- (*Sequelae of cerebrovascular accident*) sebagai kode tambahan. Namun, jika dokter menentukan bahwa tidak ada kelainan neurologis residu yang tersisa (pasien telah pulih sepenuhnya), gunakan kode Z86.7 (*Personal history of diseases of the circulatory system*).

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 11

- 1) Pasien yang mendapatkan Injeksi/infus thrombolytic agent, gunakan kode 99.10 (*Injection or infusion of thrombolytic agent*).
- 2) Kondisi *myopathy* (kelemahan otot) yang menyertai diagnosis *periodic paralysis* tidak dikode secara terpisah, melainkan digabung menjadi satu dengan kode G72.3 (*Periodic Paralysis*).
- 3) Jika pasien *epilepsy* dirawat akibat luka yang terjadi saat serangan, maka diagnosis *injury* menjadi diagnosis utama dan dapat menambahkan kode sebab luar yang relevan.
- 4) Untuk tindakan di MDC 11 yang berkaitan dengan kelenjar pituitari dan/atau pineal, maka menggunakan kode 07.19 (*Other diagnostic procedures on adrenal glands, pituitary gland, pineal gland, and thymus*).
- 5) Pada kode tindakan *adhesiolysis spinal cord* dan *nerve root* dengan teknik injeksi steroid dan analgetik, jika disesuaikan dengan ICD-9-CM tahun 2010, maka *adhesiolysis* (*Lysis Adhesion*) dengan tindakan tumpul, menggunakan jari-jemari, manual mekanik, dan tanpa instrumen merupakan *omit code* (tidak dikoding).

Contoh 1: Jika dokter melakukan tindakan *adhesiolysis spinal cord* dan *nerve root* dengan teknik injeksi *triamcinolone* 80 mg (*steroid*) pada *spinal root*, gunakan kode 03.92 (*Injection of other agent into spinal canal*)

- 6) Jika dokter melakukan tindakan prosedur diagnostik pada tulang tengkorak mencakup tindakan invasif ringan atau pemeriksaan fisik langsung pada tulang tengkorak, namun bukan prosedur biopsi atau tes pencitraan rutin seperti rontgen, transiluminasi tengkorak atau CT Scan/MRI gunakan kode 01.19 *Other diagnostic procedures on skull*.

6. **MDC 12 MATA & ADNEXA**

a. **PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 12**

1) ***Conjunctivitis (H10.-)***

Jika dokter mendiagnosis *conjunctivitis* disertai cairan yang bersifat *mucopurulent* atau *purulent*, gunakan kode H10.0 (*Mucopurulent conjunctivitis*).

Jika dokter mendiagnosis *allergic conjunctivitis*, gunakan kode H10.1 (*Acute atopic conjunctivitis*).

Jika ditemukan penyebab spesifik dari *conjunctivitis*, maka diagnosis utama disesuaikan dengan penyebab spesifiknya diikuti dengan diagnosa tambahan *conjunctivitis*. Misalnya: Jika dokter mendiagnosis *adenoviral conjunctivitis*, gunakan kode B30.1† (*Viral conjunctivitis due to adenovirus*) dan tambahkan kode H13.1* (*Conjunctivitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *Hemorrhagic conjunctivitis (enteroviral)*, gunakan kode B30.3† (*Acute epidemic haemorrhagic conjunctivitis [enteroviral]*) dan tambahkan kode H13.1* (*Conjunctivitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *epidemic keratoconjunctivitis*, gunakan kode B30.0† (*Epidemic keratoconjunctivitis*) dan tambahkan kode H19.2* (*Keratitis and keratoconjunctivitis in other infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).

2) ***Pinguecula and Pterygium (H11.0–H11.1)***

Jika dokter mendiagnosis *pterygium* pada mata termasuk *pterygium unilateral* (hanya satu mata) atau *bilateral* (kedua mata), serta *pterygium* yang disertai gangguan penglihatan gunakan kode H11.0 (*Pterygium*).

Jika dokter mendiagnosis adanya pinguecula atau pingueculitis, gunakan kode H11.1 (*Conjunctival degenerations and deposits*).

Tabel C.13. Contoh kasus *pinguecula* dan *pterygium*

Contoh 1	Dokter mendiagnosis pasien dengan <i>pterygium</i> , kemudian melakukan tindakan pengobatan berupa eksisi (pengangkatan) jaringan <i>pterygium</i> dengan <i>transposition of Pterygium</i>	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Pterygium</i>	H11.0 <i>Pterygium</i>
Prosedur	Eksisi <i>pterygium</i> dengan <i>transposition of Pterygium</i>	11.31 <i>Transposition of pterygium</i>

Tabel C.14. Contoh kasus *pinguecula* dan *pterygium*

Contoh 2	Dokter mendiagnosis pasien dengan <i>pterygium</i> , kemudian melakukan tindakan pengobatan berupa injeksi di subkonjungtiva.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Pterygium</i>	H11.0 <i>Pterygium</i>
Prosedur	Injeksi di subkonjungtiva	10.91 <i>Subconjunctival injection</i>

3) **Corneal Scar (H17)**

Jika dokter mendiagnosis *corneal scar*, gunakan kode dari kelompok H17.- (*Corneal scars and opacities*) berdasarkan karakteristik dan lokasi bekas luka / jaringan parutnya.

Jika dokter mendiagnosis bahwa bekas luka berada di pusat kornea, gunakan kode H17.1 (*Other central corneal opacity*).

Jika dokter mendiagnosis bahwa bekas luka berada di area lain dari kornea, gunakan kode H17.8 (*Other corneal scars and opacities*).

4) **Contact Lens Intolerance**

Pada kasus *contact lens intolerance*, penentuan kode utama harus didasarkan pada kelainan mata yang ditemukan selama pemeriksaan. Berikut adalah panduan pengodean:

Jika dokter mendiagnosis *Papillary conjunctivitis* (misalnya *giant papillary conjunctivitis*), gunakan kode H10.1 (*Acute atopic conjunctivitis*).

Jika dokter mendiagnosis *Corneal abrasion* atau *corneal erosion*, gunakan kode H18.8 (*Other specified disorders of cornea*).

Jika dokter mendiagnosis Edema kornea atau *staining* pada posisi 3 dan 9 o'clock, gunakan kode H18.2 (*Other corneal oedema*).

Selain itu, tambahkan kode penyebab eksternal Y77.2 (*Ophthalmic devices associated with adverse incidents*) untuk menunjukkan bahwa masalah tersebut terkait dengan penggunaan alat *ophthalmology* (seperti lensa kontak).

5) ***Uveitis (H20-H22, H30, H32)***

Untuk kasus di mana dokter mendiagnosis peradangan di ruang anterior bola mata (*anterior uveitis, iritis, siklitis, atau iridocyclitis*):

Jika dokter menyebutkan penyebab peradangan di ruang anterior bola mata, gunakan kode berikut:

Jika dokter mendiagnosis penyebabnya karena lensa mata, misalnya *phacolytic uveitis* (akibat lensa mata katarak) atau *phacoanaphylactic uveitis* (akibat pecahnya lensa atau sisa lensa setelah operasi), gunakan kode H20.2 (*Lens-induced iridocyclitis*).

Jika dokter mendiagnosis penyebabnya karena infeksi, gunakan kode H22.0 (*Iridocyclitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*), dengan tambahan kode penyakit infeksi penyebabnya.

Jika dokter mendiagnosis penyebabnya karena infeksi cacar air, gunakan kode B01.8† (*Varicella with other complications*), dengan kode tambahan H22.0* (*Iridocyclitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*)

Jika dokter mendiagnosis bahwa kondisi ini disebabkan oleh atau terkait dengan penyakit sistemik, gunakan kode H22.1* (*Iridocyclitis in other diseases classified elsewhere*) sebagai diagnosis tambahan dan gunakan diagnosis utama sesuai penyakit yang mendasarinya. misalnya jika dokter mendiagnosa *Ankylosing spondylitis dengan Iridocyclitis*, gunakan kode M45.0† (*Ankylosing spondylitis*) dan tambahkan kode H22.1* (*Iridocyclitis in other diseases classified elsewhere*)

Jika dokter mendiagnosis *Fuchs heterochromic iridocyclitis*, gunakan kode H20.8 (*Other iridocyclitis*). Jika dokter mendiagnosis *anterior uveitis* yang terjadi bersamaan dengan *Vogt-Koyanagi-Harada disease*, gunakan kode H20.8 (*Other iridocyclitis*).

Kasus di mana dokter mendiagnosis adanya peradangan di bagian posterior bola mata (*posterior uveitis, choroiditis, chorioretinitis, retinitis, atau retinal vasculitis*) dan jika dokter tidak menyebutkan penyebab peradangan, gunakan kode berdasarkan pola distribusi peradangan yang ditemukan:

Jika dokter mendiagnosis bahwa peradangan terjadi hanya pada satu titik, atau tersebar dalam bercak tetapi tidak lebih dari 1 kuadran, gunakan kode H30.0 (*Focal chorioretinal inflammation*).

Jika dokter mendiagnosis bahwa peradangan tersebar dalam banyak bercak, melibatkan lebih dari 1 kuadran, atau sangat parah hingga mencakup seluruh retina termasuk diagnosis sindrom *white dots syndrome* (WDS) seperti: *Multiple Evanescent White Dots Syndrome* (MEWDS), *Acute Posterior Multifocal Placoid Pigment Epitheliopathy* (APMPPE), *Multifocal Choroiditis With Panuveitis* (MCP), *Birdshot Chorioretinopathy* (BSCR), *Serpiginous Choroidopathy* (SC), *Punctate Inner Choroidopathy* (PIC),

Acute Zonal Occult Outer Retinopathy (AZOOR), dan *Acute Retinal Pigment Epitheliitis (ARPE)*, gunakan kode H30.1 (*Disseminated chorioretinal inflammation*).

Jika dokter mendiagnosis adanya peradangan di bagian posterior bola mata dan menyebutkan penyebab peradangan, gunakan kode berdasarkan penyebabnya sebagai berikut:

Jika dokter mendiagnosis bahwa peradangan disebabkan oleh infeksi, gunakan kode H32.0* (*Chorioretinal inflammation in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*), dengan tambahan kode penyakit infeksi penyebabnya, misalnya:

Jika disebabkan oleh virus herpes, gunakan kode B00.5† (*Herpesviral ocular disease*), dan tambahkan kode H32.0* (*Chorioretinal inflammation in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).

Jika disebabkan oleh toksoplasma, gunakan kode B58.0† *Toxoplasma oculopathy*, dan tambahkan kode H32.0* (*Chorioretinal inflammation in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis bahwa kondisi ini disebabkan oleh atau terkait dengan penyakit sistemik, gunakan kode H32.8* (*Other chorioretinal disorders in diseases classified elsewhere*).

Kasus di mana dokter mendiagnosis *panuveitis* atau *endophthalmitis*:

Jika diagnosis menyebutkan bahwa kondisi ini disebabkan oleh infeksi dan jenis infeksi spesifik telah dinyatakan, gunakan kode H45.1* (*Endophthalmitis in diseases classified elsewhere*), dengan tambahan kode penyakit infeksi penyebabnya, misalnya:

Jika dokter mendiagnosis *endophthalmitis* disebabkan oleh infeksi cacing pita (*cysticercosis*), gunakan kode B69.1† (*Cysticercosis of eye*), dan tambahkan kode H45.1* (*Endophthalmitis in diseases classified elsewhere*)

Jika dokter mendiagnosis bahwa kondisi ini disebabkan oleh atau terkait dengan penyakit sistemik, yang sering kali dokter sebut sebagai *panuveitis* alih-alih *non-infectious endophthalmitis*, gunakan kode H45.1* (*Endophthalmitis in diseases classified elsewhere*), dan tambahkan kode penyakit penyebabnya.

Jika dokter mendiagnosis bahwa kondisi ini tidak disebabkan oleh infeksi, tidak terkait dengan penyakit sistemik, atau penyebabnya tidak dapat ditentukan, gunakan kode H44.1 (*Other endophthalmitis*).

Dalam kasus di mana dokter mendiagnosis *masquerade syndrome* dan menyebutkan jenis kanker sebagai penyebabnya, gunakan kode untuk jenis kanker tersebut sebagai diagnosis utama, misalnya: C69.2 (*Malignant neoplasm of retina*), atau C83.3 (*Diffuse large B-cell lymphoma*), sebagai kode diagnosis utama. Kode untuk jenis uveitis digunakan sebagai diagnosis tambahan. Namun,

jika penyebabnya tidak disebutkan, gunakan kode untuk jenis uveitis sebagai diagnosis utama.

6) **Retinal Procedures**

Jika dilakukan beberapa prosedur operasi, berikan kode untuk prosedur operasi sesuai dengan ringkasan yang disebutkan oleh dokter dalam *resume medis* (ringkasan pulang).

Tabel C.15. Contoh kasus *retinal procedures*

Contoh 3	Dokter mendiagnosis pasien mengalami ablasio retina serosa (<i>retinal detachment</i>), kemudian melakukan tindakan <i>vitrectomy</i> dengan mengangkat cairan vitreus.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Ablasio Retina serosa	H33.2 (<i>Serous retinal detachment</i>)
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	<i>Vitrectomy</i>	14.74 (<i>Other mechanical vitrectomy</i>)

Tabel C.16. Catatan operasi dokter pada *resume medis* pada kasus *retinal procedures* beserta kode bedah

Catatan Operasi Dokter pada Resume Medis	Kode Bedah
<i>Vitrectomy</i> dengan antibiotik intravitreal	14.74 <i>Other mechanical vitrectomy</i>
	14.79 <i>Other operations on vitreous</i>
<i>Pars plana vitrectomy</i> (PPV) dengan prosedur gesper skleral endolaser dengan tamponade minyak silikon	14.74 <i>Other mechanical vitrectomy</i>
	14.49 <i>Other scleral buckling</i>
	14.54 <i>Repair of retinal detachment with laser photocoagulation</i>
	14.75 <i>Injection of vitreous substitute</i>

7) **Cataract (H25-H26)**

Kode untuk operasi pengobatan katarak diberikan berdasarkan jenis operasi yang dicatat oleh dokter. Berikut ringkasannya:

Tabel C.17. Catatan operasi dokter pada *resume medis* pada kasus *cataract* beserta kode bedah

Catatan Operasi Dokter pada Resume Medis	Kode Bedah
Ekstraksi katarak intrakapsular (ICCE)	13.19 <i>Other intracapsular extraction of lens</i>

Ekstraksi katarak ekstrakapsular (ECCE)	13.2	<i>Extracapsular extraction of lens by linear extraction technique</i>
Aspirasi lensa atau Irigasi katarak traumatis	13.3	<i>Extracapsular extraction of lens by simple aspiration (and irrigation) technique</i>
Fakoemulsifikasi (PE)	13.41	<i>Phacoemulsification and aspiration of cataract</i>
Lensektomi Pars plana (PPL)	13.42	<i>Mechanical phacofragmentation and aspiration of cataract by posterior route</i>
Lensektomi anterior	13.43	<i>Mechanical phacofragmentation and other aspiration of cataract</i>
Manual fakoemulsifikasi atau Ekstraksi katarak sayatan kecil	13.59	<i>Other extracapsular extraction of lens</i>

8) *Aphakia* (H27.0)

Jika dokter mendiagnosis *aphakia* disebabkan oleh operasi pengangkatan lensa mata, gunakan kode H27.0 (*aphakia*) dan tambahkan kode H59.8 (*Other postprocedural disorders of eye and adnexa*).

Jika dokter mendiagnosis *aphakia* disebabkan oleh cedera, gunakan kode H27.0 (*aphakia*) dan tambahkan kode T90.4 (*Sequelae of injury of eye and orbit*).

Tabel C.18. Contoh kasus *aphakia*

Contoh 4	Pasien datang untuk menjalani prosedur pemasangan lensa mata buatan. Sebelumnya, pasien telah menjalani operasi katarak dengan pengangkatan lensa mata pada kunjungan sebelumnya dan tidak dapat dilakukan pemasangan lensa karena terjadi komplikasi saat operasi.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Aphakia pasca operasi	H27.0 <i>Aphakia</i>
Diagnosis Sekunder	-	H59.8 <i>Other postprocedural disorders of eye and adnexa</i>
Prosedur	Penyisipan lensa intraokular	13.72 <i>Secondary insertion of intraocular lens prosthesis</i>

9) *Refractive Error* (H52)

Kode dalam kelompok H52.- (*Disorders of refraction and accommodation*) diberikan apabila dokter mendiagnosa gangguan refraktif, seperti *hypermetropia*, *myopia*, *astigmatism*. Jika dokter mendiagnosis *Astigmatism*, gunakan kode H52.2 (*Astigmatism*).

10) Visual Impairment (H54.-)

Kode H54.- (*Visual impairment including blindness (binocular or monocular)*) tidak digunakan sebagai kode diagnosis utama jika penyebab gangguan penglihatan sudah dicatat. Saat mengkode penyebabnya, kode H54.- dapat digunakan sebagai kode tambahan opsional.

Tabel C.19. Contoh kasus *visual impairment*

Contoh 5	Dokter mendiagnosis pasien dengan <i>senile hypermature cataract</i> pada mata kanan dan <i>senile combined cataract</i> pada mata kiri. Hasil pemeriksaan tajam penglihatan (<i>visual acuity/VA</i>) menunjukkan: • Mata kanan : hanya mampu mendeteksi gerakan tangan (<i>hand movement</i>) dan tidak membaik meskipun menggunakan lubang jarum (<i>pinhole not improve</i>). • Mata kiri : visus sebesar 1/60 atau 20/1200, dan juga tidak membaik dengan penggunaan lubang jarum (<i>pinhole not improve</i>). Tindakan operasi Phacoemulsification direncanakan hanya pada mata kanan untuk saat ini.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Senile hypermature cataract</i> pada mata kanan	H25.2 <i>Senile cataract, morgagnian type</i>
Diagnosis Sekunder	Kebutaan di mata kanan	HL 00 <i>Right eye</i> ^(IM) H54.4 <i>Blindness, monocular</i>
Prosedur	Phacoemulsification	13.41 <i>Phacoemulsification and aspiration of cataract</i>

Tabel C.20. Contoh kasus *visual impairment*

Contoh 6	Dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami <i>senile hypermature cataract</i> pada mata kanan dan <i>senile combined cataract</i> pada mata kiri. Hasil pemeriksaan tajam penglihatan (<i>visual acuity/VA</i>) menunjukkan: • Mata kanan : kemampuan melihat hanya terbatas pada persepsi gerakan tangan (<i>hand movement</i>) dan tidak membaik meskipun menggunakan lubang jarum (<i>pinhole not improve</i>). • Mata kiri : visus sebesar 1/60 atau 20/1200 , serta tidak menunjukkan perbaikan dengan penggunaan lubang jarum (<i>pinhole not improve</i>). Tindakan operasi ECCE direncanakan untuk kedua mata guna menangani kondisi tersebut.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode

Diagnosis Utama	<i>Senile hypermature cataract</i> pada mata kanan	H25.2 <i>Senile cataract, morgagnian type</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Senile combined cataract</i> Kebutaan	HL 00 <i>Right eye</i> ^(IM) H25.8 <i>Other senile cataract</i> H54.0 <i>Blindness, binocular</i>
Prosedur	<i>ECCE</i>	13.2 <i>Extracapsular extraction of lens by linear extraction technique</i>

Tabel C.21. Contoh kasus *visual impairment*

Contoh 7	Dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami katarak gabungan senil pada mata kanan dan katarak nuklear senil pada mata kiri. Hasil pemeriksaan tajam penglihatan (<i>visual acuity/VA</i>) menunjukkan: • Mata kanan : visus sebesar 5/60 atau 15/200 , yang meningkat menjadi 6/36 atau 20/100 dengan penggunaan lubang jarum (<i>pinhole</i>). • Mata kiri : visus sebesar 6/36 atau 20/100 , yang membaik menjadi 6/18 atau 20/70 dengan penggunaan lubang jarum (<i>pinhole</i>). Tindakan operasi ECCE direncanakan hanya pada mata kanan untuk saat ini guna menangani kondisi tersebut.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Senile combined cataract</i>	H25.8 <i>Other senile cataract</i>
Diagnosis Sekunder	Gangguan penglihatan parah, monocular	HL 00 <i>Right eye</i> ^(IM) H54.5 <i>Severe visual impairment, monocular</i>
Prosedur	<i>ECCE Pada Mata kanan</i>	13.2 <i>Extracapsular extraction of lens by linear extraction technique</i>

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 12

Pengodean tindakan pengangkatan benda asing pada kornea/ *removal foreign superficial cornea* ditentukan berdasarkan metode yang digunakan selama tindakan. Jika pengangkatan dilakukan tanpa insisi, gunakan kode 98.21 (*removal of superficial foreign body from eye without incision*). Apabila prosedur dilakukan dengan bantuan magnet, gunakan kode 11.0 (*magnetic removal of embedded foreign body from cornea*).

Jika dilakukan pemeriksaan mata dengan menggunakan alat *Ophthalmoscope*, gunakan kode 16.21 (*Ophthalmoscopy*). Sedangkan jika menggunakan alat *fundus photography*, gunakan kode 95.11 (*Fundus Photography*).

Gunakan kode tambahan lateralisasi mata HL00 *Right eye* ^(IM), HL01 *Left eye* ^(IM) untuk menjelaskan lokasi sisi tubuh pada diagnosa utama yang dilakukan tindakan atau prosedur dan diinput dalam aplikasi eklaim sebagai kode diagnosis sekunder.

Pasien Kontrol Post operasi Mata tanpa tindakan perawatan luka menggunakan kode Z48.8 (*Other specified surgical follow-up care*) sebagai kode diagnosa utama diikuti diagnosa lain yang ditegakkan oleh dokter dan tindakan yang relevan dengan episode perawatan pasien.

Misalnya Pasien kontrol *post vitrectomy* dengan hipertensi dan dilakukan tindakan Funduskopi maka kodenya adalah Z48.8, I10 dan 95.11 sebagai kode tindakannya.

Tabel C.22. Contoh kasus kontrol *post vitrectomy*

Contoh 8	Pasien datang ke rumah sakit untuk kontrol post vitrectomy. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan dilakukan tindakan funduskopi.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Post Operasi Vitrectomy	Z48.8 <i>Other specified surgical follow-up care</i>
Diagnosis Sekunder	Hipertensi	I10 <i>Essential (primary) hypertension</i>
Prosedur	Funduskopi	95.11 <i>Fundus photography</i>

7. MDC 13 TELINGA, MULUT, TENGGOROKAN

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 13

Untuk kode pada rentang K00–K08 dan kode S02.5, harap gunakan kode tambahan yang menunjukkan gigi yang terkena (berdasarkan informasi FDI). Kode tambahan ini diperlukan untuk memberikan informasi lebih spesifik mengenai lokasi tindakan atau kondisi pada gigi yang terkena.

Berikut ini adalah kode tambahan kode penomoran gigi :

For Permanent Teeth / Adult Teeth :

KG11 Upper Right Central Incisor
(IM)

KG12 Upper right lateral incisor
(IM)

KG13 Upper right canine (IM)

KG14 Upper right first premolar
(IM)

KG15 Upper right second premolar (IM)

KG16 Upper right first molar (IM)

KG17 Upper right second molar
(IM)

KG18 Upper right third molar (IM)

KG21 Upper left central incisor (IM)

KG22 Upper left lateral incisor ^(IM)

KG23 Upper left canine ^(IM)

KG24 Upper left first premolar ^(IM)

KG25 Upper left second premolar ^(IM)

KG26 Upper left first molar ^(IM)

KG27 Upper left second molar ^(IM)

KG28 Upper left third molar ^(IM)

KG31 Lower left central incisor ^(IM)

KG32 Lower left lateral incisor ^(IM)

KG33 Lower left canine ^(IM)

KG34 Lower left first premolar ^(IM)

KG35 Lower left second premolar ^(IM)

KG36 Lower left first molar ^(IM)

For Deciduous Teeth / Primary Teeth :

KG51 Upper Right Central Incisor ^(IM)

KG52 Upper Right Lateral Incisor ^(IM)

KG53 Upper Right Canine ^(IM)

KG54 Upper Right First Molar ^(IM)

KG55 Upper Right Second Molar ^(IM)

KG61 Upper Left Central Incisor ^(IM)

KG62 Upper Left Lateral Incisor ^(IM)

KG63 Upper Left Canine ^(IM)

KG64 Upper Left First Molar ^(IM)

KG65 Upper Left Second Molar ^(IM)

KG37 Lower left second molar ^(IM)

KG38 Lower left third molar ^(IM)

KG41 Lower right central incisor ^(IM)

KG42 Lower right lateral incisor ^(IM)

KG43 Lower right canine ^(IM)

KG44 Lower right first premolar ^(IM)

KG45 Lower right second premolar ^(IM)

KG46 Lower right first molar ^(IM)

KG47 Lower right second molar ^(IM)

KG48 Lower right third molar ^(IM)

KG71 Lower Left Central Incisor ^(IM)

KG72 Lower Left Lateral Incisor ^(IM)

KG73 Lower Left Canine ^(IM)

KG74 Lower Left First Molar ^(IM)

KG75 Lower Left Second Molar ^(IM)

KG81 Lower Right Central Incisor ^(IM)

KG82 Lower Right Lateral Incisor ^(IM)

KG83 Lower Right Canine ^(IM)

KG84 Lower Right First Molar ^(IM)

KG85 Lower Right Second Molar ^(IM)

Tabel C.23. Contoh kasus *Pulpitis*

Contoh 1	Pasien datang ke poli gigi dengan keluhan nyeri tajam dan berdenyut pada gigi geraham belakang atas kanan sejak 2 hari yang lalu. Nyeri dirasakan menetap terutama saat terkena air dingin dan mengganggu waktu tidur. Dokter mendiagnosis pulpitis ireversibel pada gigi 55 dan dilakukan tindakan ekstraksi gigi geraham belakang atas kanan.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Pulpitis ireversibel pada gigi 55	K04.0 <i>Pulpitis</i>
Diagnosis Sekunder	Lateralisasi gigi geraham belakang atas kanan pada gigi 55	KG55 <i>Upper Right Second Molar (1M)</i>
Tindakan	Ekstraksi gigi geraham belakang atas kanan	23.01 <i>Extraction of deciduous tooth</i>

1) **Otitis Externa (H60.-)**

Jika dokter mendiagnosis *cellulitis of external ear*, gunakan kode H60.1 (*Cellulitis of external ear*).

Jika dokter mendiagnosis *malignant otitis externa* atau *necrotizing otitis externa*, gunakan kode H60.2 (*Malignant otitis externa*).

Jika dokter mendiagnosis *other infective otitis externa*, maka gunakan kode H60.3 (*Other Infective Otitis Externa*).

Tabel C.24. Contoh kasus *otitis externa*

Contoh 2	Pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri telinga, demam tinggi, dan saluran telinga yang membengkak. Dokter mendiagnosis utama otitis eksterna maligna.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Otitis eksterna maligna	H60.2 <i>Malignant otitis externa</i>

2) **Cholesteatoma (H71)**

Jika dokter mendiagnosis *primary acquired cholesteatoma*, gunakan kode H71 (*Cholesteatoma of middle ear*).

Jika dokter mendiagnosis *secondary acquired cholesteatoma* atau *chronic otitis media with cholesteatoma*, gunakan kode H71 (*Cholesteatoma of middle ear*) dan tambahkan kode H66.3 (*Other chronic suppurative otitis media*).

Jika dokter mendiagnosis *cholesteatoma* yang ditemukan setelah operasi mastoidektomi, gunakan kode H95.0 (*Recurrent cholesteatoma of postmastoidectomy cavity*).

Jika dokter mendiagnosis *congenital cholesteatoma*, gunakan kode Q17.8 (*Other congenital malformation of the ear*).

Tabel C.25. Contoh kasus *cholesteatoma*

Contoh 3	Pasien dengan gangguan pendengaran (tuli) di telinga kiri, kemudian dokter mendeteksi puing-puing keratin dan epitel skuamosa di telinga tengah otitis media kronis dengan kolesteatoma. Lalu, pasien mengalami <i>tinnitus</i> di telinga kirinya. Melalui audiogram, dokter menemukan bahwa itu gangguan pendengaran konduktif sisi kiri yang merupakan komplikasi dari <i>cholesteatoma</i> . Dokter menetapkan <i>cholesteatoma</i> sebagai diagnosis utama.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Kolesteatoma	H71 <i>Cholesteatoma of middle ear</i>
Diagnosis Sekunder	Otitis media kronis	H66.3 <i>Other chronic suppurative otitis media</i>
Komplikasi	Gangguan pendengaran konduktif, telinga kiri	H90.10 <i>Conductive hearing loss, unilateral with unrestricted hearing on the contralateral side^(IM)</i>

3) ***Perforation Of Tympanic Membrane (H72.-)***

Pengodean kasus perforasi gendang telinga :

Jika dokter mendiagnosis *Acute otitis media* dengan perforasi gendang telinga, gunakan kode H66.0 (*Acute suppurative otitis media*) dan tambahkan kode H72.- (*Perforation of tympanic*) *membrane*.

Jika dokter mendiagnosis *Otitis Media Supuratif Kronis tipe Attiko-Antral* dengan perforasi gendang telinga, gunakan kode H66.2 (*Chronic attic-antral suppurative otitis media*) dan tambahkan kode H72.- (*Perforation of tympanic membrane*).

Jika dokter mendiagnosis *Traumatic tympanic membrane perforation*, gunakan kode S09.2 (*Traumatic rupture of ear drum*), dan tambahkan kode penyebab eksternal.

Tabel C.26. Contoh kasus *perforation of tympanic membrane*

Contoh 4	Pasien datang dengan keluhan sakit telinga dan berdenging (<i>Tinnitus</i>), pasien setelah jatuh dari tangga. Dokter mendeteksi gendang telinga berlubang dan berdarah di saluran telinga. Kemudian dokter mendiagnosis perforasi traumatis membran timpani.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Perforasi traumatis membran timpani	S09.2 <i>Traumatic rupture of ear drum</i>
Diagnosis sekunder	-	-
Penyebab eksternal	Jatuh dari tangga di rumah	W10.09 <i>Fall from stairs at home during unspecified activity</i>

4) **Vertigo (H81, R42)**

Jika dokter mendiagnosis *peripheral vertigo* dengan penyebab yang jelas dan spesifik, gunakan kode penyakit penyebabnya sebagai diagnosis utama, tanpa perlu menggunakan kode H81.3 *Other peripheral vertigo* sebagai diagnosis tambahan.

Jika dokter menegaskan diagnosis, antara lain:

Meniere's disease atau *endolymphatic hydrops*, gunakan kode H81.0 (*Meniere's disease*)

Benign Paroxysmal vertigo, gunakan kode H81.1 (*Benign Paroxysmal vertigo*)

Peripheral vertigo, gunakan kode H81.3 (*Other peripheral vertigo*).

Tabel C.27. Contoh kasus *vertigo*

Contoh 5	Seorang pasien wanita dewasa datang dengan keluhan vertigo hebat yang terjadi secara mendadak sejak dua hari lalu, disertai mual dan muntah. Pasien kesulitan berjalan karena ketidakseimbangan, dan pemeriksaan neurologis menunjukkan adanya nistagmus. Beberapa hari sebelumnya, pasien sempat mengalami gejala infeksi virus ringan, dan diketahui adanya peningkatan kasus serupa (kluster) di lingkungan kerja pasien. Dokter mendiagnosa kondisi tersebut sebagai Vertigo Epidemik.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Epidemic vertigo	A88.1† <i>Epidemic vertigo</i>

Diagnosis Sekunder	-	H82* <i>Vertiginous syndromes in diseases classified elsewhere</i>
---------------------------	---	--

5) **Hearing Loss (H90-H91)**

Kode H90-H91 tidak digunakan sebagai diagnosis utama jika penyebab gangguan sudah dicatat, kecuali jika penanganan difokuskan terutama pada gangguan pendengaran itu sendiri. Jika penyebab *hearing loss* dapat diidentifikasi, gunakan kode penyebabnya dan tambahkan kode H90.- atau H91.-.

Jika dokter mendiagnosis gangguan pendengaran konduktif telinga kanan disebabkan otosklerosis, gunakan kode H80.0 (*Otosclerosis involving oval window, non obliterative*) dan tambahkan kode H90.4 (*Sensorineural hearing loss, unilateral with unrestricted hearing on the contralateral side*).

Gunakan kode penyebab utama yang menyebabkan penurunan atau kehilangan pendengaran sebagai diagnosis utama, dan gunakan kode dalam kelompok H90.- (*Conductive and sensorineural hearing loss*) sebagai diagnosis tambahan.

Tabel C.28. Contoh kasus *hearing loss*

Contoh 6	Pasien didiagnosis oleh dokter dengan otosklerosis pada telinga kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pendengaran, diketahui bahwa telinga kanan mengalami gangguan pendengaran tipe konduktif, sementara pendengaran pada telinga kiri berada dalam kondisi normal. Pada saat dilakukan operasi, ditemukan adanya plak sklerotik di area jendela oval, yang kemudian ditangani melalui prosedur stapedektomi untuk memperbaiki fungsi pendengaran pasien.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Otosklerosis	H80.0 <i>Otosclerosis involving oval window, nonobliterative</i>
Diagnosis Sekunder	Gangguan pendengaran konduktif telinga kanan	H90.1 <i>Conductive hearing loss, unilateral with unrestricted hearing on the contralateral side</i>
Operasi	Stapedektomi	19.11 <i>Stapedectomy with incus replacement</i>

Tabel C.29. Contoh kasus *hearing loss*

Contoh 7	Pasien datang dengan keluhan <i>tinnitus</i> yang bersifat akut dan telah berlangsung selama satu minggu. Pemeriksaan fisik umum serta pemeriksaan kondisi telinga luar dan tengah menunjukkan hasil yang normal, tanpa adanya kelainan yang terdeteksi secara klinis. Namun, pemeriksaan fungsi pendengaran mengungkapkan adanya gangguan pendengaran sensorineural dengan penurunan ambang pendengaran sebesar 40 dB pada semua frekuensi yang diuji.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Gangguan pendengaran sensorineural mendadak	H91.2 (<i>Sudden idiopathic hearing loss</i>)
Diagnosis sekunder	-	-
Operasi	Injeksi steroid intratimpani	20.94 (<i>Injection of tympanum</i>)

6) ***Embedded and Impacted Teeth (K01.-)***

Jika dokter gigi mendiagnosis pasien mengalami gigi tertanam (*embedded*), gunakan kode K01.0 (*Embedded teeth*).

Jika dokter gigi mendiagnosis pasien dengan impaksi gigi, gunakan kode IM yang spesifik sesuai dengan regio dan jenis gigi antara K01.10 s.d K01.19.

Gunakan kode tambahan untuk gigi yang terkena berdasarkan nomor gigi. Contoh: Jika gigi yang impaksi adalah rahang bawah kanan molar tiga, gunakan kode K01.17 (*Impacted teeth, mandibular molar*)^(IM), KG48 Lower right third molar (IM).

7) ***Dental Caries (K02.-)***

Jika dokter gigi mendiagnosis *dental caries* tanpa spesifikasi lebih lanjut, gunakan kode K02.9 (*Dental caries, unspecified*).

Diagnosis karies gigi gunakan kode K02.- dengan sub kategori sesuai dengan diagnosa dokter gigi yang spesifik.

Tabel C.30. Subkategori sesuai diagnosa dokter yang spesifik pada kasus *dental caries* beserta kode ICD-10

Kata yang sama dengan diagnosis dokter gigi	ICD-10
Karies enamel, karies gigi yang baru muncul, karies awal	K02.0 <i>Caries limited to enamel</i>

Karies dentinum	K02.1 <i>Caries of dentine</i>
Karies sementum, karies akar, karies permukaan akar	K02.2 <i>Caries of cementum</i>

Jika dokter gigi mendiagnosis jenis karies lain yang spesifik tetapi tidak termasuk dalam K02.0 s.d K02.4 misalnya, *early childhood caries* atau *secondary caries*, gunakan kode K02.8 (*Other dental caries*).

Tabel C.31. Subkategori sesuai diagnosa dokter yang spesifik pada kasus *dental caries* beserta kode ICD-10

Kata yang sama dengan diagnosis dokter gigi	ICD-10
Karies enamel, karies gigi yang baru muncul, karies awal	K02.0 <i>Caries limited to enamel</i>
Karies dentinum	K02.1 <i>Caries of dentine</i>
Karies sementum, karies akar, karies permukaan akar	K02.2 <i>Caries of cementum</i>

8) **Diseases Of Pulp And Periapical Tissues (K04.-)**

Jika dokter gigi mendiagnosis *caries exposed pulp*, pemberi kode harus mengonfirmasi kepada dokter gigi mengenai kondisi jaringan pulpa atau jaringan periapikal (jaringan di sekitar ujung akar gigi). Jika konfirmasi tidak dapat dilakukan, gunakan kode K02.8 (*Other dental caries*).

Pemberi kode juga harus sangat berhati-hati untuk tidak menyamakan istilah *periodontitis* dengan *apical periodontitis*, karena keduanya merujuk pada kondisi yang berbeda dan termasuk dalam kategori yang berbeda pula :

Jika dokter mendiagnosis *Apical periodontitis* termasuk dalam kelompok kode K04.-.

Jika dokter mendiagnosis *Periodontitis* termasuk dalam kelompok kode K05.-.

Jika dokter gigi mendiagnosis *pulpitis reversible*, gunakan kode K04.0 (*Pulpitis*).

9) **Cellulitis and Abscess of Mouth (K12.2)**

Jika dokter mendiagnosis infeksi di daerah kepala dan leher, gunakan kode spesifik sesuai lokasi infeksi berikut ini:

Tabel C.32. Klasifikasi lokasi infeksi beserta kode spesifik

Lokasi	Keterangan lokasi	Kode
<i>Buccal</i>	<i>Vestibule of maxilla</i> <i>Vestibule of mandible</i> <i>Subperiosteal space of mandible</i> <i>Buccal space</i> <i>Messeteric space</i> <i>Deep and superficial temporal space</i> <i>Infraorbital space</i> <i>Canine space</i> <i>Periorbital space</i> <i>Base of upper lip</i>	K12.20 ^(IM)
<i>Submandibular</i>	<i>Submental space</i> <i>Submandibular space</i> <i>Sublingual space</i> <i>Mentalis space</i>	K12.21 ^(IM)
<i>Anterior Visceral</i>	<i>Ludwig's angina</i> <i>Pterygomandibular atau</i> <i>pterygomaxillary space</i> <i>Palatal subperiosteal area</i> <i>Infratemporal space</i>	K12.22 ^(IM)

Jika dokter mendiagnosis infeksi di leher, dan diagnosis mencakup *retropharyngeal space abscess*, *buccopharyngeal space abscess*, atau *parapharyngeal space abscess*, gunakan kode J39.0 (*Retropharyngeal and parapharyngeal abscess*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi yang berasal dari kulit permukaan di area wajah atau leher:

Untuk infeksi di wajah, gunakan kode L02.0 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of face*).

Untuk infeksi di leher, gunakan kode L02.1 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of neck*).

10) Rhinitis (J00, J30, J31.0)

Jika dokter mendiagnosis rhinitis kronis atau *NARES (Non-Allergic Rhinitis with Eosinophilia Syndrome)*, *rhinitis medicamentosa*, *drug-induced rhinitis*,

hormone-induced rhinitis, atrophic rhinitis, atau irritative rhinitis, gunakan kode J31.0 (*Chronic rhinitis*).

11) Sinusitis (J01, J32)

Pengodean kasus sinusitis :

Jika dokter mendiagnosis *acute sinusitis* atau *acute rhinosinusitis*, gunakan kode dalam kelompok J01.- (*Acute sinusitis*). Kode ini juga mencakup *subacute sinusitis*.

Jika dokter mendiagnosis *chronic sinusitis* atau *chronic rhinosinusitis*, gunakan kode dalam kelompok J32.- (*Chronic sinusitis*). Jika lokasi sinus yang terkena telah diketahui melalui pencitraan radiologi maka gunakan kode yang spesifik misalnya, dokter mendiagnosis *sinusitis* di lokasi *maxilla* gunakan kode J32.0 (*Chronic maxillary sinusitis*) dan tambahkan kode tindakan pemeriksaan pencitraan radiologinya.

Jika dilakukan pemeriksaan kultur dan ditemukan agen infeksiusnya, tambahkan kode penyebab atau agen infeksi sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis *allergic fungal sinusitis* (AFS) dengan hasil pemeriksaan patologi atau kultur positif untuk jamur *Aspergillus*, gunakan kode J30.4 (*Allergic rhinitis, unspecified*) dan tambahkan kode B44.8 (*Other forms of aspergillosis*).

Jika dokter mendiagnosis sinusitis kronik dari infeksi jamur *Aspergillus*, gunakan kode J32.9 (*Chronic sinusitis, unspecified*) dan tambahkan kode B44.8 (*Other forms of aspergillosis*).

Prosedur Bedah untuk Sinusitis:

Endoscopic Sinus Surgery (ESS): Operasi dengan menggunakan endoskop kaku untuk mengangkat lesi pada sinus. Kode operasi harus didasarkan pada detail prosedur yang dilakukan.

Microscopic Sinus Surgery (MSS): Operasi dengan menggunakan mikroskop bedah untuk mengangkat lesi pada sinus. Kode operasi harus didasarkan pada detail prosedur yang dilakukan.

Caldwell-Luc Operation (CWL): Prosedur bedah untuk mengobati sinusitis maksilaris kronis melalui pendekatan canine fossa di bawah gusi. gunakan kode tindakan 22.61 (*Excision of lesion of maxillary sinus with Caldwell-Luc approach*).

12) Tonsillectomy

Tonsillectomy merupakan prosedur pengangkatan tonsil untuk mengobati *chronic hypertrophic tonsillitis* (CHT). Kode Prosedur: 28.2 (*Tonsillectomy without adenoidectomy*).

Adenoidectomy merupakan prosedur pengangkatan adenoid untuk mengobati *adenoid hypertrophy*. Kode Prosedur: 28.6 (*Adenoidectomy without tonsillectomy*).

Jika dilakukan pengangkatan kedua tonsil dan adenoid secara bersamaan (*Tonsillectomy dengan Adenoidectomy*), gunakan kode prosedur 28.3 (*Tonsillectomy with adenoidectomy*).

Tabel C.33. Contoh kasus *tonsillectomy*

Contoh 8	Pasien datang ke Poli THT dengan keluhan nyeri menelan yang hilang timbul sejak 4 bulan yang lalu. Nyeri dirasakan semakin memberat dalam 1 minggu terakhir, terutama saat menelan makanan padat. Pasien mengalami demam dan sakit tenggorokan. Dokter mendiagnosis tonsilitis kronik, dilakukan tindakan Tonsilektomi.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Tonsilitis kronik	J35.0 (<i>Chronic Tonsilitis</i>)
Prosedur	Tonsilektomi	28.2 (<i>Tonsillectomy without adenoidectomy</i>)

13) Hoarseness

Gunakan kode yang spesifik sesuai penyebab hoarseness yang ditetapkan oleh dokter, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika dokter mendiagnosis *laryngeal web* / anomali laring kongenital, gunakan kode Q31.0 (*Web of larynx*).

Jika dokter mendiagnosis *acute laryngitis*, gunakan kode J04.0 (*Acute laryngitis*).

Jika dokter mendiagnosis *chronic laryngitis*, gunakan kode J37.0 (*Chronic laryngitis*).

Jika dokter mendiagnosis polip vokal, gunakan kode J38.1 (*Polyp of vocal cord and larynx*).

Jika dokter mendiagnosis nodul vokal, gunakan kode J38.2 (*Nodules of vocal cords*).

Jika dokter mendiagnosis kista vokal atau gangguan lain pita suara, gunakan kode J38.3 (*Other diseases of vocal cords*).

Jika dokter mendiagnosis kelumpuhan pita suara tanpa penyebab yang diketahui (idiopatik), gunakan kode J38.0 (*Paralysis of vocal cords and larynx*).

Jika dokter mendiagnosis *spastic dysphonia*, gunakan kode J38.3 (*Other diseases of vocal cords*).

Jika tidak terdapat penyebab yang ditetapkan atau jika dokter hanya mencatat "hoarseness" tanpa menyebutkan penyebabnya, gunakan kode R49.0 (*dysphonia*).

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 13

- 1) Jika dokter mendiagnosis efusi pleura akibat influenza, gunakan kode J11.1 (*Influenza with other respiratory manifestations, virus not identified*) jika virus tidak teridentifikasi secara spesifik.

- 2) Kasus tindakan ekstirpasi jaringan granulasi

Jika dokter mendiagnosis Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) pada membran timpani dan dilakukan tindakan pengangkatan jaringan perhatikan detail lokasi dan tujuan prosedur medis yang dilakukan.

- 3) Jika tindakan yang dilakukan adalah eksisi (pengangkatan) pada telinga luar sebagai tindakan terapeutik, gunakan kode 18.29 (*Excision or destruction of other lesion of external ear*).
- 4) Jika tindakan yang dilakukan berupa biopsi jaringan telinga luar dan dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, gunakan kode 18.12 (*Biopsy of external ear*) dan tambahkan kode 91.86- pemeriksaan patologi anatomi.
- 5) Jika tindakan eksisi diikuti dengan pemeriksaan patologi anatomi, gunakan kode 18.29 (*Excision or destruction of other lesion of external ear*) dan tambahkan kode 91.86- pemeriksaan patologi anatomi.
- 6) Dalam MDC 13 terdapat DRG khusus untuk tindakan *Rhinosinusitis & Nasal Polyp*, sehingga pemberi kode harus memperhatikan dokumentasi medis dan bukti tata laksana tindakan *Rhinosinusitis & Nasal Polyp*.
- 7) Apabila terdapat tindakan pada group *Rhinosinusitis & Nasal Polyp*, maka masuk ke *Rhinosinusitis & Nasal Polyp Proc*. Akan tetapi apabila pengodean group *Rhinosinusitis & Nasal Polyp* disertai lebih dari tiga tindakan pada group *Rhinosinusitis & Nasal Polyp Complex*, maka akan masuk ke dalam kelompok *Rhinosinusitis & Nasal Polyp Complex Proc*.

P13AG Rhinosinusitis & Nasal Polyp Proc.

21.31 *Local excision or destruction of intranasal lesion*

22.20 *Uncinectomy* ^(IM)

22.200 *Uncinectomy sinistra* ^(IM)

22.201 *Uncinectomy dextra* ^(IM)

22.41 *Frontal sinusotomy*
 22.410 *Frontal sinusotomy sinistra* ^(IM)
 22.411 *Frontal sinusotomy dextra* ^(IM)
 22.42 *Frontal sinusectomy*
 22.420 *Frontal sinusectomy sinistra* ^(IM)
 22.421 *Frontal sinusectomy dextra* ^(IM)
 22.50 *Sinusotomy, not otherwise specified*
 22.51 *Ethmoidotomy*
 22.510 *Ethmoidotomy sinistra* ^(IM)
 22.511 *Ethmoidotomy dextra* ^(IM)
 22.52 *Sphenoidotomy*
 22.520 *Sphenoidotomy sinistra* ^(IM)
 22.521 *Sphenoidotomy dextra* ^(IM)
 22.53 *Incision of multiple nasal sinuses*
 22.60 *Sinusectomy, not otherwise specified*
 22.63 *Ethmoidectomy*
 22.630 *Ethmoidectomy sinistra* ^(IM)
 22.631 *Ethmoidectomy dextra* ^(IM)
 22.64 *Sphenoidectomy*
 22.640 *Sphenoidectomy sinistra* ^(IM)
 22.641 *Sphenoidectomy dextra* ^(IM)
 22.9 *Other operations on nasal sinuses*
 96.21 *Dilation of frontonasal duct*

AX 13PCX Procedures for Rhinosinusitis and Nasal Polyp

21.31 *Local excision or destruction of intranasal lesion*
 21.32 *Local excision or destruction of other lesion of nose*
 22.20 *Uncinectomy* ^(IM)
 22.200 *Uncinectomy sinistra* ^(IM)
 22.201 *Uncinectomy dextra* ^(IM)
 22.41 *Frontal sinusotomy*
 22.410 *Frontal sinusotomy sinistra* ^(IM)
 22.411 *Frontal sinusotomy dextra* ^(IM)
 22.42 *Frontal sinusectomy*

22.420 *Frontal sinusectomy sinistra* ^(IM)
 22.421 *Frontal sinusectomy dextra* ^(IM)
 22.50 *Sinusotomy, not otherwise specified*
 22.51 *Ethmoidotomy*
 22.510 *Ethmoidotomy sinistra* ^(IM)
 22.511 *Ethmoidotomy dextra* ^(IM)
 22.52 *Sphenoidotomy*
 22.520 *Sphenoidotomy sinistra* ^(IM)
 22.521 *Sphenoidotomy dextra* ^(IM)
 22.53 *Incision of multiple nasal sinuses*
 22.60 *Sinusectomy, not otherwise specified*
 22.63 *Ethmoidectomy*
 22.630 *Ethmoidectomy sinistra* ^(IM)
 22.631 *Ethmoidectomy dextra* ^(IM)
 22.64 *Sphenoidectomy*
 22.640 *Sphenoidectomy sinistra* ^(IM)
 22.641 *Sphenoidectomy dextra* ^(IM)
 22.9 *Other operations on nasal sinuses*
 96.21 *Dilation of frontonasal duct*

- 8) Jika pemeriksaan telinga menggunakan alat *otomicroscope*, gunakan kode 18.13 (*Microscopic examination of external ear*)^(IM), jika menggunakan alat endoskopi gunakan kode 18.14 (*Endoscopic examination of external ear*)^(IM), jika menggunakan alat *otoscopy* gunakan kode 18.11 (*Otoscopy*).
- 9) Jika dokter melakukan prosedur tindakan x-ray dental, gunakan kode 87.11 (*Full-mouth x-ray of teeth*) atau 87.12 (*Other dental x-ray*).
- 10) Jika dokter melakukan prosedur tindakan enukleasi kista radikuler gigi gunakan kode 24.4 (*Excision of dental lesion of jaw*).
- 11) Jika dokter melakukan prosedur tindakan ekstirpasi yang dilakukan pada daerah gingiva/gum/gusi, gunakan kode 24.31 (*Excision of lesion or tissue of gum*).
- 12) Gunakan kode tambahan lateralisasi telinga HL04 *Right ear* ^(IM), HL05 *Left ear* ^(IM) dan HL05 *Bilateral ear* ^(IM) untuk menjelaskan lokasi sisi tubuh pada diagnosa utama yang dilakukan tindakan atau prosedur dan diinput dalam aplikasi eklaim sebagai kode diagnosis sekunder

8. MDC 14 SISTEM PERNAFASAN

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 14

1) Influenza (J09-J11)

Jika dokter mendiagnosis *influenza* dengan hasil tes positif untuk *avian influenza virus*, gunakan kode J09 (*Influenza due to identified avian influenza virus*).

Jika dokter mendiagnosis *influenza* dengan hasil tes positif untuk jenis virus *influenza* lainnya (misalnya A, B, C, atau H1N1), gunakan kode dari kelompok J10.- (*Influenza due to other identified influenza virus*).

Jika dokter mendiagnosis *influenza* dengan hasil virusnya tidak dinyatakan secara spesifik, gunakan kode dari kelompok J11 (*Influenza, virus not identified*).

Jika dokter mendiagnosis *influenza virus* berdasarkan pemeriksaan klinis lainnya atau hasil tes menyebutkan virus *influenza* tidak dinyatakan secara spesifik, gunakan kode dari kelompok J11 (*Influenza, virus not identified*). Jika dokter mendiagnosis *influenza* disertai dengan diagnosa lain, tambahkan kode spesifik untuk diagnosa tersebut sesuai diagnosisnya. Contoh 1: *Influenza due to identified avian influenza virus* disertai dengan *pneumonia due to escherichia coli*, gunakan kode J09 dan J15.5.

Contoh 2: *Influenza H1N1* dengan (*broncho*) *pneumonia* gunakan kode kombinasi J10.0 (*Influenza with pneumonia, seasonal influenza virus identified*).

2) Pneumonia (J12-J18, J69)

Pneumonia diklasifikasikan dalam MDC 14 dengan kategori spesifik J12–J18 dan J69. Kode J12–J17 digunakan untuk pneumonia yang disebabkan oleh agen spesifik, seperti virus, bakteri, atau organisme lainnya. Sementara itu, kode J69 digunakan untuk kondisi pneumonia yang disebabkan oleh aspirasi benda padat atau cair (*aspiration pneumonia*).

Penetapan kode untuk pneumonia harus mempertimbangkan beberapa aspek agar kode yang diberikan sesuai dengan dokumentasi klinis dan benar-benar merepresentasikan kondisi pasien secara akurat. Berikut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengkodean pneumonia:

Pengkodean dalam kategori J12–J17

Viral Pneumonia (J12)

Jika dokter mendiagnosis pneumonia yang disebabkan oleh virus, maka gunakan kode J12.- (*Viral pneumonia, not elsewhere classified*).

Jika dokter mendiagnosis pneumonia yang disebabkan oleh adenovirus, maka gunakan kode J12.0 (*Adenoviral pneumonia*).

Jika dokter mendiagnosis pneumonia yang disebabkan oleh *respiratory syncytial virus*, maka gunakan kode J12.1 (*Respiratory syncytial virus pneumonia*).

Jika dokter mendiagnosis pneumonia yang disebabkan oleh *parainfluenza virus*, maka gunakan kode J12.2 (*Parainfluenza virus pneumonia*).

Jika dokter mendiagnosis pneumonia yang disebabkan oleh *human metapneumovirus*, maka gunakan kode J12.3 (*Human metapneumovirus pneumonia*).

Jika dokter mendiagnosis pneumonia yang disebabkan oleh virus selain kelompok J12.0 s.d. J12.3, maka gunakan kode J12.8 (*Other viral pneumonia*) dan tambahkan kode dari kategori B97 (*Viral agents as the cause of diseases classified to other chapters*) untuk mengidentifikasi agen infeksi secara spesifik.

Jika dokter mendiagnosis pneumonia yang disebabkan oleh enterovirus, maka gunakan kode J12.8 (*Other viral pneumonia*) dan tambahkan kode dari kategori B97.1 (*Enterovirus as the cause of diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis pneumonia disertai infeksi virus avian influenza, maka gunakan kode J09 (*Influenza due to identified avian influenza virus*).

Jika dokter mendiagnosis pneumonia disertai virus influenza lainnya, maka gunakan kode J10.0 (*Influenza with pneumonia, other influenza virus identified*).

Jika dokter mendiagnosis pneumonia disertai virus influenza yang tidak teridentifikasi, maka gunakan kode J11.0 (*Influenza with pneumonia, virus not identified*).

Jika pneumonia disebabkan oleh virus selain kelompok J12.0 s.d J12.3 tambahkan kode dari kategori B97 (*Viral agents as the cause of diseases classified to other chapters*) untuk mengidentifikasi secara spesifik agen infeksi.

Contoh 1:

Pneumonia due to adenovirus

Kode Utama : J12.0 *Adenoviral pneumonia*

Pneumonia due to enterovirus

Kode Utama : J12.8 *Other viral pneumonia*

Kode Sekunder : B97.1 *Enterovirus as the cause of diseases classified elsewhere*

Bacterial Pneumonia (J13, J14 & J15)

Jika dokter mendiagnosis pneumonia akibat *streptococcus pneumoniae*, gunakan kode J13 (*Pneumonia due to Streptococcus pneumoniae*)

Jika dokter mendiagnosis pneumonia akibat *Haemophilus influenzae*, gunakan kode J14 (*Pneumonia due to Haemophilus influenzae*)

Jika dokter mendiagnosis pneumonia yang disebabkan oleh agen infeksi selain *S. pneumoniae* and *H. influenzae*, gunakan kode spesifik pada kelompok J15.- (*Bacterial pneumonia, not elsewhere classified*). Jika kode dalam kelompok

J15 tidak menggambarkan jenis bakteri penyebab secara spesifik, tambahkan kode dari kategori B95–B96 untuk mengidentifikasi agen infeksius penyebab pneumonia. Contoh :

Pneumonia akibat *proteus mirabilis*

Kode Utama : J15.8 *Other bacterial pneumonia*

Kode Sekunder : B96.4 *Proteus (mirabilis)(morganii) as the cause of diseases classified to other chapters*

Pneumonia akibat benda padat dan cair

Apabila pneumonia disebabkan oleh benda padat dan/atau cairan, gunakan kode J69 *Pneumonitis due to solids and liquids*. Jika penyebab spesifik teridentifikasi, maka kode tambahan dari Chapter XX (*External causes of morbidity and mortality*) harus digunakan sebagai kode sekunder untuk melengkapi informasi penyebab, misalnya sebagai berikut.

Jika dokter mendiagnosis pneumonitis yang disebabkan oleh aspirasi makanan dan muntahan, gunakan kode J69.0 *Pneumonitis due to food and vomit* dan tambahkan kode kelompok W79.- (*Inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract*).

Jika dokter mendiagnosis bahwa penyebab pneumonia adalah menghirup berbagai jenis minyak, gunakan kode J69.1 *Pneumonitis due to oils and essences* dan tambahkan kode dalam kelompok Y14.- (*Poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances, undetermined intent*)

Jika dokter menyatakan penyebab infeksi adalah aspirasi zat lain, seperti darah atau bahan lainnya, gunakan kode J69.8 *Pneumonitis due to other solids and liquids* dan tambahkan kode dalam kelompok W80.- (*Inhalation and ingestion of other objects causing obstruction of respiratory tract*).

Pada kasus pneumonia berdasarkan penyebab (J12-J18), Gunakan kode dari kelompok J12-J18 sesuai jenis pneumonia yang didiagnosis oleh dokter, contohnya sebagai berikut.

Pneumonia akibat *Acinetobacter baumannii* atau *Serratia marcescens*, gunakan kode J15.6 (*Pneumonia due to other aerobic Gram-negative bacteria*).

Cytomegaloviral pneumonia, gunakan kode B25.0† (*Cytomegaloviral pneumonitis*) dan tambahkan kode J17.1* (*Pneumonia in viral diseases classified elsewhere*).

Aspergillus pneumonia, gunakan kode B44.0† *Invasive pulmonary aspergillosis* atau B44.1† (*Other pulmonary aspergillosis*) dan tambahkan kode J17.2* (*Pneumonia in mycoses*).

Jika dokter mendiagnosis *pneumonia* sebagai *hospital-acquired pneumonia* (HAP) atau *ventilator-associated pneumonia* (VAP), maka harus ditambahkan kode penyebab eksternal untuk kondisi nosokomialnya, yaitu Y95 *Nosocomial condition*. Kode ini digunakan untuk menunjukkan bahwa infeksi pneumonia diperoleh selama perawatan di fasilitas kesehatan.

Jika dokter mendiagnosis bahwa patogen penyebab pneumonia resisten terhadap antibiotik tertentu, gunakan kode tambahan dari kelompok U80.-, U81.-, atau U88 untuk mencatat jenis resistensi bakteri yang teridentifikasi, sesuai dengan hasil pemeriksaan sensitivitas bakteri. Contohnya:

U80.0 *Penicillin resistant agent*.

U80.1 *Methicillin resistant agent*.

U80.8 *Agent resistant to other penicillin-related antibiotic*.

U81.0 *Vancomycin resistant agent*.

U81.8 *Agent resistant to other vancomycin-related antibiotic*.

U88 *Agent resistant to multiple antibiotics*. untuk kasus ini di rujuk ke *Drug Types* dan *Episode of Care* pada kode IM sesuai dengan kondisi pasien.

3) Bronchitis (J20, J40-J42)

Jika dokter mendiagnosis *acute bronchitis*, gunakan kode dari kelompok J20.- (*Acute bronchitis*). Jika penyebab spesifik diketahui (misalnya virus atau bakteri), gunakan kode spesifik sesuai patogen. Pemilihan kode harus didasarkan pada jenis bronchitis (akut atau kronis), usia pasien, serta keterangan spesifik dari dokter yang menangani. Jika penyebab tidak diketahui atau tidak dicatat, gunakan kode J20.9 (*Acute bronchitis, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis, gunakan kode berikut ini :

Jenis bronchitis kronis simpel gunakan kode J41.0 (*Simple chronic bronchitis*)

Jenis bronchitis kronik gunakan kode J41.1 (*Mucopurulent chronic bronchitis*)

Jenis bronchitis mucopurulent atau jenis chronic bronchitis tidak ditentukan gunakan kode J42 (*Unspecified chronic bronchitis*)

Jika dokter mendiagnosis bronchitis pada pasien usia kurang dari 15 tahun, gunakan kode J20.- (*Acute bronchitis*). Untuk pasien usia 15 tahun atau lebih, gunakan kode J40 (*Bronchitis, not specified as acute or chronic*).

4) Stenosis Laryngotracheal (J38.6, J39.8, J95.5)

Jika dokter mendiagnosis *subglottic stenosis* yang disebabkan oleh prosedur medis, seperti pemasangan *endotracheal tube*, gunakan kode J95.5 (*Postprocedural subglottic stenosis*).

Jika dokter mendiagnosis *Stenosis of larynx*, gunakan kode J38.6 (*Stenosis of larynx*).

Jika dokter mendiagnosis *laryngotracheal stenosis*, yaitu penyempitan yang melibatkan baik laring maupun trakea, dengan penyempitan laring lebih parah, gunakan kode J38.6 *Stenosis of larynx* dan tambahkan kode J39.8 (*Other specified diseases of upper respiratory tract*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis *subglottic stenosis* sebagai kondisi bawaan sejak lahir, gunakan kode Q31.1 (*Congenital subglottic stenosis*).

5) Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (J44.-)

Jika dokter mendiagnosis COPD dengan infeksi sekunder saluran pernafasan bawah (kecuali *influenza*), termasuk didalamnya pneumonia, maka gunakan kode J44.0 (*Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection*) sebagai kode utama. Misalnya jika diagnosis mencakup COPD dengan *acute bronchitis*, gunakan kode J44.0 (*Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection*).

Jika dokter mendiagnosis COPD dengan *acute exacerbation*, gunakan kode J44.1 (*Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis COPD dengan Eksaserbasi Akut dan *Acute Bronchitis*, gunakan kode gabungan J44.1 (*Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified*). dan J20 (*Acute bronchitis*).

Jika dokter mendiagnosis COPD dengan eksaserbasi akut dan pneumonia, maka gunakan kode J44.1 (*Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection*) untuk diagnosis COPD dan kode pada kategori J13 s/d J18 untuk diagnosis pneumonia yang dikode secara spesifik sesuai dengan agen penginfeksi misalkan J15.1 Pneumonia due to *Pseudomonas*.

Jika dokter hanya mencatat COPD tanpa spesifikasi tambahan, gunakan kode J44.9 (*Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified*).

Jika emfisema merupakan bagian dari COPD, gunakan kode J44.- (*Other chronic obstructive pulmonary disease*), sesuai kondisi. .

6) Asthma (J45-J46)

Jika dokter mendiagnosis *asthmatic bronchitis* atau hanya mencatat asma tanpa rincian tambahan, gunakan kode J45.9 (*Asthma, unspecified*). Jika diagnosis adalah *chronic asthmatic bronchitis*, gunakan kode J44.8 (*Other specified chronic obstructive pulmonary disease*).

Kode J46 (*Status asthmaticus*) hanya boleh diberikan apabila dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) secara jelas mendokumentasikan diagnosis sebagai "*acute severe asthma*" atau "*status asthmaticus*" dalam rekam medis pasien.

7) Bronchiectasis (J47)

Jika dokter mendiagnosis *bronchiectasis* atau *infected bronchiectasis*, gunakan kode J47 (*Bronchiectasis*).

Jika dokter mendiagnosis *bronchiectasis* disertai *massive haemoptysis* (batuk darah masif), gunakan kode J47 (*Bronchiectasis*) dan tambahkan kode R04.20 (*massive Haemoptysis*)^(IM).

Jika dokter mendiagnosis bronchiectasis disertai *haemoptysis*, gunakan kode J47 (*Bronchiectasis*) dan tidak menambahkan kode R04.2 (*Haemoptysis*).

8) Lung Diseases Due To External Agents (J60-J66)

Jika dokter mendiagnosis silicosis disebabkan oleh debu talc, gunakan kode J62.0 *Pneumoconiosis due to talc dust*. Namun, jika disebabkan oleh debu silika lainnya, gunakan kode J62.8 (*Pneumoconiosis due to other dust containing silica*).

Pneumokoniosis dengan tuberkulosis J65 (*Pneumoconiosis associated with tuberculosis*) dan tambahkan kode untuk pneumokoniosis (J60-J64) dan tuberkulosis (A15-A16) sebagai kode tambahan.

9) Hypersensitivity Pneumonitis Due To Organic Dust (J67.-)

Gunakan kode dari kelompok J67.- (*Hypersensitivity pneumonitis due to organic dust*) sesuai diagnosis dokter. Jika dokter menyimpulkan kondisi penyakit berhubungan dengan pencemaran lingkungan, tambahkan kode penyebab eksternal Y97 (*Environmental-pollution-related condition*).

10) Respiratory Conditions Due To External Agents (J68.-, J70.-)

Kondisi Akibat Inhalasi Bahan Kimia, Gas, Asap, dan Uap, gunakan kode dari kelompok J68.- (*Respiratory conditions due to inhalation of chemicals, gases, fumes and vapours*).

Kondisi Akibat Radiasi atau Obat-Obatan, gunakan kode dari kelompok J70.- (*Respiratory conditions due to other external agents*). Tambahkan kode penyebab eksternal pada Chapter XX (*External causes of morbidity and mortality*).

11) Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) (J80)

Jika dokter mendiagnosis *adult respiratory distress syndrome*, gunakan kode: J80 (*Adult respiratory distress syndrome*). Kode J80 sudah mencakup gejala gagal napas (*respiratory failure*) sebagai bagian dari kondisi penyakit tersebut, sehingga tidak diperlukan penambahan kode tersendiri untuk menggambarkan gagal nafas secara terpisah.

12) Pulmonary oedema (J81)

Jika dokter mendiagnosis *Acute Non-Cardiogenic Pulmonary Oedema*, gunakan kode J81 (*Pulmonary oedema*). Kode J81 dapat digunakan apabila Edema Paru terjadi tanpa disertai *Heart Failure* I50.- atau *Heart Disease* I51.9. Contohnya: Edema Paru yang disebabkan oleh cedera paru, sepsis, aspirasi, trauma, ARDS, atau keadaan lainnya.

Jika dokter mendiagnosis *Oedema Pulmonary Cardiogenic*, gunakan kode sesuai dengan diagnosis terkait jantung yang di tegakkan oleh dokter dan kode J81 (*Pulmonary oedema*) tidak perlu dikode.

13) ***Abscess Of Lung (J85)***

Jika dokter mendiagnosis abses paru disertai pneumonia, dan pneumonia tersebut tidak disebabkan oleh organisme spesifik yang termasuk dalam kode J09–J16, gunakan kode J85.1 (*Abscess of lung with pneumonia*). Namun, jika pneumonia disebabkan oleh organisme tertentu yang sudah diklasifikasikan dalam kode J09 sampai J16 (misalnya pneumonia akibat virus influenza, bakteri spesifik, atau organisme lain yang telah ditentukan), maka cukup gunakan kode pneumonia spesifik dari J09–J16.

Apabila dokter mencatat bahwa pasien memiliki abses paru tanpa disertai pneumonia, atau tidak ada informasi yang menyebutkan adanya pneumonia, gunakan kode J85.2 (*Abscess of lung without pneumonia*).

14) ***Pleural Effusion (J90-J91)***

Jika dokter tidak mencatat penyebab spesifik dari efusi pleura, gunakan kode J90 (*Pleural effusion, not elsewhere classified*).

Jika dokter mencatat penyebab spesifik dari efusi pleura, gunakan kode penyebab utama sebagai kode diagnosis utama, dan tambahkan kode J91* (*Pleural effusion in conditions classified elsewhere*) sebagai kode diagnosis tambahan.

Jika dokter mendiagnosis efusi pleura akibat kanker metastatik, gunakan kode C78.2 (*Secondary malignant neoplasm of pleura*).

Jika dokter mendiagnosis efusi pleura akibat tuberkulosis gunakan kode A15.6 *Tuberculous pleurisy, confirmed bacteriologically and histologically* (jika dikonfirmasi secara bakteriologis dan histologis). Kode A16.5 *Tuberculous pleurisy, without mention of bacteriological or histological confirmation* (jika tidak disebutkan konfirmasi bakteriologis atau histologis).

15) ***Pneumothorax (J93.-)***

Jika dokter mendiagnosis *Spontaneous tension pneumothorax*, gunakan kode J93.0 (*Spontaneous tension pneumothorax*).

Jika dokter mendiagnosis tension pneumothorax lainnya, gunakan kode J93.1 (*Other spontaneous pneumothorax*).

Pada kasus *Traumatic Pneumothorax*, jika *pneumothorax* disebabkan oleh trauma (cedera), gunakan kode S27.0 (*Traumatic pneumothorax*) dan tambahkan kode penyebab eksternal.

16) ***Other Pleural Conditions (J94.-)***

Jika dokter mendiagnosis *chylothorax*, gunakan kode J94.0 (*Chylous effusion*).

Jika dokter mendiagnosis *fibrothorax*, gunakan kode J94.1 (*Fibrothorax*).

Jika dokter mendiagnosis *haemothorax*, gunakan kode J94.2 (*Haemothorax*).

Jika dokter mendiagnosis *haemothorax* akibat oleh trauma, gunakan kode S27.1 (*Traumatic haemothorax*) dan tambahkan kode penyebab eksternal *Chapter XX (External Cause of Morbidity and Mortality)*.

Jika dokter mendiagnosis *haemothorax* dan *pneumothorax* akibat trauma, gunakan kode S27.2 (*Traumatic haemopneumothorax*).

Jika dokter mendiagnosis *haemothorax* akibat disebabkan oleh jatuh dari tangga, gunakan kode S27.1 dan tambahkan kode penyebab eksternal *Chapter XX (External Cause of Morbidity and Mortality)* W10.- (*Fall on and from stairs and steps*).

17) **Postprocedural respiratory disorders (J95)**

Jika dokter mendiagnosis malfungsi trakeostomi gunakan kode J95.0 (*Tracheostomy malfunction*).

Jika dokter mendiagnosis insufisiensi paru akut setelah bedah toraks), gunakan kode J95.1 (*Acute pulmonary insufficiency following thoracic surgery*).

Jika dokter mendiagnosis Insufisiensi paru akut setelah bedah non-toraks , gunakan kode J95.2 (*Acute pulmonary insufficiency following nonthoracic surgery*).

Jika dokter mendiagnosis Insufisiensi paru kronis setelah bedah, gunakan kode J95.3 (*Chronic pulmonary insufficiency following surgery*).

Jika dokter mendiagnosis sindrom mendelson , gunakan kode J95.4 (*Mendelson syndrome*).

Jika dokter mendiagnosis stenosis subglotis pasca-prosedural , gunakan kode J95.5 (*Postprocedural subglottic stenosis*).

Jika dokter mendiagnosis gangguan pernapasan pasca-prosedural yang tidak terklasifikasi dalam J95.0 - J95.5 seperti granuloma laring akibat intubasi, gunakan kode J95.8 (*Other postprocedural respiratory disorders*).

Jika dokter mendiagnosis gangguan pernapasan pasca-prosedural, tidak spesifik gunakan kode J95.9 (*Postprocedural respiratory disorder, unspecified*).

18) **Respiratory Failure (J96.-)**

Berikan kode dalam kelompok J96.- (*Respiratory failure, not elsewhere classified*), sesuai diagnosis dokter. Pastikan untuk mencatat apakah gagal napas bersifat akut, kronis, atau kombinasi keduanya (akut di atas kronis), karena karakteristik ini akan memengaruhi pemilihan subkategori kode yang tepat.

Jika dokter mendiagnosis gagal nafas gunakan kode pada kelompok J96.- (*Respiratory failure, not elsewhere classified*).

Jika dokter mendiagnosis gagal napas akut, gunakan kode J96.0 (*Acute respiratory failure*).

Jika dokter mendiagnosis gagal napas kronik, gunakan kode J96.1 (*Chronic respiratory failure*).

Jika dokter mendiagnosis gagal napas tidak spesifik, gunakan kode J96.9 (*Respiratory failure, unspecified*).

19) *Interstitial emphysema (J98.2) & Subcutaneous emphysema (T79.-)*

Jika dokter mendiagnosis *interstitial emphysema*, maka gunakan kode J98.2 (*Interstitial emphysema*).

Jika dokter mendiagnosis panlobular emphysema, maka gunakan kode J43.1 (*Panlobular emphysema*).

Jika dokter mendiagnosis emfisema yang tidak spesifik, maka gunakan kode J43.9 (*Emphysema, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis *interstitial emphysema* pada masa perinatal, maka gunakan kode P25.0 (*Interstitial emphysema originating in the perinatal period*).

Jika dokter mendiagnosis emfisema subkutan karena trauma, maka gunakan kode T79.7 (*Traumatic subcutaneous emphysema*) dan tambahkan kode penyebab eksternal *Chapter XX (External Cause of Morbidity and Mortality)* sesuai trauma yang dimaksud.

Jika dokter mendiagnosis emfisema subkutan bukan karena trauma, maka gunakan kode J98.20 (*Subcutaneous emphysema without trauma*)^(IM)

Jika dokter mendiagnosis emfisema subkutan karena prosedur medis, maka gunakan kode T81.8 (*Other complications of procedures, not elsewhere classified*).

Jika dokter mendiagnosis emfisema dengan COPD, maka gunakan kode gabung J44.0 (*Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection*).

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 14

Pada pasien tuberkulosis, baik yang melibatkan sistem pernapasan maupun sistem lainnya, gunakan kode A15–A19 apabila pasien masih menunjukkan sensitivitas terhadap obat. Jika mengalami resistensi Obat Anti-Tuberkulosis (OAT) gunakan kode tambahan *TB Episode of Care* dan *Drug Types*.

TB Episode of Care

U84.31 *Tuberculosis with multidrug resistance* ^(IM)

U84.32 *Tuberculosis with pre extreme drug resistance* ^(IM)

U84.33 *Tuberculosis with extreme drug resistance* ^(IM)

U84.34 *Tuberculosis with poly drug resistance* ^(IM)

U84.35 *Tuberculosis with mono drug resistance* ^(IM)

Drug Types

U82.20 *Respiratory diseases with resistance of betalactamase (ESBL) resistance* ^(IM)

U82.80 *Respiratory diseases with resistance of betalactam antibiotics* ^(IM)

U83.3 *Respiratory diseases with resistance to other antibiotics* ^(IM)

U84.10 *Respiratory diseases with resistance to antifungal drugs* ^(IM)

U84.20 *Respiratory diseases with resistance to antiviral drugs* ^(IM)

U85.0 *Respiratory diseases with resistance to antineoplastic drugs* ^(IM)

Ketika seorang pasien mendapatkan pelayanan di rumah sakit untuk tatalaksana efek samping yang ditimbulkan oleh Obat Anti-Tuberkulosis (OAT), tata cara pengodeannya sebagai berikut:

- 1) Kode diagnosis yang sesuai untuk menggambarkan efek samping OAT (baik yang bersifat sistemik maupun yang tidak ditentukan) sebagai kode diagnosis utama, **dan**
- 2) Kode Tuberculosis A15-A19 digunakan sebagai kode tambahan jika dilakukan tatalaksana terapi pengobatan untuk Tuberculosisnya, **dan**
- 3) Kode dari Bab 20 (Chapter XX) untuk mencatat penyebab luar terkait penggunaan OAT.

Jika terdapat kasus penyakit pernafasan dengan resistensi obat gunakan kode tambahan *Drug Types* untuk menunjukan jenis resistensi obatnya.

9. MDC 15 JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 15

1) *Heart Valve Disease (I05-I09, I34-I39)*

Jika dokter mendiagnosis penyakit katup mitral rematik, gunakan kode I05.- (*Rheumatic mitral valve diseases*). Jika dokter mendiagnosis penyempitan katup mitral, gunakan kode I05.0 (*mitral stenosis*).

Jika dokter mendiagnosis penyakit katup mitral non rematik, gunakan kode I34.- (*Nonrheumatic mitral valve disorders*).

Jika dokter mendiagnosis penyakit katup aorta rematik, gunakan kode I06.- (*Rheumatic aortic valve diseases*).

Jika dokter mendiagnosis penyakit katup aorta non rematik, gunakan kode I35.- (*Nonrheumatic aortic valve disorders*).

Jika dokter mendiagnosis penyakit katup mitral, katup aorta, dan katup trikuspid secara bersamaan, gunakan kode I08.3 (*Combined disorders of mitral, aortic and tricuspid valves*).

Jika dokter mendiagnosis perikarditis reumatik kronis, gunakan kode I09.2 (*Chronic rheumatic pericarditis*).

2) *Primary and Secondary Hypertension (I10 dan I15)*

3) *Primary Hypertension*

Essential (Primary) Hypertension. Jika dokter mendiagnosis hipertensi sebagai essential atau primary hypertension (tidak diketahui penyebabnya), gunakan kode I10 (*Essential (primary) hypertension*).

Jika dokter mendiagnosis hipertensi dengan *acute kidney injury* (AKI), gunakan kode I10 (*essential primary hypertension*) dan N17.3-^(IM) sesuai stagenya.

Sesuai dengan instruksi kode I12.- mengacu pada penyakit hipertensi dengan komplikasi penyakit ginjal (*renal disease*) yang secara etiologis disebabkan oleh kondisi hipertensi. Dalam proses pengkodean, sangat penting untuk memastikan bahwa dokumentasi pada rekam medis mencerminkan secara jelas dan rinci adanya hubungan kausal antara hipertensi dan penyakit ginjal tersebut. Apabila tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa penyakit ginjal disebabkan oleh hipertensi, maka kedua kondisi dikodekan secara terpisah sesuai dengan pedoman klasifikasi ICD-10.

4) *Secondary hypertension (I15.-)*

Kode I15.- (*Secondary hypertension*) hanya gunakan sebagai diagnosis utama apabila hipertensi tersebut menjadi fokus utama perawatan dan penyebab hipertensi menjadi kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis hipertensi yang disebabkan oleh *renal artery stenosis* atau sebagai *renovascular hypertension*, maka gunakan kode I15.0 (*Renovascular hypertension*) dan tambahkan kode I70.1 (*Atherosclerosis of renal artery*).

Apabila dokter mendiagnosis hipertensi sebagai *secondary hypertension* namun penyebab pastinya belum ditetapkan, misalnya pada pasien yang masih dalam proses evaluasi lanjutan seperti *hypertension in the young*, *resistant hypertension*, atau *suspected secondary hypertension* (contohnya kecurigaan terhadap pheochromocytoma), gunakan kode I15.9 (*Secondary hypertension, unspecified*). Namun, jika tidak ada pemeriksaan tambahan dilakukan, gunakan kode I10 (*Essential (primary) hypertension*).

Jika dokter mendiagnosis hipertensi disebabkan oleh penyakit ginjal, dan pasien sedang dirawat untuk hipertensi, gunakan kode I15.1 (*Hypertension secondary to other renal disorders*), diikuti dengan kode spesifik untuk penyakit ginjal yang menjadi penyebab.

Untuk kasus hipertensi disebabkan oleh gangguan kelenjar endokrin, dan pasien sedang dirawat untuk hipertensi, gunakan kode I15.2 (*Hypertension secondary to endocrine disorders*). Sama seperti sebelumnya, tambahkan kode spesifik untuk gangguan endokrin yang menjadi penyebab, misalnya E26.0 (*Primary hyperaldosteronism*).

Apabila dokter mendiagnosis hipertensi sebagai *secondary hypertension* namun penyebab pastinya belum ditetapkan, misalnya pada pasien yang masih dalam proses evaluasi lanjutan seperti *hypertension in the young*, *resistant hypertension*, atau *suspected secondary hypertension* (contohnya kecurigaan terhadap pheochromocytoma), gunakan kode I15.9 (*Secondary hypertension, unspecified*). Namun, jika tidak ada pemeriksaan tambahan dilakukan, gunakan kode I10 (*Essential (primary) hypertension*).

5) *Hypertensive Heart and Renal Disease (I11-I13)*

Kode dalam kelompok I11.- *Hypertensive heart disease* atau I12.- (*Hypertensive renal disease*) digunakan jika dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami *hypertensive heart disease* atau *hypertensive renal disease*. Pemilihan kode tergantung pada ada atau tidaknya *heart failure* atau *renal failure*. Contohnya:

Jika dokter mendiagnosis penyakit jantung hipertensif dengan gagal jantung, gunakan kode I11.0 (*Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure*). Jika dokter mendiagnosis penyakit jantung hipertensif tanpa gagal jantung, gunakan kode I11.9 (*Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure*).

Jika dokter mendiagnosis *hypertensive renal disease with renal failure*, maka gunakan kode I12.0 (*Hypertensive renal disease with renal failure*). Tambahkan kode N18.- (*Chronic kidney disease/CKD*) untuk menunjukkan stadium penyakit ginjal kronis sesuai catatan *use additional code* pada kategori N18.

Jika dokter mendiagnosis *hypertensive renal disease without renal failure*, gunakan kode: I12.9 (*Hypertensive renal disease without renal failure*). Berikut merupakan beberapa contoh kasus lain terkait *Hypertension* dengan CKD :

Jika dokter mendiagnosis *Hypertension* dengan CKD *Stage 1*, gunakan kode I12.9 (*Hypertensive renal disease without renal failure*) dan N18.1 (*Chronic kidney disease, stage 1*).

Jika dokter mendiagnosis *Hypertension* dengan CKD *Stage 2* dan *Renal Failure*, gunakan kode I12.0 (*Hypertensive renal disease with renal failure*) dan N18.2 (*Chronic kidney disease, stage 2*) .

Jika dokter mendiagnosis *Hypertension* dengan CKD *Stage 2* dan AKI stage 1, gunakan kode N17.31 (*Acute kidney injury stage 1*) ^(IM), I12.0 (*Hypertensive renal disease with renal failure*) dan N18.2 (*Chronic kidney disease, stage 2*) .

Jika dokter mendiagnosis *Hypertension* dengan CKD *Stage 4*, gunakan kode N18.4 (*Chronic kidney disease, stage 4*) dan I12.0 (*Hypertensive renal disease with renal failure*). Jika dokter mendiagnosis *Hypertension* dengan CKD *Stage 4*, gunakan kode I12.0 (*Hypertensive renal disease with renal failure*) dan N18.4 (*Chronic kidney disease, stage 4*)

Jika dokter mendiagnosis *Hypertension* dengan CKD *Stage 4* dan AKI stage 1 (akut on kronik). Berdasarkan kaidah koding, jika kondisi akut dan kronik terjadi bersamaan, maka gunakan kondisi akut sebagai diagnosis utama, sehingga pada contoh kasus di atas, kode diagnosis utama adalah N17.31 (*Acute kidney injury stage 1*) ^(IM) dan kode diagnosis sekunder adalah I12.0 (*Hypertensive renal disease with renal failure*) dan N18.4 (*Chronic kidney disease, stage 4*).

Contoh lain:

Contoh 1:

DU : Hipertensi dengan gagal ginjal yang disertai gagal jantung

DS : edema paru

Contoh 2: Hipertensi dengan gagal ginjal yang disertai dengan gagal jantung dengan diagnosis sekunder edema paru, maka menggunakan kode gabungan I13.2 (*Hypertensive heart and renal disease with both (congestive) heart failure and renal failure*) dan edema paru tidak perlu dikoding terpisah.

Contoh 3:

DU : Hipertensi dengan gagal ginjal tanpa disertai gagal jantung

DS : edema paru

Contoh 4: Hipertensi dengan gagal ginjal yang tidak disertai gagal jantung dengan diagnosis sekunder, maka masing masing dikode terpisah, yakni I12.0 (*Hypertensive renal disease with renal failure*) dan J81 (*Pulmonary oedema*)

6) *Acute Myocardial Infarction (I21-I22)*

Penggunaan kode untuk STEMI dan NSTEMI juga harus memperhatikan durasi terjadinya infark. Dalam pengodean *Acute Myocardial Infarction* (AMI), penting untuk membedakan antara infark pertama kali (*de novo* MI) dan infark yang terjadi dalam 28 hari setelah infark sebelumnya (*subsequent* MI) guna memastikan ketepatan penggunaan kode dalam kategori I21.- dan I22.- dan Infark miokard akut pertama kali (*first-time* AMI) harus dikodekan dengan kategori I21.-, yang mencakup *ST-elevated myocardial infarction* (STEMI) dan *non-ST-elevated myocardial infarction* (NSTEMI) sesuai dengan lokasi kerusakan miokard. Jika dokter mendiagnosis *acute myocardial infarction* atau *acute ST-elevated myocardial infarction* (STEMI), gunakan kode I21.0 – I21.2 sesuai dengan lokasi infark. Jika dokter mendiagnosis *acute non-ST-elevated myocardial infarction* (NSTEMI) atau *acute subendocardial myocardial infarction*, gunakan kode I21.4 (*Acute subendocardial myocardial infarction*).

Jika dokter mendiagnosis *recurrent myocardial infarction* dalam kurun waktu 28 hari setelah infark sebelumnya, maka infark tersebut dikategorikan sebagai *subsequent myocardial infarction* (MI berulang) dan harus dikodekan dalam gunakan kode dalam kelompok I22.- (*Subsequent myocardial infarction*) sesuai dengan lokasi infark. Penggunaan kode Z03.4 (*Observation for suspected myocardial infarction*) diberikan jika pasien pada saat datang ke rumah sakit memiliki gejala / tanda *myocardial infarction* tetapi saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tidak dapat ditegakkan diagnosis *myocardial infarction*, sehingga tidak membutuhkan pengobatan atau penanganan medis lanjutan. Namun jika pasien datang dengan keluhan (tanda atau gejala) dan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi diagnosis pasti atau definitif belum dilakukan, maka keluhan atau gejala tersebut harus ditetapkan sebagai diagnosis utama kode dari Chapter XVIII (R00–R99: *Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified*) harus digunakan.

7) *Complications Following Acute Myocardial Infarction (I23.-)*

Komplikasi yang muncul setelah infark miokard akut (I23.-) harus dikodekan secara spesifik sesuai dengan jenis komplikasi yang terjadi. Apabila disebutkan bahwa atrial septal defek tersebut merupakan komplikasi setelah infark miokard akut, gunakan kode I23.1 (*Atrial septal defect as current complication following acute myocardial infarction*).

Jika disebutkan bahwa trombosis di atrium atau ventrikel merupakan komplikasi setelah infark miokard akut, gunakan kode I23.6 (*Thrombosis of atrium, auricular appendage and ventricle as current complication following acute myocardial infarction*).

Jika dokter mendiagnosis komplikasi tertentu setelah infark miokard akut, gunakan kode dalam kelompok I23.- (*Certain current complications following acute myocardial infarction*), sesuai dengan jenis komplikasi yang terjadi:

Untuk *haemopericardium*, gunakan kode I23.0 (*Haemopericardium as current complication following acute myocardial infarction*).

Untuk *atrial septal defect*, gunakan kode I23.1 (*Atrial septal defect as current complication following acute myocardial infarction*).

Kode I23.- hanya digunakan untuk komplikasi yang terjadi segera setelah infark miokard akut dan masih berkaitan langsung dengan episode tersebut. Jika komplikasi terjadi lebih dari 4 minggu setelah infark miokard akut, maka pengodean akan berbeda dan tidak termasuk dalam kelompok ini.

8) Chronic Ischaemic Heart Disease (I25.-)

Jika dokter mendiagnosis *Atherosclerotic Cardiovascular Disease*, gunakan kode I25.0 (*Atherosclerotic cardiovascular disease, so described*).

Jika dokter mendiagnosis *Atherosclerotic Heart Disease*, gunakan kode I25.1 (*Atherosclerotic heart disease*). Tidak ada kode spesifik untuk jumlah pembuluh darah yang terlibat (*single vessel disease, double vessels disease, atau triple vessels disease*). Semua kondisi tersebut menggunakan kode yang sama, yaitu I25.1.

Jika dokter mendiagnosis Infark Miokard Lama (*Old Myocardial Infarction*), gunakan kode I25.2 (*Old myocardial infarction*).

Aneurisma Jantung, gunakan kode spesifik untuk aneurisma jantung jika ditemukan.

Status Pasca Operasi atau Prosedur Intervensi: Untuk pasien dengan status *post CABG* atau status *post stent placement*, pengodean tetap menggunakan Z48.8 (*Other specified surgical follow-up care*).

Status Pasca Operasi atau Prosedur Intervensi: Untuk pasien dengan status *post CABG* atau status *post stent placement*, pengodean tetap menggunakan I25.--, dengan catatan tambahan tentang prosedur yang telah dilakukan. Contoh : *Atherosclerotic Heart Disease, Status Post Coronary Bypass Graft*, pengkodean terdiri dari dua kode, yaitu I25.1 (*Atherosclerotic heart disease*) dan Z95.1 (*Presence of aortocoronary bypass graft*).

Atherosclerotic Heart Disease, Status Post Stent Placement, pengodean terdiri dari dua kode, yaitu I25.1 (*Atherosclerotic heart disease*) dan Z95.5 (*Presence of coronary angioplasty implant and graft*).

9) Pulmonary Heart Disease (I27.-)

Dalam situasi di mana *primary pulmonary hypertension* disertai dengan *heart failure, unspecified*, kedua kondisi tersebut tetap harus dikodekan secara terpisah menggunakan I27.0 (*Primary pulmonary hypertension*) untuk hipertensi pulmonal

primer yang ada kaitan dengan gagal jantung dan I50.9 (*Heart failure, unspecified*) untuk gagal jantung. Hal tersebut dilakukan karena dalam ICD-10 versi tahun 2010 tidak terdapat instruksi *include* atau *exclude* yang mengindikasikan bahwa keduanya dapat digabung dalam satu kode kombinasi. Sedangkan untuk pulmonari hipertensi sekunder yang disebabkan oleh gagal jantung, gunakan kode I27.2 (*Other secondary pulmonary hypertension*) ditambah dengan kode tambahan *Use additional code, if desired, to identify the underlying disease* untuk mengetahui penyebab kasusnya.

10) **Pericarditis (I30-I32)**

Jika dokter mendiagnosis adanya cairan perikardial (*pericardial fluid*) atau efusi perikardial (*pericardial effusion*) yang tidak disebabkan oleh peradangan, atau jika diagnosis menyebutkan *chylopericardium*, gunakan kode I31.3 (*Pericardial effusion (non-inflammatory)*).

Jika dokter mendiagnosis efusi perikardial tersebut disebabkan oleh penyebaran kanker (metastasis) ke perikardium, gunakan dua kode C79.8 (*Secondary malignant neoplasm of other specified sites*) dan tambahkan kode I31.3 (*Pericardial effusion (non-inflammatory)*) sebagai kode tambahan.

11) **Endocarditis (I33, I38, I39)**

Endocarditis dengan penyebab diketahui

Jika dokter mendiagnosis *infective endocarditis*, baik dengan rincian tambahan sebagai *acute* atau *subacute*, gunakan kode I33.0 (*Acute and subacute infective endocarditis*) dan tambahkan kode B95 - B97 untuk menentukan agen penyebab infeksi.

Jika dokter mendiagnosis endokarditis pada katup jantung yang diketahui penyebabnya gunakan kode dari kelompok I39.-* sebagai kode tambahan. Contohnya: Jika terjadi pada katup mitral, gunakan kode I39.0* (*Mitral valve endocarditis*) sebagai kode tambahan. Jika dokter mendiagnosis *syphilitic endocarditis pada katup mitral*, gunakan A52.0† (*Cardiovascular syphilis*) dan tambahkan kode I39.0* (*Mitral valve disorders in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Jika terjadi pada katup aorta, gunakan kode I39.1* (*Aortic valve disorders in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan. Jika dokter mendiagnosis *systemic lupus erythematosus (SLE)* dengan *Libman-Sacks endocarditis* pada katup aorta, gunakan kode M32.1† (*Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement*) &, dan I39.1* (*Aortic valve disorders in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Endocarditis dengan penyebab tidak diketahui

Jika dokter mendiagnosis endokarditis tanpa diketahui penyebab dan lokasi katup jantung, gunakan kode I38 (*Endocarditis, valve unspecified*).

12) **Myocarditis (I40-I41)**

Myocarditis Infeksius

Jika dokter mendiagnosis *septic myocarditis* atau *infective myocarditis*, gunakan kode I40.0 (*Infective myocarditis*). Apabila agen penyebab infeksi diketahui tambahkan kode B95-B97 untuk menentukan agen penyebab infeksi.

Jika dokter mendiagnosis *diphtherial myocarditis*, gunakan kode A36.8† (*Other diphtheria*), dan I41.0* (*Myocarditis in bacterial diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis *influenza* yang dapat dikonfirmasi dan disertai *myocarditis*, dengan penyebab selain virus tipe A atau B, gunakan kode J10.8† (*Influenza with other manifestations, other influenza virus identified*) dan tambahkan kode I41.1* (*Myocarditis in viral diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Jika diagnosis *influenza* ditegakkan berdasarkan gejala tanpa konfirmasi laboratorium dan disertai *myocarditis*, gunakan kode J11.8† (*Influenza with other manifestations, virus not identified*), I41.1* (*Myocarditis in viral diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Myocarditis Non-Infeksius

Jika dokter mendiagnosis *rheumatoid myocarditis*, gunakan kode M05.3† (*Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and systems*) dan I41.8* (*Myocarditis in other diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis *myocarditis* yang disebabkan oleh obat atau radiasi, gunakan kode I40.8 (*Other acute myocarditis*). Tambahkan kode eksternal sesuai jenis obat atau paparan radiasi sebagai kode tambahan.

13) **Cardiomyopathy (I42-I43)**

Jika dokter mendiagnosis *hypertrophic cardiomyopathy* dengan obstruksi atau *hypertrophic subaortic stenosis*, gunakan kode I42.1 (*Obstructive hypertrophic cardiomyopathy*).

Jika Dokter mendiagnosis *cardiac amyloidosis* (amiloidosis jantung), gunakan kode dari kelompok E85.- sesuai jenis amiloidosis yang teridentifikasi. Jika jenis amiloidosis tidak ditentukan, gunakan kode E85.9† (*Amyloidosis, unspecified*) dan tambahkan kode I43.1* (*Cardiomyopathy in metabolic diseases*) sebagai kode tambahan.

Jika penyakit yang menyebabkan *cardiomyopathy* tidak disebutkan, gunakan kode dagger M10.0† (*Gouty tophi of heart*) atau E05.9† (*Thyrotoxic heart*

disease) (d disesuaikan dengan kasusnya) dan tambahkan kode I43.8* (*Cardiomyopathy in other diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

14) Heart Block (I44-I45)

Jika dokter mendiagnosis *third degree atrioventricular block (complete AV block)*, gunakan kode I44.2 (*Atrioventricular block, complete*).

Jika dokter mendiagnosis *left fascicular block* tanpa merujuk secara spesifik ke *anterior* atau *posterior*, gunakan kode I44.6 (*Other and unspecified fascicular block*).

Jika dokter mendiagnosis *junctional bradycardia* atau *sinoatrial block*, gunakan kode I45.5 (*Other specified heart block*).

Jika diagnosis hanya menyebutkan *heart block* secara umum tanpa rincian lebih lanjut, gunakan kode I45.9 (*Conduction disorder, unspecified*).

15) Cardiac Arrest (I46)

Jika penyebab *Cardiac Arrest* diketahui, maka diagnosis *Cardiac Arrest* dikode sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis *Cardiac Arrest* dengan resusitasi berhasil atau *ROSC (Return of Spontaneous Circulation)*, gunakan kode I46.0 (*Cardiac arrest with successful resuscitation*).

Jika dokter mendiagnosis *Sudden Cardiac Death*, gunakan kode I46.1 (*Sudden cardiac death, so described*). Perlu diperhatikan bahwa kode ini memiliki *excludes*, kode I46.1 tidak boleh digunakan untuk kematian mendadak yang disebabkan oleh gangguan konduksi jantung (I44–I45) atau infark miokard (I21–I22). Jika *cardiac arrest* dilakukan resusitasi namun tidak berhasil dan tidak disebut sebagai *sudden cardiac death*, maka kode yang digunakan adalah I46.9 (*Cardiac arrest, unspecified*).

Prinsip pengodean I46.-, kondisi cardiac arrest tetap dikode untuk mencerminkan kondisi morbiditas secara menyeluruh, meskipun pasien dinyatakan meninggal pada saat pulang.

16) Ventricular Fibrillation and Flutter (I49.0)

Jika dokter mendiagnosis fibrilasi atau flutter ventrikel, gunakan kode I49.0 (*Ventricular fibrillation and flutter*).

Jika dokter mendiagnosis fibrilasi dan flutter ventrikel disertai penyakit jantung struktural, gunakan kode I49.00 (*Ventricular fibrillation and flutter with structural heart diseases*)^(IM).

Jika dokter mendiagnosis fibrilasi dan flutter ventrikel tanpa penyakit jantung struktural (idiopatik), misalnya pada kasus sindrom Brugada, gunakan kode I49.01 (*Ventricular fibrillation and flutter without structural heart diseases (idiopathic) [Brugada's syndrome]*)^(IM).

Jika dokter mendiagnosis fibrilasi dan flutter ventrikel tidak ditentukan apakah disertai penyakit jantung struktural atau tidak, gunakan kode I49.09 (*Ventricular fibrillation and flutter, unspecified*)^(IM).

17) Heart Failure (I50.-).

Jika dokter mendiagnosis *Right Ventricular Failure* yang disebabkan oleh *Left Ventricular Failure*, *Biventricular Failure*, atau *Right Ventricular Failure* itu sendiri, gunakan kode I50.0 (*Congestive heart failure*).

Jika dokter mendiagnosis *Pulmonary oedema* disertai *heart failure* atau *heart disease* yang tidak terklasifikasi spesifik dalam kode lain, gunakan kode I50.1 (*Left ventricular failure*).

Jika dokter mendiagnosis hanya menyebutkan *Heart Failure* tanpa rincian lebih spesifik, gunakan kode I50.9 (*Heart failure, unspecified*).

18) Peripheral Vascular Disease (I70, I73)

Jika dokter mendiagnosis atherosclerosis pada arteri ekstremitas, gunakan kode dari kelompok I70.- (*Atherosclerosis*). Sedangkan untuk penyakit vaskular perifer lainnya, gunakan kode dari kelompok I73.- (*Other peripheral vascular diseases*). Jika dokter mendiagnosis penyakit vaskular perifer disebabkan oleh diabetes melitus tipe 2, gunakan dua kode, yaitu E11.5† (*Type 2 diabetes mellitus with peripheral circulatory complications*) sebagai kode utama dan I79.2* (*Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

19) Arterial Embolism and Thrombosis (I74.-)

Jika dokter mendiagnosis *emboli arteri* atau *thrombosis arteri*, gunakan kode I74.-, yang secara spesifik merujuk pada *arterial embolism and thrombosis*. Penggunaan kode ini harus disesuaikan lebih lanjut berdasarkan lokasi oklusi arteri yang terkena sesuai dengan diagnosis dokter.

20) Phlebitis and Thrombophlebitis (I80.-)

Jika dokter mendiagnosis *deep vein thrombosis* pada kaki, gunakan kode I80.2 (*Phlebitis and thrombophlebitis of other deep vessels of lower extremities*) untuk phlebitis dan thrombophlebitis pada pembuluh darah ekstremitas bawah.

21) Oesophageal Varices (I85.-, I98.2 - I98.3)

Jika dokter mendiagnosis varises esofagus pada pasien dengan sirosis hati, gunakan kode K74.6 (*Other and unspecified cirrhosis of liver*), serta tambahkan kode tambahan berdasarkan kondisi perdarahan:

Jika tidak ada perdarahan, gunakan kode I98.2* (*Oesophageal varices without bleeding in diseases classified elsewhere*).

Jika ada perdarahan, gunakan kode I98.3* (*Oesophageal varices with bleeding in diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis varises esofagus tanpa menetapkan penyebabnya, gunakan kode berikut:

Jika ada perdarahan, gunakan kode I85.0 (*Oesophageal varices with bleeding*).

Jika tidak ada perdarahan, gunakan kode I85.9 (*Oesophageal varices without bleeding*).

22) *Gastric Varices (I86.4)*

Jika dokter mendiagnosis *gastric varices* dengan perdarahan pada pasien dengan sirosis hati, gunakan kode berikut: I86.4 (*Gastric varices*) Tambahkan juga kode K74.6 (*Other and unspecified cirrhosis of liver*) sebagai diagnosis tambahan untuk sirosis hati yang tidak dijelaskan lebih lanjut atau jenis sirosis hati lainnya.

Jika terdapat gejala atau kondisi lain seperti muntah darah atau BAB berdarah bisa dikodekan K92.0 (*Haematemesis*) (muntah darah) atau K92.1 (*Melaena*) (buang air besar berwarna hitam akibat darah terdegradasi) sesuai dengan kondisi yang dialami pasien.

Jika dokter mendiagnosis *gastric varices* tanpa pendarahan pada pasien dengan cirrhosis hati, gunakan kode K74.6 (*Other and unspecified cirrhosis of liver*) dan tambahkan kode I86.4 (*Gastric varices*).

Contoh 1:

Pasien dirawat karena sirosis hati dan juga mengalami *Gastric Ulcer* dalam perawatannya, maka kode K74.6 (*Other and unspecified cirrhosis of liver*) dapat digunakan sebagai kode utama, serta tambahkan kode I86.4 (*Gastric varices*) sebagai kode tambahan untuk mencerminkan adanya varises gaster.

Pasien dirawat karena *Gastric Varices* yang merupakan konsekuensi dari sirosis hati, maka kode I86.4 (*Gastric varices*) digunakan sebagai kode utama karena ini alasan utama perawatan. Kode K74.6 (*Other and unspecified cirrhosis of liver*) digunakan sebagai kode tambahan untuk menunjukkan etiologi yang mendasarinya.

23) *Circulatory Disease Procedures*

Percutaneous Balloon Valvuloplasty : Prosedur ini dilakukan pada pasien dengan mitral stenosis, gunakan kode 35.96 (*Percutaneous valvuloplasty*).

Prosedur untuk diagnosis dan pengobatan penyakit jantung koroner diurutkan berdasarkan langkah-langkah berikut:

Coronary Arteriography : 88.55 (*Coronary arteriography using a single catheter*), 88.56 (*Coronary arteriography using two catheters*). 88.57 (*Other and unspecified coronary arteriography*) digunakan untuk yang tidak menyebutkan jumlah kateternya.

Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA), gunakan kode 00.66 (*Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA]*).

Kode berdasarkan jumlah pembuluh darah yang ditangani : 00.40 (*Procedure on single vessel*), 00.41 (*Procedure on two vessels*), 00.42 (*Procedure on three vessels*), 00.43 (*Procedure on four or more vessels*).

Kode berdasarkan jenis stent kode prosedur: 36.06 (*Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s)*), 36.07 (*Insertion of drug-eluting coronary artery stent(s)*)

Kode berdasarkan jumlah stent yang dipasang: 00.45 (*Insertion of one vascular stent*), 00.46 (*Insertion of two vascular stents*), 00.47 (*Insertion of three vascular stents*), 00.48 (*Insertion of four or more vascular stents*)

Fractional Flow Reserve (FFR) : Prosedur ini dilakukan untuk mengukur tekanan intravaskular pada arteri koroner guna mengevaluasi aliran darah, gunakan 00.59 (*Intravascular pressure measurement of coronary arteries*).

Pemasangan Monitoring Catheter, kode prosedur berbeda tergantung pada tujuan pemantauan:

Pemantauan Tekanan Arteri Sistemik, gunakan kode 89.61 (*Systemic arterial pressure monitoring*).

Pemantauan Tekanan Vena Sentral (CVP), gunakan kode 89.62 (*Central venous pressure monitoring*).

Pemantauan Tekanan Arteri Pulmonalis (PA Wedge), gunakan kode 89.64 (*Pulmonary artery wedge monitoring*).

Berikut merupakan contoh kode dan tindakan yang dilakukan pada kasus *Cardiac Arrest*:

Jika dilakukan *cardioversion*, gunakan kode 99.62 (*Other electric counter-shock of heart*)

Jika dilakukan pijat jantung tertutup (*Closed Chest Cardiac Massage*), gunakan kode 99.63 (*Closed chest cardiac massage*).

Jika detail tindakan resusitasi jantung dan paru (CPR) tidak dicatat, gunakan kode 99.60 (*Cardiopulmonary resuscitation, not elsewhere specified*).

Radiofrequency Ablation untuk mengobati aritmia jantung, dilakukan untuk mengobati kondisi seperti *supraventricular tachycardia* atau fibrilasi atrium. Kode prosedur sebagai berikut:

Invasive Electrophysiologic Testing (EPS), gunakan kode 37.26 (*Catheter based invasive electrophysiologic testing [EPS]*)

Cardiac Mapping, gunakan kode 37.27 (*Cardiac mapping*)

Pengangkatan atau Destruksi Lesi Jantung, gunakan kode 37.34 (*Excision or destruction of other lesion of heart, other approach*).

Tindakan *repair AV Shunt* : tindakan perbaikan (revisi) av shunt yang sebelumnya telah dipasang untuk dialysis. Teknik pembedahan bervariasi,

tergantung tipe anastomosis yang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi shunt.

Contoh 1: Tindakan *repair AV Shunt* pada pasien hemodialisis, gunakan kode 39.42 (*Revision of arteriovenous shunt for renal dialysis Conversion of renal dialysis*)

Tindakan pemasangan AV Shunt dengan tujuan renal dialysis

Contoh 2: pemasangan AV Shunt dengan tujuan dialisis, gunakan kode 39.27 (*Arteriovenostomy for renal dialysis*). Tindakan *arteriovenostomy* merupakan pembuatan lubang untuk menggabungkan arteri dan vena untuk membuat fistula guna mengakses aliran darah untuk dialisis. *Code also any renal dialysis (39.95)*

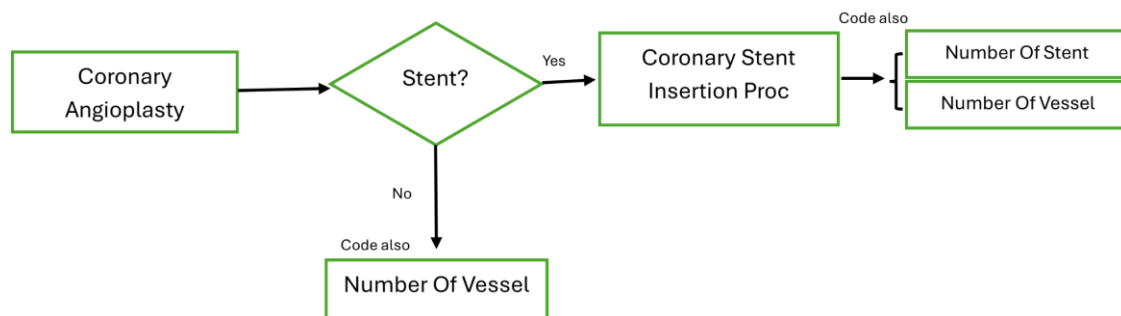
Tindakan Endovascular *Radiofrequency Ablation* pada kasus *venous insufficiency (CVI)*

Contoh 3: Dokter melakukan tindakan endovaskular radiofrequency ablation pada vena pasien yang didiagnosis *venous insufficiency (CVI)*. Tindakan tersebut menggunakan kode 39.79 (*Other endovascular procedures on other vessels*) dan dibuktikan dengan hasil USG Doppler

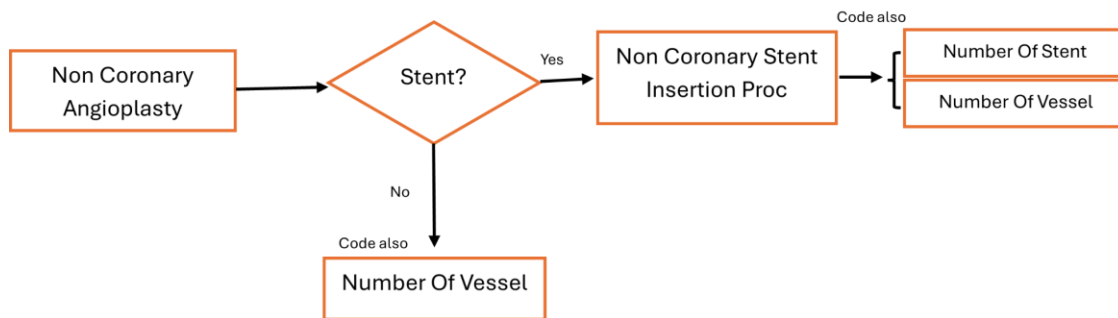
Tindakan vena seksi menggunakan kode 38.94 (*Venous cutdown*)

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 15

Pedoman koding dalam iDRG terkait jantung dan pembuluh darah yang memiliki prosedur yang kompleks dalam penanganannya seperti pada kasus pemasangan stent pada pembuluh darah dimana ada sumbatan kemudian dilakukan pelebaran untuk melancarkan peredaran darah. Pada INA-Grouper Tindakan PCI harus dikode dengan ‘*code also*’ yang ada di dalam ICD-9 CM



Gambar C.2. Pedoman koding dalam iDRG terkait jantung dan pembuluh darah



Gambar C.3. Pedoman koding dalam iDRG terkait jantung dan pembuluh darah

Gambar C.4. Alur Koding Stent Coronary & Non Coronary

- 1) Perhatikan tabel ini terkait logic iDRG karena adanya kode dalam tabel ini akan menentukan Disease Cluster (DC) dalam iDRG

Tabel C.34. Kode ICD dan DC khusus yang berhubungan pada MDC 15

No	Tindakan	Kode ICD	DC terkait
1	Catheterization	Bila ada salah satu kode ICD dibawah ini : 37.21 Right heart cardiac catheterization 37.22 Left heart cardiac catheterization 37.23 Combined right and left heart cardiac catheterization 37.26 Catheter based invasive electrophysiologic testing 88.52 Angiocardiography of right heart structures 88.53 Angiocardiography of left heart structures 88.54 Combined right and left heart angiocardiography 88.55 Coronary arteriography using a single catheter 88.56 Coronary arteriography using two catheters 88.57 Other and unspecified coronary arteriography 88.58 Negative-contrast cardiac roentgenography	Acute MI w Cath Multiple Valve Procedures w Cath Coronary Bypass w Cath Cardiac Angiography
2	Percutaneous Transluminal Cardiovascular Angiography (PTCA)	00.66 Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy 36.09 Other removal of coronary artery obstruction	Acute MI w PTCA w (+Stent) Acute MI w PTCA Coronary Bypass w PTCA PTCA (+Stent) PTCA
3	Coronary Stent	Coronary Stent Categories 36.06 Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s) 36.07 Insertion of drug-eluting coronary artery stent(s) 36.050 Insertion Of Drug eluting or coated Balloon of Coronary (IM) Number of Stents 00.45 Insertion of one vascular stent 00.46 Insertion of two vascular stents 00.47 Insertion of three vascular stents 00.48 Insertion of four or more vascular stents 00.450 Insertion of one vascular drug eluting or coated baloon (IM) 00.460 Insertion of two vascular drug eluting or coated baloon (IM)	Acute MI w PTCA w (+Stent) PTCA (+Stent)

		00.470 Insertion of three vascular drug eluting or coated balloon (IM) 00.480 Insertion of four or more drug eluting or coated balloon (IM) Number of Vessels 00.40 Procedure on single vessel 00.41 Procedure on two vessels 00.42 Procedure on three vessels 00.43 Procedure on four or more vessels 00.44 Procedure on vessel bifurcation	
No	Tindakan	Kode ICD	DC terkait
4	Non Coronary Stent	Insertion of Non-Coronary Stents 00.55 Insertion of drug-eluting stent(s) of other peripheral vessel(s) 00.63 Percutaneous insertion of carotid artery stent(s) 00.64 Percutaneous insertion of other precerebral (extracranial) artery stent(s) 00.65 Percutaneous insertion of intracranial vascular stent(s) 39.90 Insertion of non-drug-eluting peripheral (non-coronary) vessel stent(s) 36.051 Insertion Of Drug eluting or coated Balloon of Non Coronary (IM) Number of Stents 00.45 Insertion of one vascular stent 00.46 Insertion of two vascular stents 00.47 Insertion of three vascular stents 00.48 Insertion of four or more vascular stents 00.450 Insertion of one vascular drug eluting or coated balloon (IM) 00.460 Insertion of two vascular drug eluting or coated balloon (IM) 00.470 Insertion of three vascular drug eluting or coated balloon (IM) 00.480 Insertion of four or more drug eluting or coated balloon (IM) Number Of Vessel 00.45 Insertion of one vascular stent 00.46 Insertion of two vascular stents 00.47 Insertion of three vascular stents 00.48 Insertion of four or more vascular stents	PTA (+Stent)
5	Percutaneous Transluminal Angiography (PTA)	3950 & 0040 (angio/ath oth non-coro ves + procedure-one vessel) 3950 & 0041 (angio/ath oth non-coro ves + procedure-two vessels) 3950 & 0042 (angio/ath oth non-coro ves + procedure-three vessels) 3950 & 0043 (angio/ath oth non-coro ves + procedure-four+ vessels) 3950 & 0044 (angio/ath oth non-coro ves + proc-vessel bifurcation) 0061 & 0040 (perc angio precereb vess + procedure-one vessel) 0061 & 0041 (perc angio precereb vess + procedure-two vessels) 0061 & 0042 (perc angio precereb vess + procedure-three vessels) 0061 & 0043 (perc angio precereb vess + procedure-four+ vessels) 0061 & 0044 (perc angio precereb vess + proc-vessel bifurcation) 0062 & 0040 (perc angio intracran ves + procedure-one vessel) 0062 & 0041 (perc angio intracran ves + procedure-two vessels) 0062 & 0042 (perc angio intracran ves + procedure-three vessels) 0062 & 0043 (perc angio intracran ves + procedure-four+ vessels) 0062 & 0044 (perc angio intracran ves + proc-vessel bifurcation)	PTA
6	Thrombolytic Agent	99.10 Injection or infusion of thrombolytic agent	Acute MI with Thrombolytic

	Injection/Infusion	99.20 Injection or infusion of platelet inhibitor	Injection
--	---------------------------	---	-----------

Contoh 1:

- 2) Pasien usia 56 tahun datang dengan keluhan nyeri dada hebat dan sesak nafas selama 2 jam sebelum dibawa ke IGD, setelah diperiksa oleh dokter dilakukan pemeriksaan, EKG didapatkan elevasi segmen ST anterior, didiagnosis *STEMI anterior* yang akan dilakukan PCI segera. Pasien segera dipindahkan ke ruang kateterisasi jantung untuk melakukan PCI emergensi, Dalam ruang kateterisasi, dokter jantung melakukan angiografi koroner yang mengungkapkan sumbatan total pada arteri koroner anterior, Balon angioplasty ditempatkan di dalam arteri koroner untuk melebarkan sumbatan, dan stent ditempatkan untuk menjaga pembuluh darah tetap terbuka.

Diagnosis Utama : MCI Anterior

Diagnosis Sekunder : -

Tindakan : PCI

Diberikan kode I21.0 (*Acute transmural myocardial infarction of anterior wall*) sebagai diagnosis utama, kode 00.66 (*Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) of coronary artery(s); single vessel*) untuk PTCA nya, 36.07 (*Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s)*), 00.40 (*Procedure on single vessel*) code also untuk pemasangan di satu vessel, 00.45 (*Insertion of one vascular stent*) code also untuk pemasangan di satu stent, 00.49 (*SuperSaturated oxygen therapy*) dan 99.10 (*Injection or infusion of thrombolytic agent*) untuk tindakannya.

Note: PTCA wajib dikode juga untuk tindakan 36.06-36.07, 00.40-00.43, 00.45-00.49. Jika tidak lengkap akan terjadi eror. Demikian pula untuk *non-coronary vessel(s)*. Perhatikan *code also* nya.

Tabel C.35. Contoh kasus *disorder of arteries and arterioles*

Contoh 1	Pasien usia 52 tahun datang dengan keluhan nyeri hebat dan mati rasa pada kaki kanan kemudian dibawa ke IGD, pasien memiliki riwayat diabetes dan hipertensi tidak terkontrol. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang ditemukan bahwa pasien mengalami penyempitan yang signifikan pada arteri femoralis kanan, yang merupakan pembuluh darah besar yang memasok darah ke kaki kanan. Setelah melakukan konsultasi dengan tim kardiologi dan intervensionalis vaskular, diputuskan untuk melakukan tindakan PTA pada arteri femoralis kanan pasien. Prosedur PTA dilakukan dengan memasukkan kateter ke dalam arteri femoralis dan meluncurkannya ke lokasi penyempitan.
-----------------	---

	Kemudian, balon pada ujung kateter diperluas untuk melebarkan pembuluh darah yang menyempit dan mengembalikan aliran darah normal ke kaki kanan pasien.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	PAD	I77.9 (<i>Disorder of arteries and arterioles, unspecified</i>)
Diagnosis Sekunder	Hipertensi Diabetes Mellitus	I10 (<i>Essential (primary) hypertension</i>) dan E11.9 (<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>)
Prosedur	PTA	39.50 (<i>Angioplasty or atherectomy of other non-coronary vessel(s)</i>) 00.55 (<i>Insertion of drug-eluting peripheral vessel stent(s)</i>) 39.90 (<i>Insertion of non-drug-eluting peripheral vessel (non-coronary) stent(s)</i>) 00.40 (<i>Procedure on single vessel</i>) code also untuk pemasangan di satu vessel, 00.44 (<i>Procedure on vessel bifurcation</i>) 00.45 (<i>Insertion of one vascular stent</i>) code also untuk pemasangan di satu stent 00.49 (<i>SuperSaturated oxygen therapy</i>) 99.10 (<i>Injection or infusion of thrombolytic agent</i>)

- 3) Penggunaan kode 35.29 (*Multiple valve repair/replacement*) IM diperuntukkan dalam kasus operasi *valve repair* lebih dari satu dalam satu kali operasi dan tambahkan rincian katub yang diperbaiki. Jika kode 00.66 (*Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy*) minimal harus dengan 00.40 (*Procedure on single vessel*). 00.61 (*Percutaneous angioplasty or atherectomy of precerebral (extracranial) vessel(s)*) berpasangan dengan 00.63 (*Percutaneous insertion of carotid artery stent(s)*) dan 00.64 (*Percutaneous insertion of other precerebral (extracranial) artery stent(s)*). 00.62 (*Percutaneous angioplasty or atherectomy of intracranial vessel(s)*) berpasangan dengan 00.65 (*Percutaneous insertion of intracranial vascular stent(s)*). 39.50 (*Angioplasty or atherectomy of other non-coronary vessel(s)*) berpasangan 39.90 (*Insertion of non-drug-eluting*

peripheral vessel (non-coronary) stent(s)) dan 00.55/00.60 .Gunakan 36.05-*Insertion Of Drug eluting or coated Balloon* ^(IM) untuk tindakan DCB/DEB.

- 4) Pada pasien dengan diagnosis diabetes mellitus tipe 2 yang mengalami infark miokard akut, gagal jantung atau angina sebagai komplikasi diabetes mellitus, kondisi jantung tersebut dikodekan sebagai diagnosis primer sesuai kondisi yang dialami, sedangkan diabetes mellitus tipe 2 dikodekan sebagai diagnosis sekunder dengan kode E11.6 (diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi lain yang ditentukan).

10. MDC 16 SALURAN PENCERNAAN

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 16

1) Oesophagitis And Oesophageal Ulcer (K20, K22.1)

Jika dokter mendiagnosis *Streptococcal oesophagitis*, gunakan kode K20 (*Oesophagitis*) dan tambahkan kode sesuai dengan spesies *streptococcus* yang menjadi penyebabnya dengan menggunakan kode dari rentang B95.0 – B95.5 (tergantung spesies *streptococcus*).

Jika dokter mendiagnosis *Drug-induced oesophagitis* atau *drug-induced oesophageal ulcer*, gunakan kode K20 (*Oesophagitis*) pada kasus peradangan atau K22.1 (*Ulcer of oesophagus*) jika terdapat ulkus, serta tambahkan kode penyebab eksternal berdasarkan jenis obat yang menyebabkan efek samping. Misalnya, jika disebabkan oleh *tetracycline*, maka tambahkan kode penyebab eksternal Y40.4 (*Tetracyclines causing adverse effects in therapeutic use*).

Jika dokter mendiagnosis *Radiation oesophagitis*, gunakan kode K20 (*Oesophagitis*) pada kasus peradangan atau K22.1 (*Ulcer of oesophagus*). Jika terdapat ulkus, serta tambahkan kode penyebab eksternal Y84.2 (*Radiological procedure and radiotherapy as the cause of abnormal reaction of the patient*).

2) Oesophageal Obstruction (K22.2)

Jika dokter mendiagnosis obstruksi esofagus akibat benda asing, gunakan kode T18.1 (*Foreign body in oesophagus*), tambahkan kode K22.2 (*Oesophageal obstruction*), serta kode penyebab eksternal W44.- (*Foreign body entering into or through eye or natural orifice*).

Jika dokter mendiagnosis obstruksi esofagus akibat kanker esofagus, gunakan kode C15.- (*Malignant neoplasm of oesophagus*), dan tambahkan kode K22.2 (*Oesophageal obstruction*) jika prosedur medis, seperti operasi, diperlukan untuk mengatasi obstruksi tersebut.

Jika dokter mendiagnosis obstruksi esofagus akibat tertelan cairan yang bersifat korosif beberapa minggu sebelumnya, gunakan kode K22.2 (*Oesophageal obstruction*), tambahkan kode T97 (*Sequelae of toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source*), serta kode penyebab eksternal X49 (*Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified chemicals and noxious substances*).

3) Perforation Of Oesophagus (K22.3)

Jika dokter mendiagnosis *Spontaneous rupture esofagus* (*Boerhaave syndrome*), gunakan kode K22.3 (*Perforation of oesophagus*) tanpa kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis Perforasi esofagus akibat ulkus esofagus, gunakan kode K22.3 (*Perforation of oesophagus*), serta tambahkan kode K22.1 (*Ulcer of oesophagus*).

Jika dokter mendiagnosis Perforasi esofagus akibat kanker esofagus, gunakan kode C15.- (*Malignant neoplasm of oesophagus*), serta tambahkan kode K22.3 (*Perforation of oesophagus*), jika prosedur medis, seperti operasi, diperlukan untuk mengatasi *rupture* tersebut.

Jika dokter mendiagnosis *Rupture* atau perforasi esofagus akibat tertelan cairan atau bahan yang bersifat korosif, gunakan kode T54.2 (*Toxic effect of corrosive acids and acid-like substances*). Tambahkan kode K22.3 (*Perforation of oesophagus*) serta kode penyebab eksternal X49 (*Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified chemicals and noxious substances*).

4) Dyskinesia Of Oesophagus (K22.4)

Jika dokter mendiagnosis *Dyskinesia of oesophagus*, *diffuse oesophageal spasm*, gangguan motorik hipertensif pada *oesophagus*, atau *nutcracker oesophagus*, gunakan kode K22.4 (*Dyskinesia of oesophagus*).

5) Diverticulum Of Oesophagus (K22.5)

Jika dokter mendiagnosis divertikulum pada *oesophagus*, tanpa memandang jenisnya (*Zenker's*, *mid-oesophageal*, *epiphrenic*, atau *diffuse intramural*), gunakan kode K22.5 (*Diverticulum of oesophagus*)..

6) Gastro-Oesophageal Laceration-Haemorrhage Syndrome (K22.6)

Jika dokter mendiagnosis *Gastro-oesophageal laceration - haemorrhage syndrome* atau *Mallory-Weiss syndrome*, gunakan kode K22.6 (*Gastro-oesophageal laceration-haemorrhage syndrome*).

7) Disorders of oesophagus (K23.-)

Jika dokter mendiagnosis *Tuberculous oesophagitis*, gunakan kode A18.8† (*Tuberculosis of other specified organs*) dan tambahkan kode K23.0* (*Tuberculous oesophagitis*).

Jika dokter mendiagnosis *Herpes simplex oesophagitis*, gunakan kode B00.8† (*Other forms of herpesviral infection*) dan tambahkan kode K23.8* (*Disorders of oesophagus in other diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *Candidal oesophagitis* atau *candidal oesophageal ulcer*, gunakan kode B37.8† (*Candidiasis of other sites*), dan tambahkan kode K23.8* (*Disorders of oesophagus in other diseases classified elsewhere*).

8) Gastritis And Duodenitis (K29.-)

Jika dokter mendiagnosis *Acute haemorrhagic gastritis* atau gaster dengan pendarahan akut gunakan kode K29.0 (*Acute haemorrhagic gastritis*). Kode K29.0 digunakan jika hasil endoskopi menunjukkan sumber pendarahan dari gaster.

Jika dokter mendiagnosis *Viral gastritis*, ikuti pedoman diagnosis dan pengodean pada bab 1 ICD-10 (penyakit menular).

Jika dokter mendiagnosis *Gastritis* atau *duodenitis* disebabkan oleh infeksi *Helicobacter pylori*, maka tambahkan kode B98.0 (*Helicobacter pylori as the cause of diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *Portal hypertensive gastropathy*, gunakan kode K29.6 (*Other gastritis*), serta tambahkan kode penyebab K76.6 (*Portal hypertension*).

Jika tidak ada informasi spesifik tentang jenis *chronic gastritis* (*superficial* atau *atrophic*), maka gunakan kode K29.5 (*Chronic gastritis, unspecified*).

9) **Dyspepsia (K30)**

Jika dokter mendiagnosis *dyspepsia* dengan penyebab spesifik, tambahkan kode lain untuk mencatat penyebab tersebut sebagai berikut:

Dyspepsia yang disebabkan oleh obat-obatan tertentu, seperti NSAIDs, kortikosteroid, atau obat lainnya, gunakan kode K30 (*Dyspepsia*) dan tambahkan kode eksternal yang sesuai untuk mencatat jenis obat yang menyebabkan kondisi tersebut. Kode eksternal ini harus disesuaikan dengan jenis obat yang digunakan, sesuai dengan klasifikasi ICD mengenai efek samping obat.

Jika dokter mendiagnosis *dyspepsia* disebabkan oleh infeksi *Helicobacter pylori*, gunakan kode K30 (*Dyspepsia*) dan tambahkan kode B98.0 (*Helicobacter pylori as the cause of diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis *dyspepsia* bukan disebabkan oleh ulkus (*non-ulcer dyspepsia*), tetap gunakan kode K30 (*Dyspepsia*) dan tidak diperlukan kode tambahan kecuali ada informasi tambahan tentang penyebab spesifik (seperti obat atau infeksi).

10) **Other Diseases Of Stomach And Duodenum (K31.-)**

Jika dokter mendiagnosis *Pyloric stenosis* atau *gastric outlet obstruction* gunakan kode K31.1 (*Adult hypertrophic pyloric stenosis*). Jika kondisi ini bersifat kongenital (bawaan lahir), gunakan kode Q40.0 (*Congenital hypertrophic pyloric stenosis*).

Jika dokter mendiagnosis *Hourglass stricture and stenosis* gunakan kode K31.2 (*Hourglass stricture and stenosis of stomach*). Jika kondisi ini bersifat kongenital, gunakan kode Q40.2 (*Other specified congenital malformations of stomach*).

Jika dokter mendiagnosis *Pylorospasm* tanpa kaitan dengan kondisi psikiatrik, gunakan kode K31.3 (*Pylorospasm, not elsewhere classified*). Jika kondisi ini bersifat kongenital, gunakan kode Q40.2 (*Other specified congenital malformations of stomach*). Namun, jika dokter mencatat bahwa kondisi ini terkait dengan gangguan psikosomatik, gunakan kode F45.31 (*Somatiform autonomic dysfunction, upper gastrointestinal tract*) ^(IM).

11) **Appendicitis (K35-K37)**

Apendisitis akut tanpa atau dengan kondisi peritonitis, perforasi, atau abses peritoneal menggunakan kode kombinasi K35.- (*Acute appendicitis*).

Jika dokter mendiagnosis appendicitis akut disertai peritonitis umum (dengan atau tanpa ruptur/perforasi/abses dalam rongga peritoneum), gunakan kode K35.2 (*Acute appendicitis with generalized peritonitis*).

Jika dokter mendiagnosis appendicitis akut disertai peritonitis lokal (dengan atau tanpa ruptur/perforasi/abses dalam rongga peritoneum), gunakan kode kombinasi K35.3 (*Acute appendicitis with localized peritonitis*).

Jika dokter mendiagnosis appendicitis akut tetapi tidak disebutkan adanya peritonitis umum atau lokal, gunakan kode K35.8 (*Acute appendicitis, unspecified*).

Contoh 1: Jika dokter mendiagnosis apendisitis akut yang disertai dengan peritonitis umum akibat ruptur atau perforasi appendix, gunakan kode kombinasi K35.2 (*Acute appendicitis with generalized peritonitis*).

12) **Hernia (K40-K46)**

Dalam pengodean diagnosis hernia, pemberi kode harus mencatat secara rinci, apakah terdapat obstruksi atau gangrene. Perlu dicatat bahwa hernia yang disertai dengan obstruksi atau gangrene, baik satu atau keduanya, diklasifikasikan dalam kategori hernia dengan obstruksi atau gangrene.

Jika dokter mendiagnosis Hernia dengan Obstruksi gunakan kode kombinasi pada subbab Hernia (K40-K46) *with obstruction*.

Jika dokter mendiagnosis hernia yang disertai obstruksi dan gangrene gunakan kode hernia gangrene sesuai subbab Hernia (K40-K46) *with Gangrene*.

13) **Noninfective Enteritis And Colitis (K50-K52)**

Kolitis yang disebabkan oleh alergi, termasuk gastroenteritis dan kolitis alergi serta dietetik, gunakan kode K52.2-. Kolitis yang tidak disebabkan oleh alergi dan dietetik lainnya gunakan kode K52.3 (*Indeterminate colitis*). Sementara untuk kolitis yang tidak infeksius dan tidak dapat ditentukan, termasuk eosinophilic gastroenteritis, gunakan kode K52.8 (*Other specified noninfective gastroenteritis and colitis*).

14) **Allergic And Dietetic Gastroenteritis And Colitis Due To Cow's Milk Protein (K52.20)**

Alergi protein susu sapi yang menyebabkan diare, maka gunakan kode K52.20 (*Allergic and dietary gastroenteritis and colitis due to cow's milk protein*) ^(IM).

Oleh karena itu, jika dokter hanya menegaskan diagnosis sebagai alergi protein susu sapi secara umum, pemberi kode harus berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan bentuk spesifik dari alergi tersebut.

15) Vascular Disorders Of Intestine (K55.-)

Jika dokter mendiagnosis *Acute mesenteric ischaemia* atau *acute intestinal infarction*, gunakan kode K55.0 (*Acute vascular disorders of intestine*).

Jika dokter mendiagnosis *Chronic intestinal ischaemia* atau *mesenteric atherosclerosis*, gunakan kode K55.1 (*Chronic vascular disorder of intestine*).

Jika dokter mendiagnosis *Vascular ectasia of small intestine* atau *intestinal vasculitis*, gunakan kode K55.8 (*Other vascular disorders of intestine*).

16) Paralytic Ileus And Intestinal Obstruction Without Hernia (K56.-)

Jika dokter mendiagnosis obstruksi usus disebabkan oleh kanker, divertikulitis, atau enteritis regional, gunakan kode K56.6 (*Other and unspecified intestinal obstruction*), tambahkan kode penyebabnya apakah kankernya atau yang lain.

Jika dokter mendiagnosis bahwa obstruksi usus disebabkan oleh hernia, gunakan kode dari kelompok K40 – K46 untuk menunjukkan adanya obstruksi pada usus.

17) Diverticular Disease Of Intestine (K57.-)

Jika dokter mendiagnosis adanya penyakit divertikular usus besar dengan perdarahan saluran cerna bagian bawah, maka gunakan kode K57.3 (*Diverticular disease of large intestine without perforation and abscess*) sebagai kode utama. Jika pasien mengalami BAB berdarah atau perdarahan rektum (misalnya darah tampak jelas merah terang / darah segar), tambahkan kode K62.5 (*Haemorrhage of anus and rectum*) sebagai kode tambahan. Namun, jika darah dalam feses tampak berwarna hitam atau kecoklatan (melena, menunjukkan perdarahan lebih tinggi di saluran cerna), maka gunakan kode K92.1 (*Melaena*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis adanya penyakit divertikular usus besar dengan fistula, maka gunakan kode K57.2 (*Diverticular disease of large intestine with perforation and abscess*) sebagai kode utama, serta tambahkan kode K63.2 (*Fistula of intestine*) sebagai kode tambahan.

18) Other Functional Intestinal Disorders (K59.-)

Jika dokter mendiagnosis *Megacolon*, gunakan kode K59.3 (*Megacolon, not elsewhere classified*), serta tambahkan kode untuk penyakit penyebab yang mendasarinya, seperti *ulcerative colitis*, *regional ileitis*, atau *shigellosis*. Jika *megacolon* disebabkan oleh obat-obatan, gunakan kode eksternal yang sesuai dengan jenis obat yang menjadi penyebabnya.

Jika dokter mendiagnosis *Anal spasm*, gunakan kode K59.4 (*Anal spasm*).

19) Diseases Of Anus And Rectum (K60-K62)

Kode K60 – K62 digunakan berdasarkan diagnosis dokter. Jika dokter mendiagnosis *Lower gastrointestinal bleeding* atau hematochezia gunakan kode K62.5 (*Haemorrhage of anus and rectum*). Jika dokter mendiagnosis proktitis radiasi, gunakan kode K62.7 (*Radiation proctitis*).

20) Other Diseases Of Intestine (K63.-)

Jika dokter mendiagnosis Abses usus, gunakan kode K63.0 (*Abscess of intestine*). **Pengecualian:**

Abses terjadi di anus atau rektum, gunakan kode dalam rentang K61.- (*Abscess of anal and rectal regions*).

Abses terjadi di apendiks, gunakan kode K35.-.

Jika dokter mendiagnosis Perforasi usus (nontraumatik), gunakan kode K63.1 (*Perforation of intestine (nontraumatic)*).

Pengecualian:

Perforasi terjadi di apendiks, gunakan kode yang sesuai dalam rentang K35.- (*Acute appendicitis*).

Perforasi terjadi di duodenum, gunakan kode yang sesuai dalam rentang K26.- (*Duodenal ulcer*).

Jika dokter mendiagnosis Polip kolon, gunakan kode K63.5 (*Polyp of colon*).

Jika hasil patologi telah diperoleh, gunakan kode sesuai hasil patologi.

Contoh: jika hasil patologi menunjukkan adenoma, gunakan kode D12.2 – D12.6 (*Benign neoplasm of colon*) bersama dengan kode ICD-O M8140/0 (*Adenoma NOS*).

21) Peritonitis (K65, K67)

Jika dokter mendiagnosis *Spontaneous bacterial peritonitis*, gunakan kode K65.00 (*Primary peritonitis*)^(IM).

Jika dokter mendiagnosis *Secondary peritonitis*, gunakan kode K65.01 (*Secondary bacterial peritonitis*)^(IM). Jika disebabkan oleh perforasi usus, gunakan kode sesuai lokasi dan jenis perforasi, misalnya:

K62.1 (*Rectal polyp*)

K25.1 (*Acute gastric ulcer with perforation*)

K57.2 (*Diverticular disease of large intestine with perforation and abscess*).

Jika dokter mendiagnosis *Tuberculous peritonitis*, maka gunakan kode A18.3† (*Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands*) dan K67.3* (*Tuberculous peritonitis*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis peritonitis tanpa menyebutkan penyebabnya, maka gunakan kode K65.9 (*Peritonitis, unspecified*).

22) Hemoperitoneum (K66.1)

Jika dokter mendiagnosis *Hemoperitoneum* tanpa menyebutkan penyebabnya, maka gunakan kode K66.1 (*Haemoperitoneum*).

Jika dokter mendiagnosis *Hemoperitoneum* yang disebabkan oleh ruptur hepatoma, maka gunakan kode C22.0 (*Liver cell carcinoma*) dan tambahkan kode K66.1 (*Haemoperitoneum*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis *Hemoperitoneum* yang disebabkan oleh ruptur kehamilan tuba, maka gunakan kode O00.1 (*Tubal pregnancy*) serta tambahkan kode K66.1 (*Haemoperitoneum*)

23) Intestinal Malabsorption (K90.-)

Jika dokter mendiagnosis Steatorrhea pankreas gunakan kode K90.3 (*Pancreatic Steatorrhea*).

24) Postprocedural Disorders Of Digestive System (K91.-)

Jika dokter mendiagnosis *Short bowel syndrome*, pasca operasi reseksi usus, gunakan kode K91.20 (*Post surgical malabsorption, post massive bowel resection*)^(IM).

Jika dokter mendiagnosis *Postsurgical blind loop syndrome*, gunakan kode K91.28 (*Other postsurgical malabsorption*)^(IM).

25) Gastrointestinal Haemorrhage (K92.0-K92.2)

Jika dokter mendiagnosis *Lower gastrointestinal bleeding*, gunakan kode K62.5 (*Hemorrhage of anus and rectum*) atau konsultasikan dengan dokter apakah pasien mengalami *haematemesis* atau *melaena*.

Jika dokter mendiagnosis *haematemesis*, gunakan kode K92.0 (*Haematemesis*).

Jika dokter mendiagnosis *melaena*, gunakan kode K92.1 (*Melaena*).

26) Gastrointestinal Procedures

Pemberian prosedur *Esophagogastroduodenoscopy* (EGD) disertai dengan tindakan spesifik, gunakan kode tindakan spesifik tersebut tanpa perlu menambahkan kode EGD itu sendiri.

Jika dokter melakukan prosedur kontrol pendarahan secara endoskopik, gunakan kode 44.43 (*Endoscopic control of gastric or duodenal bleeding*).

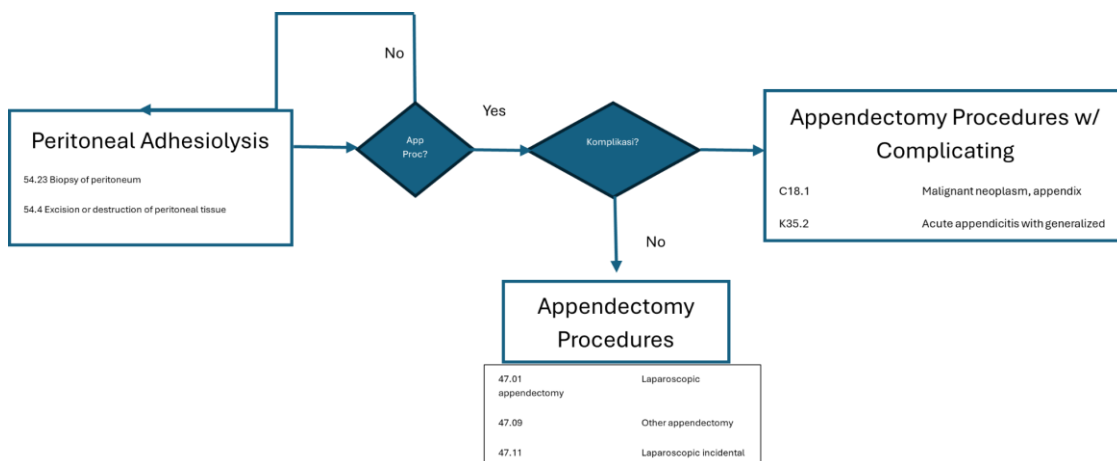
b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 16

- 1) Jika dokter mendiagnosis enteritis atau diare yang disebabkan oleh bakteri, virus, protozoa, dan agen infeksius spesifik lainnya, gunakan kode pada kategori A00 - A08.
- 2) Jika dokter mendiagnosis enteritis atau diare non infeksi, gunakan kode K52.9 (*Noninfective diarrhoea*), untuk neonatal gunakan kode P78.3 (*Noninfective neonatal diarrhoea*).
- 3) Jika dokter mendiagnosis enteritis atau diare disertai dengan dehidrasi tidak perlu dikode secara terpisah, kecuali jika dokter secara jelas mendiagnosis adanya Hypovolaemic shock, gunakan kode R57.1 (*Hypovolaemic shock*).

- 4) Kasus konstipasi pada ileus maupun obstruksi saluran cerna seharusnya tidak dikode tersendiri karena konstipasi merupakan bagian dari ileus obstruksi tersebut.

Contoh 1: Jika dokter mendiagnosis konstipasi yang disebabkan oleh hernia umbilical dengan obstruksi, gunakan kode K42.0 (*Umbilical hernia with obstruction, without gangrene*).

- 5) Tidak ada kode kombinasi baik *include / exclude* secara langsung untuk K29.7 (*Gastritis, unspecified*) dengan K92.0 (*Haematemesis*) menjadi K29.0 (*Acute haemorrhagic gastritis*). Kode K29.0 (*Acute haemorrhagic gastritis*) digunakan jika sudah tegak dan terkonfirmasi sumber perdarahan berasal dari gaster.
- 6) Tindakan *laparotomy* dan *adhesiolysis*.
- 7) *Laparotomy* jika sebagai *operative approach* bersifat “omit code” atau tidak perlu dikoding karena merupakan bagian dari kode prosedur lain.
- 8) Jika dokter melakukan prosedur re-laparotomy pada sayatan operasi laparotomi sebelumnya untuk kontrol pendarahan, eksplorasi, dan/atau insisi hematoma, gunakan kode 54.12 (*Reopening of recent laparotomy site*).
- 9) Jika dokter melakukan prosedur re-laparotomy pada sayatan operasi laparotomi sebelumnya dan dilakukan prosedur lainnya, gunakan kode 54.12 (*Reopening of recent laparotomy site*) dan tambahkan kode prosedur sesuai dengan operasi yang dilakukan.
- 10) *Adhesiolysis* konfirmasi menggunakan instrumen tajam (*surgical*) dikode terpisah, tetapi jika menggunakan teknik tumpul atau digital atau manual atau mekanik, atau tanpa instrumen bersifat “omit code” atau tidak perlu dikoding.
- 11) Peritoneal Adhesiolysis Proc dimana bila bersamaan dengan tindakan *appendectomy* maka masuk dalam kategori *Appendectomy Procedures* atau *Appendectomy Procedures w Complicating* PDx seperti diagram dibawah ini:



Gambar C.5. Peritoneal Adhesiolysis Proc

Copyright@ Pusat Pembiayaan Kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

11.

MDC 17 HEPATOBILIER DAN PANKREAS

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 17

1) Toxic Liver Disease (K71.-)

Jika dokter mendiagnosis *Toxic liver disease with hepatic coma*, gunakan kode K71.1 (*Toxic liver disease with hepatic necrosis*).

Jika dokter mendiagnosis *Drug Induced Hepatitis* akut, gunakan kode K71.2 (*Toxic liver disease with acute hepatitis*).

Jika dokter mendiagnosis *Toxic liver disease with chronic hepatitis*, gunakan kode K71.3 (*Toxic liver disease with chronic persistent hepatitis*) atau K71.4 (*Toxic liver disease with chronic lobular hepatitis*) atau K71.5 (*Toxic liver disease with chronic active hepatitis*).

Tambahkan juga kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi obat penyebabnya. Contoh : Jika dokter mendiagnosis *Drug Induce Hepatitis* karena *Rifamycins*, gunakan kode K71.2 (*Toxic liver disease with acute hepatitis*) dan Y40.6 (*Rifamycins*)

2) Hepatic Failure, not elsewhere classified (K72.-)

Jika dokter mendiagnosis gagal hati yang tidak spesifik, gunakan kode dalam kelompok K72.- yaitu *Hepatic failure, not elsewhere classified* termasuk kondisi *Encephalopathy Hepaticum* atau *Coma Hepaticum*.

3) Fibrosis and cirrhosis of liver (K74)

Jika dokter mendiagnosis *Primary biliary cirrhosis* gunakan kode K74.3 (*Primary biliary cirrhosis*).

Jika dokter mendiagnosis *secondary biliary cirrhosis* gunakan kode K74.4 (*Secondary biliary cirrhosis*) dan tambahkan kode penyebabnya.

Jika dokter mendiagnosis *biliary cirrhosis* yang disebabkan obstruksi batu saluran empedu gunakan kode K80.- dan tambahkan kode K74.4 (*Secondary biliary cirrhosis*)

Jika dokter mendiagnosis sirosis hati akibat hepatitis B kronis gunakan kode B18.1- dan tambahkan kode K74.-

Jika dokter mendiagnosis sirosis hati akibat hepatitis C kronis gunakan kode B18.2 (*Chronic viral hepatitis C*) dan tambahkan kode K74.-

Jika dokter mendiagnosis sirosis hati disebabkan oleh *Wilson's disease* maka gunakan kode E83.0 (*Disorder of copper metabolism*) dan tambahkan kode K74.-

4) Abscess Of Liver (K75.0)

Jika dokter mendiagnosis *liver abscess* dengan agen penyebab spesifik gunakan kode K75.0 (*Abscess of liver*) dan tambahkan kode agen penyebab spesifik.

Jika dokter mendiagnosis *Liver abscess* akibat komplikasi batu di saluran empedu dengan *cholangitis* gunakan K80.3 (*Calculus of bile duct with cholangitis*) dan tambahkan kode K75.0 (*Abscess of liver*).

5) Other diseases of liver (K76.-)

Jika dokter mendiagnosis *Cardiac cirrhosis*, gunakan kode K76.1 (*Chronic passive congestion of liver*).

Jika dokter mendiagnosis *Peliosis hepatis* dengan penyebab infeksi *Bartonella*, maka gunakan kode K76.4 (*Peliosis hepatis*) dan tambahkan kode A44.8 (*Other forms of bartonellosis*).

6) Liver Disorders In Diseases Classified Elsewhere (K77.-*)

Jika dokter mendiagnosis *Sarcoidosis with hepatic involvement*, gunakan kode D86.8† (*Sarcoidosis of other and combined sites*) dan tambahkan kode K77.8* (*Liver disorders in other diseases classified elsewhere*).

7) Cholelithiasis And Diseases Of Biliary Tract (K80-K83)

Jika dokter mendiagnosis Sindrom Mirizzi gunakan kode K80.5 (*Calculus of bile duct without cholangitis or cholecystitis*) dan tambahkan kode K82.0 (*Obstruction of gallbladder*)

Kasus K83.1 (*Obstruction of bile duct pada cholelithiasis*) tidak diberikan kode sendiri karena *obstruction of bile duct* merupakan bagian dari *cholelithiasis* sehingga cukup dikode K80.-.

Cholelithiasis yang disertai dengan *cholangitis* tidak dikode terpisah, melainkan menggunakan kode gabungan K80.3 (*Calculus of bile duct with cholangitis*).

Jika dokter mendiagnosis Stenosis papiler, gunakan kode K83.6 (*Stenosis of sphincter of Oddi*).

8) Pancreatitis (K85, K86.0, K86.1, K87)

Kode dalam kelompok K85.- *Acute pancreatitis* digunakan jika dokter mendiagnosis pankreatitis atau pankreatitis akut, dengan memilih kode sesuai penyebab yang ditentukan oleh dokter, sebagai contoh:

Jika dokter mendiagnosis pankreatitis akibat obat atau pankreatitis akut akibat obat, gunakan kode K85.3 (*Drug-induced acute pancreatitis*) dan tambahkan kode eksternal sesuai jenis obat penyebabnya. Misalnya jika disebabkan oleh *azathioprine* tambahkan kode eksternal Y43.4 (*Immunosuppressive agents*).

Jika dokter mendiagnosis pankreatitis akut yang disebabkan oleh kondisi hipertrigliseridemia, gunakan kode K85.8 (*Other acute pancreatitis*) tambahkan kode dan tambahkan kode E78.3 (*Hyperchylomicronaemia*).

Jika dokter mendiagnosis pankreatitis atau pankreatitis akut yang disebabkan oleh kondisi hiperkalsemia, gunakan kode K85.8 (*Other acute pancreatitis*) dan tambahkan kode kode E83.5 (*Disorders of calcium metabolism*).

Jika dokter mendiagnosis pankreatitis kronis yang disebabkan oleh kondisi hiperkalsemia gunakan kode K86.1 (*Other chronic pancreatitis*) dan tambahkan kode E83.5 (*Disorders of calcium metabolism*)

Jika dokter mendiagnosis pankreatitis sitomegaloviral gunakan kode B25.2† (*Cytomegaloviral pancreatitis*) sebagai dan tambahkan kode K87.1* (*Disorders of pancreas in diseases classified elsewhere*).

Pemberian prosedur *Endoscopic retrograde cholangiopancreatography* (ERCP) disertai dengan tindakan spesifik, gunakan kode tindakan spesifik tersebut tanpa perlu menambahkan kode ERCP itu sendiri.

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) yang bertujuan untuk mengangkat batu dari saluran empedu, gunakan kode 51.88 (*Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract*) tanpa menambahkan kode 51.10 (*Endoscopic retrograde cholangiopancreatography*) [ERCP].

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 17

- 1) Dalam MDC 17 terdapat kelompok DRG khusus untuk tindakan *Cholecystectomy* yang disertai dengan tindakan *Common bile duct exploration* (CDE). Oleh karena itu, pemberi kode perlu mencermati dokumentasi medis. Apabila ada tindakan pada kelompok *Cholecystectomy Proc*, maka dimasukkan ke dalam kelompok DRG *Cholecystectomy Proc*. Akan tetapi, apabila pengodean group *Cholecystectomy Proc* disertai dengan tambahan kode dari kelompok *CDE Procedures*, maka akan masuk ke dalam kelompok DRG *Cholecystectomy Proc. w CDE Proc*. Berikut adalah prosedur yang terdapat di dalam kelompok *Cholecystectomy Proc*. dan *CDE Procedures*:

Cholecystectomy Proc.

51.21 *Other partial cholecystectomy*

51.22 *Cholecystectomy*

CDE Procedures

51.10 *Endoscopic retrograde cholangiopancreatography* [ERCP]

51.11 *Endoscopic retrograde cholangiography* [ERC]

51.14 *Other closed [endoscopic] biopsy of biliary duct or sphincter of Oddi*

51.15 *Pressure measurement of sphincter of Oddi*

51.64 *Endoscopic excision or destruction of lesion of biliary ducts or sphincter of Oddi*

51.84 *Endoscopic dilation of ampulla and biliary duct*

51.85 *Endoscopic sphincterotomy and papillotomy*

51.86 *Endoscopic insertion of nasobiliary drainage tube*

51.87 *Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct*

- 51.88 *Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract*
- 51.96 *Percutaneous extraction of common duct stones*
- 51.98 *Other percutaneous procedures on biliary tract*

12. MDC 18 MUSKULOSKELETAL DAN JARINGAN IKAT

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 18

1) *Pyogenic Arthritis (M00.-)*

Jika dokter mendiagnosis artritis piogenik atau artritis septik, gunakan kode M00.- sesuai dengan spesifikasi jenis bakteri penyebab sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis artritis piogenik yang diketahui bakteri penyebabnya gunakan kode M00.0- s.d M00.8-.

Jika dokter mendiagnosis artritis piogenik yang diketahui bakteri yang tidak dapat dikelompokkan pada M00.0- s.d M00.2-, gunakan kode M00.8- dan tambahkan kode sesuai dengan jenis bakterinya (B95-B96).

Jika dokter mendiagnosis artritis piogenik yang tidak dapat diidentifikasi, gunakan kode M00.9- (*Pyogenic arthritis, unspecified*) sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

2) *Direct infections of joint in infectious and parasitic diseases classified elsewhere (M01.-)*

Jika dokter mendiagnosis artritis piogenik atau artritis septik, yang disebabkan oleh infeksi atau parasit yang diklasifikasikan pada bab lainnya, gunakan kode penyebabnya dan tambahkan kode M01.- sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis artritis piogenik dengan penyebab tuberkulosis pada bahu gunakan kode A18.0† (*Tuberculosis of bones and joints*) dan tambahkan kode M01.11* (*Tuberculous arthritis on Shoulder region*)

3) *Reactive Arthropathies (M02)*

Jika dokter mendiagnosis arthropathies reaktif, gunakan kode M02.- sesuai dengan etiologi penyebabnya sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis arthropathies reaktif yang diketahui etiologi penyebabnya gunakan kode M02.0- s.d M02.8-.

Jika dokter mendiagnosis arthropathies reaktif yang tidak diketahui etiologi penyebabnya gunakan kode M02.9-. sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

4) *Postinfective and reactive arthropathies in diseases classified elsewhere (M03)*

Jika dokter mendiagnosis arthropathies dengan etiologi penyebab yang diklasifikasikan pada bab lainnya, gunakan kode penyebabnya dan tambahkan kode M03.- sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis *postmeningococcal arthritis* pada bahu, gunakan kode A39.8† (*Other meningococcal infections*) dan tambahkan kode M03.01* (*Postmeningococcal arthritis on shoulder region*).

5) Rheumatoid Arthritis (M05-M06)

Jika dokter mendiagnosis *rheumatoid arthritis* seropositif gunakan kode M05.- sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis *rheumatoid arthritis* seronegatif gunakan kode M06.0- sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis *rheumatoid arthritis* yang tidak diketahui secara spesifik gunakan kode M06.9- sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

6) Psoriatic And Enteropathic Arthropathies (M07)

Jika dokter mendiagnosis arthropathies dengan etiologi penyebab yang diklasifikasikan pada bab lainnya, gunakan kode penyebabnya dan tambahkan kode M07.- sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis *arthropathic psoriasis interphalangeal toes*, gunakan kode L40.5† (*Arthropathic psoriasis*) dan tambahkan kode M07.07* (*Distal interphalangeal psoriatic arthropathy on toes*).

7) Juvenile Arthritis (M08)

Jika dokter mendiagnosis *juvenile arthritis* gunakan kode M08.- sesuai dengan lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis *Juvenile rheumatoid arthritis* pada tangan, gunakan kode M08.04 (*Juvenile rheumatoid arthritis on hand*).

Jika dokter mendiagnosis *juvenile arthritis* yang tidak diketahui secara spesifik, gunakan kode M08.9- sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis *juvenile arthritis* dengan etiologi penyebab yang diklasifikasikan pada bab lainnya, gunakan kode penyebabnya dan tambahkan kode M09.- sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis *juvenile arthritis psoriasis interphalangeal toes*, gunakan kode L40.5† (*Arthropathic psoriasis*) dan tambahkan kode M09.07* (*Juvenile arthritis in psoriasis on toes*).

Jika dokter mendiagnosis *juvenile arthritis crohn disease* gunakan kode K50.† (*Crohn's disease of small intestine*) dan tambahkan kode M09.1* (*Juvenile arthritis in Crohn's disease*) [*regional enteritis*].

8) Gout And Crystal Arthropathies (M10-M11)

Jika dokter mendiagnosis *Idiopathic gout*, gunakan kode M10.0 (*Idiopathic gout*).

Jika dokter mendiagnosis *Lead-induced gout*, gunakan kode M10.1 (*Lead-induced gout*).

Jika dokter mendiagnosis *Drug-induced gout*, gunakan kode M10.2 (*Drug-induced gout*) dan tambahkan kode penyebab T36-T50.

Jika dokter mendiagnosis *Gout due to impairment of renal function*, gunakan kode M10.3 (*Gout due to impairment of renal function*).

Jika dokter mendiagnosis *pseudogout*, gunakan kode M11.8 (*Other specified crystal arthropathies*).

Jika dokter mendiagnosis kondrokalkinosis (endapan kalsium pirofosfat) gunakan kode M11.2 (*Other chondrocalcinosis*) dan tambahkan Kode E79.0 (*Hyperuricaemia without signs of inflammatory arthritis and tophaceous disease*).

9) Other Arthritis (M13.-) Polyarthritis And Monoarthritis (M13.0 - M13.1)

Jika dokter mendiagnosis polyarthrititis atau olygoarthrititis, gunakan kode M13.0 (*Polyarthritis, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis monoarthritis, gunakan kode M13.1 (*Monoarthritis, not elsewhere classified*),

Jika dokter mendiagnosis polyarthrititis atau olygoarthrititis, gunakan kode M13.0 (*Polyarthritis, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis monoarthritis, gunakan kode M13.1 (*Monoarthritis, not elsewhere classified*),

Jika dokter mendiagnosis *arthritis* akibat infeksi, gunakan kode M00-M03 (*Infectious arthropathies*).

Jika dokter mendiagnosis *arthritis* akibat *rheumatoid arthritis*, gunakan kode M05-M06

Jika dokter mendiagnosis *arthritis* terkait psoriasis, gunakan kode M07.0, M07.3 atau M09.0.

Kode M13.0 dan M13.1 bersifat sementara dan hanya digunakan jika:

Penyebab pasti (misal: infeksi, autoimun, metabolik) belum terdeteksi melalui pemeriksaan awal dan dokter belum dapat menegakkan diagnosis spesifik (misal: artritis reumatoid, gout, atau spondilitis ankilosa).

Jika penyebab ditemukan, kode ini harus diganti dengan kode yang lebih spesifik, contoh:

a.

10) Coxarthrosis [Arthrosis Of Hip] (M16)

Osteoarthritis Pinggul Primer (Tanpa Penyebab Jelas)

Jika dokter mendiagnosis osteoarthritis pinggul pada lansia tanpa penyebab yang jelas atau osteoarthritis primer bilateral, gunakan M16.0 (*Primary coxarthrosis, bilateral*). Jika hanya satu sisi (unilateral), gunakan M16.1 (*Other primary coxarthrosis*).

Osteoarthritis Pinggul Sekunder Akibat Displasia

Untuk kondisi seperti displasia sendi pinggul (misal: soket tidak tumbuh sempurna atau riwayat terkilir sejak kanak-kanak):

Bilateral → M16.2 (*Coxarthrosis resulting from dysplasia, bilateral*).

Unilateral → M16.3 (*Other dysplastic coxarthrosis*).

Osteoarthritis Pinggul Sekunder Pasca-Trauma

Jika disebabkan oleh cedera tulang pinggul/panggul di masa lalu :

Bilateral → M16.4 (*Post-traumatic coxarthrosis, bilateral*).

Unilateral → M16.5 (*Other post-traumatic coxarthrosis*).

Osteoarthritis Pinggul Sekunder Akibat Penyebab Lain

Untuk kondisi seperti nekrosis iskemik tulang pinggul, atrofi, penggunaan steroid jangka panjang, atau komplikasi penyakit radang (arthritis reumatoid, gout):

Bilateral → M16.6 (*Other secondary coxarthrosis, bilateral*).

Unilateral → M16.7 (*Other secondary coxarthrosis*).

Catatan: Jika penyebab mendasar (misal: *arthritis reumatoid/gout*) diketahui, kode M16.6/M16.7 harus digabungkan dengan kode primer penyakit tersebut (misal: M05.- untuk arthritis reumatoid atau M10.- untuk gout).

Untuk tindakan penggantian sendi panggul, gunakan kode 81.51 (*Total hip replacement*) atau 81.52 (*Partial hip replacement*) sesuai tindakan yang dilakukan dokter, tambahkan kode 00.74 - 00.77 (*type of bearing surface*) jika informasi *bearing surface* tersedia.

Untuk operasi revisi sendi panggul pada komponen acetabular dan/atau femoral, gunakan kode 00.70 (*Revision of hip replacement, both acetabular and femoral components*) dan tambahkan kode 84.57 (*Removal of (cement)(joint) spacer*) dan/atau tambahkan kode 00.74 - 00.77 (*type of bearing surface*) jika informasi *bearing surface* tersedia.

Untuk operasi revisi sendi panggul pada komponen yang spesifik selain acetabular dan/atau femoral, gunakan kode 00.71-00.73 (*Revision of hip replacement*) dan tambahkan kode 00.74 - 00.77 (*type of bearing surface*) jika informasi *bearing surface* tersedia.

Untuk operasi revisi sendi panggul pada komponen yang tidak spesifik, gunakan kode 81.53 (*Revision of hip replacement, not otherwise specified*) dan tambahkan kode 84.57 (*Removal of (cement)(joint) spacer*) dan/atau

tambahkan kode 00.74 - 00.77 (*type of bearing surface*) jika informasi *bearing surface* tersedia.

Jika dokter mendiagnosis osteoarthritis pinggul tetapi tidak mencantumkan detail seperti jumlah sisi (unilateral/bilateral) atau penyebab pasti, kode M16.9 (*Coxarthrosis, unspecified*) dapat digunakan sebagai klasifikasi sementara.

11) Gonarthrosis [Arthritis Of Knee] (M17)

Jika dokter mendiagnosis *osteoarthritis* lutut tetapi tidak mencatat jumlah sisi yang terkena dan penyebab penyakit, pemberi kode harus berusaha menghindari pemberian kode M17.9 (*Gonarthrosis, unspecified*). Sebaiknya mencari informasi dalam catatan rekam medis dan meminta dokter untuk meninjau kembali diagnosis secara detail untuk mendapatkan kode yang lengkap sebagai berikut:

Jika dokter mendiagnosis *Osteoarthritis* lutut primer pada kedua lutut, gunakan kode M17.0 (*Primary gonarthrosis, bilateral*), dan jika hanya pada satu sisi, gunakan kode M17.1 (*Other primary gonarthrosis*).

Jika dokter mendiagnosis *Osteoarthritis* lutut pasca trauma pada kedua lutut, gunakan kode M17.2 (*Post traumatic gonarthrosis, bilateral*), dan jika hanya pada satu sisi, gunakan kode M17.3 (*Other post traumatic gonarthrosis*).

Jika dokter mendiagnosis *Osteoarthritis* lutut sekunder pada kedua lutut, gunakan kode M17.4 (*Other secondary gonarthrosis, bilateral*), dan jika hanya pada satu sisi, gunakan kode M17.5 (*Other secondary gonarthrosis*).

Jika dokter melakukan prosedur penggantian sendi lutut, maka hanya digunakan satu kode yaitu 81.54 (*Total knee replacement*), yang juga mencakup berbagai jenis *partial knee replacement*.

Jika dokter melakukan prosedur tindakan "*revision of total knee replacement*", pemberi kode harus mencari informasi dari catatan operasi tentang komponen mana yang diperbaiki untuk memberikan kode yang rinci, yaitu:

Gunakan kode 00.80 (*Revision of knee replacement, total (all components)*) untuk operasi perbaikan mengganti seluruh perangkat lutut buatan yang terdiri dari 3 bagian: material buatan yang menutupi bagian distal femur, bagian atas tibia, dan patela.

Gunakan kode 00.81 (*Revision of knee replacement, tibial component*) untuk operasi penggantian seluruh komponen tibia, termasuk pelat dasar tibia dan sisipan (pelapis) tibia.

Gunakan kode 00.82 (*Revision of knee replacement, femoral component*) untuk operasi penggantian logam yang menutupi bagian distal femur. yang mungkin juga dilakukan bersamaan dengan penggantian tibial insert.

Gunakan kode 00.83 (*Revision of knee replacement, patellar component*) untuk operasi penggantian material buatan pada bagian patella.

Gunakan kode 00.84 (*Revision of knee replacement, tibial insert (liner)*) untuk operasi penggantian material buatan yang mendukung sendi di atas logam yang menutupi tulang tibia.

Gunakan kode 81.55 (*Revision of knee replacement NOS*) untuk operasi penggantian komponen pada kedua sisi (femoral dan tibial) tanpa mengganti komponen permukaan patela.

Gunakan kode 84.56 (*Insertion or replacement of (cement) spacer*) untuk operasi penggantian *cement spacer*.

Gunakan kode 84.57 (*Removal of (cement) spacer*) untuk operasi pengambilan semen.

12) *Acquired Clawhand, Clubhand, Clawfoot, And Clubfoot (M21, Q66.0)*

Jika dokter mendiagnosis *Talipes equinovarus* atau kaki pengkor, pemberi kode sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk meninjau diagnosis apakah pasien memiliki kaki pengkor bawaan (*congenital*) atau didapat (terjadi setelah lahir).

Jika dokter mendiagnosis *Talipes equinovarus*, gunakan kode Q66.0 (*Talipes equinovarus*).

Jika dokter mendiagnosis *Talipes calcaneovarus*, gunakan kode Q66.1 (*Talipes calcaneovarus*).

Jika kondisi clubfoot atau deformitas lain yang tidak disebabkan oleh faktor bawaan lahir (*congenital*), gunakan kode M21.- .

Jika dokter tidak dapat mendiagnosis jenis kaki pengkor atau hanya dapat mendiagnosis sebagai kaki pengkor bawaan, gunakan kode Q66.8 (*Other congenital deformities of feet*).

13) *Disorders Of Patella (M22)*

Jika dokter mendiagnosis sindrom nyeri lutut anterior, sindrom nyeri patellofemoral atau sindrom nyeri patellofemoral, gunakan kode M22.2 (*Patellofemoral disorders*).

Jika dokter mendiagnosis *Malalignment of patella* atau *derangement of patella*, gunakan kode M22.3 (*Other derangements of patella*).

Jika dokter mendiagnosis *Chondromalacia of patella*, gunakan kode M22.4 (*Chondromalacia patellae*).

Jika dokter mendiagnosis displasia patela atau patela agenesis, yang merupakan kelainan pada patela itu sendiri, seperti malformasi atau ukuran yang lebih kecil dari normal, gunakan kode M22.8 (*Other disorders of patella*).

Jika dokter mendiagnosis *osteoarthritis patellofemoral*, belum ada kode khusus, gunakan kode M19.96 (*Arthrosis, unspecified, Lower leg*).

14) **Chronic Instability Of Knee (M23.5)**

Jika dokter mendiagnosis ACL (*Anterior Cruciate Ligament*) atau PCL (*Posterior Cruciate Ligament*) robekan tetapi merupakan cedera kronis, tetapi tidak menyebabkan insufisiensi atau instabilitas, maka harus dikodekan sesuai dengan Chapter XIII *Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue*, seperti M24.2 (*Disorder of ligament*). Jika terdapat insufisiensi atau instabilitas, gunakan kode M23.51 (*Chronic instability of knee, anterior cruciate ligament*) atau M23.52 (*Chronic instability of knee, posterior cruciate ligament*).

Kode ICD-9-IM untuk operasi rekonstruksi ACL/PCL terdiri dari:

Kode untuk operasi perbaikan ligamen, yaitu:

Gunakan kode 81.43 (*Triad knee*), perbaikan berarti melakukan 3 jenis operasi dalam satu waktu, terdiri dari menisektomi medial, perbaikan ligamen silang anterior, dan penjahitan ligamen kolateral medial. Dokter mungkin mencatat operasi ini sebagai prosedur O'Donoghue.

Gunakan kode 81.45 (*Other repair of the cruciate ligaments*), untuk rekonstruksi ligamen ACL atau PCL.

Gunakan kode 83.41 (*Excision of tendon for graft*), untuk pengambilan tendon dari tempat lain untuk membuat ligamen lutut baru.

Gunakan kode 83.43 (*Excision of muscle or fascia for graft*), pengambilan sebagian otot atau fascia untuk membuat ligamen lutut baru.

Kode prosedur yang dilakukan selain perbaikan ACL/PCL, yaitu:

Gunakan kode 80.26 (*Arthroscopy of knee*), untuk melihat ke dalam sendi lutut menggunakan artroskop .

Gunakan kode 80.36 (*Biopsy of joint structure of knee*), pengambilan jaringan sendi lutut untuk diperiksa.

Gunakan kode 80.46 (*Division of joint capsule, ligament, or cartilage of knee*), untuk pemotongan kapsul sendi, ligamen, atau tulang rawan di lutut.

Gunakan kode 80.6 (*Excision of semilunar cartilage of knee*), untuk mengangkat meniskus lutut.

Gunakan kode 80.76 (*Synovectomy of knee*), untuk menghubungkan jaringan sinovial untuk memudahkan operasi.

Gunakan kode 80.86 (*Other local excision or destruction of lesion of joint of knee*), untuk mengangkat sebagian sisa ligamen, tulang rawan yang terlepas, atau osteofit yang tidak berfungsi.

Jika dokter melakukan prosedur operasi lutut yang dilakukan melalui artroskopi, gunakan kode 80.26 (*Arthroscopy of knee*).

15) Haemarthrosis (M25.0)

Jika dokter mendiagnosis seorang pasien dengan hemarthrosis (pendarahan pada sendi) gunakan kode M25.0-, dikecualikan jika disebabkan oleh trauma gunakan kode traumanya kelompok kode S-T.

Jika dokter mendiagnosis seorang pasien dengan hemofilia disertai hemarthrosis (pendarahan pada sendi), gunakan kode D66 (*Hereditary factor VIII deficiency*), yang menunjukkan *factor VIII deficiency* bawaan sebagai penyebab hemofilia dan tambahkan kode M25.0 (*Haemarthrosis*)

16) Polyarteritis Nodosa And Vasculopathies (M30-M31)

Jika dokter mendiagnosis *Polyarteritis nodosa*, gunakan kode M30. (*Polyarteritis nodosa and related conditions*) atau M31. (*Other necrotizing vasculopathies*).

17) Systemic Lupus Erythematosus (M32)

Jika dokter mendiagnosis Lupus eritematosus sistemik yang diinduksi oleh obat (*drug-related systemic lupus erythematosus*), gunakan kode M32.0 (*Drug-induced systemic lupus erythematosus*).

Jika dokter mendiagnosis SLE (Systemic Lupus Erythematosus) dengan keterlibatan organ, gunakan kode M32.1† (*Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement*). Kode ini harus diikuti oleh kode tambahan yang spesifik untuk menunjukkan organ atau sistem tubuh yang terkena dampaknya, seperti:

Gunakan kode N08.5* (*Glomerular disorders in systemic connective tissue disorders*)

Gunakan kode N16.4* (*Renal tubulo-interstitial disorders in systemic connective tissue disorders*)

Gunakan kode J99.1* (*Respiratory disorders in other diffuse connective tissue disorders*)

Gunakan kode D59.1* (*Other autoimmune haemolytic anemia*).

Jika dokter mendiagnosis SLE tidak spesifik, gunakan kode M32.9 (*Systemic lupus erythematosus, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis *Lupus erythematosus* atau *discoid lupus erythematosus*, tidak gunakan kode dari kelompok M32.-. gunakan kode L93.0 (*Discoid lupus erythematosus*),

18) Systemic Sclerosis (M34)

Jika dokter mendiagnosis *Progressive systemic sclerosis*, gunakan kode M34.0 (*Progressive systemic sclerosis*).

Jika dokter mendiagnosis Sindrom CR(E)ST, gunakan kode M34.1 (*CR(E)ST syndrome*).

19) Scoliosis (M41)

Jika dokter mendiagnosis skoliosis atau *kyphoscoliosis* (kondisi tulang belakang yang melengkung dan bengkok) gunakan kode dari kelompok M41.- (*Scoliosis*) sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak. Berikut merupakan contoh kasus Skoliosis dan pengodeannya:

Skoliosis Idiopatik

Jika dokter mendiagnosis skoliosis idiopatik, gunakan kode M41.0- s.d. M41.2-.

Pasien berusia 6 bulan hingga 3 tahun, gunakan kode M41.0- (*Infantile idiopathic scoliosis*).

Pasien berusia 3–25 tahun, gunakan kode M41.1- (*Juvenile idiopathic scoliosis*).

Pasien berusia lebih dari 25 tahun, gunakan kode M41.2- (*Other idiopathic scoliosis*) setelah memastikan diagnosis sebagai Skoliosis Idiopatik Dewasa.

Skoliosis Torakogenik

Jika dokter mendiagnosis skoliosis torakogenik, gunakan kode M41.3- (*Thoracogenic scoliosis*).

Skoliosis Neuromuskular

Jika dokter mendiagnosis kelainan tulang belakang disebabkan oleh gangguan sistem saraf dan otot yang menyeluruh, seperti *cerebral palsy*, *Friedreich's ataxia*, atau *poliomyelitis*, gunakan kode M41.4- (*Neuromuscular scoliosis*).

Skoliosis Sekunder

Jika dokter mendiagnosis tulang belakang bengkok disebabkan oleh kelainan sistem lain selain sistem saraf dan otot, gunakan kode M41.5- (*Other Secondary Scoliosis*) dan tambahkan kode sesuai dengan penyebabnya.

Skoliosis Degeneratif

Jika dokter mendiagnosis tulang belakang bengkok disebabkan oleh degenerasi tulang belakang, gunakan kode M41.8 (*Other forms of scoliosis*)

Skoliosis Tidak Ditentukan

Pemberi kode harus menghindari penggunaan kode M41.9 (*Scoliosis, unspecified*). Jika ada ketidakjelasan dalam pemberian kode, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter yang menangani.

Skoliosis Kongenital

Jika dokter mendiagnosis Skoliosis kongenital yang disebabkan oleh faktor postur tubuh (skoliosis postural) atau penyebabnya tidak diketahui, gunakan kode Q67.5 (*Congenital deformity of spine*).

Jika dokter mendiagnosis Skoliosis kongenital disebabkan oleh malformasi tulang bawaan seperti hemivertebra fusion, gunakan kode Q76.3 (*Congenital scoliosis due to congenital bony malformation*).

Skoliosis Pascaprocedural

Jika dokter mendiagnosis tulang belakang bengkok disebabkan oleh operasi sebelumnya pada tulang belakang, gunakan kode M96.8 (*Other postprocedural musculoskeletal disorders*).

Skoliosis Pascaradiasi

Jika dokter mendiagnosis tulang belakang bengkok akibat paparan radiasi, gunakan kode M96.5 (*Postradiation scoliosis*).

20) Spondylolisthesis (M43.1, Q76.2)

Jika dokter mendiagnosis *spondylolisthesis* gunakan kode M43.1- (*Spondylolisthesis*) sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis *spondyloptosis* yang tidak disebabkan oleh trauma, tetap gunakan kode M43.1- (*Spondylolisthesis*) sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis *spondylolisthesis* bawaan atau didapat, pemberi kode harus berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan penyebab kondisi tersebut:

Jika dokter mendiagnosis *spondylolisthesis* yang disebabkan bawaan (*congenital*), gunakan kode Q76.20 (*Congenital spondylolisthesis*).

Jika dokter mendiagnosis *isthmic spondylolisthesis*, gunakan kode Q76.20 (*Congenital spondylolisthesis*), karena kondisi ini juga dianggap bawaan.

Untuk kasus spondylolysis:

Jika dokter mendiagnosis *spondylolysis* atau *acquired spondylolysis*, gunakan kode M43.0- (*Spondylolysis*).

Jika dokter mendiagnosis *congenital spondylolysis*, gunakan kode Q76.21 (*Congenital spondylolysis*).

Jika dokter mendiagnosis *traumatic spondylolisthesis* pada level lumbar atau sakral dengan riwayat trauma yang jelas terkait kejadian tersebut, maka kondisi ini harus dikodekan sebagai cedera, gunakan kode S33.1 (*Dislocation of lumbar vertebra*).

21) Spindylosis (M47)

Jika dokter mendiagnosis Sindrom kompresi arteri tulang belakang dan tulang belakang anterior, gunakan kode M47.0† (*Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes*) sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang

terdampak dan tambahkan kode G99.2* (*Myelopathy in diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *Spondylosis with myelopathy*, gunakan kode M47.1† (*Other spondylosis with myelopathy*) sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak dan tambahkan kode G99.2* (*Myelopathy in diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *Spondylosis with radiculopathy* atau *OA spine with radiculopathy*, gunakan kode M47.2 (*Other spondylosis with radiculopathy*) sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis *Spondylosis* atau *OA spine* tanpa *radiculopathy* atau *myelopathy*, gunakan kode M47.8 (*Other spondylosis*) sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak

Penting untuk diingat bahwa kode M47.9 (*Spondylosis, unspecified*) tidak boleh digunakan, karena dokter seharusnya dapat dengan mudah menentukan adanya penekanan serta lokasi patologi. Jika dokter tidak mencantumkan detail yang cukup, pemberi kode harus berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan informasi lebih rinci sebelum memberikan kode.

22) Intervertebral Disc Disorders (M50-M51)

Dalam pemberian kode untuk gangguan disc, tidak boleh ada riwayat cedera akut.

Jika dokter mendiagnosis *herniated nucleus pulposus* (HNP), terjadi tanpa adanya trauma akut, maka kode dari kategori M50-M51 dapat digunakan.

Jika terdapat cedera akut yang secara langsung menyebabkan HNP, maka kondisi tersebut harus dikodekan sebagai cedera akut dalam Bab XIX (*Injury, Poisoning, and Certain Other Consequences of External Causes*).

Jika terdapat cedera akut tetapi cedera tersebut tidak secara langsung menyebabkan HNP, maka kode dari kategori M50-M51 tetap dapat digunakan.

Jika dokter mendiagnosis *Cervical disc disorder with myelopathy*, gunakan kode M50.0† (*Cervical disc disorder with myelopathy*) dan tambahkan kode G99.2* (*Myelopathy in diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *Cervical disc disorder with radiculopathy*, gunakan kode M50.1 (*Cervical disc disorder with radiculopathy*).

Jika dokter mendiagnosis *cervical disc displacement*, gunakan kode M50.2 (*Other cervical disc displacement*).

Jika dokter mendiagnosis *cervical disc degeneration*, gunakan kode M50.3 (*Other cervical disc degeneration*).

Jika dokter mendiagnosis "HNP cervical" dan setelah konsultasi dengan dokter hanya diperoleh diagnosis *cervical disc disorder* tanpa spesifikasi jenis gangguan, gunakan kode M50.9 (*Cervical disc disorder, unspecified*)

Berikan kode diagnosis untuk pasien dengan gangguan discus intervertebralis lumbal (*lumbar disc disorder*) berdasarkan tipe penekanan pada sistem saraf sebagai berikut:

Jika dokter mendiagnosis *Lumbar and other intervertebral disc disorders with myelopathy*, gunakan kode M51.0† dan tambahkan kode G99.2* (*Myelopathy in diseases classified elsewhere*)

Jika dokter mendiagnosis *lumbar disc disorder with radiculopathy* gunakan kode M51.1† (*Lumbar and other intervertebral disc disorders with radiculopathy*) dan tambahkan kode G55.1* (*Nerve root and plexus compressions in intervertebral disc disorders*)

Jika dokter mendiagnosis degenerasi disc lumbal atau torakal, gunakan kode M51.3 (*Other specified intervertebral disc degeneration*), dan jika dokter mendiagnosis bahwa kondisi tersebut ditemukan bersamaan dengan *spondylosis*, tambahkan kode dari kelompok M47. (*Spondylosis*).

Jika dokter mendiagnosis *Schmorl's nodes* pada tulang belakang torakal atau lumbal, gunakan kode M51.4 (*Schmorl's nodes*).

Jika dokter mendiagnosis *lumbar disc disorder with cauda equina syndrome*, gunakan kode M51.2 (*Other specified intervertebral disc displacement*) dan tambahkan kode G83.4 (*Cauda equina syndrome*)

Kode M51.9 (*Intervertebral disc disorder, unspecified*) hanya digunakan dalam kasus di mana dokter mencatat diagnosis sebagai HNP dan tidak dapat menemukan informasi mengenai posisi serta jenis patologi tersebut.

23) Spine Fusion And Instrumentation

Tambahkan kode 84.52 (*Insertion of recombinant bone morphogenetic protein*), untuk penggunaan zat penunjang fusi tulang berupa *recombinant bone morphogenetic protein* (BMP).

Tambahkan kode 81.62–81.64 (*Total number of vertebrae fused*), jumlah level tulang belakang yang menjalani fusi, sesuai catatan dokter.

Tambahkan Kode 77.70–77.79 (*Excision of bone for graft*), pengambilan tulang dari bagian tubuh lain untuk cangkok dalam prosedur fusi spinal. Jika tidak dilakukan atau digunakan tulang sintetis, kode ini tidak diberikan.

24) Spontaneous Fracture (M48.4, M48.5, M80, M84.3, M84.4)

Fraktur spontan umumnya terjadi akibat penyakit tulang. Pemberi kode harus merujuk pada catatan medis untuk menemukan penyebab yang mendasari:

Jika dokter mendiagnosis fraktur pada pasien dengan osteoporosis, gunakan kode M80.- (*Osteoporosis with pathological fracture*) dengan digit ke-5 sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis fraktur disebabkan oleh penyakit lain, gunakan kode M84.4- (*Pathological fracture, not elsewhere classified*) dengan digit ke-5 sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis fraktur tulang belakang tanpa diketahui penyebabnya (hanya dicatat sebagai *collapsed fracture of spine*), gunakan kode M48.5- (*Collapsed vertebra, not elsewhere classified*) dengan digit ke-5 sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis *stress fracture* atau *fatigue fracture* pada

Tulang belakang, gunakan kode M48.4- (*Fatigue fracture of vertebra*) dengan digit ke-5 sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Tulang lain, gunakan kode M84.3- (*Stress fracture, not elsewhere classified*) dengan digit ke-5 sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis malunion fraktur gunakan kode M84.0- (*Malunion of fracture*) tanpa kode fraktur S-T di lokasi yang sama.

25) Fracture In Neoplastic Disease (M49.5, M90.7)

Jika dokter mendiagnosis fraktur akibat metastasis kanker ke tulang gunakan kode C79.5† (*Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow*) dan tambahkan kode M49.5-* (*Collapse of vertebra in diseases classified elsewhere*) untuk tulang belakang dan jika tulang lain yang patah, gunakan kode M90.7-* (*Fracture of bone in neoplastic disease*) dengan digit ke-5 sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

26) Rhabdomyolysis (M62.8)

Jika dokter mendiagnosis *rhabdomyolysis*, gunakan kode M62.8- (*Other specified disorders of muscle*) dengan digit ke-5 sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

27) Radial Styloid Tenosynovitis [De Quervain] (M65.4)

Jika dokter mendiagnosis *De Quervain's tenosynovitis*, gunakan kode M65.4- (*Radial styloid tenosynovitis [de Quervain]*) dengan digit ke-5 sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

28) Necrotizing Fasciitis (M72.6)

Jika dokter mendiagnosis *necrotizing fasciitis*, gunakan kode M72.6- (*Necrotizing fasciitis*) dengan digit ke-5 sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

29) Fibromyalgia (M79.7)

Jika dokter mendiagnosis *fibromyalgia*, gunakan kode M79.7- (*Fibromyalgia*) dengan digit ke-5 sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

30) Myofascial Pain Syndrome (M79.8)

Jika dokter mendiagnosis sindrom nyeri myofascial, gunakan kode M79.8- (*Other specified soft tissue disorders*) dengan digit ke-5 sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

31) Osteoporosis (M80-M82)

Jika dokter mendiagnosis *Osteoporosis* dengan patah tulang patologis, gunakan kode M80.- (*Osteoporosis with pathological fracture*), dengan digit ke-5 sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

Jika dokter mendiagnosis *Osteoporosis* tanpa patah tulang patologis, gunakan kode M81.- (*Osteoporosis without pathological fracture*),

32) Nonunion Of Fracture [Pseudarthrosis] (M84.1, M96.0)

Jika dokter mendiagnosis *nonunion* terjadi pada fraktur yang tidak ditangani atau setelah perawatan tertutup (misalnya *closed reduction*), gunakan kode M84.1- (*Nonunion of fracture [pseudarthrosis]*) dengan digit ke-5 sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak tanpa kode fracture S-T di lokasi yang sama.

Jika dokter mendiagnosis *nonunion* terjadi setelah operasi (fusi, artrodesis atau implan ortopedi), gunakan kode M96.0 (*Pseudarthrosis after fusion or arthrodesis*).

33) Periprosthetic Fracture (M96.6)

Jika dokter mendiagnosis fraktur terjadi di sekitar implan prostetik (misalnya sendi buatan) setelah pemasangan prostesis atau implan ortopedi, gunakan kode M96.6 (*Fracture of bone following insertion of orthopaedic implant, joint prosthesis, or bone plate*).

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 18

- 1) Dalam MDC 18 terdapat DRG khusus untuk pemberian *complex procedures* untuk tindakan *arthroscopy*, sehingga pemberi kode harus memperhatikan dokumentasi medis, termasuk adanya tindakan pembedahan dan/atau bukti riwayat tatalaksana pemberian transfusi, untuk memastikan pemilihan kode dan DRG yang tepat.
- 2) Apabila ada tindakan yang termasuk dalam *Arthroscopy Proc*, maka masuk ke dalam kelompok DRG *Arthroscopy Proc*. Akan tetapi apabila pengodean group *Arthroscopy Proc* disertai dengan tambahan dari kelompok *Complex Procedures for Arthroscopy*, maka akan masuk ke dalam kelompok DRG *Arthroscopy w/ Complex Proc*.

Arthroscopy Proc.

80.20 *Arthroscopy, unspecified site*

80.21 *Arthroscopy, shoulder*

- 80.22 *Arthroscopy, elbow*
- 80.23 *Arthroscopy, wrist*
- 80.24 *Arthroscopy, hand and finger*
- 80.25 *Arthroscopy, hip*
- 80.26 *Arthroscopy, knee*
- 80.27 *Arthroscopy, ankle*
- 80.28 *Arthroscopy, foot and toe*
- 80.29 *Arthroscopy, other specified sites*

Complex Procedures for Arthroscopy

- 81.42 *Five-in-one repair of knee*
- 81.43 *Triad knee repair*
- 81.44 *Patellar stabilization*
- 81.45 *Other repair of the cruciate ligaments*
- 81.46 *Other repair of the collateral ligaments*
- 81.47 *Other repair of knee*
- 81.83 *Other repair of shoulder*
- 83.63 *Rotator cuff repair*

13. MDC 19 KULIT DAN SUBKUTAN

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 19

Pada bab ini dalam kode L00 - L08 gunakan kode tambahan B95-B98 untuk mengidentifikasi agen infeksi penyebabnya.

1) Impetigo (L01.-)

Jika dokter mendiagnosis impetigo tanpa keterangan lebih lanjut, gunakan kode L01.0 (*Impetigo*).

Jika dokter mendiagnosis impetigo yang disebabkan yang merupakan komplikasi dari penyakit kulit lainnya, gunakan kode L01.1 (*Impetiginization of other dermatoses*).

2) Cutaneous Abscess, Furuncle, and Carbuncle (L02.-)

Jika dokter mendiagnosis *Abscess, cutaneous abscess, furuncle, carbuncle* di area wajah gunakan kode L02.0 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of face*), kecuali telinga, mata, dan hidung, gunakan kode kriteria sesuai dengan excludes dalam kode L02.-.

Jika dokter mendiagnosis abscess yang terkait dengan diabetes melitus tipe 2, gunakan kode E11.5 (*Non-insulin-dependent diabetes mellitus, with peripheral circulatory complications*). Jika dokter mendiagnosis abscess dan diabetes melitus type 2 yang bukan merupakan komplikasi dari diabetesnya maka gunakan kode L02.- dan E11.9 (*Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications*), jika dalam dokumentasi klinis tidak dituliskan abscess terkait dengan diabetes melitus atau tidak, pemberi kode harus mengkonfirmasi kepada dokter apakah abscess terkait dengan diabetes melitus atau tidak.

Jika dokter mendiagnosis *Abscess, cutaneous abscess, furuncle, carbuncle* di area tubuh bagian tengah, termasuk dada, punggung, perut, daerah inguinal, lipatan paha, dan pusar, gunakan kode L02.2 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of trunk*). Pengecualian untuk lokasi tertentu di batang tubuh:

Abscess terjadi di payudara, gunakan kode N61 (*Inflammatory disorders of breast*).

Abscess terjadi di organ genital pria, gunakan kode N48.2 (*Other inflammatory disorders of penis*) atau kode dalam kelompok N49.- (*Inflammatory disorders of male genital organs, not elsewhere classified*).

Abscess terjadi di organ genital wanita, gunakan kode N76.4 (*Abscess of vulva*).

Abscess terjadi di daerah *anal* dan *rectal* gunakan kode K61.- (*Abscess of anal and rectal regions*)

Abscess terjadi di area panggul bagian belakang dan pangkal paha, gunakan kode L02.3 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of buttock*).

Abscess, cutaneous abscess, furuncle, carbuncle di area lengan atau kaki termasuk ketiak, pinggul, dan bahu, gunakan kode L02.4 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb*).

Abscess, cutaneous abscess, furuncle, carbuncle di area kepala atau kulit kepala (bukan area wajah), gunakan kode L02.8 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of other sites*).

3) Cellulitis (L03.-)

Jika dokter mendiagnosis Selulitis pada batang tubuh, termasuk dada, punggung, perut, selangkangan, lipatan paha, dan pusar, gunakan kode L03.3 (*Cellulitis of trunk*). Namun, ada pengecualian untuk lokasi tertentu di batang tubuh:

Selulitis terjadi di organ genital pria, gunakan kode N48.2 (*Other inflammatory disorders of penis*) atau kode dalam kelompok N49.- (*Inflammatory disorders of male genital organs, not elsewhere classified*).

Selulitis terjadi di organ genital wanita, gunakan kode N76.4 (*Abscess of vulva*).

Selulitis terjadi di pusar bayi baru lahir, gunakan kode P38 (*Omphalitis of newborn with or without mild haemorrhage*).

4) Pemphigus dan Pemphigoid (L10.- dan L12.-)

Jika dokter mendiagnosis pemphigus, gunakan kode dalam kelompok L10.- (*Pemphigus*).

Jika dokter mendiagnosis *pemphigoid*, gunakan kode dalam kelompok L12.- (*Pemphigoid*) sesuai dengan jenis yang disebutkan oleh dokter. Pada bab ini dalam kode L10.- tambahkan juga kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi obat penyebabnya.

Jika dokter mendiagnosis *pemphigoid gestationis*, gunakan kode O26.4 (*Herpes gestationis*).

Jika dokter mendiagnosis *impetigo herpetiformis*, gunakan kode L40.1 (*impetigo herpetiformis*).

Jika dokter mendiagnosis *epidermolysis bullosa (congenital)*, gunakan kode Q81.- (*epidermolysis bullosa (congenital)*)

5) Atopic Dermatitis (L20.-)

Jika dokter mendiagnosis *Classical atopic dermatitis*, gunakan kode L20.0 (*Besnier's prurigo*).

Jika dokter mendiagnosis *Eczema Flexural atopic dermatitis* atau *Eczema infantile atopic dermatitis*, gunakan kode L20.8 (*Other atopic dermatitis*).

Jika dokter mendiagnosis *Atopic dermatitis* tanpa menyebutkan jenis spesifik (*unspecified*), gunakan kode L20.9 (*Atopic dermatitis, unspecified*).

6) **Irritant Contact Dermatitis (L24.-)**

Kode dalam kelompok L24.- *Irritant Contact Dermatitis* dapat disebabkan oleh agen *irritant* ataupun obat sesuai yang dituliskan oleh dokter.

Jika dokter mendiagnosis dermatitis kontak iritan akibat reaksi alergi (*allergic reaction*) yang disebabkan oleh obat yang berkontak dengan kulit, gunakan kode L24.4 (*Irritant contact dermatitis due to drugs in contact with skin*) dan tambahkan juga kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi obat penyebabnya.

Jika dokter mendiagnosis dermatitis kontak iritan akibat reaksi alergi (*allergic reaction*) yang disebabkan oleh obat yang tidak kontak dengan kulit, gunakan kode T88.7 (*Unspecified adverse effect of drugs or medicaments*). Perhatikan juga kriteria *excludes* pada kode tersebut.

Jika dokter mendiagnosis *Paederus dermatitis*, gunakan kode L24.81 (*Paederus dermatitis*)^(IM).

7) **Dermatitis due to Substances Taken Internally (L27.-)**

Jika dokter mendiagnosis ruam kulit akibat reaksi alergi obat, baik disebutkan sebagai *generalized skin eruption* atau hanya sebagai *skin eruption* saja gunakan kode L27.0 (*Generalized skin eruption due to drugs and medicaments*) dan tambahkan kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi obat penyebabnya.

Jika dokter mendiagnosis *localized skin eruption* akibat alergi obat, gunakan kode L27.19 (*Localized skin eruption due to drugs and medicaments, unspecified*)^(IM) dan tambahkan kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi obat penyebabnya.

Jika dokter mendiagnosis *fixed drug eruption*, gunakan kode L27.10 (*Fixed drug eruption*)^(IM) dan tambahkan kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi obat penyebabnya.

Jika dokter mendiagnosis dermatitis akibat makanan yang dimakan, gunakan kode L27.2 (*Dermatitis due to ingested food*). Terdapat *excludes* pada sub-bab ini untuk kasus dermatitis akibat makanan yang kontak langsung dengan kulit, gunakan kode L23.6, L24.6, atau L25.4 (sesuai dengan diagnosis yang diberikan oleh dokter).

8) **Psoriasis (L40.-)**

Jika dokter mendiagnosis *Arthropathic psoriasis*, gunakan kode L40.5† (*Arthropathic psoriasis*) dan tambahkan kode M07.0* (*Distal interphalangeal psoriatic arthropathy*), M07.1* (*Arthritis mutilans*), M07.2* (*Psoriatic spondylitis*), M07.3* (*Other psoriatic arthropathies*) atau M09.0* (*Juvenile arthritis psoriasis*).

Catatan: Untuk pengodean dalam kelompok M07.- dan M09.-, pastikan tidak melupakan kode utama L40.5† untuk menunjukkan lokasi penyakit yang relevan.

9) Lichen Planus (L43.-)

Gunakan kode dalam kelompok L43.- Lichen Planus, sesuai yang dituliskan oleh dokter.

Jika dokter mendiagnosis *Lichenoid drug reaction* atau *drug-induced lichen planus*, gunakan kode L43.2 (*Lichenoid drug reaction*) dan tambahkan kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi obat penyebabnya.

Jika dokter mendiagnosis *Lichen planus aktinik*, *lichen planus tropikus*, atau *actinic lichen planus*, gunakan kode L43.3 (*Subacute (active) lichen planus*).

Jika dokter mendiagnosis *Lichen planus* jenis populer, atrofik, erosif, plak, atau retikular, gunakan kode L43.8 (*Other lichen planus*).

10) Erythema Multiforme (L51.-)

Gunakan kode dalam kelompok L51.- Erythema Multiforme, sesuai jenis yang dituliskan oleh dokter.

Jika dokter mendiagnosis *Stevens-Johnson syndrome* dengan *toxic epidermal necrolysis* maka pemberi kode mengkonfirmasi terdapat *overlapping* atau tidak, jika terdapat *overlapping* gunakan kode L51.8 (*Other erythema multiforme*).

Jika dokter mendiagnosis kelainan mata pada pasien *Stevens-Johnson syndrome* dianggap sebagai komorbid ataupun komplikasi penyakit, gunakan kode L51.1 (*Bullous erythema multiforme*) dan tambahkan kode untuk kelainan mata sebagai kode tambahan.

Tabel C.36. Contoh kasus *erythema multiforme*

Contoh 1	Dokter mata mendiagnosis pasien dengan sindrom Stevens-Johnson dengan komplikasi keratitis yang terdeteksi selama pemeriksaan.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Stevens-Johnson syndrome</i>	L51.1 <i>Bullous erythema multiforme</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Keratitis</i>	H19.3 <i>Keratitis and keratoconjunctivitis in other diseases classified elsewhere</i>

Tabel C.37. Contoh kasus *erythema multiforme*

Contoh 2	Dokter mendiagnosa <i>Stevens-Johnson syndrome</i> dan <i>toxic epidermal necrolysis</i> dan terjadi pengelupasan kulit antara 10 - 30 % dari luas permukaan tubuh.
----------	---

	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Overlapping Stevens-Johnson syndrome</i>	L51.8 <i>Other erythema multiforme</i>
Diagnosis Sekunder	<i>toxic epidermal necrolysis</i>	-

11) Erythema Nodosum (L52)

Gunakan kode dalam kelompok L52 *Erythema Nodosum*, sesuai jenis kondisi yang didiagnosis oleh dokter.

Jika dokter mendiagnosis Eritema nodosum tanpa menyebutkan penyebabnya, gunakan kode L52 (*Erythema nodosum*).

Jika dokter mendiagnosis Eritema nodosum dengan menyebutkan penyebab spesifiknya, gunakan kode penyebab tersebut dan tambahkan kode L52 (*Erythema nodosum*) sebagai kode tambahan.

12) Other Erythematous Conditions (L53-L54)

Jika dokter mendiagnosis *Erythema kronik* tanpa menyebutkan penyebab gunakan kode L53.3 (*Other chronic figurate erythema*).

Jika dokter mendiagnosis erythema marginatum yang disebabkan oleh acute rheumatic fever, gunakan kode I00† (*Rheumatic fever without mention of heart involvement*) dan tambahkan kode L54.0* (*Erythema marginatum in acute rheumatic fever*) sebagai kode tambahan

13) Alopecia (L63-L66)

Jika dokter mendiagnosis *Scarring alopecia*, gunakan kode L66.- (*Cicatricial alopecia*).

Jika dokter mendiagnosis *Alopecia mucinosa* disebabkan oleh obat-obatan, gunakan kode L65.2 (*Alopecia mucinosa*) dan tambahkan kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi obat penyebabnya.

14) Hypertrichosis (L68.-)

Jika dokter mendiagnosis *Hirsutism* dan tidak menyebutkan penyebab, gunakan kode L68.0 (*Hirsutism*).

Jika dokter mendiagnosis *Hirsutism* disebabkan oleh obat-obatan, gunakan L68.0 (*Hirsutism*) dan tambahkan kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi obat penyebabnya.

Jika dokter mendiagnosis *Hirsutism* disebabkan oleh sindrom adrenogenital atau PCOS (*Polycystic Ovary Syndrome*), gunakan kode penyakit tersebut tanpa perlu menambahkan kode L68.0.

Jika dokter mendiagnosis *Hirsutism* disebabkan oleh tumor indung telur atau kelenjar adrenal, gunakan kode tumor dan tambahkan kode L68.0 (*Hirsutism*).

Jika dokter mendiagnosis *Congenital hypertrichosis lanuginosa*, gunakan kode Q84.2 (*Other congenital malformations of hair*).

Jika dokter mendiagnosis *Acquired hypertrichosis lanuginosa*, gunakan kode L68.1 (*Acquired hypertrichosis lanuginosa*).

Jika disebabkan oleh kanker maka gunakan kode kanker dan tambahkan kode L68.1 (*Acquired hypertrichosis lanuginosa*) sebagai kode tambahan.

15) Vitiligo and Other Disorders of Pigmentation (L81-L81)

Kode untuk kelompok L80 Vitiligo atau L81. Gangguan Pigmentasi Lainnya diberikan sesuai dengan diagnosis dokter.

Jika dokter mendiagnosis *vitiligo*, gunakan kode L80 (*Vitiligo*).

16) Epidermal Thickening (L82-L86)

Kode dalam kelompok L82–L86 (meliputi kondisi seperti keratosis, ulkus kulit, dan gangguan kornea) digunakan secara spesifik sesuai diagnosis klinis yang ditegakkan dokter.

Jika dokter mendiagnosis *Seborrheic keratosis*, gunakan kode L82 (*Seborrheic keratosis*).

Jika dokter mendiagnosis *Acanthosis nigricans*, gunakan kode L83 (*Acanthosis nigricans*).

Jika dokter mendiagnosis *Corns and callosities*, gunakan kode L84 (*Corns and callosities*).

Jika dokter mendiagnosis *Epidermal thickening* sesuaikan kode dengan diagnosa dokter, apabila tidak dituliskan secara tidak spesifik, gunakan kode L85.9 (*Epidermal thickening, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis *Keratoderma* yang disebabkan oleh kekurangan Vitamin A maka gunakan kode E50.8 † (*Other manifestations of vitamin A deficiency*) dan tambahkan kode L86* (*Keratoderma in diseases classified elsewhere*).

17) Transepidermal Elimination Disorders dan Pyoderma Gangrenosum (L87 - L88)

Jika dokter mendiagnosis *Keratoderma penetrans*, gunakan kode L87.0 (*Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans*).

Jika dokter mendiagnosis *pyoderma gangrenosum*, gunakan kode L88 (*Pyoderma gangrenosum*).

18) ***Decubitus Ulcer and Pressure Area (L89)***

Jika dokter mendiagnosis *decubitus ulcer and pressure area*, gunakan kode dari kelompok L89.- sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak dan tingkat keparahan.

Pengecualian diberlakukan untuk ulkus dekubitus yang terjadi di serviks uteri, kondisi tersebut harus diklasifikasikan menggunakan kode N86 (*Erosion and Ectropion of Cervix Uteri*) karena perbedaan karakteristik anatomis dan patologi yang memerlukan pendekatan diagnosis dan penanganan khusus oleh dokter spesialis kebidanan dan ginekologi.

Jika dokter mendiagnosis ulkus dekubitus yang terkait dengan diabetes melitus tipe 2, gunakan kode E11.5 (*Non-insulin-dependent diabetes mellitus, with peripheral circulatory complications*). Jika dokter mendiagnosis Ulkus Dekubitus dan diabetes melitus type 2 yang bukan merupakan komplikasi dari diabetesnya maka gunakan kode L89.- dan E11.9 (*Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications*). Jika dalam dokumentasi klinis tidak dituliskan ulkus dekubitus terkait dengan diabetes melitus atau tidak, pemberi kode harus mengkonfirmasi kepada dokter apakah ulkus dekubitus terkait dengan diabetes melitus atau tidak.

Jika dokter mendiagnosis Ulkus dekubitus tanpa diketahui penyebabnya, gunakan kode L89.- (*Decubitus ulcer and pressure area*) sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak dan tingkat keparahan.

Terdapat catatan pada ICD-10 Tahun 2010 bahwa jika ulkus dekubitus terjadi pada lebih dari 1 tempat (*multiple sites*) dengan derajat (*stage*) yang berbeda maka tetapkan 1 kode dengan derajat tertinggi.

19) ***Atrophic Disorders of Skin (L90)***

Jika dokter mendiagnosis kelainan kulit atrofi, gunakan kode L90.- sesuai dengan jenis penyebab dan lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak serta tingkat keparahan.

Jika dokter mendiagnosis *Lichen sclerosus et atrophicus*, gunakan kode L90.0 (*Lichen sclerosus et atrophicus*)

20) ***Hypertrophic Scar (L91.0)***

Jika dokter mendiagnosis parut hipertrofik atau keloid, gunakan kode L91.0 (*Hypertrophic scar*).

Jika dokter mendiagnosis seperti 'parut' tanpa spesifikasi jenis atau alasannya, gunakan kode L90.5 (*Atrophic scar*).

21) ***Granulomatous Disorders (L92)***

Jika dokter mendiagnosis granulomatosa kulit dan jaringan bawah kulit, gunakan kode dalam kelompok L92.-

Jika dokter mendiagnosis *Necrobiosis lipoidica diabetorum* (suatu kondisi yang berkaitan erat dengan diabetes mellitus) gunakan kode E10-E14 (*Diabetes mellitus*) sesuai jenis diabetes yang mendasarinya dan tambahkan kode L92.8 (*Other granulomatous disorders of skin and subcutaneous tissue*)

22) Lupus Erythematosus (L93)

Jika dokter mendiagnosis *lupus erythematosus*, gunakan kode dalam kelompok L93.- sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak dan tambahkan juga kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi obat penyebabnya.

23) Localized Connective Tissue Disorders (L94)

Kode dalam kelompok L94 (*Other localized connective tissue disorders*) digunakan sesuai diagnosis yang ditetapkan oleh dokter seperti L94.0 (*Localized scleroderma [morphea]*) atau L94.2 (*Calcinosis cutis*). Namun, terdapat pengecualian dalam penggunaan kode ini, yaitu:

Jika dokter mendiagnosis sindrom CR(E)ST gunakan kode M34.1 (*CR(E)ST Syndrome*).

Jika dokter mendiagnosis poikilo dermatomyositis gunakan kode M33.1 (*Other dermatomyositis*).

24) Vasculitis Limited to Skin (L95)

Jika dokter mendiagnosis *Vasculitis limited to skin*, gunakan kode L95 (*Vasculitis limited to skin, not elsewhere classified*).

25) Ulcer of Lower Limb (L97)

Jika dokter mendiagnosis ulkus kaki tanpa dijelaskan penyebabnya gunakan kode L97 (*Ulcer of lower limb, not elsewhere classified*).

Jika dokter mendiagnosis ulkus kronis tidak spesifik gunakan kode L98.4 (*Chronic ulcer of skin, not elsewhere classified*).

26) Disorders of Skin and Subcutaneous Tissue (L98)

Jika dokter mendiagnosis gangguan kulit dan jaringan subkutan, gunakan kode L98.- sesuai lokasi anatomi sistem muskuloskeletal yang terdampak.

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 19

Pada kasus pasien dengan abses L02.4 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb*):

- 1) Jika dilakukan insisi pada abses tersebut, gunakan kode 86.04 (*Other incision with drainage of skin and subcutaneous tissue*).
- 2) Jika eksisi dilakukan untuk mengambil jaringan, gunakan kode 86.3 (*Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue*).

- 3) Jika dilakukan biopsy pada kutis atau subkutis, gunakan kode 86.11 (*Biopsy of skin and subcutaneous tissue*).
- 4) Untuk kasus *debridement* (membuang jaringan nekrotik), gunakan kode 86.22 (*Excisional debridement of wound, infection or burn*).
- 5) Pada kasus pasien dengan ulkus thorax dextra, L98.4 (*Chronic ulcer of skin, not elsewhere classified*), jika pasien dilakukan debridement maka dapat diberikan kode sesuai tindakan debridement yang diberikan.
- 6) Kode 86.- (*Operations on skin and subcutaneous tissue*) digunakan untuk tindakan yang dilakukan di area kulit atau subkutan dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi dalam kode 86.-.
- 7) Jika dokter melakukan prosedur *mastectomy* disertai dengan prosedur flap, gunakan kode 85.45 (*Unilateral radical mastectomy*) dan tambahkan kode IM 85.70- untuk tindakan flap.
- 8) Berikut ini adalah tindakan yang biasanya berhubungan dengan MDC 19 Kulit & Subkutan :
- 9) Tindakan 86.22 (*Excisional debridement of wound, infection, or burn*) dapat dikoding jika pada laporan operasi terdapat eksisi dan *debridement* pada luka atau luka bakar.
- 10) Tindakan 86.28 (*Nonexcisional debridement of wound, infection, or burn*) merupakan tindakan pembersihan jaringan mati dan luka untuk infeksi atau luka bakar.
- 11) Tindakan *rehecting superficial* pada luka operasi yang belum sembuh, namun tidak membuka kembali abdomen, dikode menggunakan 86.59 (*Closure of skin and subcutaneous tissue of other sites*).
- 12) Tindakan eksisi lesi dengan *flap graft*.

Jika dokter melakukan prosedur eksisi lesi radikal (*wide*) dengan *flap closure*, maka dikode 86.4 *Radical excision of skin lesion*)

Jika dokter melakukan prosedur eksisi lesi radikal pada kulit dengan *graft* (mengambil jaringan dari organ/regio lain) maka dikode 86.4 ditambah dengan kode *graft* disesuaikan dengan lokasi/anatomi.

Jika dokter melakukan prosedur eksisi dengan tujuan pengambilan *graft*, maka dikode *graft* saja disesuaikan dengan lokasi/anatomi.

Tabel C.38. Contoh kasus *radical excision of skin lesion*

Contoh 3	Pasien datang dengan benjolan di wajah lalu dilakukan pemeriksaan penunjang dan ditemukan kanker kulit di wajah. Dokter melakukan tindakan eksisi pada kanker di wajah dengan flap.
-----------------	---

	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Kanker kulit di wajah	C44.2 (<i>Skin of ear and external auricular canal</i>)
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Eksisi pada wajah dengan flap	86.4 (<i>Radical excision of skin lesion</i>)

Tabel C.39. Contoh kasus *unilateral radical mastectomy*

Contoh 4	Pasien datang dengan keluhan benjolan pada payudara kiri sejak 6 bulan terakhir. Pemeriksaan radiologis dan biopsi menunjukkan hasil kanker payudara kiri pada kuadran atas dalam. Dokter melakukan tindakan unilateral radical mastectomy dan rekonstruksi payudara menggunakan flap jaringan dari paha superomedial.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Ca Mammae Sinistra pada kuadran atas dalam	C50.2 (<i>Upper-inner quadrant of breast</i>)
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Mastektomi Rekonstruksi payudara menggunakan superomedial thigh flap	85.45 (<i>Unilateral radical mastectomy</i>) 85.701 (<i>Superomedial thigh flap (IM)</i>)

14. MDC 20 ENDOKRIN, NUTRISI DAN METABOLIK

Beberapa kondisi yang termasuk dalam bab ini dapat disebabkan oleh obat atau faktor eksternal lainnya. Kode dari bab 20 (Chapter XX) dapat digunakan sebagai kode tambahan.

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 20

1) Hypothyroidism (E03.-)

Jika dokter mendiagnosis *Hypothyroidism* sekunder atau tersier yang disebabkan oleh hipopituitarisme, gunakan kode E23.0 (*Hypopituitarism*).

2) Thyrotoxicosis [Hyperthyroidism] (E05.-)

Jika dokter mendiagnosis Tirotoksikosis *Graves' disease*, gunakan kode E05.0 (*Thyrotoxicosis with diffuse goitre*).

Jika dokter mendiagnosis Tirotoksikosis akibat penggunaan obat hormon, gunakan kode E05.4 (*Thyrotoxicosis factitia*).

Jika dokter mendiagnosis Tirotoksikosis disebabkan oleh penyakit lain yang tidak terklasifikasi, gunakan kode E05.8 (*Other thyrotoxicosis*) dan/atau tambahkan kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi penyebabnya.

Jika dokter mendiagnosis *Thyrotoxic heart disease*, gunakan kode E05.9† (*Thyrotoxic heart disease*) dan tambahkan kode I43.8* (*Cardiomyopathy in other diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *exophthalmos dysthyroid* (gangguan *thyroid*), gunakan kode E05.0† (*Thyrotoxicosis with diffuse goitre*) dan tambahkan kode H06.2* (*Dysthyroid exophthalmos*).

3) Thyroiditis (E06.-)

Jika dokter mendiagnosis Tiroiditis transien tanpa nyeri atau *sporadic thyroiditis*, gunakan kode E06.6 (*Transient painless thyroiditis, sporadic*)^(IM).

4) Procedural Codes for Thyroid Disorders

Jika dokter melakukan prosedur FNAB (*fine needle aspiration biopsy*) pada kelenjar tiroid, gunakan kode 06.11 (*Closed [percutaneous] [needle] biopsy of thyroid gland*).

Jika dokter melakukan prosedur pengobatan hipertiroidisme dengan pemberian *radioactive iodine* dalam bentuk kapsul atau larutan, gunakan kode 92.28 (*Injection or instillation of radioisotopes*). Tambahkan kode IM KND-^(IM) untuk radiofarmaka yang digunakan.

Jika dokter melakukan pemeriksaan *Radioimmunoassay* (RIA), gunakan kode IM pada kelompok pemeriksaan:

92.50 *Non-Imaging Nuclear Medicine Thyroid Function Test*^(IM)

92.51 *Non-Imaging Nuclear Medicine Thyroid Cancer Marker*^(IM)

92.52 *Non-Imaging Nuclear Medicine Thyroid Antibody Test* ^(IM)

Jika dokter melakukan prosedur *thyroid scan* atau *radioactive iodine uptake*, gunakan kode 92.01 (*Thyroid scan and radioisotope function studies*) jika menggunakan MIBI (Methoxy-isobutyl-isomitril). Tambahkan kode IM KND-^(IM) untuk radiofarmaka yang digunakan.

Jika dokter melakukan prosedur drainase abses di area tiroid, jika menggunakan jarum aspirasi, gunakan kode 06.01 (*Aspiration of thyroid field*).

Jika dokter melakukan prosedur insisi untuk drainase, gunakan kode 06.09 (*Other incision of thyroid field*).

5) **Diabetes Mellitus (E10-E14)**

Jika dokter mendiagnosis diabetes tipe 1 atau *insulin-dependent diabetes mellitus*, gunakan kode dalam kelompok E10.- (*Type 1 diabetes mellitus*).

Jika dokter mendiagnosis diabetes tipe 2 atau *non-insulin-dependent diabetes mellitus*, gunakan kode dalam kelompok E11.- (*Type 2 diabetes mellitus*).

Jika dokter mendiagnosis diabetes mellitus disertai malnutrisi, gunakan kode E12.- (*Malnutrition-related diabetes mellitus*), dan kode E46 (*Unspecified protein-energy malnutrition*) tidak perlu dikode.

Jika dokter mendiagnosis *steroid-induced diabetes mellitus*, gunakan kode dalam kelompok E13.- (*Other specified diabetes mellitus*)

Jika dokter mendiagnosis *pancreatic diabetes mellitus*, gunakan kode dalam kelompok E13.- (*Other specified diabetes mellitus*).

Diabetes mellitus tanpa merinci jenisnya, gunakan kode dalam kelompok E14.- (*Unspecified diabetes mellitus*).

Diabetes Mellitus dengan multipel komplikasi

jika salah satu kondisi yang jelas lebih berat dan lebih banyak menggunakan sumber daya dibandingkan dengan yang lain, maka dicatat sebagai diagnosis utama dan yang lainnya sebagai diagnosis sekunder.

jika tidak ada satu kondisi yang lebih dominan, maka diagnosis diabetes melitus dengan multipel komplikasi merupakan diagnosis utama, dan kondisi spesifik sebagai diagnosis sekunder.

6) **Pemberian Kode untuk Komplikasi Diabetes:**

Komplikasi Akut:

Jika dokter mendiagnosis *diabetic coma with or without ketoacidosis*, *hyperosmolar coma*, *hypoglycaemic coma*, *Hyperglycaemic coma*, gunakan kode E10 – E14 dengan subkategori .0 (*With coma*)

Jika dokter mendiagnosis *diabetic coma with or without ketoacidosis*, *hyperosmolar coma*, *hypoglycaemic coma*, *Hyperglycaemic coma* akibat obat

antidiabetik, gunakan kode diabetes dengan subkategori .0 *With coma*, dan tambahkan kode eksternal Y42.3 (*Insulin and oral hypoglycaemic (antidiabetic) drug*).

Jika dokter mendiagnosis pada pasien diabetes, gunakan kode E16.0 (*Drug-induced hypoglycaemia without coma*), dan tambahkan kode diabetes mellitus selain subkatergori .0 (*With coma*) dan tambahkan kode eksternal Y42.3 (*Insulin and oral hypoglycaemic (antidiabetic) drug*).

Jika dokter mendiagnosis *Diabetic ketoacidosis*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .1 (*With ketoacidosis*).

Komplikasi Kronis:

Jika dokter mendiagnosis *Diabetic nephropathy*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .2 (*With renal complications*) dan tambahkan kode N08.3* (*Glomerular disorders in diabetes mellitus*).

Jika dokter mendiagnosis *Diabetic cataract*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .3 (*With ophthalmic complications*) dan tambahkan kode H28.0* (*Diabetic cataract*).

Jika dokter mendiagnosis katarak senil dan diabetes, gunakan kode dalam kelompok H25.- (*Senile cataract*) dan tambahkan kode diabetes dengan subkategori .9 (*Without complications*).

Jika dokter mendiagnosis *diabetic neuropathy*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .4 (*With neurological complications*) diikuti dengan salah satu kode berikut sesuai jenis neuropati yang dirinci:

G59.0* (*Diabetic mononeuropathy*)

G63.2* (*Diabetic polyneuropathy*)

G73.0* (*Diabetic amyotrophy*)

G99.0* (*Diabetic autonomic neuropathy*)

Jika jenis tidak dirinci, gunakan kode G63.2* (*Diabetic polyneuropathy*).

Jika dokter mendiagnosis gastroparesis diabetik (*gastropathy*) enteropathy diabetik (*diare*), hipomotalitas gastroentestinal (*kontstipsi*), gunakan kode diabetes sub kategori .4 (*With neurological complications*)

Jika dokter mendiagnosis Diabetes dengan gangguan pembuluh darah tepi, ulkus pada kulit atau *diabetic gangrene* atau *diabetic ulcer*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .5 (*With peripheral circulatory complications*). Gangguan pembuluh darah tepi, ulkus pada kulit atau *diabetic gangrene* atau *diabetic ulcer* tidak dikode sebagai diagnosis sekunder.

Jika dokter mendiagnosis *Peripheral vascular disease* akibat diabetes melitus tipe 2, gunakan kode E11.5 (*Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complications*), dan tambahkan kode I79.2* (*Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *Diabetic arthropathy*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .6 (*With other specified complications*), dan tambahkan kode M14.2 (*Diabetic arthropathy*).

Jika dokter mendiagnosis penyakit jantung iskemik merupakan komplikasi dari diabetes mellitus, gunakan kode diabetes dengan subkategori .6 (*With other specified complications*) dan penyakit jantung iskemik (I20-I25) tidak dikode. Jika DM tipe 2 tidak berhubungan dengan penyakit jantung iskemik maka dikode penyakit jantung iskemik (I20-I25) dan DM tipe 2 tanpa komplikasi (E11.9). Pemberi kode harus memastikan kepada dokter apakah penyakit jantung iskemik berkaitan dengan komplikasi DM tipe 2 atau tidak.

Jika dokter mendiagnosis *Diabetic neuropathic arthropathy*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .6 (*With other specified complications*), dan tambahkan kode M14.6 (*Neuropathic arthropathy*).

7) Penyakit Lain pada Pasien Diabetes

Jika dokter mendiagnosis *Cellulitis* atau abses pada pasien diabetes, gunakan kode L03.0 (*Cellulitis of finger and toe*), L03.1 (*Cellulitis of other parts of limb*), atau L02.4 (*Cutaneous abscess, furuncle, and carbuncle of limb*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi pada kaki pasien diabetes tidak disertai *peripheral vascular disease* atau *neuropathy*, gunakan kode *cellulitis* dan tambahkan kode diabetes dengan subkategori .9 (*Without complications*) sebagai diagnosis tambahan.

Jika dokter mendiagnosis diabetes dengan *chronic osteomyelitis*, gunakan kode M86.4 (*Chronic osteomyelitis with draining sinus*) atau M86.6 (*Other chronic osteomyelitis*) dan tambahkan kode subkategori .9 (*Without complications*) sebagai diagnosis tambahan.

8) Disorder of Pancreatic Internal Secretion (E16.3-E16.9)

Jika dokter mendiagnosis *glucagonoma*, gunakan kode E16.3 (*Increased secretion of glucagon*).

Jika dokter mendiagnosis gastrinoma atau *Zollinger-Ellison syndrome*, gunakan kode E16.4 (*Abnormal secretion of gastrin*).

Jika dokter mendiagnosis VIPoma, somatostatinoma, atau tumor penghasil GHRH, gunakan kode E16.8 (*Other specified disorders of pancreatic internal secretion*).

9) Hyperparathyroidism (E21.0-E21.3, E83.5)

Jika dokter mendiagnosis hiperparatiroidisme primer, gunakan kode E21.0 (*Primary hyperparathyroidism*).

Jika dokter mendiagnosis hiperparatiroidisme tersier, gunakan kode E21.2 (*Other hyperparathyroidism*).

Jika dokter mendiagnosis hiperkalsemia maligna, gunakan kode penyakit kanker sebagai diagnosis utama dan tambahkan kode E83.5 (*Disorders of calcium metabolism*) sebagai diagnosis tambahan.

Jika dokter mendiagnosis hiperkalsemia akibat penyebab lain seperti imobilisasi, dehidrasi, insufisiensi adrenal, atau tuberkulosis, gunakan kode penyakit atau kondisi penyebab dan tambahkan kode E83.5 (*Disorders of calcium metabolism*).

10) Hyperfunction of Pituitary Gland (E22, E24.0)

Jika dokter mendiagnosis akromegali, gunakan kode E22.0 (*Acromegaly and pituitary gigantism*).

Jika dokter mendiagnosis hiperprolaktinemia akibat obat, gunakan kode E22.1 (*Hyperprolactinaemia*), dan tambahkan kode eksternal sesuai jenis obat penyebab.

11) Cushing' Syndrome (E24.-)

Jika dokter mendiagnosis *pituitary Cushing's syndrome*, gunakan kode E24.0 (*Pituitary-dependent Cushing's disease*).

Jika dokter mendiagnosis *ectopic ACTH syndrome*, gunakan kode E24.3 (*Ectopic ACTH syndrome*).

Jika dokter mendiagnosis *drug-induced Cushing's syndrome*, gunakan kode E24.2 (*Drug-induced Cushing's syndrome*) dan tambahkan kode eksternal Y42.0 (*Glucocorticoids and synthetic analogues causing adverse effects in therapeutic use*).

Jika dokter mendiagnosis *adrenal Cushing's syndrome*, gunakan kode E24.8 (*Other Cushing's syndrome*).

12) Hyperaldosteronism (E26.-)

Jika dokter mendiagnosis hiperaldosteronisme primer dan disebabkan oleh tumor kelenjar adrenal, gunakan kode E26.0 (*Primary hyperaldosteronism*).

Jika dokter mendiagnosis hiperaldosteronisme sekunder tanpa menyebutkan penyebab, gunakan kode E26.1 (*Secondary hyperaldosteronism*).

13) Primary Adrenocortical Insufficiency (E27.1)

Jika dokter mendiagnosis insufisiensi adrenal primer, penyakit Addison atau insufisiensi adrenal autoimun, gunakan kode E27.1 (*Primary adrenocortical insufficiency*).

Jika dokter mendiagnosis insufisiensi adrenal primer yang disebabkan oleh tuberkulosis, gunakan kode A18.7† (*Tuberculosis of adrenal glands*), diikuti dengan kode E35.1* (*Disorders of adrenal glands in diseases classified elsewhere*).

14) Adrenomedullary Hyperfunction (E27.5)

Jika dokter mendiagnosis hiperfungsi medula adrenal, gunakan kode E27.5 (*Adrenal medullary hyperfunction*).

15) Androgen Excess (E28.1)

Jika dokter mendiagnosis kelebihan androgen akibat obat, gunakan kode E28.1 (*Androgen excess*) dan tambahkan kode penyebab eksternal.

Jika dokter mendiagnosis kelebihan androgen akibat kanker ovarium atau kelenjar adrenal, gunakan kode kanker tersebut dan tambahkan kode E28.1 (*Androgen excess*).

16) Testicular Hypofunction (E29.1)

Jika dokter mendiagnosis hipogonadisme pria tanpa menyebutkan penyebab, gangguan pasca infeksi gondok atau andropause, gunakan kode E29.1 (*Testicular hypo function*).

Jika dokter mendiagnosis hipogonadisme pasca-pengangkatan testis, gunakan kode E89.5 (*Postprocedural testicular hypofunction*).

Jika dokter mendiagnosis *Isolated hypogonadotropic hypogonadism*, hipogonadisme sekunder atau tersier, atau sindrom Kallmann, gunakan kode E23.0 (*Hypopituitarism*)

17) Disorders of Puberty (E30.-)

Jika dokter mendiagnosis pubertas prekoks tanpa menyebutkan jenisnya, gunakan kode E30.1 (*Precocious puberty*).

Jika dokter mendiagnosis pubertas prekoks akibat hiperplasia adrenal kongenital, gunakan kode E25.0 (*Congenital adrenal disorders associated with enzyme deficiency*), tanpa perlu menambahkan kode E30.1.

18) Disorders of Lipoprotein Metabolism (E78.-)

Gunakan kode dalam kelompok E78.- (*Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias*) sesuai jenis kelainan lipid yang didiagnosis oleh dokter:

Jika dokter mendiagnosis hiperkolesterolemia, gunakan kode E78.0 (*Pure hypercholesterolaemia*).

Jika dokter mendiagnosis hipergliseridemia, gunakan kode E78.1 (*Pure hyperglyceridaemia*).

Jika dokter mendiagnosis dislipidemia dengan merincikan jenis lipid yang meningkat, gunakan kode E78.2 (*Mixed hyperlipidaemia*).

Jika dokter mendiagnosis hipersilomikronemia, gunakan kode E78.3 (*Hyperchylomicronaemia*).

Jika dokter mendiagnosis hiperlipidemia familia, gunakan kode E78.4 (*Other hyperlipidaemia*).

Jika dokter mendiagnosis dislipidemia tanpa merincikan jenis lipid yang meningkat, gunakan kode E78.5 (*Hyperlipidaemia, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis HDL rendah, gunakan kode E78.6 (*Lipoprotein deficiency*).

Jika dokter mendiagnosis Kelainan lipoprotein lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya, gunakan kode E78.8 (*Other disorders of lipoprotein metabolism*).

19) Hyperuricemia (E79.0)

Jika dokter mendiagnosis hiperurisemia tanpa gejala inflamasi atau tofi, gunakan kode E79.0 (*Hyper-uricaemia without signs of inflammatory arthritis and tophaceous disease*).

Jika dokter mendiagnosis hiperurisemia disertai artritis gout, gunakan kode dalam kelompok M10.- (*Gout*), tanpa perlu menambahkan kode untuk hiperurisemia.

20) Disorders of Calcium Metabolism (E83.5)

Jika dokter mendiagnosis hiperkalsemia atau hipokalsemia tanpa menyebutkan penyebabnya, gunakan kode E83.5 (*Disorders of calcium metabolism*).

Jika dokter menyebutkan penyebabnya, gunakan kode penyakit tersebut tanpa perlu menambahkan kode E83.5 (*Disorders of calcium metabolism*).

21) Amyloidosis (E85.-)

Jika dokter mendiagnosis amiloidosis herediter yang tidak melibatkan neuropati, gunakan kode E85.0 (*Non-neuropathic hereditary amyloidosis*).

Jika dokter mendiagnosis amiloidosis herediter yang melibatkan neuropati, gunakan kode E85.1 (*Neuropathic hereditary amyloidosis*).

Jika dokter mendiagnosis amiloidosis herediter yang tidak disebutkan apakah ada neuropati atau tidak, gunakan kode E85.2 (*Hereditary amyloidosis, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis amiloidosis sekunder pada pasien hemodialisa, gunakan kode E85.3 (*Secondary systemic amyloidosis*).

22) Volume Depletion and Fluid Overload (E86, E87.7)

Jika dokter mendiagnosis kekurangan volume/dehidrasi/hipovolemia tanpa shock dengan tidak disertai kondisi utama, gunakan kode E86 (*Volume depletion*).

Jika dokter mendiagnosis kekurangan volume/dehidrasi/hipovolemia tanpa shock disertai kondisi utama, gunakan kondisi utama dan tambahkan kode E86 (*Volume depletion*).

Jika dokter mendiagnosis kekurangan volume akibat obat diuretik, gunakan kode E86 (*Volume depletion*) dan tambahkan kode eksternal untuk obat penyebab.

Jika dokter mendiagnosis kelebihan cairan tanpa menyebutkan penyebabnya, gunakan kode E87.7 (*Fluid overload*). Jika penyebabnya disebutkan (misalnya

gagal ginjal), gunakan kode penyebab tersebut dan tambahkan kode E87.7 (*Fluid overload*)

23) Hypernatremia and Hyponatremia (E87.0-E87.1)

Jika dokter mendiagnosis hipernatremia atau hiponatremia tanpa menyebutkan penyebabnya, gunakan kode E87.0 (*Hyperosmolality and hypernatremia*) atau E87.1 (*Hypo-osmolality and hyponatremia*). Jika penyebabnya disebutkan, gunakan kode penyebab tersebut tanpa perlu menambahkan kode E87.0 atau E87.1

24) Acidosis (E87.2)

Jika dokter mendiagnosis dan asidosis penyebabnya tidak disebutkan, gunakan kode E87.2 (*Acidosis*).

Jika dokter mendiagnosis asidosis dan terdapat penyebabnya, gunakan kode penyebab tersebut tanpa perlu menambahkan kode E87.2.

25) Alkalosis (E87.3)

Jika dokter mendiagnosis alkalosis dan penyebabnya tidak disebutkan, gunakan kode E87.3 (*Alkalosis*).

Jika dokter mendiagnosis alkalosis terdapat penyebabnya, gunakan kode penyebab tersebut tanpa perlu menambahkan kode E87.3.

26) Hyperkalemia and Hypokalemia (E87.5-E87.6)

Jika dokter mendiagnosis hyperkalemia dan tidak disebutkan penyebabnya, gunakan kode E87.5 (*Hyperkalemia*).

Jika dokter mendiagnosis hypokalemia dan tidak disebutkan penyebabnya, gunakan kode E87.6 (*Hypokalemia*).

Jika dokter mendiagnosis hyperkalemia, gunakan kode penyebab penyakit tersebut tanpa perlu menambahkan kode E87.5 (*Hyperkalemia*).

Jika dokter mendiagnosis hypokalemia, gunakan kode penyebab penyakit tersebut tanpa perlu menambahkan kode E87.6 (*Hypokalemia*).

Jika dokter mendiagnosis hipokalemia disebabkan oleh obat diuretik, gunakan kode E87.6 (*Hypokalemia*) dan tambahkan kode eksternal untuk jenis obat penyebab.

Jika dokter mendiagnosis hipokalemia disebabkan oleh amfoterisin B yang digunakan untuk mengobati infeksi jamur, serta menyebabkan kerusakan tubulointerstitial pada ginjal, gunakan kode N14.1 (*Nephropathy induced by other drugs, medicaments and biological substances*), dan tambahkan kode eksternal Y40.7 (*Antifungal antibiotics, systemically used*).

27) Lipodystrophy (E88.1)

Jika dokter mendiagnosis lipodistrofi akibat obat, gunakan kode E88.1 (*Lipodystrophy, not elsewhere classified*) dan tambahkan kode eksternal untuk jenis obat penyebab.

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 20

- 1) Pada pasien dengan diagnosis diabetes mellitus tipe 2 yang mengalami infark miokard akut, gagal jantung, atau angina sebagai komplikasi diabetes mellitus, kondisi jantung tersebut dikodekan sebagai diagnosis primer sesuai kondisi yang dialami, sedangkan diabetes mellitus tipe 2 dikodekan sebagai diagnosis sekunder dengan kode E11.6 (diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi lain yang ditentukan).
- 2) Apabila penyakit diabetes mellitus tidak berhubungan dengan penyakit jantung iskemik, penentuan diagnosis utama dan sekunder harus mengikuti prinsip morbiditas sebagaimana dijelaskan dalam *Chapter 2*. Dalam situasi di mana dokter menetapkan diabetes mellitus sebagai diagnosis utama dan penyakit jantung iskemik sebagai diagnosis sekunder, maka gunakan kode E11.9 (diabetes mellitus tipe II tanpa komplikasi) sebagai diagnosis utama dan kode I20–I25 sebagai diagnosis sekunder untuk penyakit jantung iskemik.
- 3) Dokumentasikan dengan benar mengenai kasus diabetes melitus, dalam iDRG terdapat 2 group tersendiri mengenai diabetes melitus yaitu, *Diabetes without Complicated PDx & Diabetes with Complicated PDx*, ketepatan dokumentasi klinis dan kode diagnosis akan berpengaruh kepada pengelompokan grouper iDRG.

15. **MDC 21 DISEASE AND DISORDERS OF THE KIDNEY AND URINARY TRACT**

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 21

1) Glomerular diseases (N00-N08)

Penggunaan subdivisi karakter keempat dari .0 sampai .8 pada kode N00-N08 yang menunjukkan perubahan morfologis dari kategori kode N00-N07, hanya diperbolehkan apabila perubahan tersebut teridentifikasi berdasarkan Biopsi atau Autopsi.

Jika dokter mendiagnosis penyakit ginjal dan gagal ginjal (baik akut, kronis, maupun yang tidak ditentukan) gunakan kode dalam kelompok N17-N19 sebagai kode tambahan.

Jika penyebab dari kondisi yang diklasifikasikan pada kode N00-N08 disebabkan oleh faktor luar, maka tambahkan kode dari bab 20 (Chapter XX) kode tambahan.

Kode I12 (*Hypertensive renal disease*) merupakan pengecualian dari kode N00-N08 dan hanya digunakan ketika kondisi tersebut berkaitan dengan hipertensi.

2) Obstructive And Reflux Uropathy (N13.-)

Gunakan kode dari kelompok N13.- untuk kasus obstruktif dan refluks uropati perhatikan kondisi tersebut disertai oleh infeksi atau tidak, penggunaan kode N13.6 adalah untuk kondisi yang termasuk dalam kode N13.0 s.d N13.5 yang disertai infeksi.

Jika dokter mendiagnosis hydronephrosis dengan batu ginjal tanpa disertai infeksi, gunakan kode N13.2 (*Hydronephrosis with renal and ureteral calculous obstruction*).

Jika dokter mendiagnosis hydronephrosis dengan batu ginjal disertai infeksi gunakan kode N13.6 (*Pyonephrosis*) dan tambahkan kode B95 - B97 untuk menentukan agen penyebab infeksi.

3) Renal Tubulo-Interstitial Disorders (N14-N16)

Pada penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan (seperti analgesik atau obat lain) atau terpapar logam berat (seperti emas atau timbal) yang dapat menimbulkan kerusakan, khususnya pada ginjal maka dalam pengodeannya adalah sbb:

Jika penyebabnya adalah obat penghilang rasa sakit golongan analgetik), gunakan kode N14.0 (*Analgesic nephropathy*). dan tambahkan kode external cause di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi obat penyebabnya

Jika penyebabnya adalah obat/bahan biologis lain (misalnya amfoterisin B, litium, siklosporin, zat kontras atau bahan lainnya), gunakan kode N14.1 (*Nephropathy induced by other drugs, medicaments, and biological substances*) dan tambahkan kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi obat penyebabnya.

Jika obat/bahan biologis tidak spesifik, gunakan kode N14.2 (*Nephropathy induced by unspecified drug, medicament, and biological substance*) dan tambahkan kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi obat penyebabnya.

Jika penyebabnya adalah logam berat (misalnya emas, timbal atau logam berat lainnya), maka gunakan kode N14.3 (*Nephropathy induced by heavy metals*) dan tambahkan kode *external cause* di bab 20 (Chapter XX) untuk mengidentifikasi agen penyebabnya.

Jika penyakit ginjal tubulo-interstitial disebabkan oleh penyakit lain (misalnya diabetes, lupus), gunakan kode penyakit primer sebagai diagnosis utama dan tambahkan kode N16.- (*Renal tubulo-interstitial disorders in diseases classified elsewhere*) sebagai diagnosis sekunder.

Tabel C.40. Contoh kasus *renal tubulo-interstitial disorders*

Contoh 1	Dokter mendiagnosis nefropati tubulo-interstisial dari <i>Multiple myeloma</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Multiple myeloma</i>	C90.0† <i>Multiple myeloma</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Nephropathy tubulo-interstitial</i>	N16.1* <i>Renal tubulo-interstitial disorders in neoplastic diseases</i>

4) **Acute Kidney Injury (N17.3-)**^(IM)

Pada kasus *acute kidney injury* (AKI), gunakan kode spesifik sesuai dengan derajat keparahannya (*stage*). Jika dokter mendiagnosis AKI tanpa diketahui derajat keparahannya, pemberi kode melakukan konfirmasi kepada dokter.

Jika dokter mendiagnosis *acute kidney injury* (AKI), gunakan kode *indonesian modification*^(IM) berikut ini untuk kode AKI :

N17.31 *Acute kidney injury stage 1* ^(IM)

N17.32 *Acute kidney injury stage 2* ^(IM)

N17.33 *Acute kidney injury stage 3 needed renal support* ^(IM)

Jika AKI terjadi pada pasien gagal ginjal kronis tambahkan kode N18.- untuk mengidentifikasi jenis CKD nya.

5) **Chronic Kidney Disease (N18.-)**

Jika dokter mendiagnosis CKD tidak disertai penyebab spesifik, gunakan kode dalam kelompok N18.- sesuai stadium (*stage*) yang dicantumkan dokter.

Jika dokter mendiagnosis CKD disertai penyebab spesifik, gunakan kode dalam kelompok N18.- dan tambahkan kode yang menunjukkan hubungan dengan ginjal.

Tabel C.41. Contoh kasus *chronic kidney disease*

Contoh 2	Dokter mendiagnosis Nephropathy DM dan CKD Stage 5	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>DM dengan Nephropathy</i>	E14.2† <i>Diabetes Mellitus with renal complications</i>
Diagnosis Sekunder	CKD Stage 5	N08.3* <i>Glomerular disorders in diabetes mellitus</i> N18.5 <i>Chronic kidney disease, stage 5</i>

Penambahan Kode Stadium: Jika dokter mencantumkan stadium (1–5), tambahkan kode N18.1–N18.5 sesuai stadium. Jika stadium tidak disebutkan, tidak perlu menambahkan kode N18.-

Tabel C.42. Contoh kasus lupus nefritis

Contoh 3	Jika dokter mendiagnosis lupus nefritis.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Lupus nefritis	M32.1† <i>Systemic lupus erythematosus with organ involvement</i>
Diagnosis Sekunder		N08.5* <i>Glomerular disorders in systemic connective tissue disorders</i>

Jika dokter mendiagnosis *chronic kidney disease stage 5* disertai hipertensi, gunakan kode kombinasi I12.0 (*Hypertensive renal disease with renal failure*) dan tambahkan kode N18.5 (*Chronic kidney disease, stage 5*).

6) **Urolithiasis N20-N23**

Berikan kode dari kelompok N20.- (*Calculus of kidney and ureter*) dan N21.- (*Calculus of lower urinary tract*) sesuai dengan lokasi batu seperti yang didiagnosis oleh dokter:

Jika dokter mendiagnosis batu saluran kemih dengan disertai ISK, gunakan kode gabungan pada sub bab *Urolithiasis* (N20-N23) sesuai dengan kriteria

excludes yang dijelaskan pada sub bab N30-N39 yang dikecualikan adalah untuk infeksi di saluran kemih yaitu untuk kode berikut ini :

N30.- (*Cystitis*)

N33.0 (*Tuberculous cystitis*)

N34.- (*Urethritis and urethral syndrome*)

N37.0 (*Urethritis in diseases classified elsewhere*)

N39.0 (*Urinary tract infection, site not specified*)

Jika dokter mendiagnosis batu saluran kemih pada hiperparatiroidisme primer, gunakan kode E21.0† (*Primary hyperparathyroidism*) dan tambahkan kode N22.8* (*Calculus of urinary tract in other diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis kolik ginjal atau kolik ureter, gunakan kode N23 (*Unspecified renal colic*).

Jika dokter mendiagnosis kolik ginjal disertai *ureterolithiasis* dengan *hydronephrosis* dan *hydronephrosis*, gunakan kode N13.2 (*Hydronephrosis with renal and ureteral calculous obstruction*). Kolik ginjal tidak perlu dikode terpisah karena merupakan gejala dari obstruksinya..

7) Contracted And Small Kidney (N26-N27)

Jika dokter mendiagnosis kontraktur ginjal, atrofi ginjal, atau sklerosis ginjal, gunakan kode N26 (*Unspecified contracted kidney*).

Jika dokter mendiagnosis kontraktur ginjal dengan hipertensi, gunakan kode kombinasi I12.- (*Hypertensive renal disease*)

Jika dokter mendiagnosis *small kidney* tanpa diketahui penyebabnya dan hanya pada satu sisi, gunakan kode N27.0 (*Small kidney, unilateral*).

Jika dokter mendiagnosis *small kidneys* atau *contracted kidneys* pada kedua sisi, gunakan kode di kelompok N27.1 (*Small kidney, bilateral*).

8) Cyst Of Kidney (N28.1)

Jika dokter mendiagnosis kista ginjal, gunakan kode N28.1 (*Cyst of kidney, acquired*).

Jika dokter mendiagnosis kista ginjal, karena kelainan kongenital, gunakan kode Q61.- (*Cystic kidney disease (congenital)*).

9) Bladder-Neck Obstruction (N32.0)

Jika dokter mendiagnosis obstruksi leher kandung kemih (*bladder neck*) atau stenosis/penyempitan leher kandung kemih (*bladder neck*), gunakan kode N32.0 (*Bladder-neck obstruction*).

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 21

1) Pengodean Diagnosis *renal artery stenosis*

Jika dokter mendiagnosis hipertensi disebabkan oleh *renal artery stenosis*, dan dirawat untuk *renal artery stenosis*, gunakan kode I70.1 (*Atherosclerosis of renal artery*) dan tambahkan kode I15.0 (*Renovascular hypertension*).

2) Pengodean Tindakan Terkait CAPD

Jika dokter melakukan prosedur pembuatan akses *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD), gunakan kode Indonesian modification (IM) sesuai teknik yang digunakan. Jika dokter melakukan prosedur pembuatan akses CAPD dengan teknik *peritoneoscopy* gunakan kode 54.932 *Insertion of peritoneal dialysis catheter: peritoneoscopy technique* ^(IM).

3) Pemasangan Akses Hemodialisis

Jika dokter melakukan prosedur pemasangan *Catheter Double Lumen* (CDL), gunakan kode 38.95 (*Venous catheterization for renal dialysis*).

Jika dokter melakukan prosedur pembuatan akses *dialysis* dengan *Tunneled Dialysis Catheter* (TDC), gunakan kode 38.950 (*Insertion of Tunneled Dialysis Catheter*) ^(IM).

Jika dokter melakukan prosedur pembuatan akses AV shunt untuk *dialysis*, gunakan kode 39.27 (*Arteriovenostomy for renal dialysis*).

Jika dokter melakukan prosedur pembukaan akses hemodialisis yang mengalami penyempitan dengan prosedur *angioplasty* atau *venoplasty* gunakan kode 39.500 (*Angioplasty or atherectomy of other non-coronary vessel(s) for dialysis Access*) ^(IM). Jika dokter melakukan prosedur perbaikan akses *dialysis arteriovenous shunt*, gunakan kode 39.42 (*Revision and replacement of Venous catheterization for renal dialysis*).

4) Jika dokter melakukan prosedur pengangkatan ginjal dari pendonor, gunakan kode Z52.4 (*Kidney donor*) dan kode 55.520 (*Living donor*) ^(IM) atau 55.521 (*Cadaver donor*) ^(IM), jika dokter melakukan prosedur transplantasi ginjal, gunakan kode prosedur 55.69 (*Other kidney transplantation*) dan 00.9- .

5) Dalam MDC 21 terdapat DRG khusus untuk prosedur *Extracorporeal shockwave lithotripsy* (ESWL), sehingga pemberi kode harus memperhatikan dokumentasi medis dan bukti tata laksana prosedur ESWL.

6) Ketika terdapat prosedur yang masuk ke dalam MDC 21 dan disertai dengan prosedur ESWL dengan kode 98.51, maka akan masuk ke dalam DRG dengan deskripsi *w/ESWL*, misalkan:

7) *Ureteroscopy Proc. w/ ESWL*

8) *Cystourethroscopy Proc. w/ ESWL*

9) *Urinary Stone/Obstruction w/ ESWL*

16. MDC 22 SISTEM REPRODUKSI PRIA

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 22

1) Hyperplasia of Prostate (N40)

Jika dokter mendiagnosis obstruksi uretra pada *benign prostatic hypertrophy/hyperplasia* (BPH), gunakan kode N40 (*Hyperplasia of prostate*) tanpa perlu kode tambahan obstruksi uretra.

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 22

Proses pengkodean tindakan medis di MDC ini, terdapat kode Indonesian Modification (IM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendokumentasikan tindakan khusus dengan lebih akurat. Beberapa kode Indonesian Modification yang digunakan antara lain:

60.50 *Laparoscopic radical prostatectomy* ^(IM)

64.970 *Revision artificial erection device* ^(IM)

63.10 *Microligation for varicocele* ^(IM)

63.11 *Laparoscopic varicocele ligation* ^(IM)

86.060 *Insertion prostatic stent/coil with ultrasound control* ^(IM)

86.061 *Insertion prostatic stent/coil with visual* ^(IM)

60.22 *Transurethral needle ablation prostate* ^(IM)

60.23 *Cryoablation of prostate* ^(IM)

60.24 *Transurethral electric vaporization prostate* ^(IM)

60.25 *High intensity focused ultrasound prostate* ^(IM)

51.120 *Laparoscopic biopsy gonad* ^(IM)

60.290 *Transurethral resection of ejaculatory duct (TURED)* ^(IM)

62.31 *Laparoscopic orchiectomy* ^(IM)

62.50 *Laparoscopic orchidopexy* ^(IM)

62.52 *Laparoscopic orchidopexy fowler stephen* ^(IM)

Detail lengkap mengenai kode *Indonesian Modification* dapat dilihat dalam daftar yang telah ditetapkan oleh Kemenkes RI. Penggunaan kode IM wajib dilakukan sesuai dengan tindakan yang terdokumentasi dalam rekam medis pasien untuk memastikan akurasi dan validitas data.

Pemanfaatan kode IM ini sangat penting dalam pengembangan sistem DRG (*Diagnosis Related Group*) kedepannya, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data pembiayaan kesehatan nasional.

Selain itu, terdapat DRG khusus untuk tindakan pada MDC 22 yang dilakukan dengan teknik laparoscopi, khususnya untuk tindakan prostatektomi, yaitu "*Radical Prostatectomy Proc. w Laparoscopy*". Untuk tindakan radikal prostatektomi yang

dilakukan dengan teknik laparoscopi, diwajibkan menggunakan kode prosedur 60.50 (*Laparoscopic radical prostatectomy*)^(IM).

17. **MDC 23 SISTEM REPRODUKSI WANITA**

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 23

1) *Inflammatory Disease Of Female Pelvic Organs (N70-N74)*

Kode diagnosis untuk peradangan dan infeksi pada organ daerah panggul wanita dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel C.43. Kode diagnosis untuk peradangan dan infeksi pada organ daerah panggul wanita

Diagnosis	Kode
Abses Tuba falopi	N70.2 <i>Abses tubo-ovarium</i> ^(IM)
Abses Ovarium	N70.2 <i>Abses tubo-ovarium</i> ^(IM)
Abses Tubo-ovarium	N70.2 <i>Abses tubo-ovarium</i> ^(IM)
Radang Rahim, <i>unspecified</i>	N71.9 <i>Inflammatory disease of uterus, unspecified</i>
Radang Rahim Akut	N71.0 <i>Acute inflammatory disease of uterus</i>
Radang Rahim Kronis	N71.1 <i>Chronic inflammatory disease of uterus</i>

Hasil identifikasi yang menunjukkan penyebab peradangan dan penyebab infeksi memiliki kode tertentu, maka gunakan kode penyebab infeksi yaitu kode *dagger* pada Bab 1 ICD-10 bersama dengan kode *asterisk* pada kelompok N74.-

Hasil identifikasi yang menunjukkan penyebab infeksi tidak memiliki kode tertentu, gunakan kode dari kelompok B95 – B97 untuk menentukan agen penyebab infeksi.

Tabel C.44. Contoh kasus *tuberculous infection of cervix uteri*

Contoh 1	Seorang pasien perempuan berusia 30 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah yang menetap disertai gangguan siklus menstruasi berupa amenorea sekunder (berhentinya haid), serta adanya gejala sistemik berupa lemas dan penurunan berat badan yang signifikan; setelah dilakukan pemeriksaan penunjang berupa kuretase endoserviks dan pemeriksaan histopatologi yang menunjukkan adanya nekrosis kaseosa dan sel datia Langhans, dokter menegakkan diagnosis <i>Tuberculous infection of cervix uteri</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Tuberculous infection of cervix uteri</i>	A18.1† <i>Tuberculosis of genitourinary system</i>
Diagnosis Sekunder	-	N74.1* <i>Female tuberculous pelvic inflammatory disease</i>

Tabel C.45. Contoh kasus *acute pelvic inflammatory disease*

Contoh 2	Pasien perempuan mengalami nyeri pada bagian bawah perut yang dirasakan di kedua sisi, disertai keputihan yang berwarna seperti nanah. Pada pemeriksaan fisik oleh dokter, ditemukan adanya nyeri tekan di area adneksa (indung telur dan tuba falopi) di kedua sisi. Hasil kultur sekret serviks menunjukkan pertumbuhan bakteri <i>E. coli</i> . Berdasarkan temuan ini, pasien didiagnosis dengan Penyakit Radang Panggul Akut (<i>Acute Pelvic Inflammatory Disease</i> /PID) yang disebabkan oleh infeksi bakteri <i>E. coli</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Acute Pelvic Inflammatory Disease (PID) due to E. coli</i>	N73.9 Penyakit radang panggul akut, tidak ditentukan
Diagnosis Sekunder	-	B96.2 <i>Escherichia</i> sebagai penyebab penyakit yang diklasifikasikan ke bab lain

Jika dokter mendiagnosis *pelvic inflammatory disease* (PID) yang terjadi setelah keguguran, kehamilan ektopik, atau *blighted ovum* maka gunakan kode O08.0 (*Genital tract and pelvic infection following abortion and ectopic and molar pregnancy*).

2) Female Pelvic Peritoneal Adhesions (N73.6)

Jika dokter mendiagnosis perlengketan/penggumpalan pada peritoneum dengan menyebutkan lokasi anatomik spesifik pada panggul dan kondisi tersebut terjadi pada pasien perempuan, gunakan kode N73.6 (*Female pelvic peritoneal adhesions*).

Jika dokter mendiagnosis perlengketan/penggumpalan pada peritoneum tanpa menyebut lokasi anatomi secara spesifik misalnya panggul atau abdomen atau apabila kondisi tersebut terjadi pada pasien laki-laki, gunakan kode K66.0 (*Peritoneal adhesions*).

Jika dokter mendiagnosis perlengketan/penggumpalan pada rongga pelvis pasca-prosedur medis, gunakan kode N99.4 (*Postprocedural pelvic peritoneal adhesions*).

Jika dokter mendiagnosis perlengketan/penggumpalan disertai obstruksi usus, gunakan kode K56.5 (*Intestinal adhesions with obstruction*).

Jika dokter melakukan prosedur re-laparotomy pada sayatan operasi laparotomi sebelumnya untuk kontrol pendarahan, eksplorasi, dan/atau insisi hematoma, gunakan kode 54.12 (*Reopening of recent laparotomy site*).

3) Disease of Bartholin's Gland (N75)

Jika dokter mendiagnosis kista kelenjar bartolin tanpa infeksi, gunakan kode N75.0 (*Cyst of Bartholin's gland*).

Jika dokter mendiagnosis abses kelenjar bartolin, gunakan kode N75.1 (*Abscess of Bartholin's gland*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi genital pada kehamilan disertai abses bartholin, gunakan kode O23.5 (*Infection of genital tract in pregnancy*) dan tambahkan kode N75.1 (*Abscess of Bartholin's gland*).

Tabel C.46. Contoh kasus *disease of bartholin's gland*

Contoh 3	Pasien perempuan tidak hamil dan tidak dalam masa nifas, terdapat benjolan di bibir vagina akibat penyumbatan kelenjar Bartholin. Tidak ada tanda infeksi (seperti kemerahan, nyeri hebat, atau demam).	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Kista Bartholin	N75.0 <i>Cyst of Bartholin's gland</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Aspirasi kista Bartholin	71.21 <i>Percutaneous aspiration of Bartholin's gland</i>

Tabel C.47. Contoh kasus *disease of bartholin's gland*

Contoh 4	Pasien perempuan, hamil 3 bulan, didiagnosis dengan abses Bartholin dan menjalani operasi marsupialisasi.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Abses Bartholin	O23.5 <i>Infections of genital tract in pregnancy</i>
Diagnosis Sekunder	-	N75.1 <i>Abscess of Bartholin's gland</i>
Prosedur	Marsupialisasi abses Bartholin	71.23 <i>Marsupialization of Bartholin's gland</i>

Tabel C.48. Contoh kasus *disease of bartholin's gland*

Contoh 5	Pasien perempuan, 4 minggu postpartum (nifas), didiagnosis dengan abses Bartholin dan menjalani operasi marsupialisasi.
-----------------	---

	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Abses Bartholin	O86.3 <i>Other genitourinary tract infections following delivery</i>
Diagnosis Sekunder	-	N75.1 <i>Abscess of Bartholin's gland</i>
Prosedur	Marsupialisasi abses Bartholin	71.23 <i>Marsupialization of Bartholin's gland</i>

4) **Other Inflammation of Vagina and Vulva (N76-N77)**

Jika dokter mendiagnosis vaginitis atau vulvovaginitis, gunakan kode N76.0 (*Acute vaginitis*) jika kondisi tersebut bersifat akut atau tidak spesifik.

Jika dokter mendiagnosis vaginitis atau vulvovaginitis sebagai bentuk subakut atau kronis, gunakan kode N76.1 (*Subacute and chronic vaginitis*).

Jika dokter mendiagnosis vulvitis akut atau tidak spesifik, gunakan kode N76.2 (*Acute vulvitis*).

Jika dokter mendiagnosis vulvitis subakut atau kronis, gunakan kode N76.3 (*Subacute and chronic vulvitis*).

Jika dokter mendiagnosis abses atau furunkel pada vulva (kecuali abses kelenjar Bartholin), gunakan kode N76.4 (*Abscess of vulva*).

Gunakan kode tambahan B95-B98 untuk mengidentifikasi agen infeksi penyebabnya yang terjadi pada kasus peradangan jika menggunakan kode N76.-.

Jika dokter mendiagnosis kasus infeksi jamur *Candida* di vulva dan/atau vagina, gunakan kode B37.3† (*Candidiasis of vulva and vagina*) dan tambahkan kode N77.1 (*Vaginitis, vulvitis, and vulvovaginitis in infectious diseases*).

Jika dokter mendiagnosis ulkus pada vulva disebabkan oleh infeksi herpes, gunakan kode A60.0† (*Herpesviral infection of genitalia*) dan tambahkan kode N77.0 (*Ulceration of vulva in infectious diseases*).

Jika dokter mendiagnosis peradangan vagina, vulva, atau kombinasi vulva-vagina akibat infeksi herpes, gunakan kode A60.0† (*Herpesviral infection of genitalia and urogenital tract*), dan tambahkan kode N77.1 (*Vaginitis, vulvitis and vulvovaginitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis ulkus pada vagina atau vulva yang tidak dapat ditentukan penyebabnya gunakan kode N76.5 (*Ulceration of vagina* atau N76.6 *Ulceration of vulva*).

Jika dokter mendiagnosis vaginitis akut yang disebabkan oleh bacterial vaginosis (BV), gunakan kode N76.0 (*Acute Vaginitis*).

5) **Endometriosis (N80.-)**

Jika dokter mendiagnosis endometriosis di uterus, gunakan kode N80.0 (*Endometriosis of uterus*).

Jika dokter mendiagnosis endometriosis di ovarium atau kista coklat ovarium, gunakan kode N80.1 (*Endometriosis of ovary*).

Jika dokter mendiagnosis endometriosis di peritoneum panggul, gunakan kode N80.3 (*Endometriosis of pelvic peritoneum*).

Jika dokter mendiagnosis endometriosis melibatkan beberapa lokasi di panggul, gunakan kode N80.7 (*Pelvic endometriosis*)^(IM) dan tambahkan kode N80.0–N80.6 untuk spesifikasi lokasi.

6) **Prolapsus Genital (N81)**

Jika dokter mendiagnosis *cystorectocele* (gabungan kistocele dan rektokel), gunakan kode N81.7 (*Cystorectocele*)^(IM). Tidak perlu menambahkan kode N81.1 (*cystocele*) atau N81.6 (*rectocele*) secara terpisah.

Jika dokter mendiagnosis Prolapsus serviks tidak spesifik, prolapsus uterus derajat 1, atau prolapsus uterus derajat 2, gunakan kode N81.2 (*Incomplete uterovaginal prolapse*).

Jika dokter mendiagnosis procidentia uteri atau prolapsus uterus derajat 3, gunakan kode N81.3 (*Complete uterovaginal prolapse*).

Jika dokter mendiagnosis Prolapsus uterovaginal yang tidak spesifik, gunakan kode N81.4 (*Uterovaginal prolapse, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis *deficient perineum* atau *Old laceration of muscles of pelvic floor*, gunakan kode N81.8 (*Other female genital prolapse*).

Jika dokter mendiagnosis prolapsus yang terjadi pada masa kehamilan atau persalinan, gunakan kode O34.5 (*Maternal care for other abnormalities of gravid uterus*). dan tambahkan kode dari kelompok N81 sesuai kondisi spesifik.

Jika dokter mendiagnosis prolapsus vaginal vault paska-histerektomi (pengangkatan rahim), gunakan kode N99.3 (*Prolapsus vaginal vault after hysterectomy*).

7) **Cyst Of Ovary (N83.0-N83.2)**

Jika dokter mendiagnosis kista folikular atau kista korpus luteum, gunakan kode N83.0 (*Follicular cyst of ovary*) atau N83.1 (*Corpus luteum cyst*).

Jika dokter mendiagnosis kista ovarium jenis lain (misalnya: kista sederhana) atau jenis kista tidak spesifik, gunakan kode N83.2 (*Other and unspecified ovarian cysts*).

Jika dokter mendiagnosis kista coklat ovarium, gunakan kode N80.1 (*Endometriosis of ovary*).

8) **Hyperplasia Endometrial (N85.0-N85.1)**

Jika dokter mendiagnosis hiperplasia endometrium cystic, glandular-cystic, polypoid, gunakan kode N85.0 (*Endometrial glandular hyperplasia*).

Jika dokter mendiagnosis *Hyperplasia of endometrium, atypical (adenomatous)*, gunakan kode N85.1 (*Endometrial adenomatous hyperplasia*).

9) **Leukorrhea (N89.8)**

Jika dokter mendiagnosis *Leukorrhea* tanpa penyebab yang jelas, gunakan kode N89.8 (*Other specified noninflammatory disorders of vagina*).

Jika dokter mendiagnosis keputihan diketahui penyebabnya, gunakan kode sesuai dengan penyebabnya.

Tabel C.49. Contoh kasus *leukorrhea*

Contoh 6	Seorang pasien perempuan berusia 29 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan leukorrhea atau keputihan yang sangat banyak, berwarna kuning kehijauan, dan berbusa, yang disertai dengan rasa gatal yang hebat serta nyeri saat berhubungan seksual (dispareunia); setelah dokter melakukan pemeriksaan fisik dan menemukan adanya gambaran strawberry cervix serta mengonfirmasi keberadaan parasit protozoa melalui pemeriksaan mikroskopis, dokter mendiagnosis pasien tersebut menderita leukorrhea karena infeksi <i>Trichomonas (vaginalis)</i>	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Leukorrhea due to <i>Trichomonas (Vaginalis)</i>	A59.0 <i>Urogenital trichomoniasis</i>
Diagnosis Sekunder	-	

10) **Postcoital And Contact Bleeding (N93.0)**

Jika dokter mendiagnosis perdarahan *postcoital*, gunakan kode N93.01 (*Postcoital bleeding*)^(IM) jika terdapat penyebab eksternal maka tambahkan kode penyebab eksternal.

Jika dokter mendiagnosis perdarahan *postcoital* yang tidak disebabkan oleh luka, gunakan kode diagnosis sesuai jenis luka tersebut sebagai diagnosis utama. Jangan gunakan kode N93.01 (*Postcoital bleeding*)^(IM), namun tetap cantumkan kode penyebab eksternal dari cedera.

Perdarahan kontak (*contact bleeding*), gunakan kode N93.00 (*Contact bleeding*)^(IM) sebagai diagnosis karena kondisi ini tidak dianggap sebagai cedera, sehingga tidak perlu diberikan kode penyebab eksternal.

Contoh 7	Pasien perempuan mengalami perdarahan setelah berhubungan seksual. Dokter menemukan perdarahan telah berhenti dan tidak ada luka yang ditemukan, diagnosisnya adalah perdarahan postcoital.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Perdarahan pasca seks	N93.01 <i>Postcoital bleeding</i>
Diagnosis Sekunder	-	-

Tabel C.50. Contoh kasus *postcoital bleeding*

Contoh 8	Pasien perempuan mengalami perdarahan setelah berhubungan seksual di rumah. Pemeriksaan dalam oleh dokter menemukan perdarahan berasal dari luka pada dinding vagina, dengan diagnosis laserasi mukosa vagina. Penanganan dilakukan dengan menjahit luka pada dinding vagina, tanpa komplikasi.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Laserasi mukosa vagina	S31.4 <i>Open wound of vagina and vulva</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Penyebab Eksternal	Hubungan seksual di rumah	X58.08 <i>Exposure to other specified factors, home, While engaged in other specified activities</i>
Prosedur	Jahitan	70.71 <i>Suture of laceration of vagina</i>

Tabel C.51. Contoh kasus *postcoital and contact bleeding*

11) Vaginal Bleeding (N93.8-N93.9)

Jika dokter mendiagnosis *dysfunctional uterine bleeding* (DUB), gunakan kode N93.8 (*Other specified abnormal uterine and vaginal bleeding*).

Jika dokter mendiagnosis *vaginal bleeding* tanpa menyebutkan penyebab atau lokasi perdarahan, gunakan kode N93.9 (*Abnormal uterine and vaginal bleeding, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis *abnormal Uterine Bleeding* [AUB], gunakan kode N93.9 (*Abnormal uterine and vaginal bleeding, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis perdarahan yang disebabkan oleh luka (misalnya, luka pada dinding vagina yang terdeteksi saat pemeriksaan dalam), gunakan kode S31.4 (*Open wound of vagina and vulva*) dan tambahkan kode penyebab eksternal untuk menjelaskan asal-usul luka.

12) Menopause (N95)

Jika dokter mendiagnosis pendarahan *postmenopause* yang terjadi secara alami atau tidak disebutkan jenisnya, gunakan kode N95.0 (*Postmenopausal bleeding*).

Jika dokter mendiagnosis *menopause* atau gejala terkait *menopause* namun tidak menyebutkan jenis *menopause* (alami atau artifisial), gunakan kode N95.1 (*Menopausal and female climacteric states*).

Jika dokter mendiagnosis vaginitis atrofik postmenopausal (radang vagina akibat penipisan jaringan), gunakan kode N95.2 (*Postmenopausal atrophic vaginitis*).

Jika dokter mendiagnosis *menopause artificial*, gunakan kode N95.3 (*States associated with artificial menopause*).

13) Habitual Aborter (N96)

Jika dokter melakukan penanganan untuk mencari penyebab aborsi habitual pada pasien yang tidak dalam kondisi hamil dan tidak dalam kondisi keguguran, gunakan kode N96 (*Habitual aborter*).

Jika dokter mendiagnosis riwayat aborsi habitual dalam kondisi hamil, gunakan kode O26.2 (*Pregnancy care of habitual aborter*).

Jika dokter mendiagnosis riwayat aborsi habitual dalam kondisi keguguran, gunakan kode dalam kelompok O03–O06 (sama seperti kasus keguguran umum).

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 23

- 1) Perhatikan kriteria *include* dan *exclude* yang berkaitan dengan MDC 23. Untuk kasus eksisi kista dan biopsi pada kista vagina N89.8:
- 2) Jika dokter melakukan prosedur eksisi pada vagina untuk pengangkatan kista tanpa pengambilan sampel jaringan untuk pemeriksaan histopatologi, gunakan kode 70.33 (*Excision or destruction of lesion of vagina*).
- 3) Jika dokter melakukan prosedur pengambilan jaringan untuk *biopsy*, gunakan kode 70.24 (*Vaginal biopsy*).
- 4) Jika dokter melakukan prosedur pengangkatan kista secara keseluruhan dan dilakukan pemeriksaan jaringan, gunakan kode 70.33 (*Excision or destruction of lesion of vagina*) dan 91.4601 (*Microscopic examination of specimen from female genital tract, Microscopic Histopathology examination of specimen from biopsy*)^(IM)
- 5) Dalam proses pengkodean tindakan medis pada MDC ini, sangat penting untuk mencatat secara jelas dan rinci dalam rekam medis mengenai jenis teknik tindakan yang digunakan, apakah dilakukan dengan teknik laparoskopi atau non-laparoskopi. Hal ini dikarenakan sistem iDRG MDC membedakan pengelompokan (*grouping*) pasien berdasarkan teknik prosedur tersebut. Sebagai contoh prosedur 68.61 (*Laparoscopic radical abdominal hysterectomy*) & 68.71 (*Laparoscopic radical vaginal hysterectomy [LRVH]*) merupakan prosedur khusus untuk DC *Laparoscopic Radical Hysterectomy Proc.*

- 6) Jika dokter melakukan pengangkatan kedua ovarium dan tuba falopi pada episode operasi secara bersamaan, gunakan kode 65.61 (*Other removal of both ovaries and tubes at same operative episode*).
- 7) Jika dokter melakukan prosedur laparoskopi untuk mengangkat kedua ovarium dan tuba falopi pada episode operasi secara bersamaan, gunakan kode 65.63 (*Laparoscopic removal of both ovaries and tubes at same operative episode*).

18. **MDC 24 KEHAMILAN, PERSALINAN DAN NIFAS**

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 24

1) Ectopic Pregnancy (O00)

Kode dalam kelompok O08.- (*Complications following abortion and ectopic and molar pregnancy*) digunakan sebagai diagnosis sekunder jika pasien mengalami komplikasi seperti perdarahan berat yang memerlukan transfusi darah (O08.1) atau syok (O08.3).

Jika komplikasi ini menjadi fokus perawatan pada episode kunjungan saat ini, baik terjadi selama episode rawat jalan maupun rawat inap, kode O08.- menjadi diagnosis utama.

Jika kondisi pada kategori O08.- muncul atau terjadi pada asuhan yang sama untuk kehamilan ektopik dan abortusnya (O00-O07), baik pada asuhan rawat inap atau rawat jalan, maka kode primernya adalah kondisi kehamilan ektopik dan abortusnya (O00-O07) dan diikuti kode sekunder O08.- yang sesuai.

Jika pasien dirawat kembali pasca 3 hari setelah tindakan kuretase dengan diagnosis utama, gunakan kode O08.1 dan kode dari O00-O07 tidak boleh ditambahkan.

Kode O00.0 (*Abdominal pregnancy*) hanya digunakan jika dokter memastikan janin telah meninggal, namun jika janin masih hidup, gunakan kode O36.7 (*Maternal care for viable fetus in abdominal pregnancy*).

Jika dokter mendiagnosis kehamilan tuba yang pecah disertai syok, gunakan kode O00.1 (*Tubal pregnancy*) dan tambahkan kode O08.3 (*Shock following abortion and ectopic and molar pregnancy*).

Jika prosedur salpingektomi disertai dengan pengangkatan *tubal pregnancy*, gunakan kode 66.62 (*Salpingectomy with removal of tubal pregnancy*).

Jika dokter melakukan prosedur laparoskopi *oophorectomy* unilateral kemudian dilakukan prosedur *salpingectomy* disertai dengan pengangkatan *tubal pregnancy*, gunakan kode 66.62 (*Salpingectomy with removal of tubal pregnancy*) dan tambahkan kode 65.31 (*Oophorectomy unilateral laparoscopy*).

Contoh 1	Pasien perempuan berusia 25 tahun, mengalami amenore (tidak menstruasi), nyeri perut, pucat, dan tekanan darah rendah. Dokter mendiagnosis kehamilan ektopik disertai syok dan melakukan operasi darurat. Pada pembedahan, ditemukan kehamilan tuba kiri yang ruptur dengan perdarahan di rongga perut sebanyak 1.500 mililiter. Pasien mendapat transfusi 3 unit <i>Packed Red Cells</i> (PRC) dan menjalani reseksi segmental tuba fallopi kiri.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Kehamilan tuba kiri pecah	O00.1 <i>Tubal pregnancy</i>
Diagnosis Sekunder	Pendarahan intraperitoneal	O08.1 <i>Delayed or excessive haemorrhage following abortion and ectopic and molar pregnancy</i>
	Syok	O08.3 <i>Shock following abortion and ectopic and molar pregnancy</i>
Operasi	Reseksi segmental tuba falopi kiri	66.62 <i>Salpingectomy with removal of tubal pregnancy</i>
Prosedur	Prosedur Transfusi PRC 3 unit	99.04 <i>Transfusion of packed cells</i>

Tabel C.52. Contoh kasus *tubal pregnancy*

2) Abortion (O03-O07)

Jika dokter mendiagnosis abortus spontan gunakan kode O03 (*Spontaneous abortion*).

Jika dokter mendiagnosis abortus karena indikasi medis, gunakan kode O04 (*Medical abortion*).

Namun, jika dokter mendiagnosis *threatened abortion*, gunakan kode O20.0 (*Threatened abortion*).

Kode dalam kelompok O03–O06 harus menggunakan 4 digit. Digit keempat menunjukkan kondisi abortus (lengkap/tidak lengkap) serta adanya komplikasi (misal: perdarahan, infeksi, atau syok). Apabila kondisi abortus tidak spesifik, gunakan kode abortus dengan subkategori .9 (*complete or unspecified without complications*).

Tabel C.53. Contoh kasus *abortion*

Contoh 2	Pasien hamil 12 minggu datang dengan keluhan kram perut dan keluar bercak darah dari vagina, dokter mendiagnosis <i>missed abortion</i> dan pasien dirawat untuk menjalani kuretase uterus	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Missed abortion</i>	O02.1 <i>Missed abortion</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Kuret	69.02 <i>Dilation and curettage following delivery or abortion</i>

Tabel C.54. Contoh kasus *abortion*

Contoh 3	Pasien hamil 8 minggu mengalami perdarahan ringan. Dokter mendiagnosis awal sebagai abortus mengancam (<i>threatened abortion</i>) dan pasien dirawat untuk istirahat. Dua hari kemudian, pasien mengalami abortus spontan yang tidak lengkap, sehingga dilakukan kuretase uterus . Diagnosis akhir adalah abortus spontan tidak lengkap .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Aborsi spontan tidak lengkap	O03.4 <i>Spontaneous abortion</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Kuret	69.02 <i>Dilation and curettage following delivery or abortion</i>

Tabel C.55. Contoh kasus *abortion*

Contoh 4	Pasien hamil 8 minggu mengalami perdarahan pervaginam disertai keluarnya jaringan di rumah. Dokter mendiagnosis abortus spontan inkomplit tanpa komplikasi dan pasien dirawat untuk menjalani kuretase uterus guna membersihkan sisa produk konsepsi di dalam rahim.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Aborsi spontan tidak lengkap	O03.4 <i>Spontaneous abortion Incomplete, without complication</i>

Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Kuret	69.02 <i>Dilation and curettage following delivery or abortion</i>

Tabel C.56. Contoh kasus *abortion*

Contoh 5	Pasien hamil 8 minggu mengalami perdarahan pervaginam disertai keluarnya jaringan di rumah. Dokter mendiagnosis sebagai abortus tidak lengkap dan pasien dirawat untuk menjalani kuretase uterus guna membersihkan sisa jaringan konsepsi di dalam rahim.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Aborsi tidak lengkap	O03.4 <i>Incomplete, without complication Spontaneous abortion</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Kuret	69.02 <i>Dilation and curettage following delivery or abortion</i>

Jika pasien dirawat dengan diagnosis awal abortus tak terhindarkan (*inevitable abortion*) dan janin kemudian keluar secara spontan tanpa intervensi medis, kode diagnosis ditentukan berdasarkan hasil akhir, yaitu jika abortus lengkap (O03.5 - O03.9) atau abortus tidak lengkap (O03.0 - O03.4). Namun, jika pada saat perawatan dokter segera melakukan tindakan kuretase uterus tanpa menunggu hasil konsepsi keluar secara spontan, maka diagnosis akhir yang tepat adalah abortus tertunda (*missed abortion*), yaitu kondisi dimana janin telah meninggal di dalam rahim namun belum dikeluarkan oleh tubuh secara alami. Kode diagnosis yang digunakan dalam kasus ini adalah O02.1 (*Missed abortion*).

Tabel C.57. Contoh kasus *abortion*

Contoh 6	Pasien hamil 8 minggu mengalami perdarahan. Dokter mendiagnosis awal sebagai abortus tak terhindarkan (<i>inevitable abortion</i>). Selanjutnya, pasien mengalami abortus spontan lengkap tanpa memerlukan tindakan kuretase uterus.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Aborsi lengkap spontan	O03.9 <i>Spontaneous abortion, complete or unspecified, without complication</i>
Diagnosis Sekunder	-	-

Prosedur	-	-
-----------------	---	---

Tabel C.58. Contoh kasus *abortion*

Contoh 7	Pasien hamil 8 minggu mengalami perdarahan hebat. Dokter mendiagnosis awal sebagai abortus tak terhindarkan (<i>inevitable abortion</i>) dan pasien dirawat untuk menjalani kuretase uterus.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Aborsi yang terlewatkan	O02.1 <i>Missed abortion</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Kuret	69.02 <i>Dilation and curettage following delivery or abortion</i>

Jika dokter mendiagnosis pasien dirawat selama kehamilan dengan riwayat keguguran berulang, maka digunakan kode O26.2 (Pregnancy care of habitual aborter), misalnya pada pasien dengan riwayat abortus habitual yang menjalani perawatan untuk pemantauan kehamilan tanpa disertai komplikasi.

Jika dokter mendiagnosis terjadi abortus sebelum atau selama perawatan, gunakan kode sesuai jenis abortus (misal: O03.- *Spontaneous abortion*) dan tidak perlu kode O26.2 lagi dikarenakan fokus perawatan dilakukan pada abortus yang terjadi saat ini

Tabel C.59. Contoh kasus *abortion*

Contoh 8	Pasien pada kehamilan ke-4, usia 10 minggu, mengalami perdarahan ringan dengan riwayat 3 kali abortus spontan berturut-turut pada trimester pertama. Dokter mendiagnosis awal sebagai abortus habituais disertai abortus mengancam dan pasien dirawat untuk istirahat total. Tiga hari kemudian, pasien mengalami abortus spontan lengkap tanpa memerlukan kuretase uterus	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Aborsi lengkap spontan	O03.9 <i>Spontaneous abortion</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	-	-

Secara umum, kode pada kelompok O08.- (*Complications following abortion and ectopic and molar pregnancy*) digunakan sebagai diagnosis sekunder atau kode penyakit penyerta untuk mengidentifikasi jenis komplikasi yang terjadi akibat abortus, kehamilan ektopik, atau kehamilan mola. Kode utama tetap harus merujuk ke kelompok O00–O07 (misalnya, O03.- *Spontaneous abortion*, O00.- *Ectopic pregnancy*, atau O01.- *Hydatidiform mole*).

Tabel C.60. Contoh kasus *abortion*

Contoh 9	Pasien menjalani tindakan aborsi 2 hari sebelumnya dan datang dengan keluhan nyeri perut hebat. Dokter mendiagnosis perforasi uterus (robekan pada dinding rahim) dan pasien dirawat untuk menjalani histerektomi (pengangkatan rahim)	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Perforasi rahim	O08.6 <i>Damage to pelvic organs and tissues following abortion and ectopic and molar pregnancy</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Histerektomi perut total	68.49 <i>Other and unspecified total abdominal hysterectomy</i>

3) Hypertensive in Pregnancy (O10-O16)

Jika dokter mendiagnosis hipertensi yang telah ada sebelum kehamilan tanpa menyebutkan jenisnya secara spesifik, gunakan kode O10.9 (*Unspecified pre-existing hypertension complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*).

Jika dokter mendiagnosis hipertensi yang telah ada sebelum kehamilan, yang kemudian diperberat dengan munculnya proteinuria pada kehamilan, gunakan kode O11 (*Pre-existing hypertensive disorder with superimposed proteinuria*).

Jika dokter mendiagnosis edema atau proteinuria gestasional tanpa hipertensi, gunakan kode O12.- (*Gestational [pregnancy-induced] oedema and proteinuria without hypertension*).

Jika dokter mendiagnosis hipertensi yang baru muncul pada kehamilan tanpa signifikan proteinuria atau pre-eklampsia ringan, gunakan kode O13 (*Gestational [pregnancy-induced] hypertension without significant proteinuria*).

Jika dokter mendiagnosis pre-eklampsia sedang, gunakan kode O14.0 (*Mild to moderate pre-eclampsia*).

Jika dokter mendiagnosis pre-eklampsia berat, gunakan kode O14.1 (*Severe pre-eclampsia*)

Jika dokter mendiagnosis *HELLP syndrome*, gunakan kode O14.2 (*HELLP syndrome*)

Jika dokter mendiagnosis preeklampsia tidak spesifik, gunakan kode O14.9 (*Pre-eclampsia, unspecified*)

Jika dokter mendiagnosis eklampsia (pre-eklampsia disertai kejang), gunakan kode spesifik, yaitu :

Kode O15.0 (*Eclampsia in pregnancy*) (saat hamil)

Kode O15.1 (*Eclampsia in labour*) (saat persalinan)

Kode O15.2 (*Eclampsia in the puerperium*) (pasca persalinan)

Kode O15.9 (*Eclampsia, unspecified as to time period*)

4) Excessive Vomiting in Pregnancy (O21,-)

Jika dokter mendiagnosis *hyperemesis gravidarum* dengan usia kehamilan kurang dari 22 minggu tanpa adanya gangguan metabolik, gunakan kode O21.0 (*Mild hyperemesis gravidarum*).

Jika dokter mendiagnosis *hyperemesis gravidarum* dengan usia kehamilan kurang dari 22 minggu dengan gangguan metabolik, gunakan kode O21.1 (*Hyperemesis gravidarum with metabolic disturbance*).

Jika dokter mendiagnosis *hyperemesis gravidarum* dengan usia kehamilan lebih dari 22 minggu, gunakan kode O21.2 (*Late vomiting of pregnancy*).

5) Infections in Pregnancy (O23, O41.1, O85, O86, O98)

Jika dokter mendiagnosis infeksi saluran kemih pada kehamilan, gunakan kode pada subkategori O23.- (*Infections of genitourinary tract in pregnancy*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi genital pada kehamilan, gunakan kode O23.5 (*Infections of the genital tract in pregnancy*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi genital pada kehamilan disertai abses bartholin, gunakan kode O23.5 (*Infections of the genital tract in pregnancy*) dan tambahkan kode N75.1 (*Abscess of Bartholin's gland*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi kantung dan selaput amnion pada kehamilan, gunakan kode O41.1 (*Infection of amniotic sac and membranes*).

Jika dokter mendiagnosis sepsis puerperal, gunakan kode O85 (*Puerperal sepsis*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi puerperal lainnya, gunakan kode pada subkategori O86.- (*Other puerperal infections*). Apabila penyebab infeksi diketahui, tambahkan kode dari kelompok B95 – B97 untuk mengidentifikasi penyebab infeksi.

Jika dokter mendiagnosis infeksi atau penyakit akibat parasit selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas, dan memerlukan penanganan obstetri, namun tidak memiliki kode spesifik, gunakan kode pada subkategori O98.- (*Maternal infectious and parasitic disease complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium*) sebagai diagnosis utama, disertai kode diagnosis tambahan untuk mengidentifikasi kondisi spesifik. Pengecualian berlaku untuk:

Z21(*Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status*),

R75 (*Laboratory evidence of human immunodeficiency virus [HIV]*)

A34 (*Obstetrical tetanus*),

O85 (*Puerperal sepsis*),

O86 (*Other puerperal infections*),

O35-O36 (*Maternal care for other known or suspected fetal problems*).

Tabel C.61. Contoh kasus *infection in pregnancy*

Contoh 10	Pasien hamil 20 minggu dengan demam, nyeri punggung, dan diagnosis <i>acute pyelonephritis</i> dari <i>E. coli</i>	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Pielonefritis akut dari <i>E. coli</i> pada kehamilan 20 minggu	O23.0 <i>Infections of kidney in pregnancy</i>
Diagnosis Sekunder		N10 <i>Acute tubulo-interstitial nephritis</i> B96.2 <i>Escherichia coli [E. coli] as the cause of diseases classified to other chapters</i>

Tabel C.62. Contoh kasus *infection in pregnancy*

Contoh 11	Pasien hamil 16 minggu dengan diagnosis pulmonary tuberculosis dan dirawat inap	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Tuberkulosis paru pada kehamilan 16 minggu	O98.0 <i>Tuberculosis complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
Diagnosis Sekunder		A16.2 <i>Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation</i>

Tabel C.63. Contoh kasus *infection in pregnancy*

Contoh 12	Pasien dengan infeksi HIV asimtomatik, kehamilan cukup bulan, melahirkan secara spontan dengan presentasi belakang kepala, dan melahirkan bayi tunggal yang hidup	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Persalinan spontan	O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
Diagnosis Sekunder	Infeksi HIV tanpa gejala	Z21 <i>Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status</i> Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Persalinan normal	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i>

Tabel C.64. Contoh kasus *infection in pregnancy*

Contoh 13	Pasien AIDS, hamil 20 minggu, dokter mendiagnosisnya dengan tuberkulosis paru, dirawat di rumah sakit	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Tuberkulosis paru pada kehamilan 20 minggu	O98.7 <i>Human immunodeficiency [HIV] disease complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV	B20.0 <i>HIV disease resulting in mycobacterial infection</i>

Tabel C.65. Contoh kasus *infection in pregnancy*

Contoh 14	Pasien sedang hamil 28 minggu dan dokter mendiagnosis diare akut	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Diare akut pada kehamilan 28 minggu	O98.8 <i>Other maternal infectious and parasitic diseases complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
Diagnosis Sekunder		A09.0 <i>Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin</i>

6) Diabetes Mellitus in Pregnancy (O24)

Jika dokter mendiagnosis diabetes sebelum kehamilan, maka pengkodean disesuaikan dengan jenis diabetesnya, yakni gunakan kode O24.0 untuk diabetes tipe 1 (*insulin-dependent*) dan O24.1 untuk diabetes tipe 2 (*non-insulin-dependent*). Apabila jenis diabetes yang disebutkan tidak spesifik, gunakan kode O24.3 (*pre-existing diabetes mellitus, unspecified*). Dalam kasus di mana pasien memiliki diabetes tipe 2 sebelum hamil dan tidak menggunakan insulin, tetapi kemudian memerlukan insulin selama kehamilan, tetap gunakan kode O24.1, karena jenis diabetesnya tidak berubah. Sementara itu, jika diabetes baru terdiagnosis selama masa kehamilan (*gestational diabetes*), gunakan kode O24.4 (*diabetes mellitus arising in pregnancy*).

Jika dokter mendiagnosis diabetes yang tidak dapat dipastikan sebelum kehamilan maupun yang baru ditemukan selama kehamilan, gunakan kode O24.9 (*diabetes mellitus in pregnancy, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis diabetes gestasional dengan hasil GCT positif, gunakan kode O28.8 (*abnormal findings on antenatal screening*).

7) Maternal Care for Known or Suspected Malpresentation of Fetus (O32,-)

Jika dokter mendiagnosis malpresentasi janin sebagai alasan rawat inap atau dasar pengambilan keputusan operasi sesar sebelum onset persalinan, gunakan kode O32.- (*Maternal care for known or suspected malpresentation of fetus*).

Jika dokter mendiagnosis malpresentasi yang menyebabkan *obstructed labour* (persalinan tersumbat) setelah persalinan dimulai, maka digunakan kode O64.- (*Obstructed labour due to malpresentation*). Namun, apabila dokter tidak mencantumkan adanya *obstructed labour*, maka kode O32.- tetap digunakan sebagai diagnosis utama.

Tabel C.66. Contoh kasus *maternal care for known or susp malpresentation of fetus*

Contoh 15	Pasien hamil 39 minggu datang ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan <i>elective sectio caesarea</i> . Hasil pemeriksaan obstetri (Leopold I, II, III, dan IV) dan hasil USG menunjukkan presentasi bokong. Dokter mendiagnosis presentasi bokong pada kehamilan 39 minggu dan dilakukan tindakan <i>low cervical cesarean section</i> . Bayi lahir hidup dengan berat 3.400 gram, dalam keadaan sehat dan tidak ada komplikasi.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Presentasi bokong sungsang pada kehamilan 39 minggu	O32.1 <i>Maternal care for breech presentation</i>

Diagnosis Sekunder		O82.0 <i>Delivery by elective caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Operasi caesar melintang rendah elektif <i>Low cervical cesarean section</i>	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

Tabel C.67. Contoh kasus *maternal care for known or susp malpresentation of fetus*

Contoh 16	Pasien hamil 39 minggu, datang dengan nyeri persalinan dari rumah. Dokter menemukan presentasi bokong janin (malpresentasi) dan terindikasi obstruksi persalinan maka dokter memutuskan untuk melakukan operasi sesar darurat transversal rendah (<i>emergency low transverse cesarean section</i>). Bayi lahir hidup dengan berat 3.400 gram, dalam keadaan sehat dan tidak ada komplikasi	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Presentasi sungsang pada kehamilan 39 minggu	O64.1 <i>Obstructed labour due to breech presentation</i>
Diagnosis Sekunder		O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Operasi caesar melintang rendah elektif	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

8) **Maternal Care for Known or Suspected Disproportion (O33.-, O64-O66)**

Jika dokter mendiagnosis adanya ketidaksesuaian (*disproportion*) sebagai alasan utama dilakukan intervensi medis, seperti operasi sesar, gunakan kode O33.- (*Maternal care for known or suspected disproportion*).

Jika dokter mendiagnosis CPD, gunakan kode O33.-.

Jika dokter mendiagnosis *obstructed labour* pada pasien hamil dengan CPD , gunakan kode O65 .-

Jika dokter mendiagnosis *obstructed labour*, gunakan kode dalam kelompok O64.- (*Obstructed labour due to malposition and malpresentation of fetus*), O65.- (*Obstructed labour due to maternal pelvic abnormality*), atau O66.- (*Other obstructed labour*) sesuai penyebab yang dicantumkan dokter.

Jika dokter mendiagnosis *cephalopelvic disproportion* (CPD), gunakan kode O33.9 (*Maternal care for disproportion, unspecified*). Jika dokter hanya mencantumkan "CPD", gunakan O33.9 (bukan kode O64-O66).

Tabel C.68. Contoh kasus *maternal care for known or suspected disproportion*

Contoh 17	Pasien hamil cukup bulan, dokter mendiagnosis panggul sempit dan menjadwalkan untuk operasi sesar transversal rendah (<i>low transverse caesarean section</i>). Bayi tunggal lahir hidup.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Panggul sempit	O33.1 <i>Maternal care for disproportion due to generally contracted pelvis</i>
Diagnosis Sekunder	-	O82.0 <i>Delivery by elective caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Operasi caesar melintang rendah elektif	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

Tabel C.69. Contoh kasus *maternal care for known or suspected disproportion*

Contoh 18	Pasien hamil cukup bulan, mengalami nyeri persalinan selama 12 jam dan belum masuk inpartu. Dokter mendiagnosis <i>cephalopelvic disproportion</i> dan dilakukan operasi <i>low cervical caesarean section</i> . Bayi tunggal lahir hidup.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Disproporsi cephalopelvic	O65.4 <i>Obstructed labour due to fetopelvic disproportion, unspecified</i>
Diagnosis Sekunder	-	O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>

Operasi	<i>Low cervical cesarean section</i>	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>
----------------	--------------------------------------	---

Tabel C.70. Contoh kasus *maternal care for known or suspected disproportion*

Contoh 19	Pasien hamil cukup bulan, mengalami nyeri persalinan selama 12 jam. Dokter mendiagnosis <i>obstructed labor due to cephalopelvic disproportion</i> (persalinan tersumbat akibat ketidaksesuaian antara kepala janin dan panggul ibu) dan melakukan operasi sesar darurat transversal rendah (<i>low transverse cesarean section</i>). Bayi tunggal lahir hidup.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Persalinan terhambat karena disproporsi cephalopelvic pada kehamilan cukup bulan	O65.4 <i>Obstructed labour due to fetopelvic disproportion, unspecified</i>
Diagnosis Sekunder		O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>
Prosedur	Operasi caesar melintang rendah darurat	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

Tabel C.71. Contoh kasus *maternal care for known or suspected disproportion*

Contoh 20	Pasien hamil cukup bulan, pembukaan serviks mencapai 7 cm tetapi tidak mengalami pembukaan lebih lanjut selama lebih dari 2 jam. Dokter mendiagnosis <i>secondary arrest of dilatation</i> (penghentian sekunder pembukaan serviks) dan melakukan operasi sesar darurat transversal rendah (<i>low transverse caesarean section</i>). Bayi tunggal lahir hidup.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Penangkapan sekunder dilatasi pada kehamilan cukup bulan	O66.9 <i>Obstructed labour, unspecified</i>
Diagnosis Sekunder		O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Operasi caesar melintang rendah darurat	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

9) Maternal Care for Tumour of Corpus Uteri (O34.1)

Jika dokter mendiagnosis bahwa wanita hamil memiliki mioma uteri, gunakan kode O34.1 (*Maternal care for tumour of corpus uteri*) dan tambahkan kode D25.- (*Leiomyoma of uterus*) sebagai diagnosis tambahan.

Jika dokter mendiagnosis mioma uteri yang menyebabkan persalinan tersumbat, gunakan kode O65.5 (*Obstructed labour due to abnormality of maternal pelvic organs*) dan tambahkan kode D25.- (*Leiomyoma of uterus*) sebagai diagnosis tambahan.

Tabel C.72. Contoh kasus *maternal care for tumour of corpus uteri*

Contoh 21	Pasien hamil 30 minggu, mengeluh nyeri perut. Dokter menemukan adanya mioma intramural berukuran 5 cm di daerah fundus uteri dan mendiagnosis sebagai degenerated myoma uteri (mioma uteri yang mengalami degenerasi). Pasien diberikan pengobatan simptomatik dan dipulangkan tanpa persalinan.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Mioma intramural yang merosot pada Kehamilan 30 minggu	O34.1 <i>Maternal care for tumour of corpus uteri</i>
Diagnosis Sekunder		D25.1 <i>Intramural leiomyoma of uterus</i>

Tabel C.73. Contoh kasus *maternal care for tumour of corpus uteri*

Contoh 22	Pasien hamil cukup bulan, mengalami nyeri persalinan. Dokter menemukan mioma intramural berukuran besar di bagian bawah rahim yang menyebabkan janin tidak dapat turun ke jalan lahir. Diagnosis ditegakkan sebagai <i>obstructed labour due to large intramural myoma</i> (persalinan tersumbat akibat mioma intramural besar). Dilakukan operasi sesar darurat (<i>emergency caesarean section</i>), dan bayi tunggal lahir hidup.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Persalinan terhambat karena mioma intramural yang besar pada kehamilan cukup bulan	O65.5 <i>Obstructed labour due to abnormality of maternal pelvic organs</i>
Diagnosis Sekunder		D25.1 <i>Intramural leiomyoma of uterus</i>
		O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>

		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Operasi sesar melintang rendah darurat <i>Low cervical cesarean section</i>	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

10) Maternal Care for Other Abnormalities of Cervix (O34.4)

Tabel C.74. Contoh kasus *maternal care for other abnormalities of cervix*

Contoh 23	Pasien dengan diagnosis karsinoma sel skuamosa serviks stadium IB1 pada usia kehamilan 32 minggu direncanakan tindakan operasi sesar. Dokter melakukan operasi sesar dan histerektomi radikal elektif dengan limfadenektomi panggul pada usia kehamilan 34 minggu, bayi tunggal lahir hidup.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Karsinoma sel skuamosa serviks stadium IB1	O34.4 <i>Maternal care for other abnormalities of cervix</i>
Diagnosis Sekunder	Persalinan prematur	C53.1 <i>Exocervix</i>
		O82.2 <i>Delivery by caesarean hysterectomy</i>
		O60.3 <i>Preterm delivery without spontaneous labour</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Histerektomi caesarean radikal dengan limfadenektomi panggul	74.4 <i>Cesarean section of other specified type</i>
		68.69 <i>Other and unspecified radical abdominal hysterectomy</i>
		40.3 <i>Regional lymph node excision</i>
ICD-O	Karsinoma sel skuamosa	M8070/3 <i>Squamous cell carcinoma NOS</i>

11) **Premature Rupture of Membranes (O42.-)**

Kode dalam kelompok O42 (*Premature rupture of membranes*) dibagi menjadi sub-kategori 4 digit berdasarkan durasi waktu antara ketuban pecah hingga mulainya kontraksi persalinan.

Kode dalam kelompok O42 dibagi berdasarkan waktu antara pecahnya ketuban hingga onset persalinan:

Jika dokter mendiagnosis ketuban pecah dini dengan onset persalinan terjadi dalam waktu ≤ 24 jam sejak ketuban pecah, gunakan kode O42.0 (*Premature rupture of membranes, onset of labour within 24 hours*).

Jika dokter mendiagnosis ketuban pecah dini dengan onset persalinan >24 jam, gunakan kode O42.1 (*Premature rupture of membranes, onset of labour after 24 hours*).

Jika dokter mendiagnosis bahwa ketuban pecah sebelum kontraksi dimulai, dan dokter memberikan tatalaksana sehingga pasien dapat pulang tanpa melahirkan, gunakan kode O42.2 (*Premature rupture of membranes, labour delayed by therapy*).

Jika dokter mendiagnosis ketuban pecah dini tidak spesifik, gunakan kode O42.9 (*Premature rupture of membranes, unspecified*).

12) **False Labour (O47.-)**

Jika dokter mendiagnosis *false labour* pada kehamilan kurang dari 37 minggu, gunakan kode O47.0 (*False labour before 37 completed weeks of gestation*).

Jika dokter mendiagnosis *false labour* pada kehamilan lebih dari 37 minggu, gunakan kode O47.1 (*False labour at or after 37 completed weeks of gestation*).

13) **Preterm Labour and Delivery (O60.-)**

Jika dokter mendiagnosis tanda persalinan premature pada ibu hamil kurang dari 37 minggu tanpa melahirkan, gunakan kode O60.0 (*Preterm spontaneous labour without delivery*).

Jika dokter mendiagnosis tanda persalinan premature pada ibu hamil kurang dari 37 minggu dan melahirkan sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu, gunakan kode O60.1 (*Preterm labour with preterm delivery*).

Jika dokter mendiagnosis tanda persalinan premature pada ibu hamil kurang dari 37 minggu dan melahirkan pada usia cukup bulan, gunakan kode O60.2 (*Preterm spontaneous labour with term delivery*).

Jika dokter mendiagnosis persalinan pada kehamilan kurang dari 37 minggu tanpa tanda persalinan prematur gunakan kode O60.3 (*Preterm delivery without spontaneous labour*).

Tabel C.75. Contoh kasus *Preterm Labour and Delivery*

Contoh 24	Pasien hamil 32 minggu merasakan kontraksi teratur Dokter mendiagnosis <i>preterm labour</i> (persalinan prematur) dan memberikan obat untuk menekan kontraksi rahim hingga rasa sakit persalinan hilang. Pasien kemudian dipulangkan ke rumah tanpa melahirkan.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Persalinan prematur tanpa melahirkan	O60.0 <i>Preterm spontaneous labour without delivery</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	-	-

Tabel C.76. Contoh kasus *Preterm Labour and Delivery*

Contoh 25	Pasien hamil 32 minggu merasakan mengalami rasa kontraksi teratur. Dokter mendiagnosis <i>preterm labour</i> (persalinan prematur) dan memberikan obat untuk menekan kontraksi rahim, namun tidak berhasil. Dua hari kemudian, pasien melahirkan secara spontan presentasi kepala dilakukan episiotomi, bayi tunggal hidup.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Persalinan prematur secara spontan dengan presentasi kepala	O60.1 <i>Preterm labour with preterm delivery</i>
Diagnosis Sekunder		O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Persalinan normal dengan episiotomi	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i>

Tabel C.77. Contoh kasus *Preterm Labour and Delivery*

Contoh 26	Pasien hamil 36 minggu merasakan kontraksi teratur dan melahirkan secara spontan pada usia kehamilan cukup bulan dengan presentasi kepala dan dilakukan episiotomi, bayi tunggal hidup.
------------------	---

	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Persalinan cukup bulan dengan	O60.2 <i>Preterm spontaneous labour with term delivery</i>
Diagnosis Sekunder	-	O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Persalinan normal dengan episiotomi	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i>

Tabel C.78. Contoh kasus *Preterm Labour and Delivery*

Contoh 27	Pasien hamil 35 minggu, dokter mendiagnosis <i>oligohydramnios</i> (cairan ketuban kurang) dan dilakukan operasi caesar dengan teknik <i>low transverse caesarean section</i> , mendapatkan bayi tunggal hidup	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Oligohidramnios</i>	O41.0 <i>Oligohydramnios</i>
Diagnosis Sekunder	Persalinan prematur	O60.3 <i>Preterm delivery without spontaneous labour</i>
		O82.0 <i>Delivery by elective caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Operasi	Operasi caesar melintang rendah elektif	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

14) **Intrapartum Haemorrhage , Postpartum Haemorrhage (O67.- , O72.-)**

Jika dokter mendiagnosis *persalinan dengan komplikasi Intrapartum haemorrhage* gunakan kode dalam kelompok O67.- (*Labour and delivery complicated by intrapartum haemorrhage, not elsewhere classified*).

Jika dokter mendiagnosis pendarahan intrapartum karena Abruption placentae, gunakan kode dalam kelompok O45.- (*Premature separation of placenta [abruption placentae]*).

Jika dokter mendiagnosis pendarahan intrapartum karena defect coagulation, gunakan kode O46.0 (*Antepartum haemorrhage with coagulation defect*).

Jika dokter mendiagnosis *postpartum haemorrhage*, gunakan kode dalam kelompok O72.- (*Postpartum haemorrhage*).

Jika dokter mendiagnosis perdarahan yang disebabkan oleh *retained, trapped or adherent placenta*, gunakan kode O72.0 (*Third-stage haemorrhage*).

Jika dokter mendiagnosis perdarahan yang disebabkan oleh placenta accreta, gunakan kode O72.0 (*Third-stage haemorrhage*) dan tambahkan kode O43.2 (*Morbidly adherent placenta*) untuk mengidentifikasi adanya perlengketan plasenta.

Jika dokter mendiagnosis perdarahan segera setelah plasenta keluar terutama yang disebabkan oleh atonia uteri (rahim tidak berkontraksi dengan baik), atau *postpartum haemorrhage* yang tidak spesifik gunakan kode O72.1 (*Other immediate postpartum haemorrhage*).

Jika dokter mendiagnosis *late postpartum haemorrhage*, yang sering disebabkan oleh sisa plasenta atau membran ketuban yang tertinggal di dalam rongga rahim, gunakan kode O72.2 (*Delayed and secondary postpartum haemorrhage*).

Jika dokter mendiagnosis bahwa perdarahan postpartum disebabkan oleh gangguan pembekuan darah, gunakan kode O72.3 (*Postpartum coagulation defect*).

15) *Labour and delivery complicated by fetal stress [distress] (O68.-)*

Jika dokter mendiagnosis adanya *fetal distress* sebagai penyulit persalinan gunakan kode dalam kelompok O68.- (*Labour and delivery complicated by fetal stress [distress]*).

Jika dokter mendiagnosis fetal distress dengan penyebab yang tidak spesifik gunakan kode O68.9 (*Labour and delivery complicated by fetal stress, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis *non-reassuring fetal status*, gunakan kode O68.8 (*Labour and delivery complicated by other evidence of fetal stress*).

Tabel C.79. Contoh kasus *Labour and delivery complicated by fetal stress [distress]*

Contoh 28	Pasien hamil anak kedua cukup bulan dengan riwayat operasi caesar pada kehamilan sebelumnya. Pada kehamilan ini, pasien melahirkan dengan bantuan <i>low forceps</i> dan dilakukan episiotomi. Dokter mencatat indikasi sebagai <i>fetal distress</i> , bayi tunggal hidup presentasi kepala.
------------------	---

	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Fetal distress pada P2A0 hamil aterm janin presentasi kepala tunggal hidup dengan riwayat SC sebelumnya	O68.9 <i>Labour and delivery complicated by fetal stress, unspecified</i>
Diagnosis Sekunder		O75.7 <i>Vaginal delivery following previous caesarean section</i>
		O81.0 <i>Low forceps delivery</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Ekstraksi forsep rendah dengan episiotomi	72.1 <i>Low forceps operation with episiotomy</i>

16) *Perineal and Vaginal Laceration during Delivery, Obstetric high vaginal laceration alone (O70.-, O71.4)*

Jika dokter mendiagnosis laserasi perineum saat persalinan, tanpa episiotomi atau sebagai tambahan dari episiotomi, gunakan kode dalam kelompok O70.- (*Perineal laceration during delivery*) sesuai dengan kode derajatnya.

Jika dokter mendiagnosis laserasi dinding vagina tanpa adanya laserasi perineum gunakan kode O71.4 (*Obstetric high vaginal laceration alone*).

17) *Delivery (O80-O84)*

Gunakan kode hasil persalinan dalam kelompok Z37.- (*Outcome of delivery*) sebagai kode diagnosis sekunder untuk semua pasien yang melahirkan. Kode dalam kelompok ini tidak boleh digunakan sebagai kode diagnosis utama dalam situasi apa pun. Bahkan jika dokter tidak mencatat hasil persalinan dalam resume medis (ringkasan pulang), adalah tanggung jawab pengode untuk mencari informasi hasil persalinan dari bagian lain rekam medis, seperti catatan persalinan atau ringkasan persalinan.

Jika dokter mendiagnosis persalinan normal tanpa komplikasi, gunakan kode dalam kelompok (O80 - O84).

Jika dokter mendiagnosis persalinan gemeli, gunakan kode dalam kelompok O84.- (*Multiple delivery*).

Tabel C.80. Contoh kasus *Delivery*

Contoh 29	Pasien hamil anak pertama cukup bulan dengan keluhan ketuban pecah < 24 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien melahirkan bayi tunggal hidup
------------------	---

	dengan presentasi kepala secara spontan dilakukan episiotomy secara spontan presentasi kepala dilakukan episiotomy,	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	P1A0 Hamil aterm janin presentasi kepala tunggal hidup dengan KPD <24 Jam	O42.0 <i>Premature rupture of membranes, onset of labour within 24 hours</i>
Diagnosis Sekunder		O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Persalinan normal dengan episiotomi	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i> 73.6 <i>Episiotomy</i>

Tabel C.81. Contoh kasus *Delivery*

Contoh 30	Pasien hamil anak pertama cukup bulan lahir spontan tunggal hidup presentasi kepala dengan diabetes gestasional dilakukan episiotomi,	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	P1A0 Hamil aterm Janin Presentasi Kepala tunggal hidup	O24.4 <i>Diabetes mellitus arising in pregnancy</i>
Diagnosis Sekunder	Diabetes gestasional	O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Persalinan normal dengan episiotomi	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i> 73.6 <i>Episiotomy</i>

Tabel C.82. Contoh kasus *Delivery*

Contoh 31	Pasien hamil anak pertama cukup bulan lahir spontan tunggal hidup presentasi kepala melahirkan bayi tunggal hidup mengalami perdarahan postpartum 600 mililiter akibat atonia uteri (rahim tidak berkontraksi dengan baik).
------------------	---

	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Perdarahan postpartum ec atonia uteri pada P1A0 hamil aterm janin presentasi kepala tunggal hidup	O72.1 <i>Other immediate postpartum haemorrhage</i>
Diagnosis Sekunder		O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Komplikasi		-
Prosedur	Persalinan normal dengan episiotomi	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i> 73.6 Episiotomy

18) **Caesarean section (O82.-)**

Jika dokter merencanakan sectio caesarea atas indikasi *previous caesarean section* atau *previous uterine scar*, gunakan kode O34.2 (*Maternal care due to uterine scar from previous surgery*) dan tambahkan kode untuk seksio sesarea elektif O82.0 (*Delivery by elective caesarean section*) serta kode outcome of delivery Z37.- (*Outcome of delivery*).

Jika dokter melakukan sectio caesarea darurat atas indikasi caesarean section atau previous uterine scar, gunakan kode O34.2 (*Maternal care due to uterine scar from previous surgery*) dan tambahkan kode O82.1 (*Delivery by emergency caesarean section*) serta kode outcome of delivery Z37.- (*Outcome of delivery*).

Jika dokter mendiagnosis *elective caesarean section* tanpa menyebutkan diagnosis sekunder atau komplikasi lain, gunakan kode O82.0 (*Delivery by elective caesarean section*).

Tabel C.83. Contoh kasus *Caesarean section*

Contoh 32	Pasien hamil anak kedua cukup bulan dengan riwayat SC satu kali r bekas luka SC dan dijadwalkan menjalani operasi SC dengan teknik <i>low transverse caesarean section</i> , melahirkan bayi tunggal hidup	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode

Diagnosis Utama	P2A0 hamil aterm janin presentasi kepala tunggal hidup dengan riwayat SC sebelumnya	O34.2 <i>Maternal care due to uterine scar from previous surgery</i>
Diagnosis Sekunder		O82.0 <i>Delivery by elective caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Operasi caesar melintang rendah elektif	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

Tabel C.84. Contoh kasus *Caesarean section*

Contoh 33	Pasien hamil anak pertama cukup bulan mengalami perdarahan dikarenakan placenta previa. Pasien kemudian menjalani operasi caesar darurat dengan teknik <i>low transverse caesarean section</i> , melahirkan bayi tunggal hidup.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Perdarahan <i>antepartum ec placenta previa</i> pada P1A0 hamil aterm janin presentasi kepala janin tunggal hidup	O44.1 <i>Placenta praevia with haemorrhage</i>
Diagnosis Sekunder		O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Operasi caesar melintang rendah darurat	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

19) *Maternal Diseases Classifiable Elsewhere but Complicating Pregnancy, Childbirth and The Puerperium (O98.-,O99.-)*

Kategori O98.- merupakan penyakit infeksi dan parasit maternal yang terklasifikasi di bab lain (di luar Bab XV) tetapi menjadi komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Kondisi yang termasuk dalam kategori O98.-, ketika menjadi komplikasi kehamilan, diperburuk oleh kehamilan, atau menjadi alasan pelayanan obstetri. Gunakan kode tambahan (Bab I), jika diperlukan untuk mengidentifikasi kondisi spesifik.

Kategori O99.- merupakan penyakit maternal lainnya yang telah diklasifikasikan di bab lain (di luar Bab XV) tetapi menjadi komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Kategori O99.- mencakup kondisi yang menjadi komplikasi kehamilan, diperburuk oleh kehamilan, atau menjadi alasan utama pelayanan obstetri dan untuk kondisi tersebut pada Indeks Alfabetik tidak menunjukkan kode spesifik di Bab XV. Gunakan kode tambahan, jika diperlukan untuk mengidentifikasi kondisi spesifik. Sebagai contoh, pada kode O99.0 (*Anaemia complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*) dapat ditambahkan kode pada kelompok D50-D64 untuk mengidentifikasi kondisi spesifik.

b. Perhatian khusus pada kode eksklusi O99.- (*Other maternal diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*):

- 1) Penyakit menular dan parasit (O98.-)
- 2) Cedera, keracunan dan konsekuensi tertentu lainnya dari penyebab eksternal (S00-T98)
- 3) Ketika alasan perawatan ibu adalah karena kondisi tersebut diketahui atau diduga telah mempengaruhi janin (O35-O36)

sehingga untuk kondisi eksklusi tersebut tidak menggunakan kode O99 melainkan menggunakan kode sesuai kriteria eksklusi. Status kehamilan dapat ditambahkan kode Z32.- (*Pregnancy examination and test*) atau Z33 (*Pregnant state, incidental*) untuk mengidentifikasi kehamilan.

c. Perhatian khusus pada kode eksklusi dalam kategori O99.-. Sebagai contoh, kode O99.1 (*Other diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*) memiliki kondisi eksklusi untuk hemoragik dengan koagulasi defek (O46.0, O67.0, O72.3).

Jika dokter mendiagnosis toksoplasmosis pada pasien hamil, gunakan kode O98.6 (*Protozoal diseases complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*) dan tambahan kode opsional B58.9 (*Toxoplasmosis, unspecified*) untuk mengidentifikasi organisme penyebab secara spesifik.

Pada kode O99.0 (*Anaemia complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*), gunakan kode tambahan D50-D64 untuk mengidentifikasi kondisi spesifik.

Tabel C.85. Contoh kasus *Maternal Diseases Classifiable Elsewhere but Complicating Pregnancy, Childbirth and The Puerperium*

Contoh 34	Pasien hamil 12 minggu membutuhkan perawatan untuk didiagnosis dengan penyakit anemia defisiensi besi (<i>iron deficiency anaemia</i>). Dokter mendiagnosis anemia defisiensi besi (<i>iron deficiency anaemia</i>) pada ibu hamil. hemoglobin H (hemoglobin H disease) Selama perawatan, pasien diberikan tatalaksana dan terapi anemia defisiensi besi.
------------------	---

	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Anemia defisiensi besi	O99.0 <i>Anaemia complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan 12 minggu	D50.9 <i>Iron deficiency anaemia, unspecified</i>

Tabel C.86. Contoh kasus *Maternal Diseases Classifiable Elsewhere but Complicating Pregnancy, Childbirth and The Puerperium*

Contoh 35	Pasien hamil 10 minggu membutuhkan perawatan untuk didiagnosis dengan penyakit <i>Alpha thalassaemia</i> . Dokter mendiagnosis Alpha Thalassaemia pada ibu hamil. hemoglobin H (hemoglobin H disease) Selama perawatan, pasien diberikan tatalaksana dan terapi <i>Alpha thalassaemia</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Penyakit <i>Alpha thalassaemia</i>	O99.0 <i>Anaemia complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan 10 minggu	D56.0 <i>Alpha thalassaemia</i>

Tabel C.87. Contoh kasus *Maternal Diseases Classifiable Elsewhere but Complicating Pregnancy, Childbirth and The Puerperium*

Contoh 36	Pasien hamil usia 28 minggu datang ke poliklinik kebidanan dengan keluhan terdapat benjolan di bibir vagina akibat penyumbatan kelenjar Bartholin. Pasien merasa sedikit tidak nyaman saat berjalan, namun tidak mengeluhkan nyeri hebat. Tidak ada demam maupun keputihan.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Komplikasi kehamilan	O99.8 <i>Other specified diseases and conditions complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
Diagnosis Sekunder	Kista Bartholin	N75.0 <i>Cyst of Bartholin's gland</i>

Tabel C.88. Contoh kasus *Maternal Diseases Classifiable Elsewhere but Complicating Pregnancy, Childbirth and The Puerperium*

Contoh 37	Pasien hamil 34 minggu mengalami cedera di rumah karena tangannya terjepit pintu. Dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami <i>fracture of first metacarpal bone</i> (patah tulang metakarpal pertama).	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Fraktur tulang metakarpal pertama	S62.20 <i>Closed fracture of first metacarpal bone</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan 34 minggu	Z33 <i>Pregnant state, incidental</i> Z32.1 <i>Pregnancy confirmed</i>
Penyebab Eksternal	Terjepit oleh pintu di rumah.	W23.09 <i>Caught, crushed, jammed or pinched in or between objects</i>

1) Solusi Unacceptable obs. diag. comb. 0-12 pada MDC 24

Pada pengodean untuk MDC 24, terdapat beberapa kombinasi kode yang tidak sesuai dengan kaidah atau tidak dapat diterima sebagai koding diagnosis. Hal ini dikarenakan karakteristik diagnosis, prosedur atau intervensi yang harus spesifik terhadap kelompok ini. Kode-kode yang tidak dapat diterima tersebut umumnya sebagai berikut:

Unacceptable obs. diag. comb. 0

Persalinan harus selalu dikodekan *outcomenya* kelompok kode Z37.- sesuai dengan kelahiran bayi. jika tidak dikode, maka akan terjadi error.

Unacceptable obs. diag. comb. 1

Kelompok diagnosis *Delivery & Outcome* berikut tidak dapat digunakan sebagai diagnosis utama jika terdapat diagnosis penyulit persalinan. Menggunakan salah satu dari kode ini sebagai diagnosis utama dan penyulit persalinan menjadi diagnosis sekunder atau tambahan maka akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652119 Unacceptable obs. diag. comb. 1. Sebagai contoh, apabila ada pasien dengan persalinan normal dengan komplikasi lalu di dalam resume medis tertulis O80 sebagai diagnosis utama, O24 sebagai diagnosis sekunder, dan Z37.0 maka akan tertolak oleh sistem karena kode tersebut tidak mewakili kondisi klinis yang menyebabkan rawat inap.

Delivery & Outcome

O80.0	<i>Spontaneous vertex delivery</i>	O83.8	<i>Other specified assisted single delivery</i>
O80.1	<i>Spontaneous breech delivery</i>	O83.9	<i>Assisted single delivery, unspecified</i>
O80.8	<i>Other single spontaneous delivery</i>	O84.0	<i>Multiple delivery, all spontaneous</i>
O80.9	<i>Single spontaneous delivery, unspecified</i>	O84.1	<i>Multiple delivery, all by forceps and vacuum extractor</i>
O81.0	<i>Low forceps delivery</i>	O84.8	<i>Other multiple delivery</i>
O81.1	<i>Mid-cavity forceps delivery</i>	O84.9	<i>Multiple delivery, unspecified</i>
O81.2	<i>Mid-cavity forceps with rotation</i>	Z37.0	<i>Single live birth</i>
O81.3	<i>Other and unspecified forceps delivery</i>	Z37.1	<i>Single stillbirth</i>
O81.4	<i>Vacuum extractor delivery</i>	Z37.2	<i>Twins, both liveborn</i>
O81.5	<i>Delivery by combination of forceps and vacuum extractor</i>	Z37.3	<i>Twins, one liveborn and one stillborn</i>
O83.0	<i>Breech extraction</i>	Z37.4	<i>Twins, both stillborn</i>
O83.1	<i>Other assisted breech delivery</i>	Z37.5	<i>Other multiple births, all liveborn</i>
O83.2	<i>Other manipulation-assisted delivery</i>	Z37.6	<i>Other multiple births, some liveborn</i>
O83.3	<i>Delivery of viable fetus in abdominal pregnancy</i>	Z37.7	<i>Other multiple births, all stillborn</i>
O83.4	<i>Destructive operation for delivery</i>	Z37.9	<i>Outcome of delivery, unspecified</i>

Unacceptable obs. diag. comb. 2

Diagnosis berikut (*Delivery & Outcome*) tidak dapat digunakan sebagai diagnosis utama karena berkaitan langsung dengan proses persalinan atau hasil persalinan yang harus dikodekan sebagai bagian dari sekunder atau tambahan, bukan sebagai penyebab utama rawat inap atau perawatan medis. Menggunakan salah satu dari kode ini sebagai diagnosis utama akan mengakibatkan error dalam pengajuan

klaim sebagai group 3652119 Unacceptable obs. diag. comb. 1. Sebagai contoh, apabila ada pasien dengan persalinan normal tanpa komplikasi lalu di dalam resume medis tertulis diagnosa O80 dan Z37.0 maka akan tertolak oleh sistem karena kode tersebut tidak mewakili kondisi klinis yang menyebabkan rawat inap

Delivery & Outcome

O80.0	<i>Spontaneous vertex delivery</i>	O83.1	<i>Other assisted breech delivery</i>
O80.1	<i>Spontaneous breech delivery</i>	O83.2	<i>Other manipulation-assisted delivery</i>
O80.8	<i>Other single spontaneous delivery</i>	O83.3	<i>Delivery of viable fetus in abdominal pregnancy</i>
O80.9	<i>Single spontaneous delivery, unspecified</i>	O83.4	<i>Destructive operation for delivery</i>
O81.0	<i>Low forceps delivery</i>	O83.8	<i>Other specified assisted single delivery</i>
O81.1	<i>Mid-cavity forceps delivery</i>	O83.9	<i>Assisted single delivery, unspecified</i>
O81.2	<i>Mid-cavity forceps with rotation</i>	O84.0	<i>Multiple delivery, all spontaneous</i>
O81.3	<i>Other and unspecified forceps delivery</i>	O84.1	<i>Multiple delivery, all by forceps and vacuum extractor</i>
O81.4	<i>Vacuum extractor delivery</i>	O84.2	<i>Multiple delivery, all by cesarean section</i>
O81.5	<i>Delivery by combination of forceps and vacuum extractor</i>	O84.8	<i>Other multiple delivery</i>
O82.0	<i>Delivery by elective cesarean section</i>	O84.9	<i>Multiple delivery, unspecified</i>
O82.1	<i>Delivery by emergency cesarean section</i>	Z37.0	<i>Single live birth</i>
O82.2	<i>Delivery by cesarean hysterectomy</i>	Z37.1	<i>Single stillbirth</i>
O82.8	<i>Other single delivery by cesarean section</i>	Z37.2	<i>Twins, both liveborn</i>
O82.9	<i>Delivery by cesarean section, unspecified</i>	Z37.3	<i>Twins, one liveborn and one stillborn</i>
O83.0	<i>Breech extraction</i>	Z37.4	<i>Twins, both stillborn</i>

Z37.5 *Other multiple births, all liveborn*

Z37.6 *Other multiple births, some liveborn*

Z37.7 *Other multiple births, all stillborn*

Z37.9 *Outcome of delivery, unspecified*

Unacceptable obs. diag. comb. 3

Kebalikan dari Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 2, jika terdapat kode diagnosis *Delivery by Caesarean Section* tetapi tidak ada kode tindakan *Caesarean Section* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652319 Unacceptable obs. diag. comb. 3

Unacceptable obs. diag. comb. 4

Jika terdapat *multiple delivery* dengan kombinasi cara bersalin tetapi kode O84.8 *Other multiple delivery* tidak di kodekan, akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652419 Unacceptable obs. diag. comb. 4.

Delivery by Caesarean Section

O82.0 *Delivery by elective caesarean section*

O82.1 *Delivery by emergency caesarean section*

O82.2 *Delivery by caesarean hysterectomy*

O82.8 *Other single delivery by caesarean section*

O82.9 *Delivery by caesarean section, unspecified*

O84.2 *Multiple delivery, all by caesarean section*

Other Multiple Delivery

O84.8 *Other multiple delivery*

Vaginal Delivery

O80.0 *Spontaneous vertex delivery*

O80.1 *Spontaneous breech delivery*

O80.8 *Other single spontaneous delivery*

O80.9 *Single spontaneous delivery, unspecified*

O81.0 *Low forceps delivery*

O81.1 *Mid-cavity forceps delivery*

O81.2 *Mid-cavity forceps with rotation*

O81.3 *Other and unspecified forceps delivery*

O81.4 *Vacuum extractor delivery*

O81.5 *Delivery by combination of forceps and vacuum extractor*

O83.0 *Breech extraction*

O83.1 *Other assisted breech delivery*

O83.2 *Other manipulation-assisted delivery*

O84.0 *Multiple delivery, all spontaneous*

O84.1 *Multiple delivery,
all by forceps and vacuum
extractor*

Unacceptable obs. diag. comb. 5

Jika terdapat kombinasi diagnosis *Postpartum/Post Abortion Condition* dan *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652519 Unacceptable obs. diag. comb. 5

Delivery & Outcome

O80.0 *Spontaneous
vertex delivery*

O80.1 *Spontaneous
breech delivery*

O80.8 *Other single
spontaneous delivery*

O80.9 *Single spontaneous
delivery, unspecified*

O81.0 *Low forceps
delivery*

O81.1 *Mid-cavity forceps
delivery*

O81.2 *Mid-cavity forceps
with rotation*

O81.3 *Other and
unspecified forceps delivery*

O81.4 *Vacuum extractor
delivery*

O81.5 *Delivery by
combination of forceps and
vacuum extractor*

O82.0 *Delivery by
elective cesarean section*

O82.1 *Delivery by
emergency cesarean section*

O82.2 *Delivery by
cesarean hysterectomy*

O82.8 *Other single
delivery by cesarean section*

O82.9 *Delivery by
cesarean section, unspecified*

O83.0 *Breech extraction*

O83.1 *Other assisted
breech delivery*

O83.2 *Other
manipulation-assisted
delivery*

O83.3 *Delivery of viable
fetus in abdominal pregnancy*

O83.4 *Destructive
operation for delivery*

O83.8 *Other specified
assisted single delivery*

O83.9 *Assisted single
delivery, unspecified*

O84.0 *Multiple delivery,
all spontaneous*

O84.1 *Multiple delivery,
all by forceps and vacuum
extractor*

O84.2 *Multiple delivery,
all by cesarean section*

O84.8 *Other multiple
delivery*

O84.9 *Multiple delivery,
unspecified*

Z37.0 *Single live birth*

Z37.1 *Single stillbirth*

Z37.2 Twins, both liveborn

Z37.3 Twins, one liveborn and one stillborn

Z37.4 Twins, both stillborn

Z37.5 Other multiple births, all liveborn

Z37.6 Other multiple births, some liveborn

Z37.7 Other multiple births, all stillborn

Z37.9 Outcome of delivery, unspecified

Postpartum/Post Abortion Condition

O08.0 Genital tract and pelvic infection following abortion and ectopic and molar pregnancy

O08.1 Delayed or excessive haemorrhage following abortion and ectopic and molar pregnancy

O08.2 Embolism following abortion and ectopic and molar pregnancy

O08.3 Shock following abortion and ectopic and molar pregnancy

O08.4 Renal failure following abortion and ectopic and molar pregnancy

O08.5 Metabolic disorders following abortion and ectopic and molar pregnancy

O08.6 Damage to pelvic organs and tissues following abortion and ectopic and molar pregnancy

O08.7 Other venous complications following

abortion and ectopic and molar pregnancy

O08.8 Other complications following abortion and ectopic and molar pregnancy

O08.9 Complication following abortion and ectopic and molar pregnancy, unspecified

Z39.0 Care and examination immediately after delivery

Z39.1 Care and examination of lactating mother

Caesarean Section

74.0 Classical cesarean section

74.1 Low cervical cesarean section

74.2 Extraperitoneal cesarean section

74.3 Removal of extratubal ectopic pregnancy

74.4 Cesarean section of other specified type

74.91 *Hysterotomy to terminate pregnancy*

74.99 *Other cesarean section of unspecified type*

Unacceptable obs. diag. comb. 6

Jika terdapat kombinasi diagnosis *Antenatal Condition* dan *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652619 Unacceptable obs. diag. comb. 6.

Antenatal Condition

O28.0 *Abnormal haematological finding on antenatal screening of mother*

O28.1 *Abnormal biochemical finding on antenatal screening of mother*

O28.2 *Abnormal cytological finding on antenatal screening of mother*

O28.3 *Abnormal ultrasonic finding on antenatal screening of mother*

O28.4 *Abnormal radiological find on antenatal screening of mother*

O28.5 *Abnormal chromosomal and genetic finding antenatal screening of mother*

O28.8 *Other abnormal findings on antenatal screening of mother*

O28.9 *Abnormal finding on antenatal screening of mother, unspecified*

O60.0 *Preterm labour without delivery*

Z36.0 *Antenatal screening for chromosomal anomalies*

Z36.1 *Antenatal screening for raised alphafetoprotein level*

Z36.2 *Other antenatal screening based on amniocentesis*

Z36.3 *Antenatal screening malformation using ultrasound and other physical methods*

Z36.4 *Antenatal screening fetal growth retardation using ultrasound oth physical methods*

Z36.5 *Antenatal screening for isoimmunization*

Z36.8 *Other antenatal screening*

Z36.9 *Antenatal screening, unspecified*

Unacceptable obs. diag. comb. 7

Jika terdapat kombinasi diagnosis *Threatened abortion* dan *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652719 Unacceptable obs. diag. comb. 7.

Threatened abortion

O20.0 *Threatened abortion*

O20.8 *Other haemorrhage in early pregnancy*

O20.9 *Haemorrhage in early pregnancy, unspecified*

Unacceptable obs. diag. comb. 8

Jika terdapat kombinasi diagnosis *Uncomplicated Abortion* dan *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652819 Unacceptable obs. diag. comb. 8

Uncomplicated Abortion

O02.0 *Blighted ovum and nonhydatidiform mole*

O02.8 *Other specified abnormal products of conception*

O02.9 *Abnormal product of conception, unspecified*

O03.1 *Spontaneous abortion, incomplete abortion complicated by delayed or excessive haemorrhage*

O03.3 *Spontaneous abortion, incomplete, with other and unspecified complications*

O03.4 *Spontaneous abortion, incomplete, without complication*

O03.6 *Spontaneous abortion, complete or unspecified, complicated by delayed or excessive haemorrhage*

O03.8 *Spontaneous abortion, complete or unspecified, with other and unspecified complications*

O03.9 *Spontaneous abortion, complete or unspecified, without complication*

O04.1 *Medical abortion, incomplete, complicated by delayed or excessive haemorrhage*

O04.3 *Medical abortion, incomplete, with other and unspecified complications*

O04.4 *Medical abortion, incomplete, without complication*

O04.6 *Medical abortion, complete or unspecified, complicated by delayed or excessive haemorrhage*

O04.8 *Medical abortion, complete or unspecified, with other and unspecified complications*

O04.9 *Medical abortion, complete or unspecified, without complication*

O05.1 *Other abortion, incomplete, complicated by delayed or excessive haemorrhage*

O05.3 *Other abortion, incomplete, with other and unspecified complications*

O05.4 *Other abortion, incomplete, without complication*

O05.6 *Other abortion, complete or unspecified, complicated by delayed or excessive haemorrhage*

O05.8 *Other abortion, complete or unspecified, with other and unspecified complications*

O05.9 *Other abortion, complete or unspecified, without complication*

O06.1 *Unspecified abortion, incomplete, complicated by delayed or excessive haemorrhage*

O06.3 *Unspecified abortion, incomplete, with other and unspecified complications*

O06.4 *Unspecified abortion, incomplete, without complication*

O06.6 *Unspecified abortion, complete or unspecified, complicated by delayed or excessive haemorrhage*

O06.8 *Unspecified abortion, complete or unspecified, with other and unspecified complications*

O06.9 *Unspecified abortion, complete or unspecified, without complication*

O07.1 *Failed medical abortion complicated by delayed or excessive haemorrhage*

O07.3 *Failed medical abortion, with other and unspecified complications*

O07.4 *Failed medical abortion, without complication*

O07.6 *Other and unspecified failed attempted abortion, complicated by delayed or excessive haemorrhage*

O07.8 *Other and unspecified failed attempted abortion, with other and unspecified complications*

O07.9 *Other and unspecified failed attempted abortion, without complication*

Unacceptable obs. diag. comb. 9

Jika terdapat kombinasi diagnosis *Complicated Abortion* dan *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652919 Unacceptable obs. diag. comb. 9.

Complicated Abortion

O02.1 *Missed abortion*

O03.0 *Spontaneous abortion, incomplete abortion complicated by genital tract and pelvic infection*

O03.2 *Spontaneous abortion, incomplete, complicated by embolism*

O03.5 *Spontaneous abortion, complete or unspecified, complicated by genital tract and pelvic infection*

O03.7 *Spontaneous abortion, complete or unspecified, complicated by embolism*

O04.0 *Medical abortion, incomplete, complicated by genital tract and pelvic infection*

O04.2 *Medical abortion, incomplete, complicated by embolism*

O04.5 *Medical abortion, complete or unspecified, complicated by genital tract and pelvic infection*

O04.7 *Medical abortion, complete or unspecified, complicated by embolism*

O05.0 *Other abortion, incomplete, complicated by genital tract and pelvic infection*

O05.2 *Other abortion, incomplete, complicated by embolism*

O05.5 *Other abortion, complete or unspecified, complicated by genital tract and pelvic infection*

O05.7 *Other abortion, complete or unspecified, complicated by embolism*

O06.0 *Unspecified abortion, incomplete, complicated by genital tract and pelvic infection*

O06.2 *Unspecified abortion, incomplete, complicated by embolism*

O06.5 *Unspecified abortion, complete or unspecified, complicated by genital tract and pelvic infection*

O06.7 *Unspecified abortion, complete or unspecified, complicated by embolism*

O07.0 *Failed medical abortion, complicated by genital tract and pelvic infection*

O07.2 *Failed medical abortion, complicated by embolism*

O07.5 *Other and unspecified failed attempted abortion, complicated by*

genital tract and pelvic infection

O07.7 Other and unspecified failed attempted abortion, complicated by embolism

Unacceptable obs. diag. comb. 10

Jika terdapat kombinasi diagnosis *Molar Pregnancy* dan *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3653019 Unacceptable obs. diag. comb. 10.

Molar Pregnancy

O01.0 Classical hydatidiform mole

O01.1 Incomplete and partial hydatidiform mole

O01.9 Hydatidiform mole, unspecified

Unacceptable obs. diag. comb. 11

Jika terdapat kombinasi diagnosis *False Labour* dan *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3653119 Unacceptable obs. diag. comb. 11.

False Labour

O47.0 False labour before 37 completed weeks of gestation

O47.1 False labour at or after 37 completed weeks of gestation

O47.9 False labour, unspecified

Unacceptable obs. diag. comb. 12

Jika terdapat kombinasi diagnosis *Delivery by Caesarean Section* tetapi tidak ada kode pada kelompok *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3653219 Unacceptable obs. diag. comb. 12 .

Caesarean Section

74.0 Classical cesarean section

74.1 Low cervical cesarean section

74.2 Extraperitoneal cesarean section

74.3 Removal of extra tubal ectopic pregnancy

74.4 Cesarean section of other specified type

74.91 Hysterotomy to terminate pregnancy

74.99 Other cesarean section of unspecified type

Delivery & Outcome

O80.0	<i>Spontaneous vertex delivery</i>	O83.3	<i>Delivery of viable fetus in abdominal pregnancy</i>
O80.1	<i>Spontaneous breech delivery</i>	O83.4	<i>Destructive operation for delivery</i>
O80.8	<i>Other single spontaneous delivery</i>	O83.8	<i>Other specified assisted single delivery</i>
O80.9	<i>Single spontaneous delivery, unspecified</i>	O83.9	<i>Assisted single delivery, unspecified</i>
O81.0	<i>Low forceps delivery</i>	O84.0	<i>Multiple delivery, all spontaneous</i>
O81.1	<i>Mid-cavity forceps delivery</i>	O84.1	<i>Multiple delivery, all by forceps and vacuum extractor</i>
O81.2	<i>Mid-cavity forceps with rotation</i>	O84.2	<i>Multiple delivery, all by cesarean section</i>
O81.3	<i>Other and unspecified forceps delivery</i>	O84.8	<i>Other multiple delivery</i>
O81.4	<i>Vacuum extractor delivery</i>	O84.9	<i>Multiple delivery, unspecified</i>
O81.5	<i>Delivery by combination of forceps and vacuum extractor</i>	Z37.0	<i>Single live birth</i>
O82.0	<i>Delivery by elective cesarean section</i>	Z37.1	<i>Single stillbirth</i>
O82.1	<i>Delivery by emergency cesarean section</i>	Z37.2	<i>Twins, both liveborn</i>
O82.2	<i>Delivery by cesarean hysterectomy</i>	Z37.3	<i>Twins, one liveborn and one stillborn</i>
O82.8	<i>Other single delivery by cesarean section</i>	Z37.4	<i>Twins, both stillborn</i>
O82.9	<i>Delivery by cesarean section, unspecified</i>	Z37.5	<i>Other multiple births, all liveborn</i>
O83.0	<i>Breech extraction</i>	Z37.6	<i>Other multiple births, some liveborn</i>
O83.1	<i>Other assisted breech delivery</i>	Z37.7	<i>Other multiple births, all stillborn</i>
O83.2	<i>Other manipulation-assisted delivery</i>	Z37.9	<i>Outcome of delivery, unspecified</i>

d. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 24

- 1) Pada kasus persalinan yang memiliki penyulit, maka yang dijadikan diagnosis utama adalah penyulit persalinannya, sedangkan kode O80-O84 (*Delivery*) digunakan sebagai diagnosis sekunder untuk menunjukkan metode persalinan. Jika tidak terdapat komplikasi atau penyulit persalinan lainnya, maka kode O80-O84 (*Delivery*) dapat digunakan sebagai diagnosis utama. Untuk kode dari kategori Z37.- merupakan hasil persalinan (*outcome delivery*) yang harus ditetapkan pada episode persalinan ibu, untuk mengidentifikasi hasil akhir persalinan, seperti kelahiran hidup tunggal, kelahiran mati atau kelahiran kembar. Kode Z37.- dapat ditempatkan sebagai diagnosis sekunder namun tidak boleh sebagai diagnosis utama.
- 2) Prosedur dilatasi dan kuretase dengan tujuan terminasi kehamilan, gunakan kode 69.01 (*Dilation and curettage for termination of pregnancy*). Prosedur dilatasi dan kuretasi pada kasus abortus *incomplete* spontan atau *missed abortion*, gunakan kode 69.02 (*Dilation and curettage following delivery or abortion*). Prosedur dilatasi dan kuretase selain tujuan di atas gunakan kode 69.09 (*Other dilation and curettage*).
- 3) Kode dalam kategori Z37.- hasil persalinan (*outcome delivery*) tidak boleh digunakan pada pasien yang telah menjalani pengguguran kehamilan atau mengalami keguguran yang mengakibatkan kelahiran janin mati saat berada di rumah sakit. Kode O95–O99 digunakan jika ada kondisi penyakit atau kelainan yang menyertai kehamilan atau persalinan.
- 4) Prosedur induksi persalinan dengan menggunakan obat-obatan menggunakan kode 73.4 (*Medical induction of labor*). Jika induksi persalinan dengan alat dilatasi servikal menggunakan kode 73.1 (*Other surgical induction of labour*), sedangkan akselerasi persalinan pada saat pasien sudah dalam kondisi persalinan menggunakan kode 73.99 (*Other operations assisting delivery, other*).
- 5) Persalinan normal pada pasien dengan Riwayat SC sebelumnya, menggunakan kode O75.7 (*Vaginal delivery following previous cesarean section*). Sedangkan shock pasca bersalin menggunakan kode O75.1 (*Shock during or following labour and delivery*).
- 6) Prosedur episiotomy menggunakan kode 73.6 (*Episiotomy*). Tindakan *episiorrhaphy* tidak dikoding terpisah apabila dilakukan setelah episiotomi pada episode perawatan yang sama. Tindakan *repair* pada rutin *episiotomy* saat persalinan normal menggunakan kode 73.6. Jika didapatkan robekan perineum spontan ataupun robekan perineum tambahan diluar *episiotomy*, maka kode O70.- (*Perineal laceration during delivery*) harus ditambahkan, serta kode 75.69 (*Repair of other current obstetric laceration*) juga ditambahkan jika dilakukan *repair perineum*.

- 7) Jika dilakukan tindakan lain bersamaan dengan tindakan SC, dapat ditambahkan kode di bawah ini:
- 8) Kode 66.39 (*Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes*) untuk sterilisasi tuba
- 9) Kode 69.99 (*Other operations on cervix and uterus*) untuk B-Lynch atau tindakan jahitan kompresi uterus lainnya
- 10) Kode 68.39 (*Other and unspecified subtotal abdominal hysterectomy, NOS*) untuk subtotal histerektomi
- 11) Kode 68.4 (*Total abdominal hysterectomy*) untuk total histerektomi
- 12) Kode 68.29 (*Other excision or destruction of lesion of uterus*) untuk eksisi uterus pada kasus reseksi uterus pada plasenta akreta.
- 13) Jika tindakan adhesiolysis dilakukan dan memenuhi kriteria eksklusi *omit code*, maka tindakan tersebut dapat dikodekan secara terpisah.
- 14) Kode prosedur atau tindakan yang dilakukan bersamaan dengan tindakan SC.
- 15) Jika terdapat *multiple delivery* dengan 2 kombinasi cara bersalin yang berbeda, gunakan kode O84.8 untuk melengkapi kaidah koding persalinan.
- 16) Kriteria kondisi yang menggunakan kode O80:
- 17) Kode O80 *Single spontaneous delivery* hanya digunakan ketika persalinan sepenuhnya normal dengan satu kelahiran hidup. Berikut merupakan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar kode O80 dapat digunakan dengan benar:
- 18) Persalinan sepenuhnya normal (memerlukan bantuan minimal atau tidak sama sekali, dengan atau tanpa episiotomi)
- 19) Tidak terdapat manipulasi janin (misalnya: rotasi) atau instrumentasi (forsep)
- 20) Terjadi persalinan spontan, pervaginam
- 21) Presentasi saat persalinan hanya bisa berupa *cephalic* (kepala) atau oksipital. Istilah seperti “*right occipito-anterior (ROA)*”, “*left occipito-anterior (LOA)*”, “*right occipito-posterior (ROP)*”, “*left occipito-posterior (LOP)*”, dan “*vertex*” menggambarkan presentasi oksipital. Presentasi lainnya seperti bokong, wajah, atau alis (dahi), tidak diperkenankan menggunakan kode O80.
- 22) Setiap komplikasi antepartum yang dialami selama kehamilan harus sudah diatasi sebelum waktu persalinan
- 23) Tidak terdapat kelainan yang mungkin terjadi pada persalinan atau melahirkan
- 24) Tidak ada komplikasi pasca persalinan yang mungkin terjadi
- 25) Tidak boleh dilakukan prosedur selain prosedur berikut ini: episiotomi tanpa forsep, *episiorrhaphy*, *amniotomy* (pecahnya selaput ketuban secara buatan), persalinan dengan bantuan manual tanpa forsep, pemberian analgesik dan/atau anestesi, pemantauan janin, induksi persalinan (jika tidak

ada indikasi medis), dan sterilisasi. Jika prosedur lain dilakukan, kode O80 tidak dapat digunakan.

- 26) *Outcome of delivery* harus berupa kelahiran hidup tunggal (Z37.0 *Single live birth*). Jika terjadi kelahiran ganda atau kelahiran mati, kode O80 tidak dapat digunakan.
- 27) Jika dokter melakukan pengangkatan kedua ovarium dan tuba falopi pada episode operasi secara bersamaan, gunakan kode 65.61 (*Other removal of both ovaries and tubes at same operative episode*).
- 28) Jika dokter melakukan prosedur laparoskopi untuk mengangkat kedua ovarium dan tuba falopi pada episode operasi secara bersamaan, gunakan kode 65.63 (*Laparoscopic removal of both ovaries and tubes at same operative episode*).

19. MDC 25 PERINATOLOGI

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 25

1) Neonatus (Bayi baru lahir)

Jika dokter mendiagnosis bayi baru lahir dengan penyakit atau gejala abnormal, gunakan kode untuk penyakit atau gejala abnormal tersebut dan tambahkan kode dalam kelompok Z38.- (*Liveborn infants according to place of birth*) sebagai kode diagnosis tambahan.

Tabel C.89. Contoh kasus *Neonatus*

Contoh 1	Bayi tunggal lahir cukup bulan di rumah sakit dengan berat lahir 3000 gram. Berdasarkan kondisi klinis dan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, dokter mendiagnosis hipoglikemia.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Hipoglikemia	P70.4 <i>Other neonatal hypoglycaemia</i>
Diagnosis Sekunder		Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>

Tabel C.90. Contoh kasus *Neonatus*

Contoh 2	Bayi tunggal lahir kurang bulan di rumah sakit dengan berat lahir 2200 gram. Dokter mendiagnosis <i>hyaline membrane disease</i> dan pneumotoraks.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>hyaline membrane disease</i>	P22.0 <i>Respiratory distress syndrome of newborn</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Pneumotoraks</i>	P25.1 <i>Pneumothorax originating in the perinatal period</i>
		Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>

2) *Fetus and Newborn Affected by Maternal Factors and by Complications of Pregnancy, Labour and Delivery (P00-P04)*

Kode dalam kelompok P00 - P04 digunakan untuk bayi baru lahir yang terkena dampak dari kondisi penyakit ibu. Kode penyakit dalam kelompok ini tidak digunakan sebagai kode diagnosis utama, tetapi digunakan sebagai kode diagnosis tambahan.

Tabel C.91. Contoh kasus *Fetus and Newborn Affected by Maternal Factors and by Complications of Pregnancy, Labour and Delivery*

Contoh 3	Bayi tunggal lahir cukup bulan di rumah sakit dengan berat lahir 3000 gram, panjang badan 50 cm. Dokter mendiagnosis sebagai <i>asfiksia neonatorum</i> ringan yang disebabkan oleh ibu dengan tuberkulosis paru.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Asfiksia <i>neonatorum</i> ringan yang disebabkan oleh ibu dengan tuberkulosis paru	P21.1 <i>Mild and moderate birth asphyxia</i>
Diagnosis Sekunder		P00.2 <i>Fetus and newborn affected by maternal infectious and parasitic diseases</i>
		Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>

3) ***Slow Fetal Growth and Fetal Malnutrition (P05)***

Jika dokter mendiagnosis gangguan pertumbuhan dan malnutrisi pada bayi baru lahir, maka kode dalam kelompok P05.- (*Slow fetal growth and fetal malnutrition*) dapat digunakan untuk bayi/neonatus baik yang lahir prematur maupun cukup bulan (*at term*).

Untuk *Light for gestational age*, gunakan kode P05.0 (*Light for gestational age*).

Untuk *Small for gestational age*, gunakan kode P05.1 (*Small for gestational age*).

Untuk malnutrisi pada bayi baru lahir yang tidak disebutkan *light or small for gestational age*, maka gunakan kode P05.2 (*Fetal malnutrition without mention of light or small for gestational age*).

Untuk *intrauterine fetal growth restriction* atau *intrauterine fetal growth retardation* (IUGR), gunakan kode P05.9 (*Slow fetal growth, unspecified*).

4) ***Disorders Related to Short Gestation and Low Birth Weight, Not Elsewhere Classified (P07.-)***

Kode pada kelompok P07.- (*Disorders related to short gestational age and low birth weight, not elsewhere classified*) hanya digunakan untuk bayi yang lahir prematur saja. Apabila dokter mencatat berat lahir dan usia kehamilan, maka berat lahir dianggap sebagai prioritas utama dalam memberikan kode pada kelompok ini. yang mencakup:

Jika berat lahir kurang dari sama dengan 999 gram, gunakan kode P07.0 (*Extremely low birth weight*)

Jika berat lahir antara 1000 – 2499 gram, gunakan kode P07.1 (*Other low birth weight*).

Jika usia kehamilan kurang dari 28 minggu (196 hari), gunakan kode P07.2 (*Extremely immaturity*).

Jika usia kehamilan mulai dari 28 minggu atau lebih tetapi belum mencapai 37 minggu, gunakan kode P07.3 (*Other preterm infants*).

Jika kode P07.0 (*Extremely low birth weight*) atau P07.1 (*Other low birth weight*) telah digunakan, maka tidak perlu lagi menambahkan kode P07.2 atau P07.3.

Tabel C.92. Contoh kasus *Disorders Related to Short Gestation and Low Birth Weight, Not Elsewhere Classified*

Contoh 4	Bayi tunggal lahir di rumah sakit pada usia kehamilan 36 minggu, berat lahir 2400 gram. Dokter mendiagnosis sebagai <i>preterm</i> (lahir prematur) disertai dengan hipoglikemia.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Prematur	P07.1 <i>Other low birth weight</i>
Diagnosis Sekunder	Hipoglikemia	P70.4 <i>Neonatal hypoglycaemia</i> Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>

Pada akhir episode rawat adalah diagnosis berdasarkan sumber daya terbesar.

Jika diagnosis *respiratory distress syndrome of newborn* (P22.0) muncul pada saat pasien dalam masa perawatan, maka termasuk komplikasi atau komorbid sehingga walaupun menghabiskan sumber daya paling banyak tetap dikode sebagai diagnosa sekunder.

Tabel C.93. Contoh kasus *Disorders Related to Short Gestation and Low Birth Weight, Not Elsewhere Classified*

Contoh 5	Bayi tunggal lahir di rumah sakit pada usia kehamilan 32 minggu, berat lahir 1800 gram, dokter mendiagnosis sebagai <i>severe birth asphyxia</i> (asfiksia lahir berat) dan <i>preterm</i> (lahir prematur).	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Prematur dengan berat badan lahir rendah dan asfiksia berat	P21.0 <i>Severe birth asphyxia</i>
Diagnosis Sekunder		P07.1 <i>Other low birth weight</i>

		Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>
--	--	--

5) ***Birth Injury to Skeleton (P13)***

Jika dokter mendiagnosis cedera atau patah tulang pada proses kelahiran bayi baru lahir, gunakan kode dalam kelompok P13.- (*Birth injury to skeleton*) sesuai dengan jenis tulang yang mengalami cedera atau fraktur.

6) ***Birth Asphyxia (P21.-)***

Jika dokter mendiagnosis *birth asphyxia*, gunakan kode spesifik dengan melihat nilai *Apgar score* pada menit pertama setelah lahir, sebagai berikut:

Jika *Apgar score* pada menit pertama adalah 0–3, gunakan kode P21.0 (*Severe birth asphyxia*).

Jika *Apgar score* pada menit pertama adalah 4–7, gunakan kode P21.1 (*Mild and moderate birth asphyxia*).

Jika *Apgar score* pada menit pertama yang tidak diketahui, gunakan kode P21.9 (*Birth asphyxia, unspecified*).

Kode pada kategori P21.- tidak boleh digunakan jika dasarnya hanya *Apgar score* yang rendah tanpa disertai bukti medis adanya kondisi asfiksia.

Tabel C.94. Contoh kasus *Birth Asphyxia*

Contoh 6	Bayi tunggal lahir cukup bulan di rumah sakit dengan <i>Apgar score</i> 1, 3, dan 7 pada menit ke-1, ke-2, dan ke-5 setelah lahir, secara berurutan. Keesokan harinya, bayi mengalami kejang. Dokter mendiagnosis bahwa bayi tersebut mengalami asfiksia berat dan <i>Hypoxic Ischaemic Encephalopathy</i> [HIE].	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Asfiksia berat	P21.0 <i>Severe birth asphyxia</i>
Diagnosis Sekunder	Ensefalopati iskemik hipoksia	P91.0 <i>Neonatal cerebral ischaemia</i> Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>

7) ***Congenital Pneumonia (P23.-)***

Jika dokter mendiagnosis *Pneumonia kongenital*, gunakan kode dalam kelompok P23.- (*Congenital pneumonia*) sesuai dengan jenis penyebab infeksi yang spesifik.

8) ***Neonatal Aspiration Syndromes (P24.-)***

Jika dokter mendiagnosis sindrom aspirasi pada neonatus, gunakan kode pada kelompok P24.- (*Neonatal aspiration syndromes*) sesuai kode spesifik.

Jika dokter mendiagnosis sindrom aspirasi akibat mekonium, gunakan kode P24.0 (*Neonatal aspiration of meconium*).

Jika dokter mendiagnosis sindrom aspirasi akibat cairan amnion, gunakan kode P24.1 (*Neonatal aspiration of amniotic fluid and mucus*).

Jika dokter mendiagnosis sindrom aspirasi akibat darah, gunakan kode P24.2 (*Neonatal aspiration of blood*).

Jika dokter mendiagnosis sindrom aspirasi akibat susu dan makanan yang teregurgitasi, gunakan kode P24.3 (*Neonatal aspiration of milk and regurgitated food*).

9) ***Haemolytic Diseases of Fetus and Newborn; Neonatal Jaundice (P55; P58-P59)***

Kode dalam kelompok P55.- (*Haemolytic diseases of fetus and newborn*), P58.- (*Neonatal jaundice due to other excessive haemolysis*), atau P59.- (*Neonatal jaundice from other and unspecified causes*), gunakan kode spesifik sesuai dengan penyebab *jaundice* yang didiagnosis oleh dokter.

10) ***Transitory disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus and newborn (P70.-)***

Jika dokter mendiagnosis sindrom bayi (dengan hipoglikemia) dari ibu dengan diabetes gestasional, gunakan kode P70.0 (*Syndrome of infant of mother with gestational diabetes*).

Jika dokter mendiagnosis sindrom bayi (dengan hipoglikemia) dari ibu penderita diabetes, gunakan kode P70.1 (*Syndrome of infant of a diabetic mother*).

Tabel C.95. Contoh kasus *Transitory disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus and newborn*

Contoh 7	Bayi tunggal lahir di rumah sakit pada usia kehamilan 36 minggu, berat lahir 2600 gram, lahir dari ibu dengan penyakit DM gestasional. Dokter mendiagnosis sebagai <i>preterm</i> (lahir prematur) dan hipoglikemia.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Prematur lahir dari ibu dengan DM gestasional	P07.3 <i>Other preterm infants</i>

Diagnosis Sekunder	Hipoglikemia	P70.0 <i>Syndrome of infant of mother with gestational diabetes</i> Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>
---------------------------	--------------	---

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 25

Dalam pengodean MDC 25, selain kode diagnosis dan prosedur, berat badan lahir bayi juga memiliki pengaruh pada hasil *grouper*. Bayi baru lahir/neonatus yang tidak sehat selama episode kelahiran sampai dengan usia 28 hari menggunakan kode P kecuali kondisi yang termasuk pada eksklusi P00 - P96 (*Certain conditions originating in the perinatal period*). Sebagai contoh, jika dokter mendiagnosis tetanus neonatorum, gunakan kode A33 (*Tetanus neonatorum*). Jika dokter mendiagnosis pemphigus neonatorum, gunakan kode L00 (*Pemphigus neonatorum*).

20. MDC 26 PENYAKIT PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 26

Beberapa kondisi yang termasuk dalam bab ini dapat disebabkan oleh obat-obatan atau faktor eksternal lainnya. Kode dari Bab XX digunakan sebagai kode tambahan untuk mengidentifikasi penyebab eksternal tersebut.

Tabel C.96. Contoh kasus Penjelasan Khusus Kode ICD dalam Kategori MDC 26

Contoh 1	Pasien mengalami anemia defisiensi folat yang disebabkan obat anti malaria	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Anemia defisiensi folat yang disebabkan oleh trimetoprim	D52.1 <i>Drug-induced folate deficiency anaemia</i>
Penyebab Eksternal	Efek samping obat anti malaria	Y41.2 <i>Antimalarials and drugs acting on other blood protozoa</i>

1) *Stem Cell / Bone Marrow Harvesting and Transplantation*

Bagi pasien kanker yang dirawat untuk pengambilan sel induk atau sumsum tulang sebagai bagian dari persiapan transplantasi, maka menggunakan kode untuk jenis kanker tersebut sebagai kode diagnosis utama.

Pada kasus *autologous donation bone marrow* tanpa purging pada resipien, gunakan kode Z52.3 (*bone marrow donor*) dan kode prosedur 41.01 (*autologous bone marrow transplant without purging*).

Pada kasus *donation bone marrow* gunakan kode Z52.3 (*bone marrow donor*) dan kode prosedur 41.91 (*Aspiration of bone marrow from donor for transplant*).

Pada kasus *autologous donation bone marrow* dengan purging gunakan kode Z52.3 (*bone marrow donor*) dan kode prosedur 41.09 (*Autologous bone marrow transplant with purging*).

Tabel C.97. Contoh kasus *Stem Cell / Bone Marrow Harvesting and Transplantation*

Contoh 2	Seorang pasien laki-laki usia 45 tahun dengan rencana terapi kanker menjalani prosedur <i>autologous donation</i> darah untuk persiapan tindakan medis lanjutan. Pasien dilakukan pengambilan dan penyimpanan darahnya sendiri tanpa dilakukan proses purging. Prosedur berjalan lancar tanpa komplikasi.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Blood donor</i>	<i>Z52.3 Blood donor</i>
Prosedur	Pengambilan dan penyimpanan darahnya sendiri	<i>41.04 Autologous hematopoietic stem cell transplant without purging</i>

Tabel C.98. Contoh kasus *Stem Cell / Bone Marrow Harvesting and Transplantation*

Contoh 3	Seorang pasien laki-laki usia 40 tahun melakukan donor sumsum tulang bagi saudaranya. Dokter melakukan tindakan pengambilan sumsum tulang (<i>bone marrow harvest</i>) di belakang tulang panggul untuk transplantasi dengan prosedur pembedahan kecil yang menggunakan jarum khusus.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Bone marrow donor</i>	<i>Z52.3 Bone marrow Donor</i>
Prosedur	Pengambilan sumsum tulang untuk transplantasi sumsum tulang	<i>41.91 Aspiration of bone marrow from donor for transplant</i>

Tabel C.99. Contoh kasus *Stem Cell / Bone Marrow Harvesting and Transplantation*

	Seorang pasien laki-laki usia 45 tahun didiagnosis <i>multiple</i>
--	--

Contoh 4	<i>myeloma</i> dan menerima transplantasi sumsum tulang dari keluarganya, kemudian menjalani Transplantasi <i>autologous</i> sumsum tulang dengan <i>purging</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Multiple myeloma	C90.0 <i>Multiple myeloma</i>
Prosedur	Transplantasi <i>autologous</i> sumsum tulang dengan <i>purging</i>	41.09 <i>Autologous bone marrow transplant with purging</i>

Pada Kasus *autologous donation* darah dengan *purging*, gunakan kode Z52.0 (*Blood donor*) dan kode prosedur 41.07 (*Autologous hematopoietic stem cell transplant with purging*).

Pada kasus *allogenic donation bone marrow* dengan *purging*, gunakan kode Z52.3 (*Bone marrow donor*) dan kode prosedur 41.02 (*Allogeneic bone marrow transplant with purging*).

Pada kasus *allogenic donation bone marrow* darah tanpa *purging*, gunakan kode Z52.3 (*Bone marrow donor*) dan kode prosedur 41.03 (*Allogeneic bone marrow transplant without purging*).

Pada kasus *allogeneic donation* darah tanpa *purging*, gunakan kode Z52.0 (*Blood donor*) dan kode prosedur 41.05 (*Allogeneic hematopoietic stem cell transplant without purging*).

Pada kasus *allogeneic donation* darah tanpa *purging*, gunakan kode Z52.0 (*Blood donor*) dan kode prosedur 41.08 (*Allogeneic hematopoietic stem cell transplant*).

Tabel C.100. Contoh kasus *Stem Cell / Bone Marrow Harvesting and Transplantation*

Contoh 5	Seorang pasien laki-laki usia 45 tahun didiagnosis <i>Acute Myeloblastic Leukaemia</i> (AML) dan menerima transplantasi sumsum tulang dari pendonor selain keluarga, kemudian menjalani Transplantasi <i>Allogenic</i> sumsum tulang dengan <i>purging</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Acute Myeloblastic Leukaemia</i> (AML)	C92.0 <i>Acute myeloblastic leukaemia</i> (AML)
Prosedur	Transplantasi <i>Allogenic</i> sumsum tulang dengan <i>purging</i>	41.02 <i>Allogeneic bone marrow transplant with purging</i>

2) **Anemia (D50-D64)**

Jika dokter mendiagnosis anemia defisiensi besi, gunakan kode dalam kelompok D50.- (*Iron deficiency anaemia*) sesuai rincian yang dicantumkan oleh dokter.

Jika dokter mendiagnosis anemia defisiensi vitamin B12, gunakan kode dalam kelompok D51.- (*Vitamin B12 deficiency anaemia*).

Jika dokter mendiagnosis anemia defisiensi folat, gunakan kode dalam kelompok D52.- (*Folate deficiency anaemia*).

Jika dokter mendiagnosis *megaloblastic anaemia*, gunakan kode D53.1 (*Other megaloblastic anaemias, not elsewhere classified*).

Jika dokter *Thalassaemia*, gunakan kode spesifik sesuai dengan jenis *thalassaemia* pada kelompok D56.- (*Thalassaemia*).

Jika dokter mendiagnosis *alpha thalassaemia*, *haemoglobin H disease*, atau *haemoglobin constant spring*, gunakan kode D56.0 (*Alpha thalassaemia*).

Jika dokter mendiagnosis *beta thalassaemia* atau *beta thalassaemia/haemoglobin E*, gunakan kode D56.1 (*Beta thalassaemia*).

Jika dokter mendiagnosis *alpha thalassaemia trait* atau *beta thalassaemia trait*, gunakan kode D56.3 (*Thalassaemia trait*).

Jika dokter mendiagnosis *thalassaemia* yang tidak spesifik, gunakan kode D56.9 (*Thalassaemia, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis *homozygous haemoglobin E*, *heterozygous haemoglobin E*, atau *haemoglobin E trait*, gunakan kode D58.2 (*Other haemoglobinopathies*).

Anemia ditemukan bersamaan dengan penyakit lain

Jika dokter mendiagnosis anemia yang disebabkan kanker, gunakan kode kanker dan tambahkan kode D63.0* (*Anaemia in neoplastic disease*).

Jika dokter mendiagnosis anemia yang disebabkan oleh penyakit hati atau gangguan endokrin, gunakan kode penyakit tersebut dan tambahkan kode D63.1* (*Anaemia due to liver and endocrine disorders*)^(IM).

Jika dokter mendiagnosis anemia yang disebabkan oleh penyakit kronis akibat infeksi, ataupun penyakit kronis lainnya, gunakan kode penyakit kronis dan tambahkan kode D63.8* (*Anaemia in other chronic diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis anemia yang disebabkan oleh infeksi kronis, gunakan kode infeksi kronis dan tambahkan kode D63.8* (*Anaemia in other chronic diseases classified elsewhere*).

3) **Other Aplastic Anaemias (D61.)-**

Jika dokter mendiagnosis anemia aplastik, gunakan kode dalam kelompok D61.- (*Other aplastic anaemias*) sesuai dengan jenis anemia aplastik yang spesifik.

Jika dokter mendiagnosis *Pancytopenia* dengan malformasi atau kongenital, gunakan kode D61.0 (*Constitutional aplastic anaemia*)

Jika dokter mendiagnosis *Bicytopenia*, gunakan kode D64.5 (*bicytopenia*)^(IM)

4) **Coagulation Disorders (D65-D69)**

Jika dokter mendiagnosis perdarahan jangka panjang akibat penggunaan obat antikoagulan, gunakan kode D68.3 (*Haemorrhagic disorder due to circulating anticoagulants*) dan tambahkan kode penyebabnya.

Jika dokter mendiagnosis *Disseminated Intravascular Coagulation* (DIC), gunakan kode D65 (*Disseminated intravascular coagulation [defibrination syndrome]*).

Jika dokter mendiagnosis *coagulation defect*, gunakan kode D68.9 (*Coagulation defect, unspecified*).

Tabel C.101. Contoh kasus *Coagulation Disorders*

Contoh 6	Perempuan berusia 55 tahun dengan kondisi fibrilasi atrium telah menjalani pengobatan dengan obat warfarin dalam jangka waktu yang lama. Dia datang dengan keluhan pendarahan gusi dan hematuria. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil PT-INR 4.0 dan dokter mendiagnosis akibat pendarahan gusi dan hematuria akibat obat warfarin.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Pendarahan Gusi dan hematuria akibat <i>warfarin</i>	D68.3 <i>Hemorrhagic disorder due to circulating anticoagulants</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Fibrilasi atrium</i>	I48 <i>Fibrilasi atrium</i>
Penyebab Eksternal	<i>Warfarin</i>	Y44.2 <i>Anticoagulants</i>

5) **Non-Thrombocytopenic Purpura (D69.0-D69.2)**

Jika dokter mendiagnosis *Nonthrombocytopenic purpura* akibat alergi, gunakan kode D69.0 (*Allergic purpura*).

Jika dokter mendiagnosis disfungsi trombosit, gunakan kode D69.1 (*Qualitative platelet defects*).

Jika dokter mendiagnosis *Nonthrombocytopenic purpura* dengan penyebab lainnya, gunakan kode D69.2 (*Other nonthrombocytopenic purpura*).

6) Agranulocytosis

Jika dokter mendiagnosis *Agranulocytosis*, gunakan kode D70 (*Agranulocytosis*) dan tambahkan kode penyebabnya.

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 26

- 1) Setelah memberikan kode jenis anemia yang didiagnosis oleh dokter, maka pengode tidak perlu menggunakan kode D64.9 (*Anaemia, unspecified*) sebagai kode diagnosis tambahan.
- 2) Jika dokter mendiagnosis *Pancytopenia* dengan penyebab spesifik, maka gunakan kode sesuai penyebab tersebut, seperti kode D73.1 (*Hypersplenism*) atau kode C92.0 (*Acute myeloid leukemia*).
- 3) Dalam MDC 26, terdapat DRG khusus untuk pemberian transfusi faktor koagulasi dan transfusi darah sehingga pemberi kode harus memperhatikan dokumentasi medis dan bukti tatalaksana pemberian transfusi.
- 4) Apabila terdapat diagnosis yang masuk ke dalam MDC 26 dan disertai dengan tindakan transfusi darah dengan kode 99.03 (*Other transfusion of whole blood*), 99.04 (*Transfusion of packed cells*), dan kode 99.05 (*Transfusion of platelets*), maka dapat dimasukkan ke dalam DRG dengan diagnosis *Red Blood Cell Disorders w/ Blood Transfusion* atau *Coagulation Disorders w/ Blood Transfusion* atau *Immunity Disorders w/ Blood Transfusion*.
- 5) Apabila terdapat diagnosis yang masuk ke dalam kelompok *coagulation disorders* dan disertai dengan tindakan transfusi faktor koagulasi dengan kode 99.06 (*Transfusion of coagulation factors*), maka dapat dimasukkan ke dalam DRG *Coagulation Disorders w/ Coagulation Factor Transfusion*.
- 6) Jika dokter mendiagnosis hemofilia *on demand*, gunakan kode D66 (*Haemophilia*) dan tambahkan kode DH00 *On Demand* (Perdarahan Akut) IM.
- 7) Jika dokter mendiagnosis hemofilia profilaksis, gunakan kode D66 (*Haemophilia*) dan tambahkan kode DH01 Profilaksis IM.
- 8) Jika dokter mendiagnosis *thalassaemia* dengan terapi kelasi besi, gunakan kode D56.- (*Thalassaemia*) dan tambahkan kode DH02 *Iron Chelation Therapy* IM.
- 9) Untuk penggunaan Albumin tambahkan *code also* DH03 *Human Albumin* IM.
- 10) Untuk penggunaan berapa jumlah kantong darah, tambahkan kode DH04 *Blood Bag* IM.

**21. MDC 27 MYELOPROLIFERATIVE DISEASES AND DISORDERS,
POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS**

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 27

**1) *Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of
lymphoid, haematopoietic and related tissue (C81-C96)***

Jika dokter mendiagnosis *classic Hodgkin lymphoma*, gunakan kode C81.7 (*Other classical Hodgkin lymphoma*).

Jika dokter mendiagnosis *follicular lymphoma*, gunakan kode spesifik dari kelompok C82.- (*Follicular lymphoma*).

Jika dokter mendiagnosis *B-cell lymphoma* dengan subtype tertentu, maka gunakan kode spesifik. Contohnya: *Diffuse large B-cell lymphoma*, gunakan kode C83.3 (*Diffuse large B-cell lymphoma*).

Jika dokter mendiagnosis *Acute myeloblastic leukaemia* gunakan kode C92.0 (*Acute myeloid leukaemia [AML]*).

22. MDC 28 PENYAKIT INFEKSI DAN PARASIT

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 28

1) ***Other Salmonella Infections (A01-A02)***

Jika dokter mendiagnosis demam tifoid yang disebabkan oleh *Salmonella typhi*, gunakan kode A01.0 (*Typhoid fever*).

Jika dokter mendiagnosis demam paratifoid yang disebabkan oleh *Salmonella paratyphi*, gunakan kode A01.4 (*Paratyphoid fever*).

Jika dokter mendiagnosis salmonella sepsis, gunakan kode A02.1 (*Salmonella sepsis*).

Jika dokter mendiagnosis *arthritis* pada *localized salmonella infection*, gunakan kode A02.2† (*Localized salmonella infection*) dan tambahkan kode M01.3* (*Arthritis in other bacterial diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis *osteomyelitis* pada *localized salmonella infections*, gunakan kode A02.2† (*Localized salmonella infection*) dan tambahkan kode M90.2* (*Osteopathy in other infectious diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis *meningitis* pada *localized salmonella infection*, gunakan kode A02.2† (*Localized salmonella infection*) dan tambahkan kode G01* (*Meningitis in other bacterial diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis *pneumonia* pada *localized salmonella infection*, gunakan kode A02.2† (*Localized salmonella infection*) dan tambahkan kode J17.0* (*Pneumonia in bacterial diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *renal tubulo-interstitial disease* pada *localized salmonella infection*, gunakan kode A02.2† (*Localized salmonella infection*) dan tambahkan kode N16.0* (*Renal tubulo-interstitial disorders in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).

2) ***Enteroinvasive Escherichia Coli Infection (A04.0-A04.4)***

Jika dokter mendiagnosis infeksi *Enteropathogenic Escherichia coli*, gunakan kode A04.0 (*Enteropathogenic Escherichia coli infection*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi *Enterotoxigenic Escherichia coli*, gunakan kode A04.1 (*Enterotoxigenic Escherichia coli infection*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi *Enteroinvasive Escherichia coli*, gunakan kode A04.2 (*Enteroinvasive Escherichia coli infection*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi *Enterohaemorrhagic Escherichia coli*, gunakan kode A04.3 (*Enterohaemorrhagic Escherichia coli infection*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi *intestinal Escherichia coli* yang tidak terklasifikasi pada kode A04.0-A04.3, gunakan kode A04.4 (*Other intestinal Escherichia coli infections*).

3) **Botulism (A05.1)**

Gunakan kode dalam kelompok A05.- (*Other bacterial foodborne intoxication, not elsewhere classified*) untuk keracunan makanan bakterial yang tidak diklasifikasikan di bawah kelompok lain, sesuai dengan jenis bakteri yang diidentifikasi oleh dokter sebagai penyebab.

Jika dokter mendiagnosis *botulism*, gunakan kode A05.1 (*Botulism*).

4) **Amoebiasis (A06.-)**

Gunakan kode dalam kelompok A06.- (*Amoebiasis*), sesuai dengan jenis infeksi amoeba yang didiagnosis oleh dokter.

Jika dokter mendiagnosis *abscess* hati yang disebabkan amoeba, gunakan kode A06.4 (*Amoebic liver abscess*) dan tambahkan kode K77.0* (*Liver disorders in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *abscess* paru-paru disertai atau tanpa disertai *abscess* hati yang disebabkan amoeba, gunakan kode A06.5† (*Amoebic lung abscess*) dan tambahkan kode J99.8* (*Respiratory disorders in other diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *abscess* otak disertai atau tanpa disertai *abscess* hati dan atau *abscess* paru-paru yang disebabkan amoeba, gunakan kode A06.6† (*Amoebic brain abscess*) dan tambahkan kode G07* (*Intracranial and intraspinal abscess and granuloma in diseases classified elsewhere*).

5) **Tuberculosis (A15-A19)**

Tuberkulosis paru, gunakan kode dalam kelompok A15.- dan A16.- sesuai diagnosis yang disebutkan oleh dokter:

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis paru berdasarkan penemuan basil tahan asam pada dahak melalui pewarnaan atau metode PCR, gunakan kode A15.0 (*Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture*).

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis paru berdasarkan hasil kultur saja, gunakan kode A15.1 (*Tuberculosis of lung confirmed by culture only*).

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis berdasarkan hasil biopsi jaringan, gunakan kode A15.2 (*Tuberculosis of lung, confirmed histologically*).

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis berdasarkan gejala klinis, seperti batuk kronis dan gambar radiologi dada yang konsisten dengan tuberkulosis (misalnya, adanya kavitas di bagian atas paru) tetapi pemeriksaan mikrobiologi dan histopatologi tidak menemukan basil tuberkulosis, gunakan

kode A16.0 (*Tuberculosis of lung, bacteriologically and histologically negative*).

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis berdasarkan gejala klinis dan gambar radiologi dada tanpa pemeriksaan dahak atau biopsi jaringan, gunakan kode A16.1 (*Tuberculosis of lung, bacteriological and histological examination not done*).

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis dengan tidak ada bukti pemeriksaan dahak atau biopsi jaringan dilakukan, gunakan kode A16.2 (*Tuberculosis of lung without mention of bacteriological or histological confirmation*).

Tuberkulosis kelenjar getah bening, gunakan kode sesuai lokasi kelenjar getah bening yang terkena:

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis kelenjar getah bening intratoraks, gunakan kode A15.4 (*Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes, confirmed bacteriologically and histologically*) atau A16.3 (*Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes, without mention of bacteriological or histological confirmation*), tergantung konfirmasi diagnosis melalui pemeriksaan laboratorium atau tidak.

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis kelenjar getah bening abdomen, gunakan kode A18.3 (*Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands*).

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis kelenjar getah bening perifer (misalnya, di leher), gunakan kode A18.2 (*Tuberculous peripheral lymphadenopathy*).

Tuberkulosis pleura:

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis pleura dengan spesifikasi diagnosis yang dikonfirmasi melalui biopsi menunjukkan proses *granulomatosa* atau basil tahan asam ditemukan pada jaringan atau cairan pleura atau pemeriksaan PCR positif, gunakan kode A15.6 (*Tuberculous pleurisy, confirmed bacteriologically and histologically*).

Tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atau hasilnya negatif, gunakan kode A16.5 (*Tuberculous pleurisy, without mention of bacteriological or histological confirmation*).

Tuberkulosis pada organ lain:

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis meningitis, gunakan kode A17.0† (*Tuberculous meningitis*) dan tambahkan kode G01* (*Meningitis in bacterial diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis tuberkuloma atau tuberkulosis otak, gunakan kode A17.8† (*Other tuberculosis of nervous system*) sebagai kode utama dan tambahkan kode G07* (*Intracranial and intraspinal abscess and granuloma in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis perikarditis, gunakan kode A18.8† (*Tuberculosis of other specified organs*) dan tambahkan kode I32.0* (*Pericarditis in bacterial diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis peritonitis, maka gunakan kode A18.3† (*Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands*) dan tambahkan kode K67.3* (*Tuberculous peritonitis*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis tulang atau sendi, maka gunakan kode A18.0† (*Tuberculosis of bones and joints*) dan tambahkan kode tambahan sesuai lokasi tulang atau sendi yang terkena. Misalnya, terjadi pada lokasi tulang belakang, maka gunakan kode M49.0* (*Tuberculosis of spine*).

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis respirasi primer dengan konfirmasi laboratorium atau histopatologi, gunakan kode A15.7 (*Primary respiratory tuberculosis, confirmed bacteriologically and histologically*).

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis respirasi primer tanpa konfirmasi laboratorium atau histopatologi, gunakan kode A16.7 (*Primary respiratory tuberculosis, without mention of bacteriological or histological confirmation*).

Jika dokter mendiagnosis tuberkulosis milier akut pada satu organ tunggal, gunakan kode A19.0 (*Acute miliary tuberculosis of a single site*).

Tuberkulosis milier akut pada beberapa organ tunggal, maka gunakan kode A19.1 (*Acute miliary tuberculosis of multiple sites*) dan berikan kode tambahan untuk setiap organ yang terkena sesuai tingkat keparahan penyakit.

6) ***Infection Due To Other Mycobacteria (A31.-)***

Jika dokter mendiagnosis infeksi yang disebabkan mycobacteria yang tidak terklasifikasi pada kode A15-A19 dan A30.-, gunakan kode A31.- (*Infection Due To Other Mycobacteria*).

7) ***Listeriosis (A32.-)***

Jika dokter mendiagnosis *cutaneous listeriosis*, gunakan kode A32.0 (*cutaneous listeriosis*).

Jika dokter mendiagnosis *listerial meningitis*, gunakan kode A32.1† (*Listerial meningitis and meningoenkephalitis*) dan tambahkan kode G01* (*Meningitis in bacterial diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *listerial meningoenkephalitis*, gunakan kode A32.1† (*Listerial meningitis and meningoenkephalitis*) dan tambahkan kode G05.0* (*Enkephalitis, myelitis and enkephalomyelitis in bacterial diseases classified elsewhere*).

8) ***Diphtheria (A36.-)***

Jika dokter mendiagnosis difteri, gunakan kode dalam kelompok A36.- (*Diphtheria*) dengan memperhatikan jenis lokasi anatomi yang terkena difteri.

Jika dokter mendiagnosis *Pharyngeal diphtheria*, gunakan kode A36.0 (*Pharyngeal diphtheria*).

Jika dokter mendiagnosis *Nasopharyngeal diphtheria*, gunakan kode A36.1 (*Nasopharyngeal diphtheria*).

Jika dokter mendiagnosis *Laryngeal diphtheria*, gunakan kode A36.2 (*Laryngeal diphtheria*).

Jika dokter mendiagnosis *Cutaneous diphtheria*, gunakan kode A36.3 (*Cutaneous diphtheria*). Jika dokter mendiagnosis *erythrasma*, gunakan L08.1 (*erythrasma*).

Jika dokter mendiagnosis konjungtivitis difteri, gunakan kode A36.8† (*Other diphtheria*) dan tambahkan kode H13.1* (*Conjunctivitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).

9) ***Meningococcal Infection (A39.-)***

Jika dokter mendiagnosis *Meningococcal meningitis*, gunakan kode A39.0† (*Meningococcal meningitis*) dan tambahkan kode G01* (*Meningitis in bacterial diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *Waterhouse-Friderichsen syndrome*, gunakan kode A39.1† (*Waterhouse-Friderichsen syndrome*) dan tambahkan kode E35.1* (*Disorders of adrenal glands in diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi meningokokus endocarditis, gunakan kode A39.5† (*Meningococcal heart disease*) dan tambahkan kode I39.8* (*Endocarditis, valve unspecified, in diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi meningokokus pada organ lain yang tidak terklasifikasi pada kode A39.0-A39.5, gunakan A39.8† (*Other meningococcal infections*), disertai kode tambahan sesuai organ yang terinfeksi.

10) ***Sepsis (A40-A41)***

Jika dokter mendiagnosis sepsis yang disebabkan oleh bakteri *streptococcal*, gunakan kode dalam kelompok A40.-, serta perhatikan kriteria eksklusi *Streptococcal sepsis*.

Tabel C.102. Contoh kasus *Sepsis*

Contoh 1	Pasien terdiagnosis pielonefritis akut lalu mengalami demam tinggi dan menggigil, pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh 39 °C, frekuensi napas 26 kali per menit, denyut jantung 100 kali per menit, tekanan darah 120/70 mmHg. Kultur bakteri dari urin dan darah positif untuk E.coli. Diagnosis dokter pielonefritis akut dan sepsis akibat bakteri e.coli	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode

Diagnosis Utama	Pielonefritis akut	N10 <i>Acute tubulo-interstitial nephritis</i>
Diagnosis sekunder	Sepsis karena <i>E.Coli</i>	A41.5 <i>Sepsis due to other Gram-negative organisms</i> B96.2 <i>Escherichia coli [E. coli] as the cause of diseases classified to other chapters</i>

Kategori kode R65.- tidak boleh digunakan sebagai kode utama. Kategori ini hanya digunakan bersama kode lain untuk menunjukkan kondisi yang terjadi akibat penyakit atau penyebab tertentu. Kode penyebab atau penyakit dasarnya harus dicatat terlebih dahulu.

Jika dokter mendiagnosis SIRS tanpa gagal organ, gunakan kode R65.0 (*Systemic inflammatory response syndrome of infectious origin without organ failure*).

Jika dokter mendiagnosis SIRS dengan gagal organ, gunakan kode R65.1 (*Systemic inflammatory response syndrome of infectious origin with organ failure*).

Tabel C.103. Contoh kasus *Sepsis*

Contoh 2	Pasien dengan penyakit sirosis hati datang dengan gejala demam dan menggigil, yang telah berlangsung selama 2 hari. Pemeriksaan fisik menunjukkan suhu tubuh 38,5 °C, denyut jantung 110 kali per menit, serta nyeri tekan di daerah perut. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan jumlah leukosit sebanyak 15.000 sel/mm ³ , dengan neutrofil 90% dan limfosit 10%. Pemeriksaan cairan dalam rongga peritoneal menunjukkan leukosit sebanyak 1.500 sel/mm ³ , dengan neutrofil 90%. Kultur bakteri dari cairan dalam rongga peritoneal positif untuk <i>E. coli</i> , sedangkan kultur bakteri dari darah negatif. Dokter mendiagnosis peritonitis akut primer yang disebabkan bakteri <i>E. coli</i>	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Peritonitis akut primer	K65.00 <i>Primary peritonitis</i> ^(IM)
Diagnosis Sekunder	Sirosis hati	K74.6 <i>Other and unspecified cirrhosis of liver</i>

Sindrom respons inflamasi sistemik karena <i>E.Coli</i>	R65.0 <i>Systemic Inflammatory Response Syndrome of infectious origin without organ failure</i> B96.2 <i>Escherichia coli [E. coli] as the cause of diseases classified to other chapters</i>
---	--

Tabel C.104. Contoh kasus *Sepsis*

Contoh 3	Pasien datang dengan gejala demam tinggi dan menggigil, yang telah berlangsung selama 3 hari dan mempunyai komorbid diabetes mellitus tipe 2. Pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh 40 °C, frekuensi napas 28 kali per menit, denyut jantung 112 kali per menit, dan tekanan darah 100/70 mmHg. Pemeriksaan fisik terhadap berbagai sistem tubuh tidak menemukan kelainan. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan jumlah leukosit sebanyak 20.500 sel/mm ³ , dengan neutrofil 90%. Kultur darah menunjukkan adanya <i>Staphylococcus aureus</i> . Dokter mendiagnosis <i>sepsis</i> disebabkan bakteri <i>staphylococcus aureus</i> dan diabetes mellitus tipe 2 tanpa komplikasi.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Staphylococcus aureus sepsis</i>	A41.0 <i>Sepsis a due to Staphylococcus aureus</i>
Diagnosis Sekunder	Diabetes mellitus tipe 2 tanpa komplikasi	E11.9 <i>Type II non-insulin-dependent diabetes without complications</i>

11) ***Congenital Syphilis (A50.-)***

Gunakan kode dalam kelompok A50.- (*Congenital syphilis*), sesuai karakteristik sifilis kongenital. Pada sifilis kongenital, tambahkan kode organ yang terkena, misalnya:

Jika dokter mendiagnosis sifilis kongenital kurang dari 2 tahun setelah lahir dengan gejala, gunakan kode A50.0 (*early congenital, symptomatic*)

Jika dokter mendiagnosis sifilis kongenital kurang dari 2 tahun setelah lahir tanpa gejala klinis, namun dengan hasil tes serologi positif dan/atau tes cairan spinal negatif pada bayi berusia kurang dari 2 tahun, gunakan kode A50.1 (*Early congenital syphilis, latent*).

Jika dokter mendiagnosis sifilis kongenital kurang dari 2 tahun setelah lahir tanpa gejala, gunakan kode A50.2 (*early congenital, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis keratitis interstisial akibat sifilis, gunakan kode A50.3† (*Late congenital syphilitic oculopathy*) dan tambahkan kode H19.2* (*Late congenital syphilitic interstitial keratitis*).

Jika dokter mendiagnosis sifilis dengan manifestasi *arthritis*, gunakan kode A50.5† (*Other late congenital syphilis, symptomatic*) dan tambahkan kode M03.1* (*Postinfective arthropathy in syphilis*).

12) *Anogenital Herpesviral [Herpes Simplex] Infection (A60.-)*

Jika dokter mendiagnosis infeksi herpes simpleks pada saluran genital wanita, gunakan kode A60.0† (*Herpesviral infection of genitalia and urogenital tract*) dan tambahkan kode N77.0* (*Ulceration of vulva in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*) atau N77.1* (*Vaginitis, vulvitis and vulvovaginitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi herpes simpleks pada saluran genital pria, gunakan kode A60.0† (*Herpesviral infection of genitalia and urogenital tract*) dan tambahkan kode yang sesuai dalam kelompok N51.-* (*Disorders of male genital organs in diseases classified elsewhere*).

13) *Viral Meningitis (A87.-)*

Jika dokter mendiagnosis *enteroviral meningitis*, *coxsackievirus meningitis*, atau *echovirus meningitis*, gunakan kode A87.0† (*Enteroviral meningitis*) dan tambahkan kode G02.0* (*Meningitis in viral diseases classified elsewhere*).

14) *Dengue Fever [Classical Dengue] (A90-A91)*

Jika dokter mendiagnosis demam *dengue*, gunakan kode A90 (*Dengue fever [classical dengue]*).

Jika dokter mendiagnosis demam berdarah dengue dengan shock, gunakan kode A91.0 (*Dengue haemorrhagic fever with shock*)^(IM).

Jika dokter mendiagnosis Pada diagnosis demam berdarah dengue tanpa shock, gunakan kode A91.1 (*Dengue haemorrhagic fever without shock*)^(IM).

15) *Measles (B05.-)*

Gunakan kode yang termasuk dalam kelompok B05.- (*Campak/Measles*). Perhatikan kode *dagger* dan *asterisk* pada kondisi measles disertai dengan komplikasi.

Jika dokter mendiagnosis *measles encephalitis*, gunakan kode B05.0† (*Measles complicated by encephalitis*) dan tambahkan kode G05.1* (*Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in viral diseases classified elsewhere*).

Jika dokter mendiagnosis *measles* yang berhubungan dengan pneumonia, gunakan kode B05.2† (*Measles complicated by pneumonia*) dan tambahkan kode J17.1* (*Pneumonia in viral diseases classified elsewhere*).

16) *Human Immunodeficiency Virus [HIV] Disease (B20-B24)*

Berikut merupakan aturan penerapan kode untuk berbagai tahap penyakit HIV sesuai diagnosis dokter:

Jika dokter mendiagnosis penyakit yang dirawat adalah komplikasi dari HIV, gunakan kode dalam kelompok di bawah ini:

Jika dokter mendiagnosis pasien HIV positif yang disertai penyakit infeksi atau parasit (infeksi oportunistik), gunakan kode dalam kelompok B20.- (*Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases*),

Jika dokter mendiagnosis pasien HIV positif yang disertai dengan kanker atau neoplasma ganas, gunakan kode dalam kelompok B21.- (*Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasms*),

Jika dokter mendiagnosis pasien HIV positif yang disertai dengan kegagalan sistem organ spesifik lain, gunakan kode dalam kelompok B22.- (*Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other specified diseases*), atau

Jika dokter mendiagnosis sindrom infeksi yang tidak terklasifikasi pada kode B20-B22, gunakan kode dalam kelompok B23.- (*Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other conditions*).

Tabel C.105. Contoh kasus *Human Immunodeficiency Virus [HIV] Disease*

Contoh 4	Seorang pasien laki-laki berusia 30 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan batuk kronis berdahak yang sudah berlangsung selama satu bulan, disertai demam di malam hari dan penurunan berat badan yang drastis. Pasien diketahui memiliki riwayat HIV positif yang disertai tuberkulosis paru.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Tuberculosis paru	B20.0 <i>HIV disease resulting in mycobacterial infection</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV	-

Tabel C.106. Contoh kasus *Human Immunodeficiency Virus [HIV] Disease*

Contoh 5	Pasien HIV, dokter menerima pasien di rumah sakit untuk pengobatan <i>herpes zoster disseminata</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Herpes zoster</i> yang disebarluaskan	B20.3 <i>HIV disease resulting in other viral infections</i>

Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV	B02.7 <i>Disseminated zoster</i>
---------------------------	--------------	----------------------------------

Jika dokter mendiagnosis bahwa pasien HIV sedang dirawat untuk beberapa komplikasi sekaligus, salah satu kondisi yang jelas lebih berat dan lebih banyak menggunakan sumber daya dibandingkan dengan yang lain, maka dicatat sebagai diagnosis utama dan yang lainnya sebagai diagnosis sekunder.

Jika tidak ada satu kondisi yang lebih dominan, maka diagnosis HIV yang menyebabkan infeksi multipel, maka gunakan kode B20.7 (*HIV disease resulting in multiple infections*) dan tambahkan kode untuk setiap jenis infeksi.

Tabel C.107. Contoh kasus *Human Immunodeficiency Virus [HIV] Disease*

Contoh 6	Pasien penderita HIV dirawat di rumah sakit untuk menjalani pengobatan meningitis kriptokokus dan tuberkulosis paru (tes pemeriksaan AFB positif)	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Penyakit HIV meningitis kriptokokus	B20.7 <i>HIV disease resulting in multiple infections</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV tuberkulosis paru	B20.0 <i>HIV disease resulting in mycobacterial infection</i> B20.8 <i>HIV disease resulting in other infectious and parasitic diseases</i>

Tabel C.108. Contoh kasus *Human Immunodeficiency Virus [HIV] Disease*

Contoh 7	Pasien HIV dengan tuberkulosis paru, setelah menerima obat antivirus pasien mengalami <i>anemia aplastik</i> , sehingga dokter harus merawatnya di rumah sakit. Dokter mendiagnosis anemia aplastik yang di induksi obat dan HIV dengan tuberkulosis paru.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Anemia aplastik</i> yang diinduksi obat	D61.1 <i>Drug-induced aplastic anaemia</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV dengan tuberkulosis paru	B20.0 <i>HIV disease resulting in mycobacterial infection</i>
Komplikasi	-	-
Penyebab Eksternal	Efek samping anti-retrovirus	Y41.5 <i>Antiviral drugs</i>

Jika dokter mendiagnosis bayi baru lahir dari ibu yang terinfeksi HIV dengan adanya kelainan gunakan kode kelainan tersebut, dan tambahkan kode P00.2 (*Fetus and newborn affected by maternal infectious and parasitic disease*), Z20.6 (*Contact with and exposure to human immunodeficiency virus [HIV]*), dan kode dalam kelompok Z38.- (*Liveborn fetus according to place of birth*).

Penanganan efek samping yang disebabkan oleh obat antivirus untuk pengobatan HIV, gunakan kode efek samping tersebut dan tambahkan kode penyakit HIV serta tambahkan kode penyebab eksternal sesuai jenis obat tersebut.

Jika dokter mendiagnosis penyakit HIV pada ibu hamil, melahirkan, atau dalam masa nifas, gunakan kode O98.7 (*Human immunodeficiency virus [HIV] diseases complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*) dan tambahkan kode dalam kelompok B20- B24.

17) *Aspergillosis* (B44.-)

Gunakan kode dalam kelompok B44.- (*Aspergillosis*), berdasarkan sesuai letak anatomi dan klinis infeksi.

Jika dokter mendiagnosis *aspergillosis pulmonal* akut, subakut, atau invasif, gunakan kode B44.0 (*Invasive pulmonary aspergillosis*).

Jika dokter mendiagnosis *aspergillosis pulmonal kronis*, *aspergilloma*, atau *aspergillosis bronkopulmoner alergik*, gunakan kode B44.1 (*Other pulmonary aspergillosis*).

18) *Malaria* (B50-B54)

Jika dokter mendiagnosis malaria, gunakan kode dalam kelompok B50-B53 sesuai dengan jenis *plasmodium* dan komplikasinya.

Hindari menggunakan kode B54 (*Unspecified malaria*), jika telah diketahui jenis *plasmodiumnya*.

19) *Toxoplasmosis* (B58.-)

Gunakan kode dalam kelompok B58.- (*Toxoplasmosis*), berdasarkan organ yang di diagnosis dokter.

Jika dokter mendiagnosis kongenital toxoplasmosis, gunakan kode P37.1 (*Congenital toxoplasmosis*)

Jika dokter mendiagnosis *toxoplasmosis chorioretinitis*, gunakan kode B58.0† (*Toxoplasma oculopathy*) dan tambahkan kode H32.0* (*Chorioretinal inflammation in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 28

- 1) Jika dokter mendiagnosis *typhoid* dalam kehamilan , gunakan kode O98.8 (*Other maternal infectious and parasitic diseases complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*) dan tambahkan kode A01.0 (*Typhoid fever*).

- 2) Jika dokter mendiagnosis demam tifoid dengan diare, gunakan kode A01.0 (*Typhoid fever*) dan tidak perlu menambahkan kode A09.- (*Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin*).
- 3) Kasus TB dengan *Pneumonia/Bronchopneumonia* menggunakan kode gabungan A16.2 (*Tuberculosis of lung*), dengan penjelasan kondisi tuberculous pneumonia sudah termasuk (*include*) dalam kode A16.2. Perlu dijadikan perhatian pada sub bab A15-A19 termasuk pada kondisi infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis* dan *mycobacterium bovis*:
- 4) Kode A15.1 (*Tuberculosis of lung, confirmed by culture only*) hanya digunakan pada TB Paru yang sudah ditegakkan melalui kultur.
- 5) A15.2 (*Tuberculosis of lung, confirmed histologically*) hanya digunakan pada TB Paru yang sudah ditegakkan melalui pemeriksaan histologis.
- 6) A15.3 (*Tuberculosis of lung, confirmed by unspecified means*) hanya digunakan pada TB Paru yang sudah tegak namun tidak dapat dipastikan secara bakteriologi ataupun histologis.
- 7) Kasus TB dengan *marasmus*, gunakan kode A15.- atau A16.- dan *marasmus* tidak dikode terpisah.
- 8) Kode *pneumonia* (J18.9) dengan TB Paru (A15.2 atau A16.2) sudah termasuk dalam kode A15.2 atau A16.2 dengan kepastian dari pemeriksaan penunjang. Jika ada sepsis / *Septicaemia, unspecified* (A41.9) dengan *Pneumonia* (J18.9) tidak ada instruksi *includes/exclude* secara langsung untuk kode gabungan antara keduanya.
- 9) Jika dokter mendiagnosis sepsis disertai shock, gunakan kode A41.9 (*Sepsis, unspecified*) dan tambahkan kode R57.2 (*Septic shock*).
- 10) Jika dokter mendiagnosis sepsis disertai shock kardiogenik, gunakan kode A41.9 (*Sepsis, unspecified*) dan tambahkan kode R57.0 (*Cardiogenic shock*).
- 11) Jika dokter mendiagnosis sepsis disertai shock hipovolemik, gunakan kode A41.9 (*Sepsis, unspecified*) dan tambahkan kode R57.1 (*Hypovolaemic shock*).
- 12) Jika dokter mendiagnosis gangrene, gunakan kode R02 (*Gangrene, not elsewhere classified*).
- 13) Jika dokter mendiagnosis gas gangrene pada diabetes mellitus, gunakan kode A48.0 (*Gas gangrene*) dan tambahkan kode diabetes mellitusnya.
- 14) Jika dokter mendiagnosis *Scrub typhus dengan hepatitis*, gunakan kode A75.3† (*Typhus fever due to Rickettsia tsutsugamushi*) dan tambahkan kode K77.0* (*Liver disorders in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).
- 15) Jika dokter mendiagnosis ancylostomiasis, gunakan kode B76.0 (*Ancylostomiasis*).

- 16) Jika dokter mendiagnosis askariasis atau infeksi cacing gelang, gunakan kode B77.- (*Ascariasis*).

23. **MDC 29 PENYAKIT DAN GANGGUAN MENTAL**

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 29

1) *Dementia (F00-F03)*

Gunakan kode dalam kelompok F00 – F03 sesuai diagnosis dokter berdasarkan evaluasi klinis dan temuan tambahan. Kode F00.- tidak dapat menjadi diagnosis utama karena merupakan kode asterisk.

Tabel C.109. Contoh kasus *Dementia in Alzheimer's Disease*

Contoh 1	Pasien wanita berusia 70 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan kehilangan memori, sering lupa, kesalahan dalam berhitung, sulit berkonsentrasi dan emosi labil. hasil pemeriksaan CT Scan menunjukkan <i>multiple areas of infarction</i> di korteks serebral kedua sisi. Dokter mendiagnosis <i>dementia multi infarct</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Dementia multi-infarct</i>	F01.1 <i>Dementia multi-infarct</i>

2) *Delirium, Not Induced by Alcohol and Other Psychoactive Substances (F05)*

Gunakan kode dalam kelompok F05.- (*Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances*), sesuai diagnosis dokter.

Tabel C.110. Contoh kasus *Delirium, Not Induced by Alcohol and Other Psychoactive Substances*

Contoh 2	Pasien datang dengan keluhan gaduh gelisah, kebingungan, insomnia, halusinasi visual, dan tidak responsif terhadap lingkungan sekitarnya dialami sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit dan pasien memiliki riwayat operasi 3 hari sebelum muncul keluhan gaduh gelisah, dalam masa perawatan mengalami demam dan nyeri punggung. Pemeriksaan fisik menunjukkan suhu tubuh 39°C dengan nyeri tekan di area pinggang kanan. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan adanya 10 sel darah putih <i>per high power field</i> . Dokter mendiagnosis <i>Postoperative delirium</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Delirium pasca operasi</i>	F05.8 <i>Other delirium</i>

3) ***Other Mental Disorders due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disease (F06.-)***

Gunakan kode dalam kelompok F06.- (*Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease*), berdasarkan gambaran klinis pasien sesuai pemeriksaan dokter.

Tabel C.111. Contoh kasus *Other Mental Disorders due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disease*

Contoh 3	Pasien wanita usia 25 tahun datang dengan keluhan halusinasi visual dan suara, pasien sedang menjalani terapi <i>systemic lupus erythematosus</i> (SLE). Dokter mendiagnosis halusinasi organik.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Hallucinosis organik</i>	<i>F06.0 Organic hallucinosis</i>

4) ***Skizofrenia (F20.-)***

Gunakan kode dalam kelompok F20.- (*Schizophrenia*) berdasarkan gambaran klinis pasien sesuai pemeriksaan dokter.

Tabel C.112. Contoh kasus *Skizofrenia*

Contoh 4	Pasien datang ke IGD diantar keluarga dengan keluhan gelisah dan sering marah-marah sejak ±2 bulan sebelum masuk rumah sakit. Pasien tampak curiga berlebihan, sering menolak berbicara dengan orang lain, dan beberapa kali berteriak sendiri tanpa sebab yang jelas. Keluarga menyatakan pasien merasa selalu diawasi oleh tetangganya. Pasien juga mengaku mendengar suara-suara yang mengancam dan memerintahnya untuk waspada. Pasien mengalami gangguan tidur serta penurunan aktivitas sehari-hari. Pada pemeriksaan status mental ditemukan waham kejar dan halusinasi pendengaran. Dokter menegakkan diagnosis <i>Skizofrenia Paranoid</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Skizofrenia Paranoid	<i>F20.0 Paranoid schizophrenia</i>

5) ***Acute and transient psychotic disorders (F23.-)***

Gunakan kode dalam kelompok F23.- (*Acute and transient psychotic disorders*) berdasarkan gambaran klinis pasien sesuai pemeriksaan dokter.

Tabel C.113. Contoh kasus *Acute and transient psychotic disorders*

Contoh 5	Pasien datang diantar oleh keluarga dengan keluhan gelisah dialami kurang dari satu bulan sebelum masuk rumah sakit. Pasien tampak ketakutan dan sering berteriak sendiri. Pasien belum pernah mengalami kondisi ini sebelumnya. Dokter mendiagnosis <i>Acute schizophrenia-like psychotic disorder</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Acute schizophrenia-like psychotic disorder</i>	F23.2 <i>Acute schizophrenia-like psychotic disorder</i>

6) Schizoaffective disorders (F25.-)

Gunakan kode dalam kelompok F25.- (*Schizoaffective disorders*) berdasarkan gambaran klinis pasien sesuai pemeriksaan dokter.

Tabel C.114. Contoh kasus *Schizoaffective disorders*

Contoh 6	Pasein datang dengan keluhan gelisah, berbicara terus menerus, sering mengalami tertawa terbahak bahak yang dialami sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Pasien sebelumnya mengalami keluhan yang sama 2 bulan terakhir. Dokter mendiagnosis <i>schizoaffective disorder, manic type</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Schizoaffective disorder, manic type</i>	F23.2 <i>Schizoaffective disorder, manic type</i>

7) Bipolar affective disorder (F31-)

Gunakan kode dalam kelompok F31.- (*Acute and transient psychotic disorders*) berdasarkan gambaran klinis pasien sesuai pemeriksaan dokter.

Tabel C.115. Contoh kasus *Bipolar affective disorder*

Contoh 7	Pasien diantar oleh keluarga dengan keluhan marah marah, emosi labil, dan baru saja memecahkan kaca jendela rumahnya. Menurut keluarga, pasien sulit diberikan nasehat oleh keluarganya. Pasien tidak ada keluhan halusinasi atau waham. Keluhan ini telah dialami sejak 2 bulan sebelum masuk rumah sakit. Dokter mendiagnosis <i>bipolar affective disorder, current episode manic without psychotic symptoms</i> .
-----------------	---

	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Bipolar affective disorder, current episode manic without psychotic symptoms</i>	F31.1 <i>Bipolar affective disorder, current episode manic without psychotic symptoms</i>

8) **Somatoform Disorders (F45-)**

Gunakan kode dalam kelompok F45.- (*Somatoform disorders*) berdasarkan diagnosis yang ditegakkan oleh dokter.

Tabel C.116. Contoh kasus *Somatoform Disorders*

Contoh 8	Pasien datang dengan keluhan sulit tidur yang dialami beberapa hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengeluh nyeri pada area lambung yang bersifat hilang timbul, semakin hari nyeri makin bertambah dan tidak ada keluhan mual muntah. Pasien telah diberikan terapi nyeri untuk lambungnya. Namun, menurut pasien tidak ada perubahan. Berdasarkan anamnesa diketahui pasien beberapa minggu sebelum masuk rumah sakit sedang mengalami masalah di kantornya yang sangat mengganggu pikirannya. Dokter mendiagnosis <i>somatoform autonomic dysfunction</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Somatoform autonomic dysfunction</i>	F45.3 <i>Somatoform autonomic dysfunction</i>

9) **Eating Disorders (F50.-)**

Gunakan kode dalam kelompok F50.- (*Eating disorders*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini mencakup berbagai kondisi terkait pola makan abnormal dan persepsi terhadap berat badan atau bentuk tubuh yang menyebabkan gangguan fisik maupun psikologis signifikan, seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, atau gangguan makan tidak terklasifikasi pada bab lainnya.

Jika dokter mendiagnosis *eating disorder* yang terjadi pada kondisi *dissociative [conversion] disorders*, gunakan kode F50.5 (*Vomiting associated with other psychological disturbances*) dan tambahkan kode F44.- (*Dissociative [conversion] disorders*).

Jika dokter mendiagnosis *eating disorder* yang terjadi pada kondisi *hypochondriacal disorder*, gunakan kode F50.5 (*Vomiting associated with other psychological disturbances*) dan tambahkan kode F45.2 (*hypochondriacal disorder*).

Jika dokter mendiagnosis psikogenik vomiting, gunakan F50.5 (*Vomiting associated with other psychological disturbances*).

Jika dokter mendiagnosis hyperemesis gravidarum karena faktor emosional, gunakan kode O21.- (*Excessive vomiting in pregnancy*) dan tambahkan kode F50.5 (*Vomiting associated with other psychological disturbances*).

10) *Sleep Disorders (G47.-, F51.-)*

Jika dokter mendiagnosis gangguan tidur organik, gunakan kode dalam kelompok G47.- (*sleep disorders (organic)*).

Jika dokter mendiagnosis gangguan tidur non organik, gunakan kode dalam kelompok F51.- (*Nonorganic sleep disorders*).

11) *Mental and Behavioural Disorders Associated with The Puerperium, Not Elsewhere Classified (F53.-)*

Gunakan kode dalam kelompok F53.- (*Mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk menggambarkan gangguan seperti depresi pasca persalinan, kecemasan berlebihan, psikosis pascapersalinan, atau gangguan adaptasi yang berkaitan dengan stres perinatal, yang muncul sebagai respons terhadap perubahan fisik, hormonal, emosional, dan sosial yang signifikan selama periode pasca melahirkan.

12) *Specific Personality Disorders (F60.-)*

Gunakan kode dalam kelompok F60.- (*Specific personality disorders*) berdasarkan diagnosis yang diberikan oleh dokter.

Tabel C.117. Contoh kasus *Specific Personality Disorders*

Contoh 9	Pasien datang dengan keluhan sering merasa curiga terhadap orang-orang di sekitarnya. Pasien meyakini bahwa rekan kerjanya sering membicarakan dirinya dan berusaha menjatuhkannya, meskipun tidak terdapat bukti yang jelas. Pasien juga sulit mempercayai orang lain dan mudah tersinggung terhadap perkataan yang dianggap menyinggung dirinya. Keluhan tersebut telah berlangsung sejak lama dan sering menimbulkan konflik dengan orang lain. Dokter mendiagnosis gangguan kepribadian paranoid.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Paranoid personality disorder</i>	F60.0 <i>Paranoid personality disorder</i>

13) *Enduring Personality Changes, Not Attributable to Brain Damage and Disease (F62.-)*

Gunakan kode dalam kelompok F62.- (*Enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease*) berdasarkan diagnosis yang diberikan oleh dokter. Perhatikan bahwa pada kelompok kode F62.- terdapat catatan eksklusif yang merujuk pada kelompok F07.-. (*Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction*).

14) *Retardasi Mental (F70-F79)*

Gunakan kode dalam kelompok F70 – F79, berdasarkan tingkat keparahan retardasi mental sesuai dengan diagnosis dokter. Perhatikan untuk penggunaan karakter keempat berdasarkan ada atau tidaknya gangguan perilaku, yaitu :

.0 *With the statement of no, or minimal, impairment of behaviour*

.1 *Significant impairment of behaviour requiring attention or treatment*

.8 *Other impairments of behaviour*

.9 *Without mention of impairment of behaviour*

Gunakan kode tambahan untuk mengidentifikasi kondisi yang berhubungan, seperti : autisme (*autism*), gangguan tumbuh kembang lainnya (*other developmental disorders*), epilepsi (*epilepsy*), gangguan tingkah laku (*conduct disorders*), dan cacat fisik berat (*severe physical handicap*).

15) *Other behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence (F98.-)*

Gunakan kode dalam kelompok F98.- (*Other behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence*) berdasarkan diagnosis yang diberikan oleh dokter. kelompok kode ini terdiri atas berbagai gangguan yang bersifat heterogen dengan karakteristik utama berupa onset yang terjadi pada masa kanak-kanak, namun memiliki perbedaan karakteristik klinis dalam berbagai aspek lainnya. Perhatikan bahwa pada kelompok kode F98.- terdapat catatan eksklusif berdasarkan diagnosis yang spesifik.

Tabel C.118. Contoh kasus *Other behavioural and emotional disorders with onset usually*

Contoh 10	Seorang balita berusia 3 tahun yang secara konsisten mencari dan menelan serpihan tembok, tanah, atau kertas di area bermainnya meskipun telah diberikan asupan nutrisi yang cukup oleh orang tuanya. Perilaku ini telah berlangsung selama lebih dari satu bulan dan bukan merupakan bagian dari praktik budaya tertentu atau tahap perkembangan oral yang normal, sehingga memicu kekhawatiran akan risiko keracunan timbal atau obstruksi pencernaan. Dokter mendiagnosis pica pada masa kanak-kanak.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Pica of infancy and childhood</i>	F98.3 <i>Pica of infancy and childhood</i>

occurring in childhood and adolescence

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 29

- 1) Pada MDC 29 terdapat DRG khusus untuk pemberian tindakan *Electroconvulsive Therapy* (ECT), sehingga pemberi kode harus memperhatikan dokumentasi medis dan bukti tata laksana pemberian ECT.
- 2) Ketika terdapat diagnosis yang masuk ke dalam MDC 29 dan disertai dengan tindakan ECT dengan kode 94.27 (*Other electroshock therapy*), 94.270 (*Electroconvulsive therapy (ECT), conventional*)^(IM), atau 94.271 (*Electroconvulsive therapy (ECT), with premedication*)^(IM), maka akan masuk ke dalam DRG dengan deskripsi w/ECT, misalkan:
 - 3) *Schizophrenia and Schizoaffective Disorders w/ ECT - Chronic*
 - 4) *Schizophrenia and Schizoaffective Disorders w/ ECT - Sub Acute*
- 5) Jika pasien diberikan prosedur *Transcranial magnetic stimulation (TMS)* gunakan kode 94.28 (*Transcranial magnetic stimulation (TMS)*)^(IM)

24. MDC 30 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 30

1) *Encounter For General Medical Examination (Z00-Z01)*

Kode Z00.-, Z01.- digunakan untuk pemeriksaan dan investigasi pada pasien yang tidak memiliki keluhan atau diagnosis yang dilaporkan.

Jika pasien melakukan pemeriksaan tidak ditemukan penyakit atau kelainan apapun sehingga tidak memerlukan tatalaksana atau pengobatan, gunakan kode dalam kelompok Z00.- (*General examination and investigation of persons without complaint and reported diagnosis*) atau Z01.- (*Other special examinations and investigations of persons without complaint or reported diagnosis*) atau Z02.- (*Examination and encounter for administrative purposes*).

Jika seorang calon pendonor organ ginjal melakukan pemeriksaan rutin tanpa disertai penyakit atau kelainan apapun, gunakan kode Z00.5 (*Examination of potential donor of organ and tissue*).

Jika pasien melakukan pemeriksaan gigi rutin tanpa disertai penyakit atau kelainan apapun, gunakan kode Z01.2 (*Dental Examination*).

Jika pasien melakukan pemeriksaan mata rutin tanpa disertai penyakit atau kelainan apapun, gunakan kode Z01.0 (*Examination of eyes and vision*).

Pemeriksaan untuk skrining

Pemeriksaan skrining yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit tertentu seperti skrining adanya kanker serviks, gunakan kode Z11-Z13, bukan Z00.- atau Z01.-

Pemeriksaan untuk tujuan administratif

Pemeriksaan yang dilakukan untuk keperluan administratif seperti surat keterangan sehat untuk kerja, gunakan kode Z02.-

Pemeriksaan atas dasar gejala atau keluhan

Pasien memiliki gejala atau keluhan yang membuatnya harus diperiksa, tetapi tidak ditemukan penyakit atau kelainan, maka gunakan kode gejala atau keluhan yang menyebabkan pasien datang untuk diperiksa. Tidak perlu menggunakan kode Z00.- atau Z01.- karena fokusnya adalah pada gejala atau keluhan tersebut.

Contoh 1: Pasien sakit kepala, setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, maka gunakan kode R51 (*Headache*) sebagai diagnosis utama, bukan Z00.- atau Z01.-

Penyakit/ kelainan ditemukan saat pemeriksaan

Apabila dalam suatu pemeriksaan ditemukan penyakit atau kelainan, maka gunakan kode penyakit atau kelainan tersebut sebagai diagnosis utama dan tidak perlu menambahkan kode Z00.- atau Z01.-.

Contoh 2: Pasien *medical check-up* lalu ditemukan penyakit hipertensi, gunakan kode I10 (*Essential (primary) hypertension*)

Pemeriksaan Panggul (*Pelvic Examination*)

Pemeriksaan panggul menggunakan metode *conventional Papanicolaou smear* atau *liquid-based preparation* yang merupakan bagian dari pemeriksaan rutin tahunan atau berdasarkan jadwal tertentu, tanpa adanya gejala atau keluhan, dan hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya penyakit atau kelainan, maka gunakan kode Z01.4 (*Gynaecological examination (general)(routine)*) sebagai diagnosis utama.

Pengecualian:

Pemeriksaan dilakukan untuk tujuan kontrasepsi (KB) maka gunakan kode dalam kelompok Z30.- (*Contraceptive management*).

Pemeriksaan dilakukan untuk mendiagnosis kehamilan maka gunakan kode dalam kelompok Z32.- (*Pregnancy examination and test*).

2) Examination And Encounter For Administrative Purposes (Z02)

Kode diagnosis dalam kelompok Z02.- (*Examination and encounter for administrative purposes*) digunakan untuk individu yang menjalani pemeriksaan hanya untuk tujuan administratif dan tidak ditemukan penyakit atau kelainan selama pemeriksaan berlangsung. Beberapa ketentuannya sebagai berikut:

Apabila selama pemeriksaan ditemukan penyakit atau kelainan, maka gunakan kode penyakit/kelainan tersebut sebagai diagnosis utama dan tidak perlu menggunakan kode dalam kelompok Z02.-.

Kode Z02.7 digunakan secara khusus untuk penerbitan sertifikat medis pada pasien atau keluarga yang meminta dokumen resmi dari dokter, seperti:

- o Sertifikat kematian
- o Surat keterangan sehat
- o Surat keterangan ketidakmampuan atau disabilitas

Kode Z02.7 tidak digunakan apabila dokter tidak hanya menerbitkan dokumen resmi tetapi juga memberikan layanan pemeriksaan penyakit, gejala, pengobatan pasien sakit, atau layanan pemeriksaan kesehatan lainnya, seperti:

- Z00 – Z01 (*Encounter for general medical examination*)
- Z02.0 – Z02.6 dan Z02.8 – Z02.9 (*Other examinations for administrative purposes*)
- Z10 (*Routine general health check-up of defined subpopulation*)

Contoh 1: Pasien datang untuk mendapatkan surat keterangan sehat tanpa ada keluhan atau gangguan yang dialaminya. Pemeriksaan dilakukan dengan hasilnya normal, maka gunakan kode Z02.8 (*Other examinations for administrative purposes*).

3) ***Medical Observation And Evaluation For Suspected Diseases And Conditions (Z03)***

Gunakan kode dalam kategori Z03.– (*Medical observation and evaluation for suspected diseases and conditions*) digunakan untuk diagnosis “suspek” setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan standar pelayanan dan diagnosis belum tegak.

Contoh 1: Pasien diduga menderita kanker payudara karena ditemukan massa/benjolan di payudara kiri berdasarkan hasil pemeriksaan klinis yang prominen. Dokter mendiagnosis suspek neoplasma payudara sebelah kiri, gunakan kode Z03.1 (*Observation For Suspected Malignant Neoplasm*).

4) ***Follow-Up Examination After Treatment (Z08-Z09)***

Gunakan kode dalam kelompok Z08.- (*Follow-up examination after treatment for malignant neoplasms*) untuk pemeriksaan evaluasi pengobatan atau kontrol neoplasma ganas (kanker) dan tambahkan kode diagnosis kanker.

Gunakan kode dalam kelompok Z09.- (*Follow-up examination after treatment for conditions other than malignant neoplasms*) untuk Pemeriksaan evaluasi pengobatan atau kontrol pada kondisi selain neoplasma ganas, dan tambahkan kode diagnosis sesuai penyakitnya.

Tabel C.119. Contoh kasus *Follow-Up Examination After Treatment*

Contoh 1	Pasien datang ke rumah sakit untuk kontrol penyakit hipertensi dengan keluhan pusing dan tensi darah tinggi.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Kontrol ulang	Z09.8 <i>Follow-Up Examination After Other Treatment for Other Conditions</i>
Diagnosis sekunder	Hipertensi	I10 <i>Essential (primary) hypertension</i>

Tabel C.120. Contoh kasus *Follow-Up Examination After Treatment*

Contoh 2	Pasien datang ke rumah sakit untuk kontrol setelah menjalani psikoterapi <i>Mixed anxiety and depressive disorder</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode

Diagnosis Utama	Kontrol ulang	Z09.3 <i>Follow-Up Examination After Psychotherapy</i>
Diagnosis sekunder	<i>Mixed anxiety and depressive disorder</i>	F41.2 <i>Mixed anxiety and depressive disorder</i>

5) **Contact With And Exposure To Communicable Diseases (Z20.-)**

Jika dokter mendiagnosis adanya riwayat kontak atau paparan terhadap penyakit menular, gunakan kode dalam kelompok Z20.- (*Contact with and exposure to communicable diseases*).

Kode dalam kelompok Z20.- berlaku ketika individu diketahui berada dalam kondisi yang berisiko terhadap penularan penyakit, meskipun belum ada bukti pasti terjadinya infeksi.

Pemberian kode Z20.- bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko penularan dan membantu dalam merencanakan langkah-langkah pencegahan serta pemantauan yang diperlukan.

Hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan bahwa individu tersebut terinfeksi, maka kode untuk penyakit yang bersangkutan harus digunakan sebagai diagnosis utama, dan kode Z20.- tidak lagi relevan.

6) **Asymptomatic Human Immunodeficiency Virus [HIV] Infection Status (Z21)**

Jika dokter mendiagnosis status infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) pada individu yang tidak menunjukkan gejala atau manifestasi klinis terkait penyakit, gunakan kode dalam kelompok Z21.- (*Asymptomatic Human Immunodeficiency Virus [HIV] Infection Status*).

7) **Contraceptive Management (Z30.-)**

Gunakan kode Z30.- (*Contraceptive management*), digunakan untuk manajemen kontrasepsi. Pasien yang telah melahirkan di FKTP dan dirujuk oleh dokter sesuai indikasi medis untuk melakukan tubektomi interval di FKRTL, gunakan kode Z30.2 (*Sterilization*). Jika dokter melakukan prosedur sterilisasi, gunakan kode Z30.2 (*Sterilization*) untuk semua jenis sterilisasi.

Dalam hal pemasangan IUD sesuai indikasi medis spesialistik di FKRTL, maka :

Jika dokter melakukan pemantauan IUD berupa pemeriksaan, pemasangan kembali atau pelepasan IUD, gunakan kode Z30.5 (*Surveillance of (intrauterine) contraceptive device*).

Jika dokter mendiagnosis komplikasi pada IUD yang bergeser dari posisinya (*displacement*), masuk ke rongga panggul, atau menembus dinding rahim

(perforasi), gunakan kode T83.3 (*Mechanical complication of intrauterine contraceptive device*).

Jika dokter melakukan prosedur penggantian alat kontrasepsi intrauterin (IUD) yang baru, gunakan kombinasi kode 97.71 (*Removal of intrauterine contraceptive device*) dan kode 69.7 (*Insertion of intrauterine contraceptive device*).

Kode Prosedur untuk Sterilisasi Wanita:

Jika dokter melakukan prosedur *Tubal Ligation* (TL), gunakan kode 66.31 (*Other bilateral ligation and crushing of fallopian tubes*).

Jika dokter melakukan prosedur *Tubal Resection* (TR), *Postpartum TR*, *Interval TR*, *Operasi Pomeroy*, atau *Modified Pomeroy*, gunakan kode 66.32 (*Other bilateral ligation and division of fallopian tubes*).

Sterilisasi Umum (*Female Sterilization*):

Pada tindakan untuk sterilization, seperti tubektomi MOW pada tindakan *Seccio Caesaria*, gunakan kode 66.39 (*Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes*).

Kode Prosedur untuk Sterilisasi Pria:

Jika dokter melakukan prosedur *vasectomy*, gunakan kode 63.73 *Vasectomy*.

Jika dokter melakukan prosedur *ligasi Vas Deferens*, gunakan kode 63.71 (*Ligation of vas deferens*).

Jika dokter melakukan prosedur sterilisasi umum (*Male Sterilization*), gunakan kode 63.70 (*Male sterilization procedure, not otherwise specified*).

8) *Supervision Of Normal Pregnancy (Z34-Z35)*

Gunakan kode dari kelompok Z34.- (*Supervision of normal pregnancy*) untuk pemeriksaan kehamilan normal.

Gunakan kode dari kelompok Z35.- (*Supervision of high-risk pregnancy*) untuk pemeriksaan kehamilan yang berisiko tinggi.

Jika dokter melakukan pemeriksaan kehamilan dengan riwayat aborsi, gunakan kode Z35.1 (*Supervision of pregnancy with history of abortive outcome*).

Kode Z34.- atau Z35.- tidak digunakan jika dokter telah mendiagnosisi penyakit atau kelainan tertentu dalam kehamilan.

9) *Outcome Of Delivery (Z37.-)*

Kode dari kelompok Z37.- (*Outcome of delivery*) digunakan sebagai diagnosis tambahan untuk mendokumentasikan hasil persalinan pada ibu yang melahirkan.

10) *Liveborn Infants According To Place Of Birth (Z38.-)*

Gunakan kode dalam kelompok Z38.- (*Liveborn infants according to place of birth*) sebagai diagnosis untuk mendokumentasikan bayi yang dilahirkan hidup berdasarkan tempat lahir.

11) *Postpartum Care And Examination (Z39.-)*

Gunakan kode dari kelompok Z39.- (*Postpartum Care And Examination*) untuk pelayanan dan pemeriksaan ibu post partum tanpa komplikasi.

Jika dokter mendiagnosis kontrol rutin pada ibu post partum, gunakan kode Z39.2 (*routine postpartum follow-up*).

12) *Other Surgical Follow-Up Care (Z42-Z48)*

Ketika kode dalam kelompok Z42-Z48 digunakan, tidak perlu memberikan kode tambahan dari kelompok Z08-Z09. Berikut adalah panduan spesifik untuk penggunaan kode dalam kelompok Z42-Z48:

Gunakan kode Z42.- (*Follow-up Care Involving Plastic Surgery*) untuk perawatan lanjutan terkait tindakan bedah plastik atau rekonstruktif yang dilakukan setelah cedera sembuh atau untuk perbaikan jaringan parut pascaoperasi.

Gunakan kode Z43.- (*Attention to Artificial Openings*) apabila dokter memberikan layanan terkait lubang buatan (*artificial openings*), seperti penutupan, dilatasi dengan sonde atau bougie, pembentukan kembali, pelepasan kateter, atau pembersihan lubang buatan. **Contoh:** Trakeostomi, gastrostomi, ileostomi, kolostomi, sistostomi, atau vagina buatan, menutup lubang buatan, membersihkan lubang buatan atau melepas selang dari lubang tersebut.

Gunakan kode Z44.- (*Fitting and Adjustment of External Prosthetic Device*) apabila dokter memberikan layanan untuk memasang atau menyesuaikan alat prostetik eksternal berdasarkan letak anatominya, dengan memperhatikan kriteria eksklusi dalam kode Z44.-.

Gunakan kode Z45.- (*Adjustment and Management of Implanted Device*) apabila dokter memberikan layanan untuk menyesuaikan tatalaksana atau pemasangan alat implan berdasarkan jenis alat yang digunakan.

Gunakan kode Z46.- (*Fitting and Adjustment of Other Devices*) apabila dokter memberikan layanan untuk memasang atau menyesuaikan alat lain berdasarkan letak anatominya.

Gunakan kode Z47.- (*Other Orthopedic Follow-Up Care*) apabila dokter memberikan layanan tindak lanjut ortopedi sebelumnya.

Gunakan kode Z48.- (*Other Surgical Follow-Up Care*) apabila dokter memberikan layanan tindak lanjut pembedahan atau operasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Jika dokter yang mencatat adanya layanan tambahan yang diberikan kepada pasien (misalnya, pelepasan jahitan luka operasi), gunakan kode untuk perawatan tindak lanjut (*follow-up care*) yaitu kode dalam kelompok Z42 – Z50 sebagai gantinya.

13) *Care Involving Use Of Rehabilitation Procedures (Z50.-)*

Gunakan kode dari kelompok Z50.- (*Care involving use of rehabilitation procedures*) berdasarkan prosedur rehabilitasi yang dilakukan.

14) *Other medical care (Z51.-)*

Gunakan kode dari kelompok Z51.- (*Other medical care*) apabila untuk kunjungan pasien untuk mendapatkan perawatan medis atau perawatan lanjutan tertentu.

Jika pasien datang hanya untuk menjalani sesi radioterapi, gunakan kode Z51.0 (*Radiotherapy session*) dan tambahkan kode kankernya.

Jika pasien datang hanya untuk menjalani sesi kemoterapi, gunakan kode Z51.1 (*Chemotherapy session for neoplasm*) dan tambahkan kode kankernya.

Jika pasien datang hanya untuk menjalani kemoterapi dan radioterapi, gunakan kode Z51.1 (*Chemotherapy session for neoplasm*), kode Z51.0 (*Radiotherapy session*) dan tambahkan kode kankernya.

Jika pasien datang khusus untuk mendapatkan pelayanan perawatan paliatif, gunakan kode Z51.5 (*Palliative care*).

15) *Donors Of Organs And Tissues (Z52.-)*

Gunakan kode dari kelompok Z52.- (*Donors of organs and tissues*) pada donor organ dan jaringan.

16) *Persons Encountering Health Services For Specific Procedures, Not Carried Out (Z53.-)*

Gunakan kode dari kelompok Z53.- (*Persons encountering health services for specific procedures, not carried out*) untuk pasien yang batal operasi.

Jika pasien batal operasi karena terdapat kontraindikasinya, gunakan kode Z53.0 (*Procedure not carried out because of contraindication*).

Jika pasien batal operasi karena kontraindikasi dan memiliki indikasi medis perawatan, gunakan kode penyakit atau kondisi indikasi medisnya dan tambahkan kode Z53.0 (*Procedure not carried out because of contraindication*).

Tabel C.121. Contoh kasus *Persons Encountering Health Services For Specific Procedures, Not Carried Out*

Contoh 3	Pasien rencana tindakan BMV (<i>Balloon Mitral Valvuloplasty</i>) dengan TEE (<i>Transesophageal Echocardiography</i>) intra tindakan, saat TEE ditemukan adanya trombus sehingga tindakan BMV dibatalkan. Pasien diberikan terapi <i>double antiplatelet</i> dan direncanakan rawat jalan.
-----------------	---

	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Mitral stenosis severe dengan trombus	Z53.0 (<i>Procedure not carried out because of contraindication</i>)
Diagnosis sekunder	-	-
Prosedur	TEE (<i>Transesophageal Echocardiography</i>)	88.72 <i>Transesophageal echocardiography</i>

Tabel C.122. Contoh kasus *Persons Encountering Health Services For Specific Procedures, Not Carried Out*

Contoh 4	Pasien datang ke rumah sakit di rencanakan untuk operasi TKR (<i>Total Knee Replacement</i>). Saat dalam perawatan pasien mengalami demam, batuk, sesak dan dokter mendiagnosis pneumonia berat. pasien batal dilakukan operasi dan dilakukan perawatan untuk pneumonianya.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Pneumonia	J18.9 <i>Pneumonia, unspecified</i>
Diagnosis sekunder	Osteoarthritis pro TKR	Z53.0 (<i>Procedure not carried out because of contraindication</i>)

17) Problems related to physical environment (Z58)

Gunakan kode dalam kelompok Z58.- (*Problems related to physical environment*) berdasarkan faktor-faktor yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik tempat seseorang tinggal atau beraktivitas.

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 30

- 1) Penggunaan kode Z masih digunakan untuk melengkapi kondisi utama saat dilakukan *follow up* penyakit dan digunakan untuk terapi pada penyakit seperti kemoterapi, radioterapi, fisioterapi, rehabilitasi medis maupun status persalinan dan bayi baru lahir. Kode-kode Z digunakan sebagai dasar pengajuan klaim, bukan untuk kepentingan statistik penyakit rumah sakit. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara kode untuk klaim dan kode untuk keperluan statistik rumah sakit.

2) Bila Pasien kontrol pengobatan dengan diagnosis utama yang sama dengan kunjungan sebelumnya maka kode Z08.- s/d Z09.- digunakan untuk klaim pasien rawat jalan kunjungan “*follow up*”

3) Untuk Follow Up hanya ada 3 Sub bab kode yang digunakan yaitu:

4) Z08.- *Follow-up examination after treatment for malignant neoplasms*

Digunakan untuk kontrol pada pasien kanker tanpa tindakan khusus, seperti: kemoterapi (Z51.1) atau radioterapi (Z51.0).

Jika dokter mendiagnosis pasien datang kontrol dengan karsinoma kandung kemih post sistektomi, gunakan kode Z08.0 (*Follow-up examination after surgery for malignant neoplasm*) dan tambahkan kode kankernya.

5) Z09.- *Follow-up examination after treatment for conditions other than malignant neoplasms*

Digunakan untuk kontrol ulang di rawat jalan dengan diagnosis yang sama pada kunjungan sebelumnya.

Jika dokter melakukan pemeriksaan kontrol pasca pencabutan pen / plat atau alat fiksasi internal, gunakan kode Z09.4 (*Follow-up examination after treatment of fracture*) dan kode Z87.8 (*Personal history of other specified conditions*)

Jika dokter melakukan pemeriksaan kontrol rutin pada pasien gagal jantung, gunakan kode Z09.8 (*Follow-up examination after other treatment for other conditions*) dan tambahkan kode I50.9 (*Heart failure, unspecified*).

6) Z39.- *Postpartum care and examination*

Digunakan untuk pelayanan atau pemeriksaan rutin ibu dalam masa nifas (*postpartum*) tanpa adanya komplikasi medis akut.

Jika dokter melakukan pemeriksaan rutin pasca persalinan, gunakan kode pada kelompok Z39 (*Postpartum care and examination*)

7) Kode Z42 *Follow-up care involving plastic surgery*

Digunakan untuk kontrol setelah prosedur bedah plastik atau rekonstruksi.

Jika pasien kontrol pasca bedah rekonstruksi akibat luka bakar pada tangan kanan dan dokter mendiagnosis kontraktur *manus dextra*, gunakan kode Z42.3 (*Follow-up care involving plastic surgery of upper extremity*).

8) Kode Z47 *Orthopaedic follow-up care, unspecified*

Jika pasien datang untuk melakukan pengangkatan pen / plat / sekrup atau alat fiksasi internal lainnya, gunakan kode Z47.0 (*Follow-up care involving removal of fracture plate and other internal fixation device*).

Jika pasien datang untuk melakukan pengangkatan alat fiksasi eksternal atau alat traksi, gunakan kode Z47.8 (*Other specified orthopaedic follow-up care*).

9) Kode Z48 *Other surgical follow-up care*

Digunakan untuk perawatan pasca pembedahan yang tidak terklasifikasi pada kode Z40 s/d Z47.

Jika dokter melakukan perawatan angkat jahitan pada luka robek di area kepala, gunakan kode Z48.0 (*Attention to surgical dressings and sutures*) dan kode prosedur pelepasan jahitan di area abdomen 97.38 (*Removal of sutures from head and neck*).

10) Kode Z95 (Riwayat Implan Jantung/Pembuluh Darah)

Jika pasien kontrol ke poli bedah jantung pasca operasi CABG, gunakan kode Z09.0 (*Follow-up examination after surgery for other conditions*) dan tambahkan kode Z95.1 (*Presence of aortocoronary bypass graft*)

11) Kode Z50 digunakan untuk pelayanan prosedur rehabilitasi dengan menambahkan kode penyakit penyerta.

12) Kode Z51 digunakan untuk perawatan medis lainnya, yang tidak terklasifikasi seperti Kemoterapi / Radioterapi dan/atau *Palliative care* dengan menambahkan kode penyakitnya.

25. MDC 31 MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 31

Penetapan kasus ke dalam MDC 31 dilakukan berdasarkan diagnosis utama serta didukung oleh diagnosis sekunder atau tindakan operasi (*OR procedure*). Pasien akan dikelompokkan ke dalam MDC 31 apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Memiliki diagnosis utama berupa trauma,
dan
- 2) Memiliki minimal dua kode diagnosis trauma yang signifikan, baik sebagai diagnosis utama atau diagnosis sekunder, yang berasal dari kategori lokasi tubuh yang berbeda.

atau

Memiliki minimal dua kode tindakan operasi (*OR procedure*) yang signifikan akibat trauma, yang berasal dari kategori lokasi tubuh yang berbeda.

3) Kategori Lokasi Cedera Berdasarkan Diagnosis

Terdapat 8 kategori lokasi tubuh untuk diagnosis trauma signifikan sebagai berikut:

- 1 Trauma Kepala Signifikan
- 2 Trauma Dada Signifikan
- 3 Trauma Abdomen Signifikan
- 4 Trauma Ginjal Signifikan
- 5 Trauma Sistem Perkemihan Signifikan
- 6 Trauma Pelvis atau Tulang Belakang Signifikan
- 7 Trauma Ekstremitas Atas Signifikan
- 8 Trauma Ekstremitas Bawah Signifikan
- 0 Trauma Tidak Signifikan

4) Kategori Lokasi Cedera Berdasarkan Prosedur Operasi (OR Procedure)

Kategori lokasi tubuh untuk tindakan operasi akibat trauma dibagi sebagai berikut:

- A Intrakranial
- B Maksilofasial
- C Dada
- D Abdomen
- E Tulang Belakang
- F Ekstremitas Atas
- G Ekstremitas Bawah
- H Kulit

Kode Blok S (S00–S99) dan T (T00-T14) digunakan untuk pengodean berbagai jenis cedera, gunakan kode secara spesifik sesuai dengan jenis cedera, lokasi anatomi dan jenis luka (luka terbuka atau luka tertutup). Kode pada bagian S untuk pengodean berbagai jenis cedera yang terkait pada satu regio tubuh dan bagian T untuk mencakup cedera pada beberapa regio tubuh atau yang tidak spesifik termasuk kasus keracunan dan dampak dari penyebab eksternal. Penggunaan pada kode ini harus dilengkapi dengan kode penyebab luar (*external cause*) dari kategori kode V01-Y98 guna menjelaskan mekanisme jenis cedera.

Jika terdapat berbagai lokasi cedera ditentukan dalam judul, maka :

- 5) kata “*with*” (dengan) menunjukkan keterlibatan kedua lokasi
- 6) kata “*and*” (dan/atau) menunjukkan keterlibatan salah satu atau kedua lokasi.

Apabila terdapat lebih dari satu jenis cedera dan masing masing cedera dapat diidentifikasi dengan jelas berdasarkan dokumentasi medis, maka setiap cedera harus dikodekan secara terpisah sesuai jenis lokasinya. Apabila terdapat cedera multipel yang tidak memberikan rincian tentang karakteristik masing masing cedera, gunakan kategori kombinasi untuk cedera multipel.

Blok pada bagian S serta T00-T14 dan T90-T98 berisi cedera pada tingkat tiga karakter yang diklasifikasikan berdasarkan jenis sebagai berikut:

- 7) Cedera superfisial termasuk:

- Abrasi
- Lepuh (bukan termal)
- Kontusi, termasuk memar dan hematoma
- Cedera dari benda asing superfisial (serpihan) tanpa luka terbuka yang besar
- Gigitan serangga (tidak berbisa)

- 8) Luka terbuka termasuk:

- Gigitan hewan
- Luka robek
- Laserasi
- Luka tusuk: NOS (*Not Otherwise Specified*) atau dengan benda asing (penetrasi)

- 9) Fraktur termasuk:

- Fraktur Tertutup: majemuk (*compound*) terinfeksi (*infected*), misil (*missile*), retak (*fissured*), greenstick, impaksi (*impacted*), linier, march, simpel, slipped epiphysis, spiral, dengan atau tanpa keterlambatan penyembuhan,

Fraktur Terbuka: majemuk (*compound*), terinfeksi (*infected*), misil (*missile*), tusukan (*puncture*), dengan benda asing, serta dengan atau tanpa keterlambatan penyembuhan. Dikecualikan: fraktur patologis (M84.4), fraktur dengan osteoporosis (M80.-), fraktur stres (M84.3), malunion fraktur (M84.0), dan nonunion fraktur [*pseudarthrosis*] (M84.1).

Dislokasi, atau pergeseran (*dislocated*).

10) Dislokasi, *sprain* (terkilir), dan *strain* (ketegangan otot) termasuk:

Avulsi

Laserasi

Terkilir

Ketegangan otot

Trauma : haemarthrosis, robek (*rupture*), subluxation, robek (*tear*)

11) Cedera pada saraf dan medula spinalis, termasuk lesi lengkap atau tidak lengkap pada lesi medula spinalis yang masih berkesinambungan pada cedera traumatik saraf dan medula spinalis berupa:

pemutusan saraf

hematomielia (perdarahan pada medula spinalis)

paralisis (sementara)

paraplegia

quadriplegia

12) Cedera pada pembuluh darah termasuk :

Avulsi

Laserasi

Traumatik:

aneurisma atau fistula (arterivenous)

hematoma rteri

ruptur

13) Cedera pada otot, fasia, dan tendon termasuk :

14) Avulsi

15) Laserasi

16) Ketegangan otot (*strain*)

17) Ruptur traumatik

18) *Crushing injury*

19) Amputasi traumatik

- 20) Cedera pada organ dalam meliputi:
- 21) cedera akibat ledakan (*blast injury*)
- 22) memar (*bruise*)
- 23) gegar/cedera akibat benturan (*concussion*)
- 24) *crushing*
- 25) laserasi
- 26) traumatik:
- 27) hematoma
- 28) luka tusuk (*puncture*)
- 29) pecah (*rupture*)
- 30) robek (*tear*)
- 31) Cedera lain yang tidak spesifik
- 32) Dalam kasus terjadinya cedera di beberapa lokasi anatomi secara bersamaan, jika dokter mendiagnosis salah satu cedera yang lebih berat, gunakan kode cedera yang lebih berat dan tambahkan kode cedera lainnya.

Tabel C.123. Contoh kasus Penjelasan Khusus Kode ICD dalam Kategori MDC 31

Contoh 1	Seorang pasien datang ke rumah sakit akibat tertabrak mobil saat sedang berjalan kaki. Dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami fraktur tulang paha kanan tertutup, fraktur lengan atas kanan terbuka tertutup, dan terkilir pada pergelangan kaki kanan. Dokter melakukan tindakan reduksi tertutup pada tulang paha kanan dan lengan atas kanan tanpa fiksasi internal.	
	Diagnosis Dokter	Pengode memberi kode
Diagnosis utama	Fraktur pada tulang paha kanan tertutup	S72.30 <i>Fracture of shaft of femur, closed</i>
Diagnosis sekunder	Fraktur pada tulang lengan atas kanan terbuka	S42.21 <i>Fracture of upper end of humerus, open</i>
	Terkilir pada pergelangan kaki kanan	S93.4 <i>Sprain and strain of ankle</i>
Penyebab eksternal	Seorang pejalan kaki tertabrak mobil	V03.1 <i>Pedestrian injured in collision with car, pick-up or van, traffic accident</i>
Prosedur	Reduksi tertutup pada tulang paha tanpa fiksasi internal	79.05 <i>Closed reduction of fracture without internal fixation, femur</i>

- 33) Dalam kasus terjadinya cedera di beberapa lokasi anatomi secara bersamaan namun diagnosis dokter tidak mencantumkan cedera yang dominan atau menonjol, gunakan kode multiple dan tambahkan kode cedera lainnya.

Apabila terdapat cedera multipel pada satu regio yang sama, menggunakan kode spesifik dari kelompok kode S dengan menambahkan karakter keempat (.7) yang merepresentasikan kondisi multipel.

Tabel C.124. Contoh kasus Penjelasan Khusus Kode ICD dalam Kategori MDC 31

Contoh 2	Pasien datang dengan cedera saat mengendarai mobil dan menabrak pohon. Dokter mendiagnosis cedera multipel pada organ intratorakal dan fraktur terbuka pada tulang lengan atas. Pada kondisi tersebut dilakukan prosedur pemasangan WSD dan prosedur ORIF pada tulang lengan atas.	
	Diagnosis Dokter	Pengode memberi kode
Diagnosis utama	Cedera multipel pada organ intratorakal	S27.7 <i>Multiple injuries of intrathoracic organs</i>
Diagnosis Sekunder	Fraktur terbuka pada tulang lengan atas	S42.21 <i>Open Fracture of upper end of humerus</i>
Penyebab Eksternal	Pengemudi mobil terluka karena menabrak pohon	V47.59 <i>Car occupant injured in collision with fixed or stationary object</i>
Prosedur	Pemasangan WSD	34.04 <i>Insertion of intercostal catheter for drainage</i>
	ORIF pada tulang lengan atas	79.39 <i>Open reduction of fracture with internal fixation, humerus</i>

34) Dalam kasus terjadinya cedera dengan jenis atau karakteristik cedera yang sama pada beberapa lokasi anatomi yang berbeda, gunakan Kode Blok T (T00–T07) dan tambahkan kode S00–S99 sebagai kode tambahan.

Tabel C.125. Contoh kasus Penjelasan Khusus Kode ICD dalam Kategori MDC 31

Contoh 3	Pasien datang dengan cedera saat mengendarai mobil dan menabrak pohon. Setelah dilakukan pemeriksaan radiologi dokter mendiagnosis multiple fraktur terbuka pada leher femur kanan, tibia kanan dan ditemukan perdarahan epidural. Pada kondisi tersebut dilakukan tatalaksana observasi perdarahan dan nyeri.	
	Diagnosis Dokter	Pengode memberi kode
Diagnosis utama	Multipel fraktur terbuka pada leher femur kanan dan tibia kanan	T02.31 <i>Open Fractures involving multiple regions of one lower limb</i>
Diagnosis sekunder	Perdarahan Epidural	S06.4 <i>Epidural haemorrhage</i> S72.01 <i>Open Fracture of neck of femur</i> S82.21 <i>Open Fracture of shaft of tibia</i>

Penyebab eksternal	Pengemudi mobil terluka karena menabrak pohon	V47.59 <i>Car occupant injured in collision with fixed or stationary object</i>
---------------------------	---	---

Tabel C.126. Contoh kasus Penjelasan Khusus Kode ICD dalam Kategori MDC 31

Contoh 4	Pasien datang dengan luka trauma akibat mengendarai mobil dan menabrak pohon. Dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami fraktur leher femur terbuka, kontusio serebral fokal (<i>focal cerebral contusion</i>), kehilangan kesadaran (<i>loss of consciousness</i>), memar pada wajah, leher, dan kandung kemih (<i>contusion of face, neck, and bladder</i>), serta luka robek pada pipi, paha dan telinga (<i>laceration of cheek, thigh and ear</i>). Dokter melakukan tindakan ORIF untuk menatalaksana fraktur leher femur terbuka, penjahitan luka robek pipi, paha dan telinga dan di rawat di ICU.	
	Diagnosis Dokter	Pengode memberi kode
Diagnosis utama	Fracture leher femur terbuka	S72.01 <i>Open Fracture of neck femur</i>
Diagnosis sekunder	Kontusio serebral fokal Penurunan kesadaran ec. <i>conticious cerebral focal</i> Luka robek telinga Laserasi pipi Laserasi paha Memar wajah Memar leher Memar bahu	S06.3 <i>Focal brain injury</i> S06.0 <i>Concussion</i> S01.3 <i>Open wound of ear</i> S01.40 <i>Open wound of cheek</i> ^(IM) S71.1 <i>Open wound of thigh</i>
Penyebab eksternal	Pengemudi mobil terluka dalam tabrakan dengan pohon	V47.59 <i>Car occupant injured in collision with fixed or stationary object</i>
Prosedur	<i>Open Reduction Internal Fixation (ORIF)</i> Penjahitan luka robek pada telinga Penjahitan luka robek pipi dan paha	79.35 <i>Open reduction of fracture with internal fixation, femur</i> 18.4 <i>Suture of laceration of external ear</i> 86.59 <i>Closure of skin and subcutaneous tissue of other sites</i>

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 31

Apabila terdapat kasus cedera multipel dan tidak dapat ditentukan sebagai diagnosis utama, gunakan kode multipel dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika jenis cederanya sama dan berada pada satu regio tubuh yang sama, gunakan karakter keempat ‘.7’ pada kode blok S00-S99.
- 2) Jika jenis cedera tidak sama, tetapi berada pada satu regio tubuh yang sama, gunakan karakter keempat ‘.7’ pada kategori terakhir masing-masing blok, seperti S09, S19, S29, dst.
- 3) Jika jenis cedera sama tetapi berada di regio tubuh yang berbeda, gunakan kode pada blok T00-T05.

Perhatikan pengecualian berikut:

- 4) Jika cedera internal yang dicatat bersama dengan hanya cedera permukaan dan/atau luka terbuka, gunakan kode cedera internal untuk mengode diagnosis tersebut.
- 5) Jika fraktur tulang tengkorak dan muka yang berhubungan dengan cedera intrakranium, gunakan kode cedera intrakranium untuk mengode diagnosis tersebut.
- 6) Jika perdarahan intrakranium yang tercatat bersama cedera lain yang hanya di kepala, kode perdarahan intrakranium untuk mengode diagnosis tersebut.
- 7) Jika fraktur yang tercatat dengan luka terbuka hanya di lokasi yang sama, gunakan kode fraktur untuk mengode diagnosis tersebut.

26. **MDC 32 LUKA BAKAR**

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 32

1) *Burns And Corrosions Of External Body Surface, Specified By Site (T20-T25)*

Kode T20-T25 digunakan untuk luka bakar dan/atau luka korosif pada permukaan tubuh bagian luar yang ditentukan berdasarkan lokasi atau bagian tubuh. Gunakan kode spesifik untuk lokasi luka (misalnya lengan, dada, atau tungkai), tingkat keparahannya (derajat satu, dua, atau tiga) dan persentase luas area luka. Kode luas area luka menjadi kode tambahan untuk memberikan informasi tingkat keparahan cedera

Tabel C.127. Contoh kasus *Burns And Corrosions Of External Body Surface, Specified By Site*

Contoh 1	Pasien anak datang dengan luka bakar akibat terkena api unggun di perkemahan hutan pramuka. Dokter mendiagnosis luka bakar derajat tiga pada dada (18% dari permukaan tubuh) dan dilakukan tindakan <i>debridement</i> berulang sebanyak 3x di ruang operasi untuk penanganan luka bakarnya.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Luka bakar derajat tiga pada dada (18% dari permukaan tubuh)	T21.3 <i>Burn of third degree of trunk</i>
Diagnosis Sekunder	-	T31.1 <i>Burns involving 10-19% of body surface</i>
Penyebab Eksternal	Terkena api unggun di perkemahan hutan pramuka	X03.89 <i>Exposure to controlled fire, not in building or structure, other specified area during unspecified activity</i>
Prosedur	Debridemen sebanyak 3x	86.22 <i>Excisional debridement of wound, infection, or burn</i> (dalam iDRG inputkan <i>multiplicity</i> kode dengan menuliskan “3” di kolom <i>setting</i> atau menginput 86.22 sebanyak 3x)

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 32

- 1) Jika dokter mendiagnosis luka bakar dengan luas area luka bakar tertentu, gunakan kode pada kategori T31.- (*Burns classified according to extent of body surface involved*).

- 2) Jika dokter mendiagnosis luka korosif dengan luas area luka korosif tertentu, gunakan kode pada kategori T32.- (*Corrosions classified according to extent of body surface involved*).
- 3) Jika dokter melakukan prosedur *escharotomy*, gunakan kode 83.15 (*Escharotomy*)^(IM)
- 4) Untuk Penggunaan Albumin IM code also DH 03 Human Albumin.

27. **MDC 33 INJURIES, POISONING & CERTAIN OTHER CONSEQUENCES OF EXTERNAL CAUSES**

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 33

Ketika mengkode cedera, keracunan atau trauma lain (Bab XIX), tambahkan kode penyebab eksternal (Bab XX) untuk menjelaskan sebab luar seperti : penyebab, lokasi, dan aktivitas saat kejadian.

1) *Poisoning By Drugs, Medicaments And Biological Substances (T36-T50)*

Jika dokter mendiagnosis keracunan akibat obat atau bahan kimia, gunakan kode pada kelompok T36 – T50 yang mencakup berbagai jenis zat penyebab keracunan. Selain itu, dokumentasikan penyebab eksternal dengan menggunakan kode dalam Bab XX.

Jika dokter mendiagnosis pasien mengalami efek samping obat, gunakan kode sesuai dengan efek samping obat dan tambahkan kode dari kelompok Y sebagai kode penyebab eksternal.

Tabel C.128. Contoh kasus *Poisoning By Drugs, Medicaments And Biological Substances*

Contoh 1	Pasien datang dengan mual, kulit dan mata kuning. Pasien mempunyai riwayat tuberkulosis rutin mengonsumsi OAT. Dokter mendiagnosis <i>drug induced liver injury</i> (DILI) dengan hepatitis akut karena efek samping obat OAT.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Cedera hati akibat obat dengan hepatitis akut	K71.2 <i>Toxic liver disease with acute hepatitis</i>
Diagnosis Sekunder	-	
Penyebab Eksternal	Efek samping OAT	Y41.1 <i>Antimycobacterial drugs</i>

2) *Post-Traumatic Wound Infection, Not Elsewhere Classified (T79.3)*

Jika dokter mendiagnosis infeksi luka yang terjadi akibat trauma atau cedera, gunakan kode T79.3 (*Posttraumatic wound infection, not elsewhere classified*).

3) *Compartment Syndrome (T79.6, M62.2)*

Jika dokter mendiagnosis *traumatic compartment syndrome* atau *Volkmann's ischemic contracture*, gunakan kode T79.6 (*Traumatic ischaemia of muscle*), dan tambahkan kode penyebab eksternal.

Jika dokter mendiagnosis *nontraumatic compartment syndrome*, gunakan kode M62.2 (*Ischaemic infarction of muscle*).

4) ***Infection following a procedure not elsewhere classified (T79.6) & Infection and inflammatory reaction due to other internal prosthetic devices, implants and grafts, not elsewhere classified (T85.7)***

Jika dokter mendiagnosis infeksi pada luka pasca operasi, gunakan kode T81.4 (*Infection following a procedure not elsewhere classified*) atau T85.7 (*Infection and inflammatory reaction due to other internal prosthetic devices, implants and grafts, not elsewhere classified*) dan tambahkan kode penyebab eksternal dari kelompok Y60 – Y69 atau Y83 – Y84 yang menjelaskan konteks prosedur medis terkait.

5) ***Mechanical Complication of Internal Fixation Device of Bones (T84.1 & T84.2)***

Jika dokter mendiagnosis komplikasi mekanis seperti :*breakdown (mechanical), displacement, leakage, malposition, obstruction, mechanical, perforation, protrusion* yang disebabkan oleh fiksasi internal pada tulang ekstremitas , gunakan kode T84.1 (*Mechanical complication of internal fixation device of bones of limb*). Namun, jika disebabkan oleh fiksasi internal pada tulang lainnya, gunakan kode T84.2 (*Mechanical complication of internal fixation device of other bones*).

Tabel C.129. Contoh kasus *Mechanical Complication of Internal Fixation Device of Bones*

Contoh 2	Pasien dengan riwayat operasi stabilisasi tulang belakang (PLIF L4-L5) 1,5 tahun yang lalu datang mengeluhkan nyeri punggung bawah hebat yang menjalar ke paha kiri sejak dua bulan terakhir. Dari hasil pemeriksaan fisik dan evaluasi radiologis, ditemukan adanya komplikasi mekanis berupa pergeseran dan terlepasnya (<i>pulled out</i>) <i>pedicle screw</i> pada pedikel L4 kiri. dokter mendiagnosis komplikasi mekanis implan fiksasi internal tulang belakang dan menjalani operasi pengangkatan implan lama.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	<i>Pulled Out Pedicle screw</i> pada pedikel L4 kiri	T84.2 <i>Mechanical complication of internal fixation device of other bones</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Pengangkatan implan lama	78.69 <i>Removal of implanted devices from bone, other</i>

6) ***Infection and Inflammatory Reaction due to Internal Fixation Device [Any Site] (T84.6)***

Jika dokter mendiagnosis infeksi dan reaksi inflamasi yang disebabkan oleh alat fiksasi internal di lokasi manapun, gunakan kode T84.6 (*Infection and inflammatory reaction due to internal fixation device [any site]*).

Jika dokter mendiagnosis infeksi yang terjadi setelah pemasangan fiksasi internal (seperti implan atau alat ortopedi lainnya), gunakan kode T84.6 (*Infection and inflammatory reaction due to internal fixation device [any site]*) dan tambahkan kode penyebab eksternal Y83.1 (*Surgical operation with implant of artificial internal device*).

7) *Complications of other internal prosthetic devices, implants and grafts (T85,-)*

Jika dokter mendiagnosis komplikasi mekanis seperti *breakdown (mechanical), displacement, leakage, malposition, obstruction, mechanical, perforation, protrusion* pada alat prosetetik lainnya, implan dan *graft*, gunakan kode T85.-.

Jika dokter mendiagnosis komplikasi mekanis pada alat prostetik mata lainnya, implan, dan cangkok (*graft*), gunakan kode T85.3 (*Mechanical complication of other ocular prosthetic devices, implants and grafts*).

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 33

1) Subdivisi karakter keempat pada kategori W00-Y34 kecuali Y06-Y07 digunakan untuk mengidentifikasi tempat kejadian eksternal. Subdivisi karakter kelima pada kategori V01-Y34 digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas saat kejadian.

2) Untuk kasus kecelakaan, lihat pada catatan sebelum blok kodenya. *The following fourth-character subdivisions are for use with categories V20-V28 :*

.0	<i>Driver</i>	<i>injured</i>	<i>in</i>	<i>nontraffic</i>	<i>accident</i>
.1	<i>Passenger</i>	<i>injured</i>	<i>in</i>	<i>nontraffic</i>	<i>accident</i>
.2	<i>Unspecified</i>	<i>motorcycle rider</i>	<i>injured</i>	<i>in nontraffic</i>	<i>accident</i>
.3	<i>Person</i>	<i>injured</i>	<i>while</i>	<i>boarding or</i>	<i>alighting</i>
.4	<i>Driver</i>	<i>injured</i>	<i>in</i>	<i>traffic</i>	<i>accident</i>
.5	<i>Passenger</i>	<i>injured</i>	<i>in</i>	<i>traffic</i>	<i>accident</i>
.9	<i>Unspecified motorcycle rider injured in traffic accident</i>				

28. MDC 34 NEOPLASMA

Pengodean neoplasma dilakukan dengan menggabungkan kode topografi dan kode morfologi. Kode topografi menunjukkan lokasi anatomis neoplasma, yaitu kode C00-C97 untuk neoplasma ganas, serta kode D00-D48 untuk neoplasma jinak, *in situ*, dan tidak diketahui jenisnya (*uncertain behavior*). Kode morfologi mengacu pada volume 1 ICD 10 tahun 2010 dan kode *Indonesian Modification* (IM) pada bagian *Morphology Of Neoplasms*.

a. PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 34

1) Prosedur Terapi Kanker (Kemoterapi, Radioterapi)

Jika pasien datang untuk menjalankan sesi kemoterapi oral pada neoplasma, gunakan kode Z51.1 (*Chemotherapy session for neoplasm*) dan tambahkan kode neoplasmanya.

Jika pasien datang untuk menjalankan sesi kemoterapi injeksi pada neoplasma, gunakan kode Z51.1 (*Chemotherapy session for neoplasm*), tambahkan kode neoplasmanya dan gunakan kode tindakan 99.25 (*Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance*).

Jika pasien datang melakukan sesi radioterapi pada neoplasma, gunakan kode Z51.0 (*Radiotherapy session*), tambahkan kode neoplasmanya dan gunakan kode tindakan radioterapi yang dilakukan.

Jika pasien datang melakukan sesi radioterapi bersamaan dengan kemoterapi injeksi pada neoplasma, gunakan kode Z51.0 (*Radiotherapy session*), Z51.1 (*Chemotherapy session for neoplasm*), tambahkan kode neoplasmanya dan gunakan kode tindakan 99.25 (*Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance*) serta gunakan kode tindakan radioterapi yang dilakukan.

Jika pasien datang untuk menjalani tindakan kemoterapi intra-arterial dengan metode *Transarterial Chemoembolization* (TACE), gunakan kode Z51.1 (*Chemotherapy session for neoplasm*), tambahkan kode neoplasmanya, dan gunakan kode tindakan 99.250 (*Transarterial chemoembolization (TACE)*)^(IM)

Tabel C.130. Contoh kasus Prosedur Terapi Kanker

Contoh 1	Pasien di diagnosa kanker payudara pada area kuadran bawah dalam direncanakan untuk menjalani kemoterapi injeksi sesuai dengan siklus kemoterapi yang ditetapkan oleh DPJP.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Kanker payudara pada area kuadran bawah-dalam on kemoterapi injeksi	Z51.1 <i>Chemotherapy session for neoplasm</i>

Diagnosis Sekunder	-	C50.3 <i>Lower-inner quadrant of breast</i>
Prosedur	Injeksi Kemoterapi	99.25 <i>Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance</i>

Tabel C.131. Contoh kasus Prosedur Terapi Kanker

Contoh 2	Pasien datang terdiagnosa kanker payudara pada area kuadran bawah yang direncanakan prosedur <i>external beam radiotherapy</i> (EBRT).	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Kanker payudara pada area kuadran bawah on radioterapi	Z51.0 (<i>Radiotherapy session</i>)
Diagnosis Sekunder	-	C50.3 <i>Lower-inner quadrant of breast</i>
Prosedur	External Beam Radiotherapy (EBRT)	92.23 (<i>Radioisotopic teleradiotherapy</i>)

Tabel C.132. Contoh kasus Prosedur Terapi Kanker

Contoh 3	Pasien datang terdiagnosa kanker payudara pada area kuadran bawah dan direncanakan pemberian kemoterapi injeksi bersamaan dengan prosedur External beam radiotherapy (EBRT).	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Kanker payudara pada area kuadran bawah on kemo-radiasi	Z51.1 <i>Chemotherapy session for neoplasm</i>
Diagnosis Sekunder	-	Z51.0 (<i>Radiotherapy session</i>) C50.3 <i>Lower-inner quadrant of breast</i>
Prosedur	Injeksi Kemoterapi	99.25 <i>Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance</i>
	External Beam Radiotherapy (EBRT)	92.23 (<i>Radioisotopic teleradiotherapy</i>)

2) Komplikasi Terkait dengan Keganasan

Jika dokter mendidagnosis anemia pada pasien yang menderita keganasan yang dilakukan transfusi sel darah merah, gunakan kode D63.0* (*Anaemia in neoplastic disease*), kode keganasannya dan tambahkan kode tindakan 99.04 (*Transfusion of packed cells*).

Tabel C.133. Contoh kasus Komplikasi Terkait dengan Keganasan

Contoh 4	Pasien dengan kanker payudara pada area kuadran atas dalam dengan jenis <i>adenoid cystic carcinoma</i> direncanakan untuk <i>total mastectomy bilateral</i> . pasien juga mengalami anemia, diberikan transfusi <i>packed red cells</i> dan dilakukan <i>total mastectomy bilateral</i> .	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	Kanker Payudara pada area kuadran atas-dalam	C50.2† <i>Upper-inner quadrant of breast</i>
Diagnosis Sekunder	Anemia pada kanker	D63.0* <i>Anaemia in neoplastic disease</i>
Prosedur	Total Mastectomy bilateral	85.42 <i>Bilateral simple mastectomy</i>
	Transfusi <i>packed red cells</i>	99.04 <i>Transfusion of packed cells</i>
Morfologi	<i>Adenoid cystic carcinoma</i>	M8200/3 <i>Adenoid cystic carcinoma</i>

Jika dokter mendiagnosis paraneoplastik polineuropati pada pasien yang masih memiliki kanker, gunakan kode kanker dan tambahkan kode G63.1* (*Polyneuropathy in neoplastic disease*).

3) Kode Morfologi Neoplasma

Kode morfologi neoplasma dimulai dengan huruf "M", diikuti oleh 5 digit angka. Empat digit pertama menunjukkan jenis jaringan neoplasma, sedangkan digit kelima, yang dipisahkan oleh garis miring (/), menunjukkan perilaku neoplasma tersebut. Digit kelima terdiri dari:

Tabel C.134. Kode Morfologi Neoplasma

Perilaku Kode	Deskripsi	Bab II Kategori
/0	<i>Benign neoplasms</i>	D10-D36
/1	<i>Neoplasms of uncertain and unknown behaviour</i>	D37-D48
/2	<i>In situ neoplasms</i>	D00-D09
/3	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary</i>	C00-C76; C80-C96

/6	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be secondary</i>	C77-C79
/9	Neoplasma ganas, tidak pasti apakah situs primer atau metastasis	

4) ***Periampullary Carcinoma (C17.0, C24.0, C24.1, C25.0)***

Jika dokter mendiagnosis kanker yang terletak di duodenum bagian atas, gunakan kode C17.0 (*Malignant neoplasm of duodenum*).

Jika dokter mendiagnosis kanker yang terletak di saluran empedu ekstrahepatik distal, gunakan kode C24.0 (*Malignant neoplasm of extrahepatic bile duct*).

Jika dokter mendiagnosis kanker yang terletak di *ampulla of Vater*, gunakan kode C24.1 (*Malignant neoplasm of ampulla of Vater*).

Jika dokter mendiagnosis kanker terletak di kepala pankreas, gunakan kode C25.0 (*Malignant neoplasm of head of pancreas*).

5) ***Liver Carcinoma (C22.-)***

Jika dokter mendiagnosis hepatoma atau hepatocellular carcinoma, gunakan kode C22.0 (*Liver cell carcinoma*).

Jika dokter mendiagnosis *intrahepatic cholangiocarcinoma* atau cholangiocarcinoma, gunakan kode C22.1 (*Intrahepatic bile duct carcinoma*).

Jika dokter mendiagnosis hanya menyebutkan *liver tumor*, gunakan kode D37.6 (*Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of liver, gallbladder, and bile ducts*).

Jika dokter mendiagnosis *liver mass* yang tidak spesifik, gunakan kode K76.9 (*Liver disease, unspecified*).

6) ***Ewing's Sarcoma (C40-C41)***

Jika dokter mendiagnosis neoplasma ganas pada tulang panggul, gunakan kode C41.4 (*Malignant neoplasm of pelvic bones, sacrum, and coccyx*).

Jika dokter mendiagnosis neoplasma ganas pada jaringan lunak lengan atas, gunakan kode C49.1 (*Malignant neoplasm of connective and soft tissue of upper limb, including shoulder*), kemudian tambahkan kode morfologi :

M9260/3 *Ewing's sarcoma*

M9473/3 *Primitive neuroectodermal tumor*

M9364/3 *Peripheral neuroectodermal tumor*

7) *Carcinoma Mammæ (C50.-)*

Jika dokter mendiagnosis neoplasma ganas payudara, gunakan kode dalam kelompok C50.- (*Malignant neoplasm of breast*) sesuai lokasi anatomi neoplasma pada payudara.

Jika dokter mendiagnosis *breast tumour*, gunakan kode D48.6 (*Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of breast*).

8) *Carcinoma of cervix (C53.-)*

Jika dokter mendiagnosis neoplasma ganas serviks, gunakan kode dalam kelompok C53.- (*Malignant neoplasm of cervix uteri*) sesuai lokasi anatomi neoplasma.

Jika dokter mendiagnosis neoplasma ganas *endocervix*, gunakan C53.0 (*Endocervix*).

Jika dokter mendiagnosis neoplasma ganas *exocervix*, gunakan C53.1 (*Exocervix*).

Jika dokter mendiagnosis neoplasma ganas serviks yang tidak spesifik, gunakan C53.1 (*Cervix uteri, unspecified*).

9) *Malignant neoplasm of corpus uteri (C54-C55)*

Jika dokter mendiagnosis neoplasma ganas pada uterus gunakan kode dalam kelompok C54.- (*Malignant neoplasm of corpus uteri*) sesuai lokasi anatomi:

C54.0 (*Isthmus uteri*)

C54.1 (*Endometrium*)

C54.2 (*Myometrium*)

C54.3 (*Fundus uteri*)

C54.8 (*Overlapping lesion of corpus uteri*)

C54.9 (*Corpus uteri, unspecified*)

10) *Neoplasm of ovary (C56, D27, D39.1)*

Jika dokter mendiagnosis tumor ovarium jenis *cystadenoma* dengan *borderline malignancy* atau *low malignant potential*, gunakan kode C56 (*Malignant neoplasm of ovary*).

Jika dokter mendiagnosis neoplasma ganas pada ovarium , gunakan kode C56 (*Malignant neoplasm of ovary*).

Jika dokter mendiagnosis *benign neoplasm of ovary*, gunakan kode D27 (*Benign neoplasm of ovary*).

Jika dokter mendiagnosis *ovarian tumour*, gunakan kode D39.1 (*Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of ovary*).

11) Primary and Secondary Neoplasm Coding

Jika pada fokus utama perawatan pasien adalah kanker metastasis, gunakan kode kanker metastasis (*secondary*) dan tambahkan kode kanker primernya.

Jika dokter mendiagnosis kanker metastasis dengan riwayat kanker primer yang sudah tertangani, gunakan kode kanker metastasis (*secondary*) dan tambahkan kode Z85.- (*Personal history of malignant neoplasm*).

12) Benign neoplasm of bone and articular cartilage (D16)

Jika dokter mendiagnosis *exostosis benign*, gunakan kode dalam kelompok D16.- (*Benign neoplasm of bone and articular cartilage*), sesuai lokasi anatomi neoplasma.

Jika dokter mendiagnosis *congenital multiple exostoses*, *hereditary multiple exostoses*, atau *multiple osteochondromatosis*, gunakan kode Q78.6 (*Multiple congenital exostoses*).

13) Leiomyoma of Uterus (D25.-)

Jika dokter mendiagnosis myoma uteri dengan lebih dari satu jenis, gunakan kode D25.7 (*Leiomyoma of uterus, multiple sites*) ^(IM), dan tambahkan kode D25.0 (*Submucous leiomyoma of uterus*), D25.1 (*Intramural leiomyoma of uterus*), dan/atau D25.2 (*Subserosal leiomyoma of uterus*) sesuai lokasi anatomi myoma uteri.

Jika dokter mendiagnosis myoma uteri yang tidak spesifik, gunakan kode D25.9 (*Leiomyoma of uterus, unspecified*).

14) Craniopharyngioma (D35.3, D44.4)

Jika dokter mendiagnosis *craniopharyngioma benign*, gunakan kode D35.3 (*Benign neoplasm of craniopharyngeal duct*).

Jika dokter mendiagnosis *craniopharyngioma uncertain*, gunakan kode D44.4 (*Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of craniopharyngeal duct*).

b. PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 34

Layanan Kedokteran Nuklir dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu nuclear medicine dan nuclear diagnostic :

- 1) *Nuclear Medicine* menggunakan kode tindakan 92.28 *Injection or instillation of radioisotopes* atau 92.29 *Other radiotherapeutic procedure* sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan tambahkan kode IM radiofarmaka.

Jika dokter melakukan prosedur injeksi radioisotop, gunakan kode tindakan 92.28 (*Injection or instillation of radioisotopes*) dan tambahkan kode IM radiofarmaka yang digunakan.

Jika dokter melakukan prosedur isotop lainnya, gunakan kode tindakan 92.29 (*Other radiotherapeutic procedure*) dan tambahkan kode IM radiofarmaka yang digunakan.

- 2) *Nuclear Diagnostic* menggunakan kode tindakan 92.5- ^(IM) sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan tambahkan kode IM farmakoterapi.

Jika dokter melakukan prosedur pemeriksaan tes fungsi tiroid, gunakan kode prosedur 92.50 (*Non-Imaging Nuclear Medicine Thyroid Function Test*)^(IM).

Jika dokter melakukan prosedur pemeriksaan penanda kanker tiroid, gunakan kode prosedur 92.51 (*Non-Imaging Nuclear Medicine Thyroid Cancer Marker*)^(IM).

Jika dokter melakukan prosedur pemeriksaan tes antibodi tiroid, gunakan kode prosedur 92.52 (*Non-Imaging Nuclear Medicine Thyroid Antibody Test*)^(IM).

- 3) Tata cara pengodean pada pelayanan kedokteran nuklir harus ditambahkan dengan kode IM Farmakoterapinya tanpa diawali dengan kode Z51.0 *Radiotherapy Session*.

4) Layanan Kedokteran Nuklir

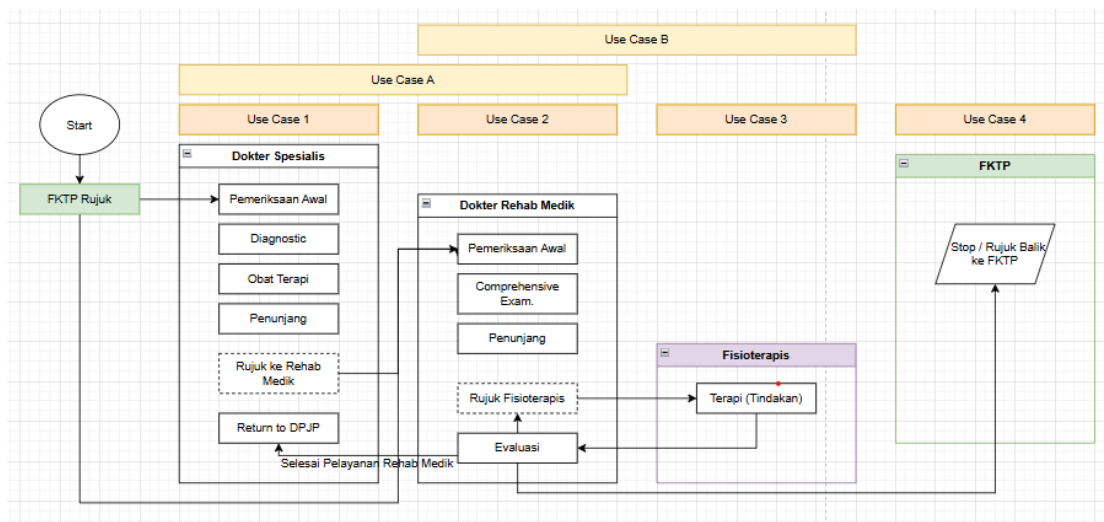
Jika pasien datang untuk mendapatkan layanan kedokteran nuklir tanpa penggunaan injeksi radioisotop, gunakan kode diagnosis sesuai kondisi tanpa kode Z51.0 (*Radiotherapy Session*).

5) Layanan CT Simulation dan TPS

Jika pasien datang untuk mendapatkan layanan *CT Simulation* dan TPS, gunakan kode diagnosis sesuai kondisi dan tambahkan kode tindakan yang diberikan :

- 6) 88.380 CT simulator 3D ^(IM)
- 7) 88.381 CT simulator: Intensity-Modulated Radiotherapy (IMRT) / Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) ^(IM)
- 8) 88.382 CT simulator: stereotactic ^(IM)
- 9) 88.383 CT simulator 4D^(IM)
- 10) 88.384 CT simulator: Deep Inspiration Breath Hold (DIBH) ^(IM)
- 11) 88.390 Conventional simulator ^(IM)

29. **MDC 35 REHABILITASI MEDIK**



Gambar C.6. Alur Rehabilitasi Medik

Jika pasien datang untuk melakukan prosedur rehabilitasi medik, gunakan kode dari kelompok Z50.- (*Care involving use of rehabilitation procedures*), tambahkan kode penyakitnya dan gunakan kode tindakan terapi rehabilitasi mediknya.

Tabel C.135. Contoh kasus Terapi Rehabilitasi

Contoh 1	Pasien dengan diagnosa <i>Low back Pain</i> (LBP), dari hasil assessment dokter memberikan terapi rehabilitasi berupa peregangan, dan infrared.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Menetapkan Kode
Diagnosis Utama	terapi rehabilitasi medik	Z50.1 (<i>Other physical therapy</i>)
Diagnosis Sekunder	<i>Low back Pain</i> (LBP)	M54.5 <i>Low Back pain</i>
Prosedur	Terapi rehabilitasi berupa peregangan, dan infrared	93.27 <i>Stretching of muscle or tendon</i> 93.35 <i>Other heat therapy</i>

30. MDC 36 UNGROUPABLE ATAU UNRELATED

Ungroupable atau *unrelated* akan muncul ketika sistem grouper tidak bisa menemukan kecocokan antara kode diagnosis dan tindakan yang dimasukkan ke dalam sistem. Sesuai dengan aturan pada ICD-10 diantaranya ada beberapa kode yang hanya bisa dipakai untuk laki-laki, perempuan, bayi baru lahir maupun berdasarkan rentang usia. Jika ditemukan ketidaksesuaian tersebut, maka sistem secara otomatis akan masuk ke MDC 36.

Dalam kondisi *error grouping* (*Ungroupable* atau *unrelated*), pengode dapat memperbaiki kesalahan tersebut dan menginputnya ke dalam sistem sesuai iDRG. Pengode diharapkan mampu menerapkan etika pengodingan sesuai dengan ICD-10 versi 2010 tidak hanya berdasarkan hafalan atau catatan dari kode yang sering muncul. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir adanya *error grouping* karena yang paling sering terjadi, pemberi kode tidak memasukkan *code also* atau *modifier* lain yang tidak berdampak signifikan pada *grouper* terdahulu.

a. Error Codes

b. 3611199 *Primary Diagnosis code is not valid for Female or Male*

Error pada kasus ini terjadi karena kode yang dimasukkan tidak sesuai, yaitu terdapat ketidaksesuaian antara jenis kelamin pasien dan diagnosis yang dicatat. Perhatikan kesesuaian diagnosis dengan jenis kelamin, karena ada kode yang hanya bisa digunakan untuk satu jenis kelamin laki-laki atau perempuan saja.

Contoh 1:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Primary Diagnosis code C56 is not valid for Male

Gambar C.7. Contoh error codes pada *Primary Diagnosis code is not valid for Male* atau

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Primary Diagnosis code N40 is not valid for Female

Gambar C.8. Contoh error codes pada *Primary Diagnosis code is not valid for Female*

Apabila terjadi hal demikian, silahkan identifikasi terlebih dahulu apakah jenis kelamin pasien sudah sesuai dengan kode diagnosisnya:

- 1) Jika jenis kelamin yang tidak sesuai, silahkan ganti terlebih dahulu jenis kelamin dalam sistemnya.
- 2) Jika kode diagnosis yang kurang tepat, silahkan cek ke dokumen rekam medis dan konfirmasi terlebih dahulu kepada dokter untuk dilakukan perbaikan.

c. 3611299 *Diagnosis code is not valid for patient's age*

Error pada kasus ini terjadi karena adanya kesalahan pemilihan kode diagnosis yang tidak sesuai dengan usia pasien. Perhatikan kesesuaian diagnosis dengan rentang usia, karena ada kode yang hanya bisa digunakan untuk usia <28 hari maupun rentang usia yang lain.

Contoh 1:

MDC	Ungroupable or Unrelated	36
DRG	Diagnosis code H25.9 is not valid for patient's age : 4 years 11322 1824 45290	3611299

Gambar C.9. Contoh error codes pada *Diagnosis code is not valid for patient's age*

Apabila terjadi hal demikian, silahkan cek terlebih dahulu kesesuaian usia pasien atau kode diagnosis yang kurang tepat:

- 1) Jika data yang kurang tepat, silahkan perbaiki data pasiennya
- 2) Jika kode diagnosis yang kurang tepat, silahkan cek ke dokumen rekam medis dan konfirmasi terlebih dahulu kepada dokter untuk dilakukan perbaikan.

d. 3600019 *Unrelated OR Procedure*

Error pada kasus ini terjadi karena kode diagnosis yang dicatat tidak sesuai dengan tindakan medis yang diberikan. Perhatikan kesesuaian antara kode diagnosis dengan kode tindakan yang dipilih agar tidak terjadi *Unrelated OR Procedure*. Jika kombinasi antara diagnosis dan tindakan sudah sesuai, maka tidak akan terjadi *Unrelated OR Procedure*.

Contoh *Unrelated OR Procedure*:

Jika kode diagnosis N47.1 (*Phimosis*) ^(IM) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode prosedur berupa 58.0 (*Urethrotomy*) ^(IM), maka akan terjadi *Unrelated OR Procedure* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Unrelated OR Procedure

Gambar C.10. Contoh error codes pada *Unrelated OR Procedure*

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis N47.1 (*Phimosis*) ^(IM) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode prosedur berupa 64.0 (*Circumcision*) ^(IM), maka tidak terjadi *Unrelated OR Procedure* seperti berikut:

MDC	Diseases and Disorders of the Male Reproductive System
DRG	Minor Penis Proc. w/ No CC

Gambar C.11. Contoh *Unrelated OR Procedure* yang benar

e. 3614129 Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Drug Type

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* jenis obat resisten yang harus diperbaiki dengan cara melengkapi dengan kode sebagai berikut:

Drug Types

U82.20(*Respiratory diseases with resistance of betalactamase (ESBL) resistance*)^(IM)

U82.80 (*Respiratory diseases with resistance of betalactam antibiotics*)^(IM)

U83.3 (*Respiratory diseases with resistance to other antibiotics*)^(IM)

U84.10(*Respiratory diseases with resistance to antifungal drugs*)^(IM)

U84.20(*Respiratory diseases with resistance to antiviral drugs*)^(IM)

U85.0 (*Respiratory diseases with resistance to antineoplastic drugs*)^(IM)

Contoh error:

Jika kode diagnosis A15.0 (*Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode tambahan (*additional code*) berupa U84.31 (*Tuberculosis with multidrug resistance*)^(IM) tanpa menambahkan *code also* jenis obat resisten sebagai kode tambahan, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Drug Type

Gambar C.12. Contoh error codes pada *Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Drug Type*

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis A15.0 (*Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode tambahan (*additional code*) berupa U84.31 (*Tuberculosis with multidrug resistance*)^(IM) dengan menambahkan *code also* jenis obat resisten berupa U83.3 (*Respiratory diseases with resistance to other antibiotics*)^(IM) sebagai kode tambahan, maka tidak akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Diseases and Disorders of the Respiratory System
DRG	Respiratory Drug Resistance TB

Gambar C.13. Contoh *Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Drug Type* yang benar

f. 3614229 Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Episode Type

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* episode dari resisten yang harus diperbaiki dengan cara melengkapi dengan kode berikut:

TB Episode of Care

U84.31(*Tuberculosis with multidrug resistance*)^(IM)

U84.32(*Tuberculosis with pre extreme drug resistance*)^(IM)

U84.33(*Tuberculosis with extreme drug resistance*)^(IM)

U84.34(*Tuberculosis with poly drug resistance*)^(IM)

U84.35(*Tuberculosis with mono drug resistance*)^(IM)

Contoh error:

Jika kode diagnosis A15.0 (*Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode tambahan (*additional code*) berupa U83.3 (*Respiratory diseases with resistance to other antibiotics*)^(IM) tanpa menambahkan *code also* episode dari resisten sebagai kode tambahan, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Episode Type

Gambar C.14. Contoh error codes pada *Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Episode Type*

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis A15.0 (*Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode tambahan (*additional code*) berupa U83.3 (*Respiratory diseases with resistance to other antibiotics*)^(IM) dengan menambahkan *code also* jenis obat resisten berupa U84.31 (*Tuberculosis with multidrug resistance*)^(IM) sebagai kode tambahan, maka tidak akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Diseases and Disorders of the Respiratory System
DRG	Respiratory Drug Resistance TB

Gambar C.15. Contoh *Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Episode Type* yang benar

g. 3615029 Error: Missing Code Also: Angiocardiography Proc.

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* prosedur angiokardiografi yang harus diperbaiki dengan cara melengkapi *coding* dengan kode berikut:

Angiocardiology Proc.

- 88.51 (*Angiocardiology of venae cavae*)
- 88.52 (*Angiocardiology of right heart structures*)
- 88.53 (*Angiocardiology of left heart structures*)
- 88.54 (*Combined right and left heart angiocardiology*)
- 88.55 (*Coronary arteriography using a single catheter*)
- 88.56 (*Coronary arteriography using two catheters*)
- 88.57 (*Other and unspecified coronary arteriography*)
- 88.58 (*Negative-contrast cardiac roentgenography*)

h. 3615129 Error: Missing Code Also: Catheterization Proc.

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* prosedur kateterisasi yang harus diperbaiki dengan cara melengkapi *coding* dengan kode berikut:

Catheterization Procedures

- 37.21 (*Right heart cardiac catheterization*)
- 37.22 (*Left heart cardiac catheterization*)
- 37.23 (*Combined right and left heart cardiac catheterization*)

i. 3615229 Error: Stent Insertion wo/ Number of Stent or Number of Vessels

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* dari prosedur pemasangan stent berupa jumlah stent yang dipasang dan/atau jumlah pembuluh darah yang dilakukan tindakan dengan cara melengkapi kode berikut:

Number of Stents

- 00.45 (*Adjunct vascular system procedures, Insertion of one vascular stent*)
- 00.46 (*Adjunct vascular system procedures, Insertion of two vascular stents*)
- 00.47 (*Adjunct vascular system procedures, Insertion of three vascular stents*)
- 00.48 (*Adjunct vascular system procedures, Insertion of four or more vascular stents*)

Number of Vessels

- 00.40 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on single vessel*)
- 00.41 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on two vessels*)
- 00.42 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on three vessels*)
- 00.43 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on four or more vessels*)

Contoh error:

Jika kode diagnosis I25.1 (*Atherosclerotic heart disease*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode prosedur utama berupa 00.66 (*Parcutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) or coronary atherectomy*) dan menambahkan kode 36.07 (*Insertion of drug- eluting coronary artery stent(s)*) tanpa menambahkan *code also* dari prosedur pemasangan stent sebagai kode tambahan, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Error coding: PTCA w/o Number of Vessels

Gambar C.16. Contoh error codes pada *Error: Stent Insertion wo/ Number of Stent or Number of Vessels*

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis I25.1 (*Atherosclerotic heart disease*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode prosedur utama berupa 00.66 (*Parcutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) or coronary atherectomy*) dan menambahkan kode 36.07 (*Insertion of drug- eluting coronary artery stent(s)*) dengan menambahkan *code also* dari prosedur pemasangan stent berupa kode 00.40 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on single vessel*) dan kode 00.45 (*Adjunct vascular system procedures, Insertion of one vascular stent*) sebagai kode tambahan, maka tidak akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Diseases and Disorders of the Circulatory System
DRG	PTCA (+Stent) w/ No CC

Gambar C.17. Contoh *Error: Stent Insertion wo/ Number of Stent or Number of Vessels* yang benar

Jika kode diagnosis I25.1 (*Atherosclerotic heart disease*) sebagai diagnosis utama dicantumkan dengan kode prosedur utama berupa 00.66 (*Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) or coronary atherectomy*) dan menambahkan kode 36.07 (*Insertion of drug- eluting coronary artery stent(s)*) dengan menambahkan *code also* dari prosedur pemasangan stent berupa kode 00.40 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on single vessel*) sebagai kode tambahan tanpa menambahkan kode 00.45 (*Adjunct vascular system procedures, Insertion of one vascular stent*) sebagai kode tambahan karena tidak dilakukan pemasangan stent maka akan mendapatkan DRG PTCA seperti berikut:

MDC	Diseases and Disorders of the Circulatory System
DRG	PTCA w/ No CC

Gambar C.18. Contoh *Error: Stent Insertion wo/ Number of Stent or Number of Vessels* yang benar

j. 3615329 Error: Number of Stent wo/ Insertion Proc.

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* dari prosedur pemasangan stent dengan cara melengkapi *coding* dengan kode berikut:

Stents Insertion Procedure

00.55 (*Insertion of drug-eluting peripheral vessels stent(s)*)

39.90 (*Insertion of non-drug -eluting peripheral vessel stent(s)*)

k. 3615429 Error: Angioplasty wo/ Number of Vessels

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* dari prosedur *angioplasty* berupa berapa banyak pembuluh darah yang dilakukan tindakan dengan cara melengkapi *coding* dengan kode berikut:

Number of Vessels

00.40 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on single vessel*)

00.41 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on two vessels*)

00.42 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on three vessels*)

00.43 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on four or more vessels*)

l. 3615529 Error: Missing code also (00.56 or 00.57)

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* dari prosedur rangkaian pemasangan alat pacu jantung dengan cara melengkapi *coding* dengan kode berikut:

Implantation or Replacement of Defibrillator

00.56 (*Insertion or replacement of implantable pressure sensor (lead) for intracardiac hemodynamic monitoring*)

00.57 (*Implantation or replacement of subcutaneous device for intracardiac hemodynamic monitoring*)

m. 3634819 Error blood transfusion for neoplasm without anemia

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean, yaitu tercantumnya kode tindakan untuk transfusi tanpa disertai input kode diagnosis anemia. Untuk memperbaikinya, perlu ditambahkan kode diagnosis anemia yang sesuai dengan kondisi keganasan dan diagnosis pasien.

Contoh error:

Jika kode diagnosis C20 (*Malignant neoplasm of rectum*) dicantumkan dengan kode prosedur berupa 99.04 (*Transfusion of packed cells*) tanpa disertai input kode

diagnosis anemia sebagai kode diagnosis tambahan, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Error blood transfusion for neoplasm without anemia

Gambar C.19. Contoh error codes pada *Error blood transfusion for neoplasm without anemia*

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis C20 (*Malignant neoplasm of rectum*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode prosedur berupa 99.04 (*Transfusion of packed cells*) dengan disertai input kode diagnosis anemia berupa D63.0* (*Anaemia in neoplastic disease*) sebagai kode diagnosis tambahan, maka tidak akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Neoplasm
DRG	Blood Transfusion for Neoplasm w/ Mild CC

Gambar C.20. Contoh *Error blood transfusion for neoplasm without anemia* yang benar

n. 36001x9 Ungroupable: Radiotherapy Session w/o Radiotherapy Proc

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean, yaitu terdapat kode diagnosis untuk radioterapi namun belum dilakukan input pada kode tindakan. Untuk memperbaikinya, tambahkan kode tindakan radioterapi yang sesuai dengan jenis radioterapi yang diberikan kepada pasien.

Therapeutic radiology

92.20 (*Infusion of liquid brachytherapy radioisotope*)

92.21 (*Superficial radiation*)

92.22 (*Orthovoltage radiation*)

92.23 (*Radioisotopic teleradiotherapy*)

92.24 (*Teleradiotherapy using photons*)

92.25 (*Teleradiotherapy using electrons*)

92.26 (*Teleradiotherapy of other particulate radiation*)

92.27 (*Implantation or insertion of radioactive elements*)

Contoh error:

Jika kode diagnosis Z51.0 (*Radiotherapy session*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode diagnosis sekunder berupa C71.9 (*Malignant neoplasm, brain, unspecified*) tanpa disertai input kode tindakan radioterapinya, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Ungroupable: Radiotherapy Session w/o Radiotherapy Proc.

Gambar C.21. Contoh error codes pada *Ungroupable: Radiotherapy Session w/o Radiotherapy Proc*

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis Z51.0 (*Radiotherapy session*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode diagnosis sekunder berupa C71.9 (*Malignant neoplasm, brain, unspecified*) dengan disertai input kode tindakan radioterapinya berupa 92.25 (*Teleraditherapy using electrons*), maka tidak akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Neoplasm
DRG	Radiotherapy

Gambar C.22. Contoh *Ungroupable: Radiotherapy Session w/o Radiotherapy Proc* yang benar

o. 36002x9 Ungroupable: Radiotherapy w/o Z51.0

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengkodean pada tindakan radioterapi berupa diagnosis radioterapi yang belum dilakukan input. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, tambahkan kode Z51.0 (*Radiotherapy Session*) seperti contoh diatas.

Contoh 1:

Jika kode diagnosis C71.9 (*malignant neoplasm, brain, unspecified*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan menambahkan kode prosedur berupa 92.25 (*Teleradiotherapy using electrons*) tanpa menambahkan kode Z51.0 (*Radiotherapy session*) sebagai kode diagnosis sekunder, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Ungroupable: Radiotherapy w/o Z51.0

Gambar C.23. Contoh error codes pada *Ungroupable: Radiotherapy w/o Z51.0*

p. 36003x9 Ungroupable: Chemotherapy Proc. without Z51.1

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengkodean, yaitu terdapat kode tindakan untuk kemoterapi namun kode diagnosis yang menyertainya belum dimasukkan. Untuk memperbaikinya, tambahkan kode diagnosis Z51.1 (*Chemotherapy Session for Neoplasm*) sesuai dengan prosedur yang dilakukan.

Contoh error:

Jika kode diagnosis C20 (*Malignant neoplasm of rectum*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan menambahkan kode prosedur berupa 99.25 (*Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance*) tanpa disertai kode diagnosis Z51.1 (*Chemotherapy Session for Neoplasm*) sesuai dengan prosedur yang dilakukan, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Ungroupable: Chemotherapy Proc. without Z51.1

Gambar C.24. Contoh error codes pada *Ungroupable: Chemotherapy Proc. without Z51.1*

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis C20 (*Malignant neoplasm of rectum*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan menambahkan kode prosedur berupa 99.25 (*Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance*) dengan ditambahkan kode diagnosis Z51.1 (*Chemotherapy Session for Neoplasm*) sebagai diagnosis tambahan sesuai dengan prosedur yang dilakukan, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Neoplasm
DRG	Chemotherapy (Injection)

Gambar C.25. Contoh *Ungroupable: Chemotherapy Proc. without Z51.1* yang benar

q. 3635129 Ungroupable: Rehabilitation without Procedures

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan kode dari tindakan rehabilitasi medis yang harus diperbaiki dengan cara melengkapi dengan kode berikut sesuai dengan tindakan yang diberikan kepada pasien:

Functional Diagnostic & Evaluation

88.79 (*Other diagnostic ultrasound*)

89.22 (*Cystometrogram*)

89.23 (*Urethral sphincter electromyogram*)

89.24 (*Uroflowmetry (UFR)*)

89.25 (*Urethral pressure profile (UPP)*)

89.34 (*Digital examination of rectum*)

89.37 (*Vital capacity determination*)

89.38 (*Other nonoperative respiratory measurements*)

89.41 (*Cardiovascular stress test using treadmill*)

89.42 (*Masters' two-step stress test*)

89.43 (*Cardiovascular stress test using bicycle ergometer*)

93.01 (*Functional evaluation*)

- 93.02 (*Orthotic evaluation*)
- 93.03 (*Prosthetic evaluation*)
- 93.04 (*Manual testing of muscle function*)
- 93.05 (*Range of motion testing*)
- 93.06 (*Measurement of limb length*)
- 93.08 (*Electromyography*)
- 93.09 (*Other diagnostic physical therapy procedure*)

Orthotic Prosthetic Proc.

- 84.40 (*Implantation or fitting of prosthetic limb device, not otherwise specified*)
- 84.41 (*Fitting of prosthesis of upper arm and shoulder*)
- 84.42 (*Fitting of prosthesis of lower arm and hand*)
- 84.43 (*Fitting of prosthesis of arm, not otherwise specified*)
- 84.45 (*Fitting of prosthesis above knee*)
- 84.46 (*Fitting of prosthesis below knee*)
- 84.47 (*Fitting of prosthesis of leg, not otherwise specified*)
- 93.23 (*Fitting of orthotic device*)
- 93.52 (*Application of neck support*)
- 93.53 (*Application of other cast*)
- 97.13 (*Replacement of other cast*)

Therapeutic Exercise Procedures

- 93.11 (*Assisting exercise*)
- 93.12 (*Other active musculoskeletal exercise*)
- 93.13 (*Resistive exercise*)
- 93.14 (*Training in joint movements*)
- 93.17 (*Other passive musculoskeletal exercise*)
- 93.18 (*Breathing exercise*)
- 93.19 (*Exercise, not elsewhere classified*)
- 93.22 (*Ambulation and gait training*)
- 93.24 (*Training in use of prosthetic or orthotic device*)
- 93.27 (*Stretching of muscle or tendon*)
- 93.28 (*Stretching of fascia*)
- 93.29 (*Other forcible correction of deformity*)
- 93.31 (*Assisted exercise in pool*)

- 93.32 (*Whirlpool treatment*)
- 93.33 (*Other hydrotherapy*)
- 93.36 (*Cardiac retraining*)
- 93.37 (*Prenatal training*)
- 93.38 (*Combined physical therapy without mention of the components*)

Therapeutic Procedures with Modality

- 93.34 (*Diathermy*)
- 93.35 (*Other heat therapy*)
- 99.27 (*Iontophoresis*)
- 99.81 (*Hypothermia (central) (local)*)
- 99.82 (*Ultraviolet light therapy*)
- 99.83 (*Other phototherapy*)

Therapeutic Manipulation Procedures

- 76.95 (*Other manipulation of temporomandibular joint*)
- 93.15 (*Mobilization of spine*)
- 93.16 (*Mobilization of other joints*)
- 93.21 (*Manual and mechanical traction*)
- 93.25 (*Forced extension of limb*)
- 93.26 (*Manual rupture of joint adhesions*)
- 93.61 (*Osteopathic manipulative treatment for general mobilization*)
- 93.62 (*Osteopathic manipulative treatment using high-velocity, low-amplitude forces*)
- 93.63 (*Osteopathic manipulative treatment using low- velocity, high-amplitude forces*)
- 93.64 (*Osteopathic manipulative treatment using isotonic, isometric forces*)
- 93.65 (*Osteopathic manipulative treatment using indirect forces*)
- 93.66 (*Osteopathic manipulative treatment to move tissue fluids*)
- 93.67 (*Other specified osteopathic manipulative treatment*)
- 99.93 (*Rectal massage (for levator spasm)*)

Interventional Rehabilitation Procedures

- 03.96 (*Percutaneous denervation of facet*)
- 04.2 (*Destruction of cranial and peripheral nerves*)
- 81.91 (*Arthrocentesis*)
- 93.91 (*Intermittent positive pressure breathing (IPPB)*)

Other Rehabilitation Procedures

- 93.39 (*Other physical therapy*)
- 93.54 (*Application of splint*)
- 93.59 (*Other immobilization, pressure, and attention to wound*)
- 93.71 (*Dyslexia training*)
- 93.72 (*Dysphasia training*)
- 93.73 (*Esophageal speech training*)
- 93.74 (*Speech defect training*)
- 93.75 (*Other speech training and therapy*)
- 93.89 (*Rehabilitation, not elsewhere classified*)
- 93.94 (*Respiratory medication administered by nebulizer*)
- 93.99 (*Other respiratory procedures*)
- 94.51 (*Referral for psychotherapy*)
- 97.88 (*Removal of external immobilization device*)

Contoh error:

Jika kode diagnosis Z50.1 (*Other physical therapy*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan menambahkan kode diagnosis sekunder berupa M54.59 (*Low back pain, site unspecified*) tanpa disertai kode dari tindakan rehabilitasi medis, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Ungroupable: Rehabilitation without Procedures

Gambar C.26. Contoh error codes pada *Ungroupable: Rehabilitation without Procedures*

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis Z50.1 (*Other physical therapy*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan menambahkan kode diagnosis sekunder berupa M54.59 (*Low back pain, site unspecified*) dengan disertai kode dari tindakan rehabilitasi medis berupa 93.32 (*Whirlpool treatment*), maka tidak akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Rehabilitation
DRG	Therapeutic Exercise Procedures

Gambar C.27. Contoh *Ungroupable: Rehabilitation without Procedures* yang benar

31. **MDC 90 PROSEDUR DIAGNOSIS**

- a. Pada prosedur CT scan atau MRI terdapat kode IM untuk membedakan penggunaan kontras dengan menggunakan kode 99.290 (*Injection Of Contrast Agent*)^(IM).
- b. Jika pasien dilakukan prosedur CT scan pada kepala dengan kontras, gunakan kode 87.03 (*Computerized axial tomography of head*) dan tambahkan kode 99.290 (*Injection Of Contrast Agent*).
- c. Jika pasien dilakukan prosedur MRI pada kepala dengan kontras, gunakan kode 88.91 (*Magnetic resonance imaging of brain and brain stem*) dan tambahkan kode 99.290 (*Injection Of Contrast Agent*).
- d. Jika pasien dilakukan prosedur SPECT CT *parathyroid* menggunakan Thallium-201 (Tl-201), gunakan kode 92.13 (*Parathyroid scan*) dan tambahkan kode KND06 Thallium-201 (Tl-201)^(IM).
- e. Jika pasien dilakukan prosedur PET Scan *parathyroid* menggunakan Rubidium-82 (Rb-82) - Chloride, gunakan kode 92.13 (*Parathyroid scan*) dan tambahkan kode KND11 Rubidium-82 (Rb-82) - Chloride^(IM).
- f. Jika pasien dilakukan prosedur pemeriksaan RIA untuk memeriksa *Thyroid Cancer Marker*, gunakan kode 92.50 (*Non-Imaging Nuclear Medicine Thyroid Function Test*)^(IM).